



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULAN MEI
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Bab I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Tujuan 1

Bab II Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Malang 2

2.1 Visi 2

2.2 Misi..... 2

2.3 Motto 2

2.4 7 Nilai Budi Utama 2

2.5 Struktur Organisasi 3

Bab III Laporan Kinerja Pelayanan..... 4

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI) 4

3.1.1 Tabel Capaian BOR,LOS,TOI,BTO 4

3.1.2 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO 4

3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut 4

3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan 5

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada 7

3.3 Kinerja Bidang Pelayanan 23

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik 23

3.3.2 Rawat Inap 26

3.3.3 Intensive Care Unit (ICU) 34

3.3.4 High Care Unit (HCU) 35

3.3.5 Instalasi Gawat Darurat (IGD) 36

3.3.6 Instalasi Kamar Operasi (IKO) 37

3.4 Kinerja Bidang Penunjang 38

3.4.1 Instalasi Farmasi 38

3.4.2 Laboratorium 56

3.4.3 Rekam Medis - Pendaftaran..... 60

3.4.4 Radiologi 66

3.4.5 Gizi 71

3.4.6 CSSD - Laundry 82

3.5 Kinerja Bidang Umum dan Keuangan 90

3.5.1 SDM 90

3.5.2 IPSRS 99

3.5.3 Security 104

3.5.4 Parkir..... 107

3.5.5 Humas Marketing 107

3.5.6 Penjaminan 113

3.5.7 PIPP – MOD - MPP..... 114

3.5.8 *Cleaning Service* 123

3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum..... 124

3.6 Komite dan Tim 127

3.6.1 Komite Mutu 127

3.6.2 Komite PPI 180

3.6.3 Tim PKRS..... 194

3.6.4 Tim Prognas..... 196

3.6.5 Tim PPRA..... 238

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT 244

3.7 Permasalahan Rumah Sakit 246

3.8 Profil SDM 261

Bab IV Kesimpulan dan Saran..... 265

Bab V Penutup..... 266

Lampiran 267

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Bulan Mei Tahun 2025 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

2.1 VISI

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

2.2 MISI

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

2.3 MOTTO

Sahabat Menuju Sehat

2.4 7 NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur Dipercaya
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan struktur Organisasi Rumah Sakit Prima Husada Malang sebagai berikut :



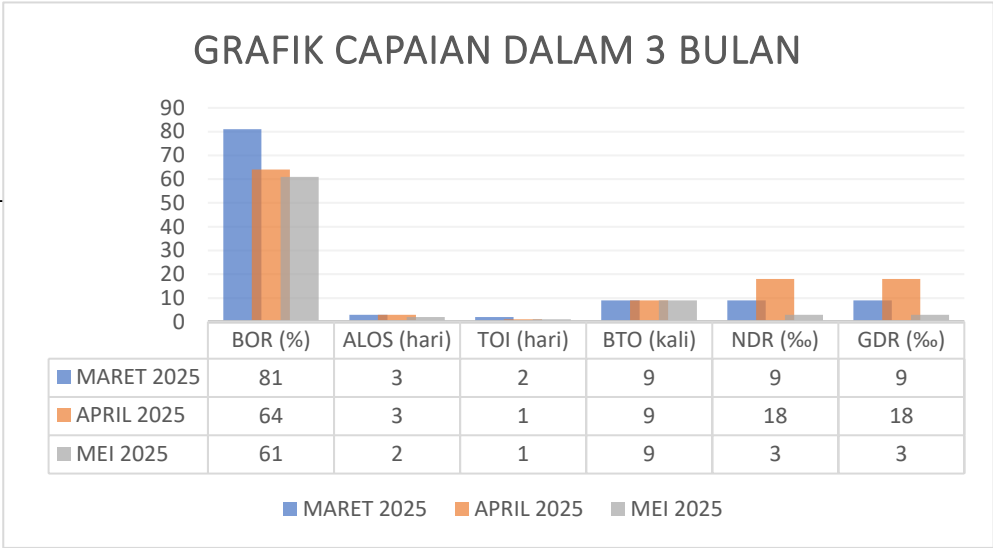
BAB III
LAPORAN KINERJA PELAYANAN

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI)

3.1.1 Tabel Capaian BOR, LOS, TOI, BTO

INDIKATOR	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	CATATAN
BOR	68%	81%	64%	61%	Penurunan signifikan sejak Bulan April
LOS	3 hari	3 hari	3 hari	2 hari	Penurunan LOS, dibawah standar SE PT DPM
TOI	1 hari	2 hari	1 hari	1 hari	Stabil, efisien
BTO	8 kali	9 kali	9 kali	9 kali	Konsisten tinggi, diluar standar ideal

3.1.2 Grafik Capaian BOR, LOS, TOI, BTO



3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut

INDIKATOR	NILAI MEI 2025	STANDAR IDEAL	EVALUASI SINGKAT
BOR	61%	60%-85%	Masih dalam standar, batas rendah
LOS	2 hari	BPJS : 3 hari UMUM : 6-12 hari	Dibawah standar BPJS, perlu dicermati
TOI	1 hari	1-3 hari	Sesuai standar, efisien
BTO	9 kali	4-5 kali	Konsisten tinggi, perlu evaluasi

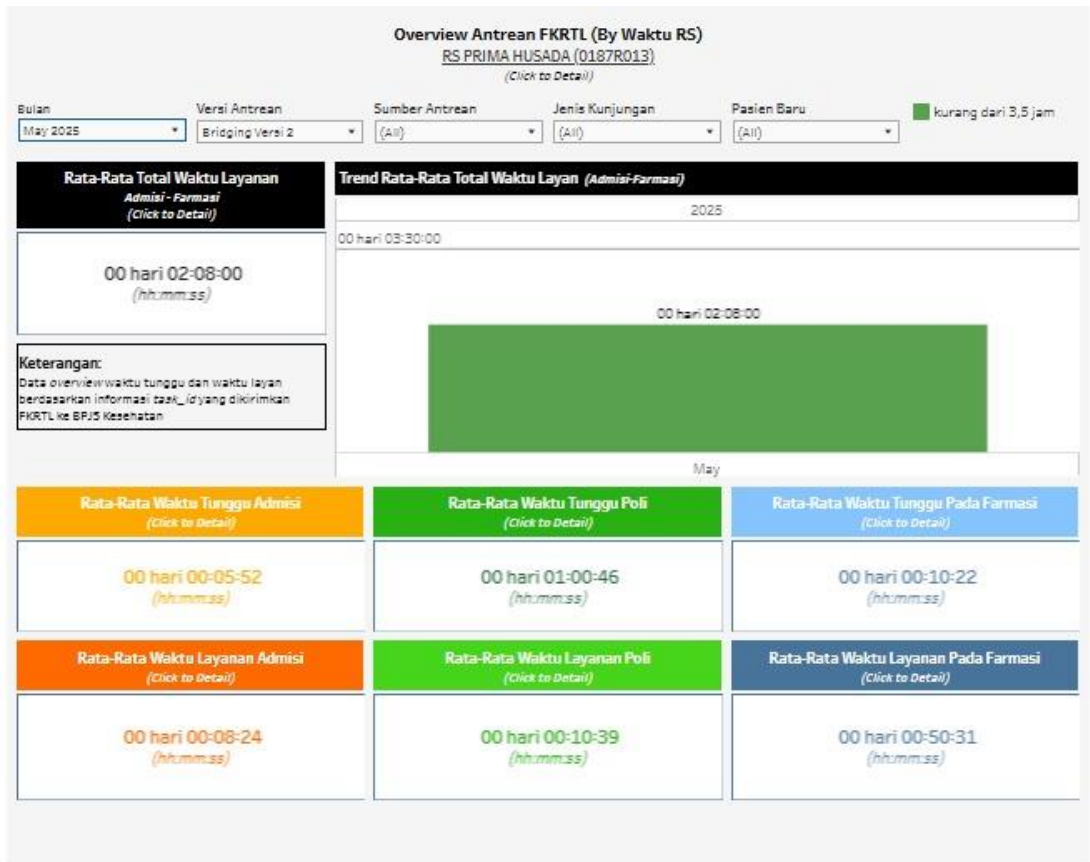
Masalah :

- BOR turun ke 61%**
Masih dalam rentang standar, namun tren penurunan berkelanjutan sejak Maret bisa mengindikasikan :
 - Penurunan jumlah pasien rawat inap.
 - Kemungkinan ruang rawat tidur kurang dimanfaatkan optimal.
- LOS semakin pendek (2 hari)**
 - Lebih rendah dari standar SE PT.DPM (3 hari) untuk pasien BPJS.
 - Risiko pemulangan terlalu cepat, yang dapat meningkatkan risiko readmisi atau komplikasi.
- TOI tetap ideal (1 hari)**
Menandakan proses pergantian pasien berjalan lancar dan efisien.
- BTO tetap tinggi (9 kali)**
 - Menunjukkan rotasi pasien yang sangat cepat.
 - Bisa menyebabkan kelelahan staf dan potensi penurunan kualitas layanan.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Audit LOS dan readmisi : Pastikan pasien tidak dipulangkan terlalu cepat demi menjaga mutu dan keselamatan.
- 2. Evaluasi kapasitas dan pemanfaatan tempat tidur : Cek apakah BOR rendah disebabkan oleh penurunan permintaan atau masalah manajemen.
- 3. Monitoring beban kerja staf : Kaji dampak BTO tinggi pada tenaga medis dan lakukan langkah mitigasi jika diperlukan.
- 4. Penggunaan sistem manajemen tempat tidur digital : Untuk mengoptimalkan distribusi pasien dan pemakaian ruang.
- 5. Sosialisasi dan pelatihan terkait discharge planning : Agar pemulangan pasien tetap berdasarkan indikasi klinis, bukan hanya efisiensi administratif.

3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan



NO		KETERANGAN	BULAN (2025)				
		Waktu Rata-Rata Rata-Rata Tahun 2024	Januari	Februari	Maret	April	Mei
1	Total Waktu Layanan	2:12:37	02:07:27	01:59:21	02:09:52	02:18:27	02:08:00
2	Waktu Tunggu Admisi	0:11:52	00:07:37	00:04:57	00:06:52	00:05:18	00:05:52
3	Waktu Layanan Admisi	0:07:49	00:05:49	00:04:58	00:05:36	00:07:16	00:08:24
4	Waktu Tunggu Poli	1:03:51	01:06:01	01:05:56	01:02:05	01:08:06	01:00:46

5	Waktu Layanan Poli	0:14:56	00:09:41	00:10:08	00:10:47	00:09:38	00:10:39
6	Waktu Tunggu Farmasi	0:14:47	00:11:17	00:09:31	00:12:56	00:13:02	00:10:22
7	Waktu Layanan Farmasi	0:54:42	00:44:57	00:38:06	00:48:35	00:51:36	00:50:31

Analisis :
 Pada bulan ini jika dibandingkan rata-rata tahun 2024 maka bulan ini masih lebih baik dilihat dari waktu total layanan. Namun terjadi peningkatan dari bulan sebelumnya.

Plan	Menyampaikan hasil evaluasi ke programmer PT Disa Prima Medika
Do	Koordinasi dengan unit terkait dan factor yang mempengaruhi.hasil dari identifikasi programmer
Study	Data rekap bulan sebelumnya yang menjadi acuan dalam perbandingan perbaikan.
Action	1. Menghubungi programmer 2. Monitoring evaluasi 3. Lakukan Tindak lanjut sesuai hasil Monev

NO	JENIS	TARGET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI-TGL 28
1	Sumber antrian melalui mobile JKN	>30%	46,43%	47.64%	49.61%	50.19%	48.42%
2	Capaian pemanfaatan antrian (onsite dan online Mobile JKN)	>90%	95.11%	94.28%	92.04%	94.61%	94.20%

Analisis :
 Pemanfaatan antrian online sudah mencapai target yang disyaratkan (>30%) dan (>90%)

Plan	Mempertahankan hasil > 30% dan meningkatkan untuk kinerja di bulan selanjutnya
Do	Sosialisasi ke unit terkait
Study	Data bulan-bulan sebelumnya sebagai acuan dari data yang sudah diperbaiki
Action	1. Memanfaatkan aplikasi https://dataviz.bpjs-kesehatan.go.id/ untuk monitoring 2. Monitoring evaluasi <i>feedback</i> 3. Supervisi kabit

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada

3.2.1 Bidang Pelayanan Dan Keperawatan

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
BIDANG PELAYANAN DAN KEPERAWATAN				
1	IRNA	Bimbingan Doa pada pasien IRNA	Sudah berjalan rutin 3x seminggu	Berjalan dengan baik dan respon pasien baik
2	IRNA	Senam hamil	Senam hamil berjalan rutin	-
		Penambahan TT rawat inap, untuk VIP kelas 1 dan kelas 2	Sudah selesai	Fasilitas seperti tv masih belum terpasang
		Foto bayi	Sudah berjalan	Fasilitas dari unit sendiri
		ERM rawat inap	Belum berjalan tetapi sudah ada progres dengan trial	Masih banyak yang eror
3	IRJA	Poli Eksekutif	Sudah berjalan mulai dari 2024 untuk bulan april 2025 ada 31 pasien, 15 pasien di dominasi oleh pasien obgyn dan anak 10 pasien	Pasien saraf sakura masih belum ada pasien sama sekali untuk bulan april 2025
4	IGD	Edukasi mengenai kriteria kegawatan menurut BPJS	Membuat video edukasi, sudah terpasang poster di IGD tentang pelayakit yang tidak terkafer bpjs	Sudah terpasang di IGD

3.2.2 Bidang Penunjang

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
Instalasi Farmasi Rumah Sakit				
1.	Depo Farmasi	1. KPO Elektronik (E-KPO)	a. Penulisan KPO (Kartu Pengambilan Obat) menulis manual sehingga memperlama waktu tunggu obat rawat jalan. b. Pengajuan form penambahan fitur E-KPO ke programmer yaitu data obat di print dengan printer thermal kemudian di tempel ke KPO pasien. c. DPJP bisa mengakses e-KPO di SIMRS. d. Jumlah KPO tertinggal : 126.	Dalam antrian progamer

			e. Belum tersedia printer thermal untuk cetak e-KPO.	
		2. Perbaikan sistem ROP Depo Farmasi dan Gudang Farmasi	a. Melakukan evaluasi dan perbaikan rumus serta sistem permintaan barang dari depo ke Gudang Farmasi melalui rumus ROP. b. Melakukan evaluasi dan perbaikan rumus serta sistem permintaan pembelian Gudang Farmasi melalui rumus ROP. c. Fitur sisa stok depo pada sistem ROP sudah tersedia.	Monitoring dan evaluasi rumus ROP yang sudah ada
		3. Renovasi ruang Pencampuran Obat (LAF) sesuai standart	a. Renovasi Pencampuran Obat (LAF) sesuai standart selesai tanggal 20/03/2025, ruangan steril dilapisi vinyl dan monitoring tekanan ruangan dengan magnehelic dan dicatat pada spreadsheet. b. Form pengajuan penambahan 1 unit Laminar Air Flow (LAF) untuk dispensing sediaan steril dan 1 unit pass-box air lock untuk tempat masuk dan keluarnya alat kesehatan dan bahan obat sebelum dan sesudah dilakukan pencampuran. <i>Pass box</i> ini terletak di antara ruang persiapan dan ruang steril. Form sudah masuk ke Pengadaan PT. Disa Prima Medika.	Follow up form pengajuan LAF dan pass-box air lock
		4. Perluasan ruang Depo Farmasi sesuai standart	a. Pengajuan perluasan ruangan di depo farmasi untuk penggantian lemari pendingin yaitu penyimpanan obat ke lemari pendingin yang lebih besar dan vaksin di letakkan dalam <i>vaccine refrigerator</i> disertai Log tag. b. Perluasan ruang buffer stok 6 Maret 2025, sudah tersedia cctv dan smart door lock.	Koordinasi dengan kepala bidang terkait rencana lokasi penyimpanan showcase 2 pintu (785 liter) dan <i>vaccine refrigerator</i> .

		5. Website PRIMANTARA	a. Presentasi MOCKUP oleh Programmer PT sudah dilakukan pada tanggal 23/09/2024. b. Presentasi MOCKUP oleh Vendor pada tanggal 20/12/2024, notulen sudah masuk ke PT, menunggu ACC Pendaftaran pasien PRIMANTARA ke farmasi masih menggunakan kertas manual. c. Belum ada fitur jasa pengiriman obat (Primantara) ke rumah pasien di SIMRS dan diperlukan penanda di resep bahwa obat dikirim serta diperlukan marking agar terdapat penanda bahwa obat telah disiapkan.	Permintaan dihold menunggu kenaikan pasien PRIMANTARA. Monitoring dan Evaluasi
		6. Jasa pengantaran obat	a. Pendataan pasien masih menggunakan google spreadsheet dan kitir manual, belum ada fitur yang bridging dengan SIMRS sebagai penanda resep bahwa obat dikirim serta diperlukan marking agar terdapat penanda bahwa obat sudah siap. b. Promo Lifetime diskon 50% untuk pengguna baru berjalan mulai Bulan Desember 2024. c. Subsidi promo untuk obat tertinggal menggunakan pengantaran gratis. d. Perubahan alur pembayaran PRIMANTARA di kasir sudah dilakukan pada tanggal 08/01/2025.	Pendataan secara manual, belum bridging dengan SIMRS. Sementara menggunakan spreadsheet dan perubahan alur pembayaran di Kasir.
		7. Rencana pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis	a. Sudah dilakukan pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis namun masih terkendala tenaga TTK kurang (jika ada staf yang sakit). b. Meminimalisir waktu tunggu pasien non kronis dengan obat yang tidak banyak.	Pengajuan fitur ke progamer.

			c. Masih ada komplain pasien terkait waktu tunggu. d. Belum ada fitur pemisahan resep masuk kronis dan non kronis.	
		8. Pengambilan obat dengan TTD elektronik	a. TTD elektronik pengambilan obat rawat jalan sudah berjalan dan memudahkan untuk mengecek retriaksi kelengkapan obat kronis, namun terkendala pada jaringan yang lemah. b. TTD elektronik pengambilan obat IGD rawat jalan dan pasien rawat inap pulang masih belum bisa dan tahap koordinasi dengan progamer.	Dalam antrian progamer. Monitoring dan evaluasi sistem elektronik.
		9. Pelayanan retriaksi obat kronis: penambahan fitur Centang "Perlu Hasil Penunjang Lab dan Hasil Pemeriksaan Lab dimunculkan saat DPJP input e-resep; Hasil Pemeriksaan Lab di Fitur Penjualan Farmasi	Pengajuan form penambahan fitur agar DPJP input resep dan penjaminan pelayanan obat bagi peserta JKN sesuai dengan ketentuan retriaksi dan/atau peresepan maksimal obat, memudahkan Farmasi mengecek kesesuaian hasil penunjang dan obat yang diresepkan sesuai retriaksi obat kronis.	Pengajuan fitur ke progamer.
		10. Penambahan fitur laporan berkas obat kronis, laporan resep iter, dan laporan reep PRB di SIMRS	Pengajuan form penambahan fitur laporan di SIMRS yaitu : a. Format laporan berkas obat kronis, berisi : nomor, tanggal registrasi, no. registrasi, no. rm, nama pasien, unit asal, nama dokter, no. sep, nama obat, hasil pemeriksaan penunjang. Tujuan untuk memudahkan farmasi melihat kelengkapan berkas klaim obat kronis yaitu Resep, SEP, Hasil Pemeriksaan Penunjang b. Format laporan resep iter, berisi : nomor, tanggal kunjungan, nama pasien, no. rm, no. kartu, no. SEP, unit	Pengajuan fitur ke progamer.

			asal, nama dokter, jumlah iter, nama obat, aturan pakai, jumlah obat, tanggal kunjungan berikutnya, status iter (terlayani/ belum). Tujuan untuk memudahkan farmasi, verifikator, DPJP untuk melihat laporan resep iter dan target iter. c. Format laporan resep PRB, berisi : nomor, nama dokter, tanggal kunjungan, nama pasien, no. rm, no. kartu, no. SEP, alamat, no. telp, diagnosa PRB, asal FKTP perujuk, asal SRB (FKTL/RS), nama obat, aturan pakai, jumlah obat. Tujuan untuk memudahkan farmasi, verifikator, DPJP untuk melihat laporan resep PRB dan target PRB.	
		11. Penambahan fitur warning di SIMRS DPJP "Pasien tidak ambil obat"	Pengajuan form penambahan fitur warning di SIMRS DPJP "Pasien tidak ambil obat" untuk mengurangi retur obat tertinggal.	Pengajuan fitur ke progamer.
2.	Gudang Farmasi	1. Pengembangan fitur scan barcode gudang farmasi dan depo farmasi untuk pemasukan dan pengeluaran stok.	a. Proposal scan barcode sudah diajukan ke PT pada tanggal 01/10/2024. b. Sudah dilakukan presentasi pada tanggal 04/10/2024. c. Pendataan master barcode sudah diserahkan ke Programmer PT. Tindak lanjut untuk barang yang tidak memiliki barcode yaitu dibuatkan barcode internal oleh progamer. d. Alat scanner barcode, barcode printer, thermal paper sudah tersedia pada tanggal 16/11/2024. e. Software aplikasi barcode dalam tahap dikerjakan oleh progamer.	Rencana trial menunggu Programmer PT
		2. Perluasan Gudang Farmasi	a. Perluasan Gudang Farmasi di Lantai 2, karena pallet buffer sudah tidak cukup.	Sudah berjalan. Follow up pengadaan katrol.

			b. Pengajuan katrol untuk penurunan buffer dari lantai 2.	
3.	Floorstok IKO	Perbaiki sistem penyimpanan floorstok IKO	Progres perbaikan Floorstok IKO tahun 2023 : a. Tanggal 03 Januari 2023 dilakukan rapat koordinasi floorstok IKO dengan perawat IKO dan programmer terkait sistem floorstok IKO yaitu : - Tidak adanya petugas farmasi khusus IKO sehingga monitoring stok di IKO tidak berjalan → Pengajuan petugas farmasi di IKO. - Perubahan alur dari depo iko ke floorstok IKO. - Karu IKO menentukan obat dan BMHP yang dimasukkan dalam list floorstok. - Perbaiki alur floorstok iko ke depo farmasi. - List barang yang masuk dalam kategori floorstok dan jumlahnya. - List barang yang masuk dalam kategori BMHP. - Penggunaan BMHP yang diambil dari Gudang Farmasi apakah perlu di inputkan tindakan dan ditagihkan ke pasien → Konsul dengan keuangan PT terkait tagihan BMHP yang digunakan IKO. - Koordinasi dengan karu IKO penentuan barang sharing dose. - Konsul dengan keuangan PT terkait tagihan pasien untuk penggunaan obat maupun alkes sharing.	Monitoring dan Evaluasi.

			- Konsul dengan programmer terkait alur penginputan sharing dose. b. Tanggal 17 Maret 2023 dilakukan sosialisasi alur floorstok IKO oleh progamer yaitu : - Alur input obat dan bmhp oleh perawat IKO di SIMRS → perawat menulis resep manual – barang disiapkan, kemudian input resep setelah operasi sesuai yang terpakai. - Alur permintaan floorstok iko ke depo farmasi oleh perawat IKO di SIMRS. - Alur release stok oleh depo farmasi di SIMRS. - Alur minta barang BMHP IKO ke gudang farmasi oleh perawat di SIMRS. c. SPO alur Pelayanan Sediaan Farmasi Sistem Floorstock Di Instalasi Kamar Operasi terbit tanggal 24 Maret 2023. d. Tanggal 03 April 2023 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO dan programer terkait sistem floorstok IKO yaitu : - Petugas IKO ditemukan salah memilih unit tujuan saat input permintaan sehingga dapat menyebabkan selisih stok → Petugas IKO diharap lebih teliti dalam melakukan inputan permintaan (memperhatikan tujuan permintaan BMHP ke Gudang dan permintaan barang floorstok ke depo farmasi).	
--	--	--	---	--

			- Melakukan double check oleh petugas farmasi, apabila IKO salah input permintaan maka konfirmasi ke petugas IKO untuk revisi inputan sesuai tujuan permintaan - Pembuatan SPO alur floorstok iko. - Jumlah stok di sistem Floorstok IKO bisa sampai minus → Pengajuan ke programmer untuk stok sistem di lock hanya sampai angka 0 (tidak sampai minus). - Penetapan alur bmhp IKO bahwa list bmhp yang sudah disetor ke keuangan PT dimasukkan dalam paket tindakan operasi sehingga tidak perawat tidak input ke pasien. e. Tanggal 08 Mei 2023 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO dan programmer terkait sistem floorstok IKO yaitu : - Terdapat stok yang tidak sesuai antara kartu stok, jumlah fisik, dan jumlah sistem. Stok sistem belum di lock. Dengan adanya penyesuaian item dan jumlah floorstok di IKO sehingga terdapat stok yang kelebihan dan atau kurang → Melakukan stok opname floorstok IKO. Mengajukan pemutihan stok IKO untuk penyesuaian dengan kesepakatan jumlah floorstok terbaru. Kelebihan dan atau	
--	--	--	--	--

			kekurangan stok dibuatkan berita acara untuk penyesuaian stok. Progres perbaikan Floorstok IKO tahun 2024 : a. Fitur Floorstok unit IKO sudah tersedia dan sudah dijalankan. b. Fitur minta barang floor stock sudah tersedia dan sudah dijalankan. c. Sistem stok IKO sudah dikunci. d. Ada petugas farmasi di IKO untuk monitoring stok. e. Tanggal 15 Juli 2024 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO, Kabid Penunjang, Kabid Keperawatan yaitu : - Ditemukan input permintaan FS menggunakan tipe trans “farmasi” bukan fitur “floor stok unit” sehingga terjadi kelebihan barang yang tidak sesuai jumlah FS, dikarenakan barang yang dikirimkan ada yang kurang dari yang dimintakan. Hal ini terjadi dikarenakan selisih stok di IKO di sistem stoknya tidak ada namun fisiknya ada sehingga staf farmasi yang diiko tidak mencatat di barang menipis sehingga tidak disiapkan permintaan FS ketika malam hari karena secara fisik stoknya masih ada → Menyamakan persepsi antara permintaan FS dengan permintaan hutang input ke pasien. Jika staf farmasi melakukan	
--	--	--	--	--

			random stok dan ditemukan selisih stok lebih disistem maka akan konfirmasi ke perawat untuk diinputkan ke pasien. Jika terdapat selisih stok fisik lebih dan stok simrs 0 maka farmasi mengecek stok yang ada didepo farmasi dan simrs depo farmasi. Jika stok simrs berlebih maka release stok ke iko. - Ditemukan perbedaan barang di resep manual dan inputan simrs, farmasi menuliskan apa yang ada diinputan resep, perawat iko mengambil barang namun tidak ada di tulisan resep manual hari itu → Farmasi melakukan double cek resep manual dan inputan simrs jika ada yang belum diinputkan maka akan di stabilo di resep manual dan resep diserahkan ke perawat untuk diinputkan kembali. Resep akan dibedakan, untuk resep yang belum selesai diinput akan ada didekat komputer iko. Untuk resep yang sudah diinput akan ditaruh dikeranjang di lemari obat. f. Tanggal 15 Juli 2024 dilakukan rapat evaluasi floorstok IKO dengan perawat IKO, Kabid Penunjang, Kabid Keperawatan yaitu : - Konsinyasi implant IKO belum di lock → dilakukan stok opname. Data	
--	--	--	---	--

			diberikan ke programmer agar dilakukan penyesuaian stok. Programmer langsung merubah dan sistem di lock. - Perubahan alur penyiapan obat dan bmhp operasi → perawat input resep sesuai advice DPJP – farmasi menyiapkan – jika ada barang yang tidak terpakai maka di retur penjualan. g. Revisi SPO : - SPO Pelayanan Kefarmasian Di Instalasi Kamar Operasi terbit tanggal 12 November 2024. - SPO Permintaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Instalasi Kamar Operasi Kepada Instalasi Farmasi. h. Tersedia alur penggunaan sediaan sharing dose. Contoh : Isonest. i. Menggunakan tabel penggunaan obat sharing dose. j. Ada petugas farmasi di IKO	
Instalasi Rekam Medis				
1.	Rekam Medis	1. Mengaplikasikan E-RM (IRJA dan IRNA).	1. Sudah terealisasi E-RM Rawat Jalan IGD dan IRJA. Rehab sudah berjalan mulai tanggal 01-05-2024. IRNA dalam proses tahap akhir, target pada Bulan Juni 2025. 2. Melakukan pendataan fitur yang dibutuhkan pada SIMRS, lalu diserahkan kepada Programmer PT.	Kurang sinkron antara fitur perawat dan rekam medis, seperti : TTD tidak terisi, belum muncul pengkajian fisioterapis di fitur rekam medis. Permasalahan E-RM dan layanan Poli yang belum masuk E-RM sudah disampaikan kepada Programmer PT sekaligus flow chart.
		2. Penggunaan ERM Rawat Inap	1. Kolaborasi dengan Programmer PT. 2. Melakukan trial pada awal Bulan Mei 2025.	Follow up. Monitoring dan Evaluasi.
		3. Kirim ke Satu Sehat untuk	Pengiriman data ke satu sehat (untuk data kunjungan	Monitoring dan Evaluasi.

		Pasien Rawat Jalan (Baik ERM ataupun Non ERM)	dan diagnosis) dilakukan setiap hari. Temuan dan TL : - ERM yang belum lengkap dan valid. - TL : Koordinasi dengan Tim Pendaftaran terkait identitas pasien yang tidak lengkap. - Bayi baru lahir yang belum mempunyai NIK. - TL : Kie ke keluarga pasien agar segera pengurusan KK. - Pasien yang tidak membawa identitas dengan lengkap. - TL : KIE ke keluarga pasien untuk mengirimkan identitas melalui chat WA.	
		4. Dokumentasi DRM lama.	- Melakukan scanning form kedalam SIMRS. - Tarikan data bisa diambil pada rekap kunjungan di SIMRS. - Menunggu programmer membuat fitur scanning.	Koordinasi dengan Programmer. Pengajuan ke PT.
		5. Retensi DRM	- Data DRM yang akan diretensi menunggu Programmer PT sebelum dilakukan pemilahan dan pemusnahan DRM. - Pemusnahan terakhir dilakukan pada Tahun 2018.	Follow up Programmer PT.
		6. Rekap Data Laporan Dinkes	- Data yang dibutuhkan tidak semua bisa ditarik oleh system. - Pengajuan fitur ke Programmer PT. - RM membuat Google Spreadsheet untuk diisi oleh unit-unit terkait setiap harinya. - Tujuannya untuk memudahkan Karu RM dalam pelaporan RL ke Dinkes tepat waktu.	Dalam Proses.
2.	Pendaftaran	1. Anjungan Pasien Mandiri.	1. Melakukan studi banding atau mencari informasi terkait penggunaan APM di RS lain.	Dalam proses dan diajukan ke Program Kerja Tahun 2025.

			2. Membuat flowchart dan diajukan ke Programmer PT.	
		2. Penetapan petugas jaga.	Melakukan penetapan PJ disetiap divisi, Pendaftaran Central, CSO dan Pendaftaran IGD dengan personil tetap, dengan tujuan supaya petugas menguasai permasalahan dan fokus pelayanan, memudahkan telusur dan perbaikan jika ada komplain dan masalah.	PJ Pendaftaran Central : Tyas PJ Pendaftaran IGD : Riri Pendaftaran CSO : Shinta Bella
		3. Pendaftaran pasien	1. Reservasi pasien umum dan asuransi melalui web, disertai pembayaran melalui VA. 2. Kolaborasi dengan IT dan SIMRS.	Proses mengerjakan TOR
Instalasi Radiologi				
1.	Radiologi	1. Menambahkan fitur hasil radiologi di SIMRS supaya hasil JPEG dapat diakses.	3. Sudah dirapatkan dengan Programmer untuk dibuatkan fitur tersendiri.	Dalam antrian programmer.
		2. Menambah jam pelayanan supaya pelayanan maksimal.	4. Melakukan close recruitmen untuk mengisi jam kosong pada siang hari.	Surat pemberitahuan kebutuhan Sp.Rad sudah diterima oleh Ketua Kolegium.
		3. Respon Time Radiologi	5. Kolaborasi dengan perawat untuk melakukan pencatatan di Google Spreadsheet secara real time.	Mulai dijalankan awal Tahun 2024.
Instalasi Laboratorium				
1.	Laboratorium	1. Pengadaan LIS.	1. Hardware sudah terpasang di Laboratorium. 2. Software proses dikerjakan oleh Programmer dan Vendor.	Dalam antrian programmer.
		2. Stok Opname BDRS	BDRS berjalan mulai 29 November 2024.	SO akan dilakukan Pada hari Sabtu, 22 Maret 2025.
		3. Penambahan fitur	1. Penambahan fitur upload hasil laboratorium rujukan dari luar RS. 2. Penambahan fitur centang otomatis hasil pemeriksaan yang abnormal, batas atas dan batas bawah sudah dicatat dan diajukan ke Programmer PT.	Dalam antrian Programmer PT.
Instalasi Gizi dan Dapur				
1.	Gizi	1. Pengaktifan Poli	1. Kolaborasi dengan	Monitoring dan evaluasi setiap bulan.

		Gizi di Rawat Jalan/MCU Gizi.	Humas&Marketing. 2. Kolaborasi dengan pelayanan antar obat (PRIMANTARA), free MCU Gizi.	
		2. Prima Healthy Meal.	Sudah pengajuan TOR ke PT.	Menunggu ACC.
		3. Daftar Menu Makanan Penunggu VIP.	Book Menu sudah proses dikerjakan oleh PKRS.	Dalam proses.
		4. Registrasi alat makan	1. Kolaborasi dengan penyaji untuk melakukan pencatatan keluar masuknya sendok di Google Spreadsheet. 2. Perbaikan alur saat mengambil peralatan makan di ruangan, jika ditemukan sendok hilang maka dicatat di Google Spreadsheet dan dioperkan ke perawat ruangan untuk ditagihkan ke saat pasien KRS. 3. Dilakukan stok opname setiap bulan untuk menghitung peralatan makan. 4. Membuat SPO Pengecekan Fasilitas RS Sebelum Pasien KRS.	Registrasi alat makan sudah berjalan sejak Bulan Januari 2024 Proses dibuatkan SPO kehilangan alat makan, penggantian biaya dilakukan di Kasir, jika tidak tertagihkan maka tanggungjawab unit bersama.
		5. Pemesanan diit melalui SIMRS	1. Memastikan proses pemesanan diet lebih efisien dan mengurangi kesalahan pemesanan diet dari DPJP ke perawat, perawat ke ahli gizi. 2. Ahli gizi mengkonfirmasi diet di SIM-RS jika ada penambahan diet/ganti diet saat selesai visitasi di ruangan. 3. Proses cetak label langsung efisien tanpa harus mengetik ulang dan tidak menulis manual di label. 4. Koordinasi dengan bagian SIM-RS supaya segera di realisasikan ke unit.	Monitoring dan evaluasi.
		6. QC sesuai sistem HACCP	1. Pelatihan HACCP dilakukan oleh seluruh Ahli Gizi. 2. Memastikan proses quality control makanan sesuai standar. 3. Memastikan 7 prinsip HACCP. 4. Koordinasi dengan SDM jika ada informasi terkait	Menunggu jadwal pelatihan.

			pelatihan tersebut.	
2.	Dapur	1. Perbaikan menu makanan dan plating. 2. Menu makanan buka puasa senin-kamis.	1. Sudah dilakukan supervisi oleh Direktur Utama PT DPM pada hari Senin, 18 November 2024. 2. Kebijakan penggunaan alat makan dan SPO plating sudah dibuatkan sebagai pedoman penyaji dalam melakukan pekerjaan. Program PT berjalan mulai tanggal 09 Desember 2024. Yang sudah disiapkan : 1. Daftar siklus menu makanan. 2. SPO pemesanan makanan buka puasa (+). 3. Link google form untuk pemesanan (+). 4. Kebijakan pemesanan makanan hari H maksimal pukul 06.00 WIB.	Monitoring dan Evaluasi. Revisi tampilan sedang diproses oleh PKRS (Eriko). Monitoring dan Evaluasi.
3.	Pantry	1. Food Waste	Perbaikan pencatatan sisa makanan berdasarkan menu makanan untuk mengetahui makanan yang kurang diminati.	Monitoring dan Evaluasi
Instalasi CSSD dan Laundry				
1.	CSSD	1. Mengajukan mesin sterilikator (steam plasma). 2. Perbaikan serah terima menggunakan digital form. 3. Perbaikan jam kerja	Belum terealisasi. Sudah berjalan di Bulan Juli 2024. Pelayanan mulai pukul 06.30-21.00 WIB, jika ada alat yang akan disetor diatas jam pelayanan maka dilakukan pre-cleaning di unit masing-masing.	Monitoring dan evaluasi permintaan sterilisasi alat semi critical sesuai kebutuhan sterilisasi instrument bedah syaraf. 5. Kolom tidak terisi lengkap. 6. Monitoring Evaluasi oleh Karu dan Kabid. Berjalan per Bulan Desember 2024. Monitoring Evaluasi oleh Karu dan Kabid.
2.	Laundry	1. Mengajukan mesin cuci industry dengan kapasitas 30kg. 2. Membuat digital form untuk permintaan linen. 3. Pengadaan Bedcover untuk pasien VIP dan LINEN IKO.	Belum terealisasi. 1. Rencana permintaan sehari 2 kali oleh unit sesuai dengan kebutuhan. 2. Belum terealisasi. 1. Rencana diajukan ulang dengan melampirkan keluhan pasien VIP, kerusakan linen IKO.	Monitoring dan evaluasi penggunaan mesin cuci industry utama. Berjwal awal Tahun 2025. Linen IKO dan VIP sudah diproses. Selimut VIP sudah diajukan.

		4. Perbaikan jam kerja	2. Pelayanan ada 3 shift, shift malam dimulai pukul 22.00-04.00 WIB tanpa jam istirahat, dan memenuhi stok di unit.	Berjalan per Bulan Desember 2024.
Lain-lain				
1.	Lain-lain	1. Rapat Bulanan masing-masing Unit dengan Kabid.	Dilakukan per Bulan November 2024. Supervisi pemahaman pelaksana tentang pedoman pelayanan, pengorganisasian, dan pelayanan sesuai dengan akreditasi. Pelaksanaan : 1. Tanya Jawab 2. Role Play	1. RM dan Pendaftaran Hari : Senin, 16-06-2025. Waktu : 13.00 WIB sd selesai. Tempat : Hall Sakura Lt 5 (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom). 2. Farmasi Hari : Selasa, 17-06-2025. Waktu : 13.00 WIB sd selesai Tempat : Hall Sakura Lt 5 (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom) 3. Gizi Hari : Rabu, 18-06-2025 Waktu : 11.00 WIB sd selesai Tempat : Lokasi Dinas (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom) 4. Laboratorium Hari : Kamis, 19-06-2025 Waktu : 14.00 WIB sd selesai Tempat : Lokasi Dinas (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom) 5. Radiologi Hari : Jum'at, 20-06-2025 Waktu : 14.00 WIB sd selesai Tempat : Lokasi Dinas (Yang berhalangan hadir)

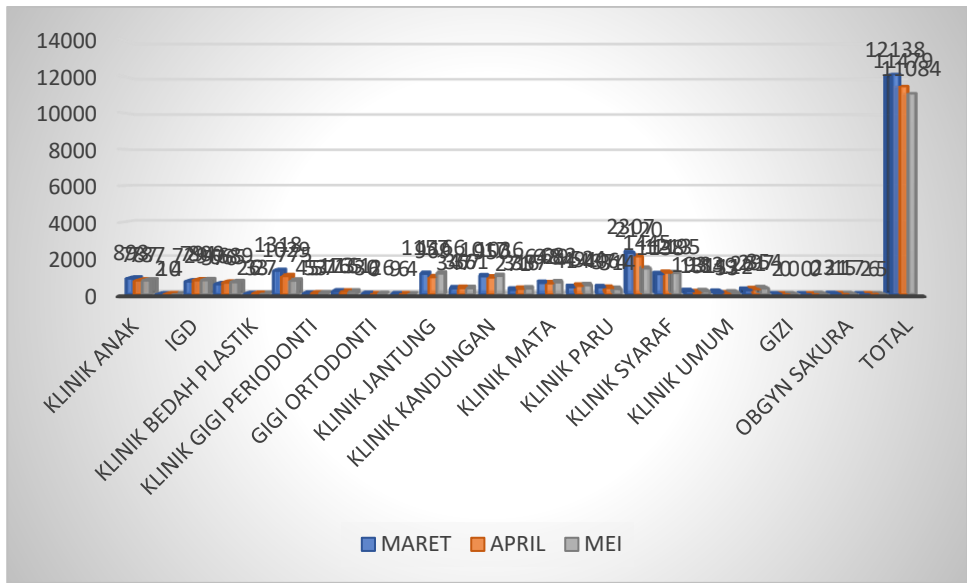
				menggunakan Zoom) 6. CSSD dan Laundry Hari : Sabtu, 21-06-2025 Waktu : 13.00 WIB sd selesai Tempat : Laundry (Yang berhalangan hadir menggunakan Zoom) 7. Rapat All Karu Penunjang Hari : Sabtu, 28-06-2025 Waktu : 13.00 WIB sd selesai Tempat : Ruang Direktur RS
--	--	--	--	---

3.3 Kinerja Bidang Pelayanan

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik

3.3.1.1 Kunjungan Pasien Lama dan Baru

NO	NAMA UNIT	MARET 2025			APRIL 2025			MEI 2025		
		BARU	LAMA	TOTAL	BARU	LAMA	TOTAL	BARU	LAMA	TOTAL
1	Klinik Anak	42	851	893	50	737	787	42	745	787
2	Anak sakura	0	2	2	2	8	10	1	3	4
3	IGD	227	502	729	260	534	794	259	541	800
4	Klinik Bedah	28	548	576	55	610	665	35	654	689
5	Klinik Bedah Plastik	2	24	26	2	31	33	1	26	27
6	Klinik Fisioterapi	1	1317	1318	2	1027	1029	1	774	775
7	Klinik Gigi Periodonti	7	38	45	12	41	53	3	54	57
8	Gigi spesialis pedodontis	17	156	173	14	151	165	15	146	161
9	Gigi Ortodonti	7	23	30	1	5	6	4	22	26
10	Klinik Ibu dan Anak	0	9	9	0	6	6	0	4	4
11	Klinik Jantung	23	1134	1157	11	958	969	19	1147	1166
12	Klinik Jiwa	12	335	347	13	354	367	9	352	361
13	Klinik Kandungan	80	937	1017	102	848	950	97	939	1036
14	Klinik Kulit dan Kelamin	20	251	271	39	279	316	35	302	337
15	Klinik Mata	46	602	648	44	585	629	53	629	682
16	Klinik Orthopedi	14	400	414	20	471	491	30	494	524
17	Klinik Paru	4	402	406	8	336	374	10	304	314
18	Klinik Penyakit Dalam	35	2272	2307	47	2063	2120	43	1402	1445
19	Klinik Syaraf	34	1104	1138	35	1178	1213	35	1160	1195
20	Klinik THT	36	157	193	40	91	131	32	151	183
21	Klinik Umum	125	24	149	29	24	53	76	36	112
22	Klinik Urologi	18	243	261	30	267	297	43	311	354
23	Gizi	1	1	2	0	0	0	0	0	0
24	Bedah Saraf	0	0	0	0	0	0	1	22	23
25	Obgyn Sakura	4	17	21	3	12	15	2	15	17
26	Penyakit dalam sakura	1	1	2	2	4	6	1	4	5
Total		784	11354	12138	821	10620	11479	847	10237	11084



Analisis :

- 1. Kunjungan di bulan mei menurun dari bulan sebelumnya,sebanyak 3,5% dari bulan april 2025. Analisanya ada dokter cuti haji dengan pasien terbanyak sehingga kunjungan menurun sekitar 385 pasien di poli rawat jalan
- 2. Jumlah pasien terbanyak ada di Poli penyakit dalam sebanyak 2120 ,jumlah pasien ini menurun dibandingkan bulan april 2025 karena ada 1 dokter ipd cuti selama 1 bulan dan dengan pasien yang terbanyak
- 3. Kunjungan poli bedah saraf sudah stabil untuk bulan mei karena dokter bedah saraf sudah aktif kembal dari bulan sebelumnya
- 4. Untuk poli pedodonti anak dalam 3 bulan terakhir menurun dikarenakan setiap praktek ada pembatasan kuota sehingga jumlah pasien tidak banyak dalam 3 bulan terakhir
- 5. Kunjungan poli eksekutif adalah bulan mei menurun 16,1% dari bulan april 2025 disebabkan pasien lebih memilih umum biasa di bandingkan poli Sakura karena tidak terlalu mahal

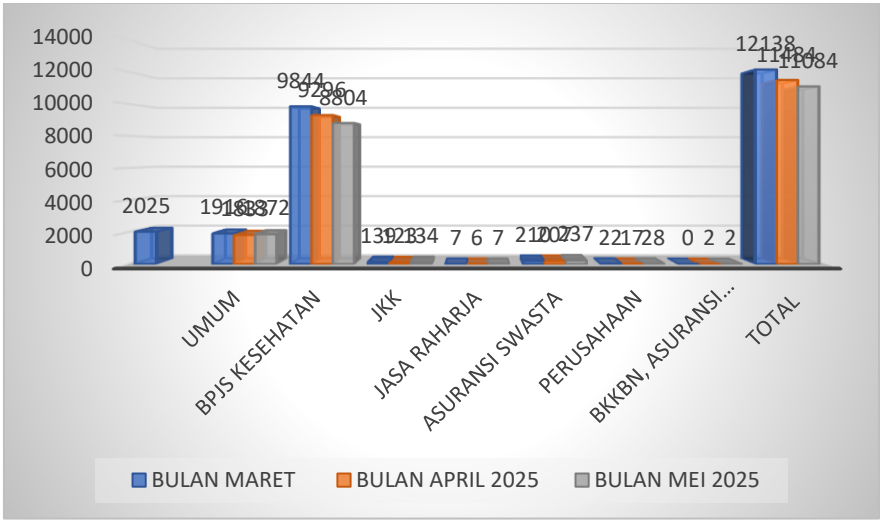
Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Koordinasi dengan pendaftaran penjangkaran pasien umum dan asuransi untuk memperkenalkan pelayanan poli sakura
- 2. Menginformasikan kepada seluruh unit rawat inap wajib edukasi saat krs untuk pasien umum,asuransi tentang pelayanan poli sakura
- 3. Menambah jam HFIS untuk poli pedodonti sehingga akan menambah jumlah pasien
- 4. Memisahkan pasien BPJS dengan pasien non BPJS. Pasien Non BPJS di daftarkan di poli Sakura.
- 5. Koordinasi dengan Humas dan Marketing untuk penjangkaran asuransi dan perusahaan.
- 6. Sosialisasi pada faskes dengan pelayanan baru yang ada di rumah sakit prima husada
- 7. Koordinasi dengan humas marketing untuk rutin menampilkan promo di media sosial
- 8. Koordinasi dengan pendaftaran untuk sellau menanyakan pasien yang mendaftar apakah memiliki asuransi komersil.
- 9. Sosialisasi pada komunitas pasien geriatri maupu prolanis klinis MS,bahwa dokter gigi ortodonti (perawat gigi) dan poli sakura
- 10. Sosialisasi pada perusahaan dan stakeholder bahwa ada poli sakura yang menyediakan layanan one stop service
- 11. Mengajukan pelayanan baru otho,bedah,uro dan kulit di Poli Sakura

1.3.1.2 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran

NO	STATUS PEMBAYARAN	BULAN MARET 2025	%	BULAN APRIL 2025	%	BULAN MEI 2025	%
1	Umum	1916	15,8%	1833	15,96%	1872	16,89%
2	BPJS Kesehatan	9844	81,1%	9296	80,95%	8804	79,43%
3	JKK	139	1,1%	123	1,07%	134	1,21%
4	Jasa raharja	7	0,1%	6	0,05%	7	0,06%
5	Asuransi swasta	210	1,7%	207	1,80%	237	2,14%
6	Perusahaan	22	0,2%	17	0,15%	28	0,25%
7	BKKBN, Asuransi Pemerintah	0	0%	2	0,02%	2	0,02%
	Total	12138	100%	11484	100%	11084	100%

1.3.1.2.1 Grafik Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran



Analisis :
Kunjungan pasien bulan Mei 2025 berdasarkan cara pembayaran menurun 3,5% dari bulan april 2025 . Kunjungan terbanyak adalah pasien dengan penjamin BPJS Kesehatan sebesar 79,43%. Kunjungan bpjs menurun di bandingkan bulan maret 2025 dikarenakan banyaknya peraturan bpjs dan ada dokter dengan kunjungan terbanyak cuti pada bulan mei 2025 sehingga kunjungan pasien bpjs juga menurun
Kunjungan terendah berdasarkan cara pembayaran kunjungan asuransi pemerintah dengan 0,02% ada 2 kunjungan

Rencana Tindak Lanjut :
Untuk meningkatkan kunjungan pasien rawat jalan adalah dengan meningkatkan pelayanan terbaik serta berkoordinasi dengan marketing untuk melakukan kunjungan dan menawarkan beberapa pelayanan baru seperti poli sakura yang bisa bekerjasama dengan berbagai asuransi, poli bedah saraf dan poli gigi anak. bekerjasama dengan humas marketing terutama MCU haji dan vaksin internasional (meningitis, polio dan influenza)

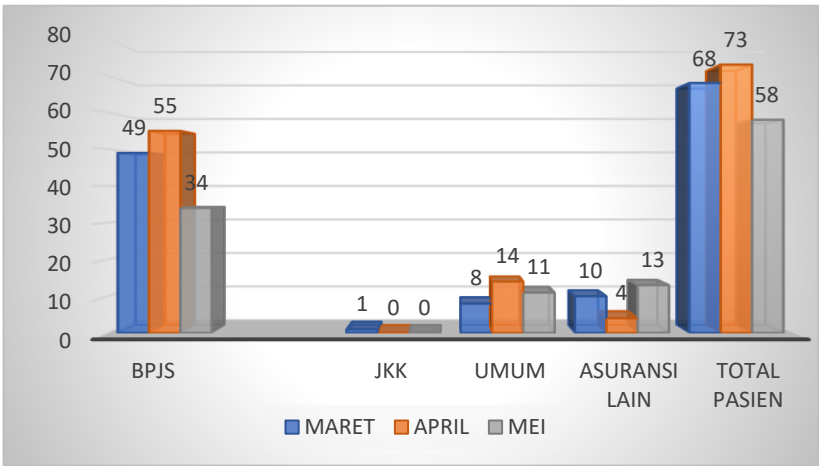
3.3.2 Rawat Inap

3.3.2.1 Kunjungan Rawat Inap 2C

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret 2025- Mei 2025)

NO	HAL	MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	49	55	34	↓ 38,1%
2	JKK	1	0	0	0%
3	Umum	8	14	11	↓ 21,4%
4	Asuransi Lain	10	4	13	↑ 69,2%
Total Pasien		68	73	58	↓ 20,5%

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar (Maret -Mei 2025)



1.3.2.1.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANS I	
1	Mei 2025	34	11	0	13	58
	Analisa	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan mei menurun 38,1% dari bulan sebelumnya di sebabkan kunjungan dari di IGD banyak yang naik kelas dan pasien VIP dan VVIP menurun	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan mei mengalami penurunan 21,4% dari bulan sebelumnya di sebabkan kunjungan IGD yang masuk VIP dan VVIP menurun	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan mei pasien di irna 2c tidak ada untuk cara bayar jkk	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan mei mengalami peningkatan 69,2% dari bulan sebelumnya	Total pasien bulan mei 2025 mengalami penurunan 20,5% (15 pasien) dari bulan sebelumnya
	RTL	1. Meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke				

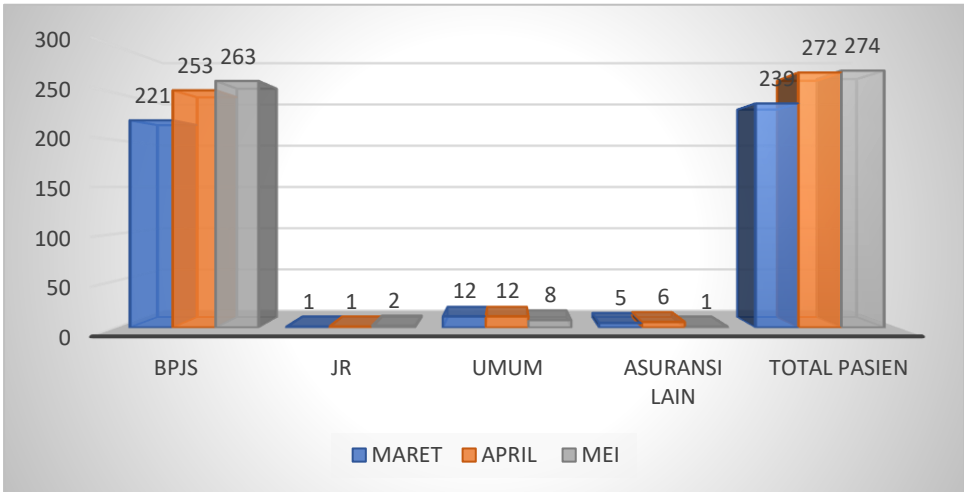
		VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran
		2. Rencana penambahan VVIP 1 TT
		3. Memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti paket alat, mandi, baju pasien khusus VIP/VVIP
		4. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap
		5. Bekerjasama dengan marketing untuk meningkatkan pasien pasien asuransi terutama perusahaan perusahaan yang baru
		6. Meningkatkan pelayanan yang lebih ekstra kepada pasien
		7. Mempromosikan ruangan vip/vvip lewat sosial media

3.1.1.1 Kunjungan Rawat Inap 3C Anak

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar (Maret - Mei 2025)

NO	HAL	MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	221	253	263	↑ 3,8%
2	JR	1	1	2	↑ 50%
3	Umum	12	12	8	↓ 33,3%
4	Asuransi Lain	5	6	1	↓ 95%
Total Pasien		239	272	274	↑0,72%

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret - Mei 2025)



3.3.2.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

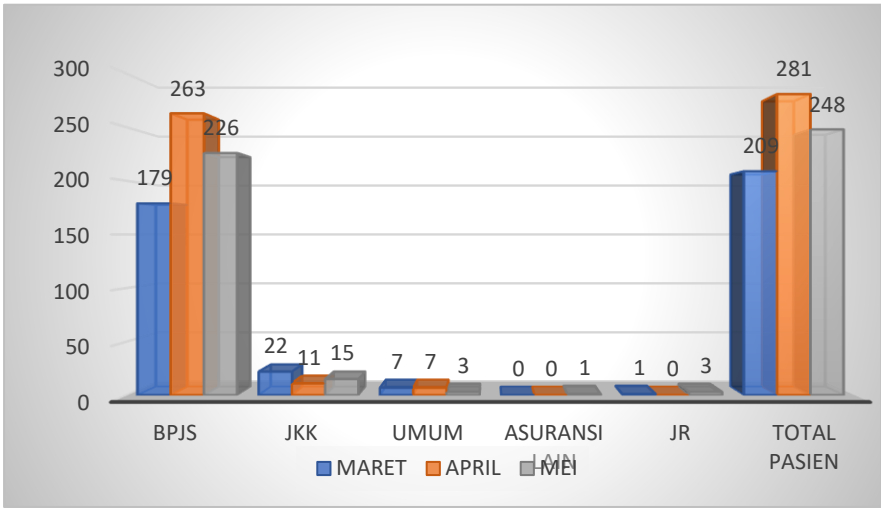
NO.	BULAN MEI 2025	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JR	ASURANSI	
1	Analisis	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir meningkat untuk bulan mei 2025 mengalami peningkatan 3,8% dari bulan april 2025 di sebabkan kunjungan dari IGD terutama pasien anak meiningkat dan banyaknya pasien yang MRS saat periksa di rawat jalan	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil,untuk bulan mei 2025 mengalami penurunan dari bulan sebelumnya di sebabkan saat pasien umum naik VIP dan VVIP	Pasien JR dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan mei 2025 mengalami penurunan 33,3% dari bulan sebelumnya	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan mei 2025 mengalami penurunan 95% dari bulan sebelumnya	Total keseluruhan bulan mei mengalami peningkatan 0,72% dari bulan april 2025 (2 pasien)
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulanya 2. Memperbaiki setiap fasilitas yang ada di unit jika ada yang rusak 3. Promosi ruangan anak lewat media sosial ,tiktok dan IG 4. Program taman anak-anak harus di terealisasikan di irna anak untuk tahun ini 5. Berkoordinasi dengan Marketing untuk kunjungan ke TK atau paud tentang pelayanan gigi anak baru				

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap 2,3,4 A

3.1.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret - Mei 2025)

NO	HAL	MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	179	263	226	↓14,06%
2	JKK	22	11	15	↑ 36,3%
3	Umum	7	7	3	↓ 100%
4	Asuransi Lain	0	0	1	↑0%
5	JR	1	0	3	↑100%
Total Pasien		209	281	248	↓ 11,7 %

3.1.1.2.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret – Mei 2025)



3.1.1.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN MEI	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian Mei 2025	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan mei mengalami penurunan 14,06% dari bulan sebelumnya disebabkan kunjungan di IGD menurun terutama pasien dengan BPJS kelas 2	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan mei mengalami penurunan dari bulan sebelumnya	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk kunjungan bulan mei mengalami peningkatan 36,3 % dari bulan sebelumnya di sebabkan kunjungan rujukan dari perusahaan meningkat dari IGD yang masuk rawat inap	Pasien JR/Asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan mei 2025 mengalami peningkatan 100% dari bulan sebelumnya	Total pasien di lantai 2,3,dan 4 mengalami penurunan 11,7% (33 pasien)
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 6. Pemberian edukasi yang baik 7. Berkoordinasi dengan bagian humas marketing untuk melakukan kunjungan di perusahaan-perusahaan untuk melakukan pendekatan ke HRD				

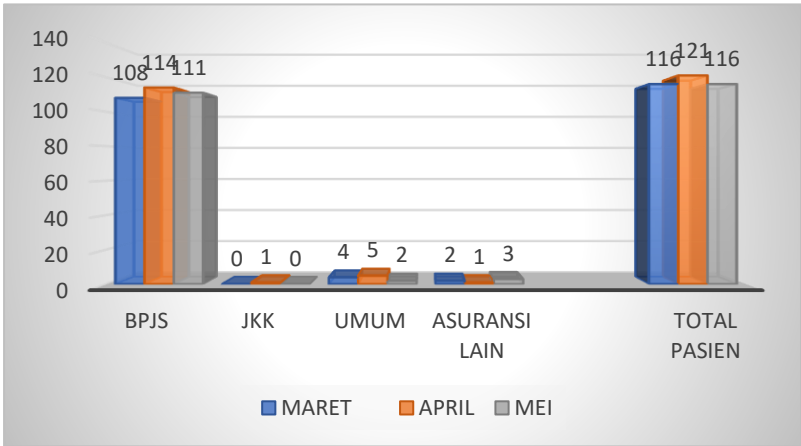
3.1.1.3 Kunjungan Rawat Inap 5C

3.1.1.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret – Mei 2025)

NO	HAL	MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	108	114	111	↓2,70%
2	JKK	0	1	0	↑100%

3	Umum	4	5	2	↓60%
4	Asuransi Lain	2	1	3	↑ 66,6%
Total Pasien		116	121	116	↓4,13%

3.1.1.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret -Mei 2025)



3.1.1.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN MEI	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANS I	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami belum stabil untuk bulan mei menurun 2,7% dari bulan sebelumnya	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan mei mengalami penurunan 60% dari bulan sebelumnya	Pasien JKK dalam 3 bulan belum stabil untuk bulan mei 2025 mengalami peningkatan 100% dari bulan sebelumnya	Pasien Asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan mei 2025 mengalami peningkatan 66,6 50% dari bulan sebelumnya	Pada bulan mei 2025 total pasien mengalami penurunan 4,13% dari bulan sebelumnya
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 6. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya dan berkoordinasi dengan marketing untuk selalu koordinasi dengan faskes tentang pelayanan pasien TB di rumah sakit prima husada				

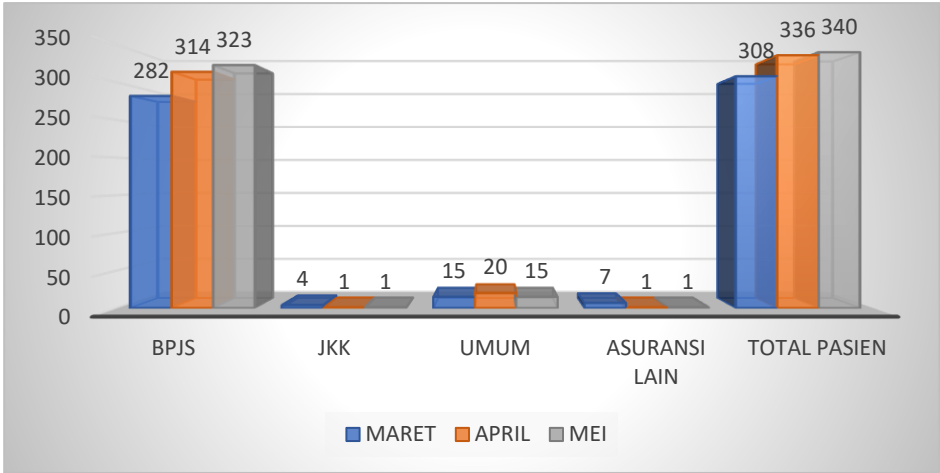
3.1.1.4 Kunjungan Rawat Inap 6, 7, 8 A

3.1.1.4.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret - Mei 2025)

NO	PENJAMIN	MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	282	314	323	↑ 2,5%
2	JKK	4	1	1	0%
3	Umum	15	20	15	↓ 25%

4	Asuransi Lain	7	1	1	0%
Total Pasien		308	336	340	↑ 1,2%

3.1.1.4.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret - Mei 2025)



3.1.1.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

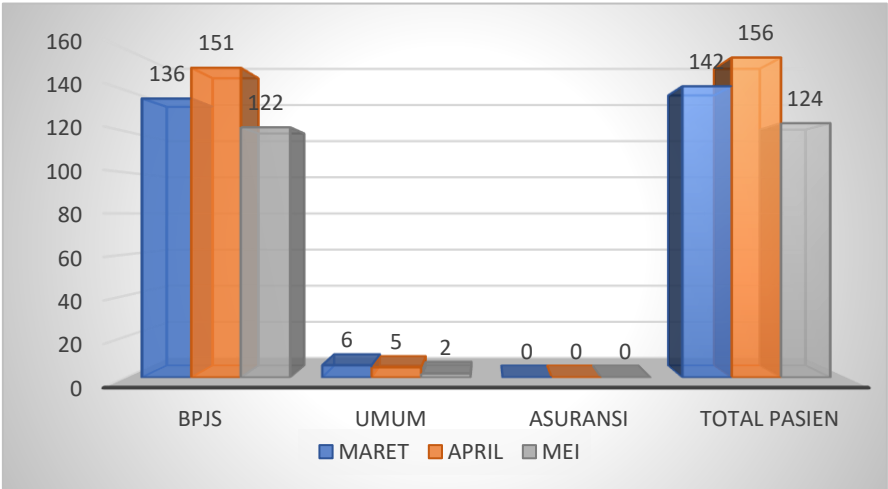
NO.	BULAN MEI	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir kunjungan di irna 6,7 dan 8 A meningkat untuk bulan mei 2025 mengalami peningkatan 2,5% dari bulan sebelumnya di sebabkan kunjungan di IGD sudah stabil meningkat untuk kelas 3	Pasien Umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan mei 2025 mengalami penurunan 25% di bandingkan bulan sebelumnya	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan mei 2025 jumlah pasiennya tetap dibandingkan bulan sebelumnya	Pasien Asuransi / JR dalam 3 bulan mengalami penurunan untuk bulan mei 2025 mengalami stagnan bandingkan bulan sebelumnya	Total semua pasien mengalami peningkatan pasien 1,2 % dari bulan sebelumnya
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 6. Berkoordinasi dengan bagian humas marketing untuk melakukan kunjungan di perusahaan-perusahaan untuk melakukan pendekatan ke HRD				

3.1.1.5 Kunjungan Rawat Inap Maternitas

3.1.1.5.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret - Mei 2025)

NO	HAL	MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	136	151	122	↓ 19,20%
2	Umum	6	5	2	↓ 60%
3	Asuransi	0	0	0	0%
Total Pasien		142	156	124	↓ 20,5%

3.1.1.5.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret - Mei 2025)



3.1.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

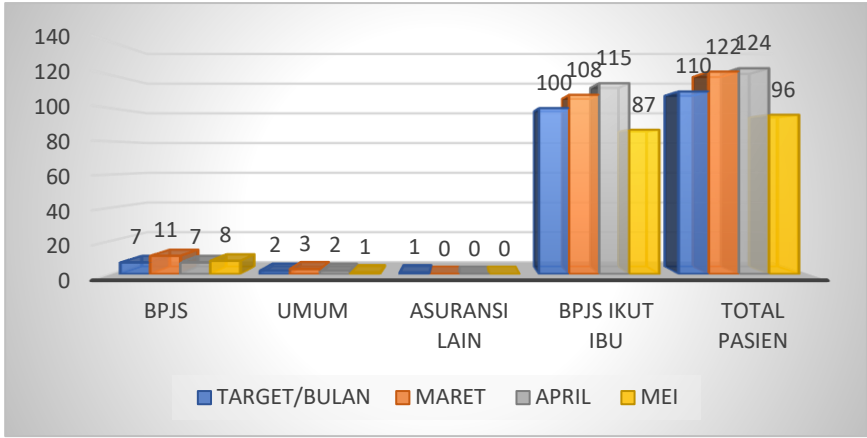
NO	BULAN MEI	RAWAT INAP			KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian mei 2025	Pasien BPJS dalam 3 bulan mengalami belum stabil untuk bulan mei 2025 mengalami penurunan 19,2% dari bulan sebelumnya disebabkan kunjungan yang tindakan obgyn menurun dari igdd dan poli	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan mei 2025 mengalami penurunan 60% dari bulan sebelumnya	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir tidak ada pasien yang lahiran menggunakan asuransi swasta selain BPJS	Total pasien bulan mei 2025 mengalami penurunan 20,5% dari bulan sebelumnya
2	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan bekerja sama dengan humas marketing terutama untuk kunjungan ke bidan bidan praktek yang mempunyai BPJS	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan ,bekerjasama dengan humas marketing untuk posting di ig tentang pelayanan di maternitas	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan ,dan mengadakan corporate gatreing dengan perusahaan setiap 1 tahun sekali	

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap Neonatologi

3.3.2.7.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret -Mei 2025)

NO	HAL	TARGET/BULAN	MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	7	11	7	8	↑ 14,3%
2	Umum	2	3	2	1	↓ 50%
3	Asuransi Lain	1	0	0	0	0%
4	BPJS IKUT IBU	100	108	115	87	↓ 24,34%
Total Pasien		110	122	124	96	↓ 22,6%

1.3.2.7.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret - Mei 2025)



3.3.2.7.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	UMUM	ASURANSI	BPJS IKUT IBU	Total Pasien
1	Mei 2025	8	1	0	87	96
	Analisa	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan mei 2025 mengalami peningkatan 14,3 dari bulan sebelumnya	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir mengalami penurunan untuk bulan mei 2025 mengalami penurunan 50% dari bulan sebelumnya	Pasien asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan april 2025 tidak ada pasien sama sekali	Pasien BPJS ikut ibu dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan mei 2025 mengalami penurunan 24,34 % dibandingkan bulan sebelumnya	Total pasien dalam bulan mei 2025 mengalami penurunan 22,6% di bandingkan bulan april 2025
	RTL	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya, dan berkoordinasi dengan marketing untuk menginformasikan ke bidan bidan jejaring	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya, kerjasam a dengan marketing, membuat program pelayanan baru seperti pijat bayi sehingga menarik banyak pasien	Meningkatkan pelayanan dan koordinasi dengan bagian marketing untuk meningkatnka n pasien asuransi	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya, kerjasa ma dengan marketing	Meningkatkan pelayanan agar bisa tercapai peningkatan di setiap bulanya, kerjasam a dengan marketing, memb uat program foto bayi dari unit neo

3.1.2 Intensive Care Unit (ICU)

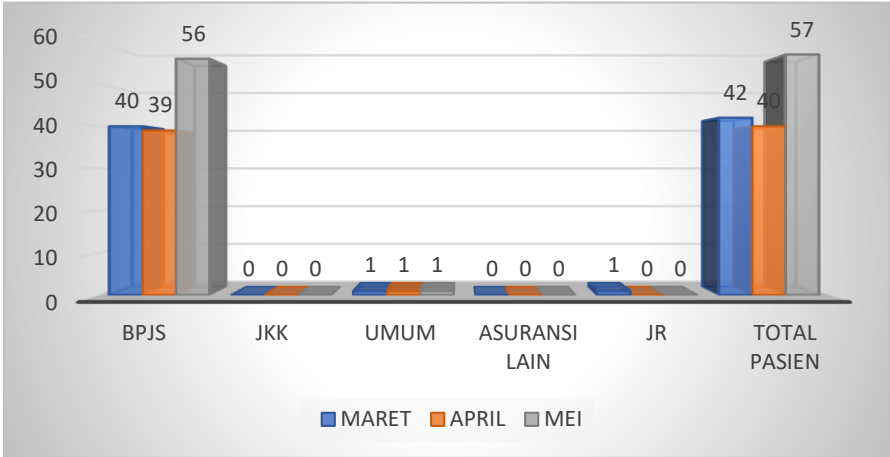
3.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar

(Maret - Mei 2025)

NO	PENJAMIN	MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	40	39	56	↑ 42,5%
2	JKK	0	0	0	0%
3	Umum	1	1	1	0%
4	Asuransi Lain	0	0	0	0%
5	JR	1	0	0	0%
Total Pasien		42	40	57	↑ 40,1%

3.1.1.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar

(Maret - Mei 2025)



3.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

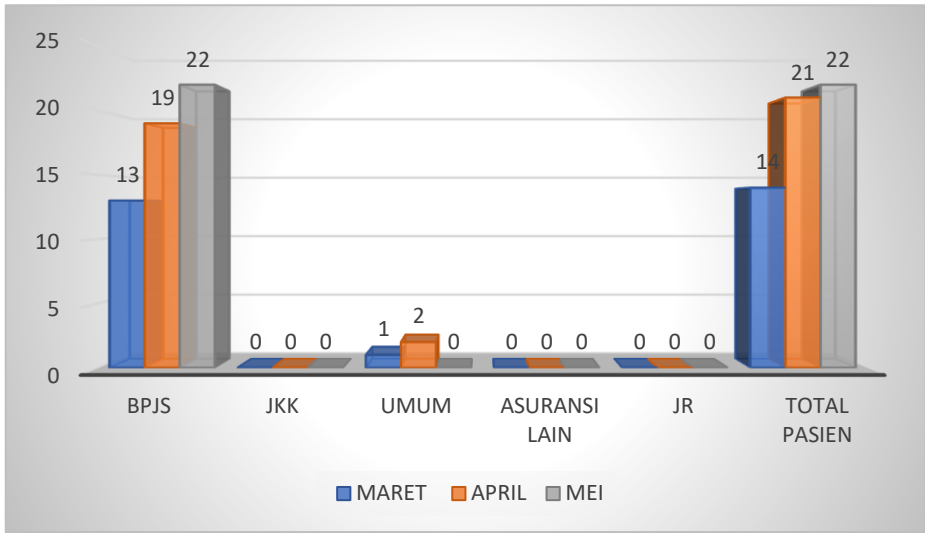
NO.	BULAN MEI	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan untuk bulan mei 2025 mengalami peningkatan 42,5% dibandingkan bulan sebelumnya	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir mengalami stagnan bulan mei 2025 jumlah kunjungan tetap dengan bulan sebelumnya	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir tidak ada pasien 0	Pasien JR/ Asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan mei 2025 tidak ada kunjungan sama dengan bulan sebelumnya	Pada 3 bulan terakhir jumlah total pasien belum stabil untuk bulan mei total pasien meningkat 40,1% dibandingkan bulan sebelumnya
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama ICU 3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat 5. Meningkatkan kualitas SDM yang ada di ICU				

3.1.2 High Care Unit (HCU)

3.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret - Mei 2025)

NO	HAL	MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	13	19	22	↑13,6%
2	JKK	0	0	0	0%
3	Umum	1	2	0	↓ 100%
4	Asuransi Lain	0	0	0	0%
5	JR	0	0	0	0%
Total Pasien		14	21	22	↑ 4,5%

3.1.1.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret - Mei 2025)



3.1.2.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

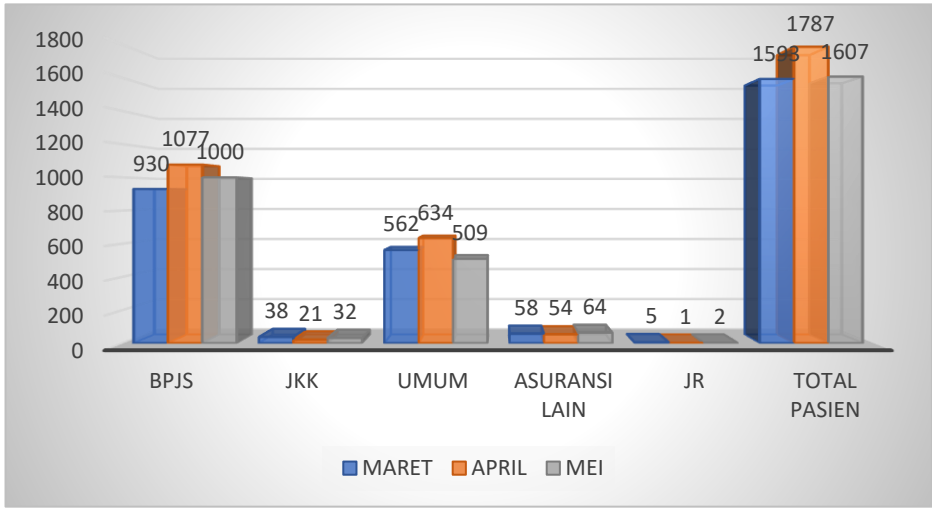
NO.	BULAN MEI	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir mengalami peningkatan, untuk bulan mei 2025 mengalami peningkatan 13,6% di bandingkan bulan lalu	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan mei 2025 mengalami penurunan 100% dari bulan sebelumnya	Tidak ada pasien JKK selama 3 bulan	Pasien JR/ Asuransi dalam 3 bulan terakhir masih belum ada pasien	Pada 3 bulan terakhir jumlah total pasien bulan mei 2025 mengalami peningkatan 4,5% dari bulan sebelumnya
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama HICU 3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat				

3.1.3 Instalasi Gawat Darurat (IGD)

3.1.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret - Mei 2025)

NO	HAL	MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	930	1077	1000	Type equation he ↓ 7,7%
2	JKK	38	21	32	↑ 34,3%
3	Umum	562	634	509	Type equation he ↓ 24,5%
4	Asuransi Lain	58	54	64	↑ 15,6%
5	JR	5	1	2	Type equation he ↑ 50%
Total Pasien		1593	1787	1607	↓ 11,2%

3.1.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Maret - Mei 2025)



3.1.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN MEI 2025	RAWAT INAP				TOTAL PASIEN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis	Kunjungan pasien BPJS dari 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan mei 2025 mengalami penurunan 7,7% dari bulan sebelumnya di sebabkan penurunan kasus gawat darurat secara umum dan meningkatnya gaya hidup sehat	Kunjungan pasien dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan mei 2025 mengalami penurunan 24,5% dari bulan sebelumnya disebabkan penurunan kasus gawat darurat secara umum di daerah malang utara	Kunjungan pasien dengan jaminan JKK dari 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan mei 2025 mengalami peningkatan 34,3% dari bulan sebelumnya di sebabkan banyaknya kunjungan JKK di prima husada ini di bantu oleh marketing yang selalu kolaborasi dengan perusahaan	Kunjungan pasien dengan jaminan JR dan asuransi dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan mei 2025 mengalami peningkatan 16,6% dari bulan sebelumnya banyaknya pasien asuransi yang masuk IGD	Total Kunjungan pasien IGD semua jaminan bulan mei 2025 mengalami penurunan 11,2% dari bulan sebelumnya

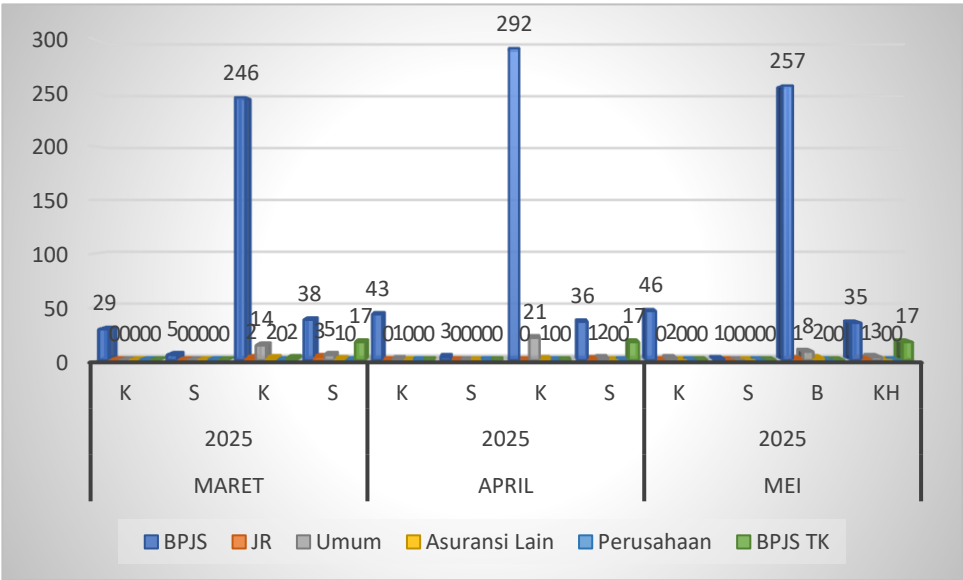
2	RTL	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan pasien BPJS IGD dengan memperbaiki pelayanan dan mengurangi komplain serta bekerjasama dengan marketing untuk menambah kerja sama dengan beberapa faskes I area kabupaten Malang	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan jaminan UMUM dengan memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan maksimal	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan jaminan JKK dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan beberapa Perusahaan Kabupaten Malang	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan Asuransi swasta IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan memperbaiki pelayanan dan bekerjasama dengan pihak terkait (marketing, asuransi centre)
---	-----	---	--	--	---	---

3.1.4 Instalasi Kamar Operasi (IKO)

3.1.4.1 Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Maret -Mei 2025)

NO	HAL	MARET 2025				APRIL 2025				MEI 2025				MEI 2025
		k	s	k	s	k	s	k	s	k	s	b	kh	Penurunan 10,5%
1	BPJS	29	5	24	38	4	3	29	36	46	1	257	35	
2	JR	0	0	2	3	0	0	0	1	0	0	1	1	
3	Umum	0	0	14	5	1	0	21	2	2	0	8	3	
4	Asuransi Lain	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	2	0	
5	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	BPJS TK	0	0	2	17	0	0	0	17	0	0	0	17	
	Total Pasien	364				417				373				

3.1.4.2 Grafik Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Maret - Mei 2025)



3.1.4.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	BULAN MEI	IKO					KESIMPULAN
		BPJS	BPJS TK	UMUM	PERUSAHAAN	JR/ASURANSI	
1	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir pasien operasi yang menggunakan BPJS menurun 9,3% dari bulan sebelumnya	Pasien BPJS TK dalam 3 bulan operasi belum stabil untuk bpjs TK stagnan, untuk bulan mei 2025 di bandingkan bulan sebelumnya	Pasien Umum operasi dalam 3 bulan terakhir meningkat untuk bulan mei 2025 mengalami penurunan 45,8% dibandingkan bulan sebelumnya	Pasien perusahaan dalam 3 bulan terakhir stagnan tidak ada operasi selama 3 bulan terakhir	Pasien Asuransi / JR dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk mei 2025 mengalami stagnan di bandingkan bulan sebelumnya	Total pasien untuk bulan mei 2025 menurun 10,5%
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya dan mengurangi pasien IDO sehingga pasien puas dengan pelayanan operasi di prima husada 2. Berkoordinasi dengan bagian marketing untuk ekspos ruangan IKO yang sudah di ganti vinyl 3. Mengikuti pelatihan yang terbaru sehingga menunjang pelayanan yang terbaik di IKO 4. Berkoordinasi dengan humas marketing, terutama kunjungan ke perusahaan-perusahaan dan psc untuk mengirim ke prima husada malang 5. mengirimkan pelatihan asisten bedah saraf 6. Memberikan edukasi yang bagus untuk pasien pasien operasi					

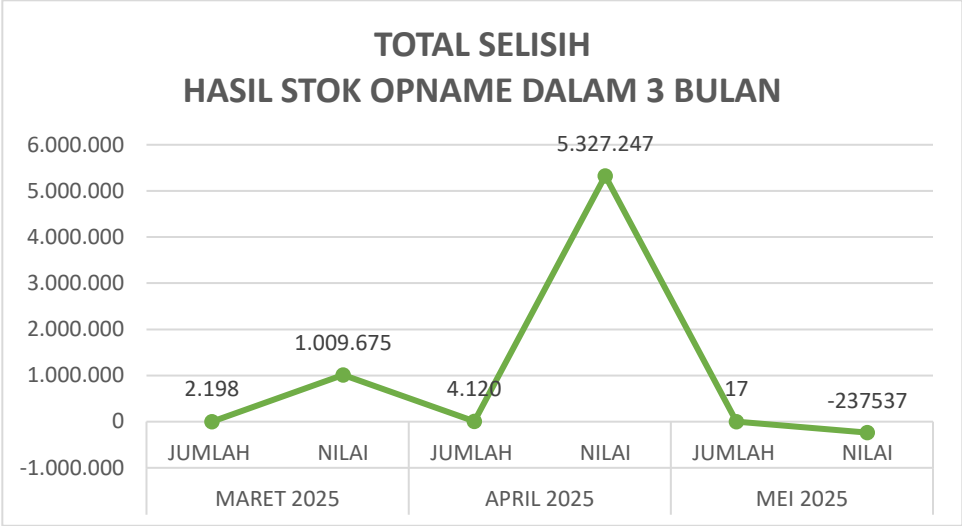
3.2 Kinerja Bidang Penunjang

3.2.1 Instalasi Farmasi

3.2.1.1 Tabel Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Maret – Mei 2025

UNIT	JUMLAH STOK	JUMLAH PERSEDIAAN					
		MARET 2025		APRIL 2025		MEI 2025	
		JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI
GUDANG	FISIK	1.035.559	1.873.594.700	965.498	1.728.454.181	925.158	1.698.286.012
	SISTEM	1.035.558	1.874.036.506	965.498	1.728.454.181	925.120	1.697.960.945
	SELISIH	1	+34.860	0	0	38	+325.067
DEPO FARMASI	FISIK	163.384	504.874.177	225.599	642.691.694	242.327	721.442.047
	SISTEM	161.212	505.093.452	221.475	635.531.901	242.338	721.932.977
	SELISIH	2.173	-219.275	4.126	7.159.787	-11	-490.932
IKO	FISIK	1.891	91.545.201	1.670	81.173.371	2.301	91.020.298
	SISTEM	1.867	90.351.111	1.686	83.005.912	2.311	91.091.969
	SELISIH	24	+1.194.090	-6	-1.832.540	-10	-71.672
GUDANG RETURE	FISIK	0	0	0	0	0	-71.672
	SISTEM	0	0	0	0	0	0
	SELISIH	0	0	0	0	0	0
TOTAL SELISIH		2.198	+1.009.675	4.120	+5.327.247	17	-237.537

3.2.1.2 Grafik Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Maret - Mei 2025



3.2.1.3 Analisis dan Tindak Lanjut

Hasil stok opname pada Bulan Mei 2025 belum mendekati target (-237.537), analisisnya sebagai berikut :		
NO	ANALISA	RENCANA TINDAK LANJUT
GUDANG FARMASI		
Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname belum mencapai target, yaitu sebesar +Rp 325.067.		
Analisa :		
1.	Terdapat selisih lebih pada barang dengan kode (F00575) Ondansentron tab 8 mg sebanyak 20 tab. Hal ini disebabkan Depo Farmasi salah input jumlah barang dan petugas gudang tidak teliti saat release dan serah terima barang, seharusnya kelipatan 30 tab dalam 1 box.	Melakukan serah terima barang dengan memastikan sediaan obat pada setiap box nya.
2.	Terdapat selisih kurang pada barang dengan kode (F02164) Transofix sebanyak 12 pcs. Hal ini disebabkan petugas gudang kurang release stok saat serah terima barang BMHP ke Poli Bedah. Pengeluaran tercatat pada kartu stok.	
3.	Terdapat selisih lebih pada barang dengan kode (F00129) Cairan INF Sterile Water For Irrigation 1000 ml sebanyak 30 flash. Hal ini disebabkan pengambilan tidak dilakukan serah terima dengan baik sehingga barang ada yang tidak diambil. Hal ini disebabkan ruangan resepan infus untuk operasi → depo input permintaan barang ke gudang → gudang release stok → depo konfirmasi ke ruangan untuk ambil infus ke gudang namun tidak segera diambil.	Perubahan alur yang seharusnya berjalan, yaitu : Ruangan resepan sesuai jumlah → Depo Farmasi permintaan ke Gudang Farmasi → Gudang Farmasi serah terima dengan Depo Farmasi dan melakukan release stok → Barang diambil di Depo Farmasi oleh Perawat Ruangan sesuai dengan jumlah yang diinput.
DEPO FARMASI		
Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname masih sangat jauh dari target (0) yaitu sebesar -Rp 490.932, hal ini disebabkan karena :		
1.	F00480 Methylprednisolon secara fisik tersedia merk phapros, pada kertas kerja SO hanya tersedia merk MAHAKAM, sedangkan pada sistem sudah tersedia Methylprednisolon – PHAPROS	Kertas kerja dicetak dari sistem.
2.	Penataan buffer di ruang buffer stok tidak ada label dan campur menjadi satu dan tidak berdasarkan alfabetis sehingga perhitungan buffer terhambat.	Perbaikan penataan ulang buffer stok sesuai rak di Ruang Buffer Stok.

	Contoh : Nebacetin Powder seharusnya masuk rak tetapi penempatannya pada buffer.	
3.	Ketidaksesuaian antara barang yang diambil perawat IGD menggunakan resep manual dengan inputan resep di SIMRS, seperti : - F01481 IV Cannula Plus No 20-Hospitech (-89) - F00651 Pulmicort Respules 05 mg/ml-Astra Zeneca (-16) - F04514 Cairan INF NS 0.9% 500 ml-Satoria (-13) - F01475 Infusion Set Dewasa Y Set-Otsuka (-6) - F04697 Cairan INF RL 500 ml-Satoria (-6) - F04501 Santagesik Inj 500mg/2ml-Sanbe (+12) - F00659 Ranitidine Inj 50mg/2ml-Hexpharm Jaya (+3) - F01967 Spalk 10 x 5 cm-(TE-10) (+3)	Koordinasi dengan Kabid Keperawatan untuk menertibkan petugas dalam penginputan resep sesuai dengan barang yang diambil. Petugas Farmasi melakukan double crosscheck, jika ada yang belum terinput maka akan dishare di Grup dan meminta bukti inputan (sudah berjalan), perlu supervisi dari Kabid Keperawatan.
4.	Ketidaksesuaian antara inputan resep dan barang yang diberikan disebabkan perbedaan nama barang sama namun beda pabrik atau beda ukuran yang digunakan, seperti: - F03296 ETT Cuff No 5.0-Prodevice (-1) - F01353 ETT Cuff No 7.0-WORK (+1) - F01427 Handscoon Non Steril S-Altamed (+19) - F01428 Handscoon Non Steril XS-Altamed (-19) - F00481 Methylprednisolone Inj 125 mg/2 ml-Mahakam (-1) - F00480 Methylprednisolone Inj 125 mg/2 ml-Phapros (+1)	1. Memperbaiki sistem pengeluaran barang dari gudang ketika ada nama barang sama namun beda pabrik dengan memastikan stok depo dihabiskan terlebih dahulu sebelum dinonaktifkan. 2. Sosialisasi kepada perawat perbaikan fitur pencarian dalam SIMRS untuk meningkatkan akurasi pemilihan barang. 3. Memperbaiki sistem penyiapan barang bertanggungjawab atas input penjualan.
5.	Selisih lebih terjadi karena proses retur ODD harian yang tidak optimal dari rawat inap (Resep ODD harian tidak diinput retur di SIMRS sementara pasien sudah KRS)	Perawat memastikan obat harian yang tidak digunakan diretur melalui SIMRS setiap hari. Melakukan audit dan evaluasi kembali alur retur obat di IRNA.
6.	BMHP dan obat yang diambil perawat untuk tindakan di Poli Rawat Jalan tidak segera dikembalikan saat poli selesai dan hutang inputan resep menyebabkan selisih kurang, seperti : - Spuit 50 cc LP (-1) - Urin Bag (-1) - Red Dot (-8)	Koordinasi dengan Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala Ruang terkait alur serah terima BMHP untuk tindakan di Poli Rawat Jalan
FLOORSTOK IKO Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname masih sangat jauh dari target (0) yaitu sebesar – Rp 1.832.540, hal ini disebabkan karena :		
1.	Jadwal operasi sering berbenturan dengan waktu perhitungan stok floorstock sehingga terdapat selisih. Hal ini disebabkan ketidaksesuaian antara inputan resep dan barang yang diberikan disebabkan perbedaan nama barang sama namun beda pabrik atau beda ukuran yang digunakan, seperti : - F03296 ETT Cuff No 5.0-Prodevice (-1) - F01349 ETT Cuff No 5.0-Work (+1) - F01430 Handscoon Steril 6.5-Saveglove (-1) - F01435 Handscoon Steril 8-Saveglove (+1)	1. Lakukan stok opname saat apotek tidak melayani transaksi untuk menghindari selisih. 2. Simpan data stok opname harian sebagai arsip. 3. Perbaiki semua obat sudah dipindai barcode. 4. Perawat bertanggungjawab atas keluar masuknya barang ketika admin IKO tidak ada ditempat.
GUDANG RETUR Dari tabel 3.2.1.1 tampak bahwa hasil stok opname sudah sesuai dengan target (0).		
1.	Tidak terdapat rak Gudang Retur.	Sentralisasi master barang PT. DPM dan mengajukan gudang retur kembali dimunculkan.

3.2.1.4 Tabel Daftar Obat-obat Near ED <6 bulan (Maret - Mei 2025)

No	Kode	Nama Barang	Satuan	Harga Beli	Tanggal Expired	No Batch	Jumlah Fisik Baik (BULAN)			Total Harga	Laporan Penjualan 1 Tahun Terakhir
							Maret	April	Mei		
1	F01348	Ett cuff no 4.5 - work	Pcs	36.500	30/03/2025	200321	12	12	12	483.000	1
2	F00939	Benang t-lene 5-0 I17 - triton	Pcs	80.000	30/06/2025	200601AC	28	25	25	2.000.000	103
3	F00796	Vaksin influenza - flubio - biofarma	Vial	121.032	30/06/2025	8020824	3	1	2	242.064	23
4	F00542	Ntg inj 1 mg/ml - ferron	Vial	65.000	30/07/2025	BN4832412A	16	16	16	1.040.000	31
5	F00580	Oseltamivir caps 75 mg (hibah dinkes) - indofarma	Caps	10.010	30/07/2025	210V2062	1.100	1.100	1.100	11.011.000	0
6	F00030	Aminophylline inj 24 mg/ml - phapros	Amp	4.000	30/08/2025	66307030-1	34	29	11	44.000	243
7	F00307	Ferriprox tab 500 mg - apotex inc	Tab	35.100	30/08/2025	ry1625	194	194	94	3.299.400	0
8	F00603	Perossal 2x6 - dipa pharmala b	Pcs	231.000	30/08/2025	22HA14780	16	10	12	2.772.000	87
9	F00726	Susuk kb II (levonorgestrel 75 mg)	Pcs	-	31/08/2025	0100017	16	16	16	-	0
10	F00228	Cotrimoxazole syr 240 mg/5 ml - mersi	Btl	2.773	30/09/2025	A21797	76	64	53	146.969	259
11	F00176	Cendo pantocain 2% - cendo	Flash	13.250	30/09/2025	2P30926	11	11	11	145.750	14
12	F04724	Dermavix s iv 6x7cm - onemed	Pcs	1.982	01/09/2025	27102088	-	-	25	49.550	0
13	F01337	Dj stent 6 fr close end - medika	Pcs	280.000	30/09/2025	76122032	14	14	13	3.640.000	18
14	F01394	Foley cath silicon no 10 - rusch	Pcs	110.000	30/09/2025	KME20K3008	5	5	1	110.000	2
15	F00607	Phenobarbital tab 30 mg - kimia farma	Tab	200	30/09/2025	I31729N	100	10	10	2.000	90
16	F00735	Tekasol ointment cr 10 g - sdm	Tub	40.950	30/09/2025	D000IAI	7	7	5	204.750	34
17	F04623	Tobramycin eye drop 5 ml - ferron	Btl	15.856	30/09/2025	4630910	40	40	20	317.120	22
18	F01400	Foley cath silicon no 8 - rusch	Pcs	222.000	30/10/2025	KMF20I2362	4	4	4	888.000	5
19	F00586	Oxoferin sol 30 ml -	Btl	80.50	30/10/2025	B3K953C	2	2	2	161.000	10

		pharos		0							
20	F020 27	Suction cath no. 8	Pcs	6.045	30/10/20 25	202283 6	13	13	13	78.585	6
21	F013 90	Foley cath no 20 - rusch	Pcs	20.57 0	30/11/20 25	P20L04	10	10	10	205.700	15
Total										26.840.888	

3.2.1.5 Analisis Obat Near ED < 6 bulan (Bulan Mei-November 2025)

Analisis	Tindak Lanjut
Rekap Near ED < 6 bulan (Bulan Mei - November 2025) karena obat dan alkes slow moving : - ETT Cuff No 4.5-WORK, dimasukkan ke dalam trakea untuk memastikan tidak tertutupnya trakea sebagai saluran pernapasan dan udara pernapasan dapat masuk kedalam paru-paru. Faktur pembelian terakhir tanggal 19/07/2024 dari distributor sejumlah 8 pcs, penerimaan alkes dengan ed < 1 tahun dari distributor. - Benang T-Lene 5-0 I17-TRITON, digunakan untuk operasi. Penyimpanan di IKO tidak FEFO sehingga ditemukan barang near ED, faktur pembelian terakhir tanggal 28/09/2021 dari distributor sejumlah 24 pcs. - Vaksin Flubio-BIOFARMA, digunakan untuk melindungi tubuh dari penyakit akibat virus influenza. Faktur pembelian terakhir tanggal 20/03/2025 dari distributor sejumlah 4 vial, penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor. - NTG Inj 1 mg/ml-FERRON, indikasi untuk mengontrol hipertensi dengan cepat selama pembedahan jantung, Menurunkan tekanan darah dan menjaga hipotensi yang terkontrol selama prosedur pembedahan, Mengontrol iskemia miokard selama dan setelah pembedahan, Gagal jantung kongestif yang tidak responsif karena infark miokard akut, Angina tidak stabil yang sulit disembuhkan dengan beta blocker dan nitrat sublingual. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 25/06/2024 dari distributor sejumlah 10 amp. - Oseltamivir Caps 75 mg (hibah dinkes)-INDOFARMA, untuk mengatasi infeksi virus influenza tipe A atau B. Penggunaan obat death moving. Penerimaan obat dari dinas kesehatan tanggal 06/08/2021 sejumlah 700 tablet untuk pengobatan covid-19. - Aminophylline Inj 24 mg/ml-PHAPROS, untuk mengatasi serangan asma bronkial. Pembelian terakhir tanggal 27/11/2024 dari RS Prima Husada Sukorejo sejumlah 30 ampul. Penggunaan obat slow moving tapi termasuk obat emergency. - Ferriprox tab 500 mg-APOTEX INC untuk terapi kelebihan Fe (zat besi) pada pasien talasemia mayor. Faktur pembelian terakhir tanggal 21/02/2021 dari distributor sejumlah 300 tablet. Penggunaan obat death moving karena obat tidak bisa di klaim obat kronis di FKRTL. - Perossal 2x6-DIPA PHARMALAB merupakan material sintetis pengganti tulang yang resorbable, digunakan untuk pengisian atau rekonstruksi tulang pada tulang yang rusak. Faktur pembelian terakhir tanggal 15/01/2025 dari distributor sejumlah 12 pcs, penerimaan alkes dengan ed < 1 tahun dari distributor. - Susuk kb II (Levonorgestrel 75 mg) diberikan untuk kontrasepsi. Penggunaan KB slow moving. Penerimaan hibah dari BKKBN dengan ed < 1 tahun pada tanggal 31/07/2024 sejumlah 16 pcs. - Cotrimoxazole SYR 240 mg/5 ml-MERSI untuk infeksi saluran nafas, kulit, saluran kemih dan kelain, gastrointestinal, infeksi THT. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 04/12/2024 dari distributor sejumlah 30 botol.	- Membuat surat edaran ke DPJP untuk meresepkan obat/ alkes yang near ed. - Koordinasi dengan karu untuk menggunakan alkes yang near ed. - Koordinasi dengan PT. DPM untuk melakukan retur ke distributor. Koordinasi dengan DPJP obat yang <i>death moving</i> di <i>stop order</i> dan dikeluarkan dari Formularium RS. - Sediaan farmasi near ED akan dilakukan koordinasi dengan PHS jika barang lebih berjalan di PHS akan diberikan dan dilakukan koordinasi dengan DPJP untuk peresepan.

11. Cendo Pantocain 2%-CENDO, digunakan untuk anestesi lokal. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 10/07/2023 dari distributor sejumlah 16 flash.
12. Dermavix S IV 6x7cm-ONEMED digunakan untuk plester infus. Penerimaan barang dari RSDH dengan ed < 1 tahun pada tanggal 14/05/2025 sejumlah 25 pcs.
13. Dj Stent 6 Fr Close End-MEDIKA dimasukkan ke dalam ureter untuk mencegah atau menangani penyumbatan aliran urine dari ginjal. Faktur pembelian terakhir tanggal 26/11/2024 dari distributor sejumlah 5 pcs.
14. Foley Cath Silicon No 10-RUSCH, dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Faktur pembelian terakhir tanggal 17/01/2023 dari distributor sejumlah 10 pcs.
15. Phenobarbital tab 30 mg-KIMIA FARMA, digunakan untuk mengobati atau mencegah kejang. Peresepan terakhir tanggal 01/04/2023 penggunaan obat jadi death moving, faktur pembelian terakhir tanggal 16/02/2024 dari distributor sejumlah 100 tab.
16. Tekasol Ointment CR 10 g-SDM, digunakan untuk mengurangi gejala luka keloid pada operasi minor dan mempercepat penyembuhan luka. Penggunaan obat death moving, faktur pembelian terakhir tanggal 16/12/2022 dari distributor sejumlah 78 tube.
17. Tobramycin eye drop 5 ml-FERRON, digunakan untuk mengatasi iritasi mata akibat infeksi bakteri. Faktur pembelian terakhir tanggal 18/02/2025 dari distributor sejumlah 40 botol, penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor.
18. Foley Cath Silicon No 8-RUSCH dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Penggunaan alkes slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 26/03/2024 dari distributor sejumlah 10 pcs.
19. Oxoferin Sol 30 ml-PHAPROS digunakan untuk luka terinfeksi, penyembuhan luka yang lambat sesudah traumatik atau sesudah operasi, ulkus decubitus, ulkus kaki kronis pada insufisiensi vena, ulkus dan luka akibat aliran darah erteri, ulkus diabetic, ganggren, luka bakar. Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 27/02/2024 dari distributor sejumlah 3 botol.
20. Suction Cath No. 8 digunakan untuk pembersih jalan nafas pada saluran sistem pernafasan, dengan cara penyedotan untuk mengeluarkan cairan berlebih khususnya pada daerah oropharyngeal dan nasopharyngeal. Penggunaan alkes slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 24/03/2023 dari distributor sejumlah 10 pcs.
21. Foley Cath Co 20-RUSCH dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine. Faktur pembelian terakhir tanggal 24/09/2024 dari distributor sejumlah 10 pcs. Penerimaan alkes dengan ed < 1 tahun dari distributor.

3.2.1.6 Managemen Resiko dan Aksi Mitigasi

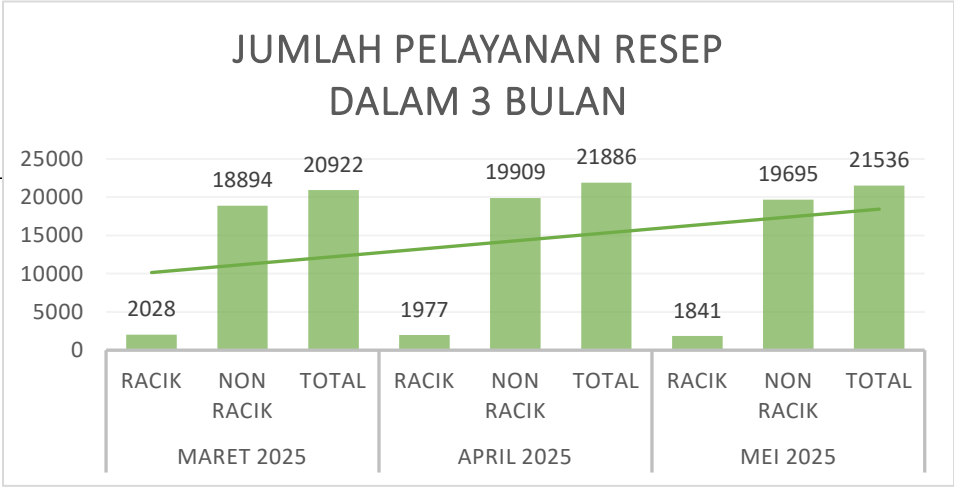
No Risk	Divisi	Spesialis terkait	Pemilik Risk	Tipe Risk	Deskripsi Risk	Pengendalian yang sudah ada	Skor Risk Sebelumnya	Dampak	Kemungkinan	Status Perubahan Rating Risiko	Mitigasi yang sedang dijalankan	Target Penyelesaian	Target Skor Risk	Indikator Kunci Mitigasi	Rencana Review
1	Komite medik	Dokter/ Dokter spesialis	Pasien	Klinis	Kesalahan input e-resep	Kontrol dan supervisi	9	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	SPO penulisan dan input resep serta supervisi	Meninjau ulang setiap tahun terkait kompetensi dokter
2	IFRS	Apoteker/ TTK	Pasien	Klinis	Kesalahan penyiapan obat	Kontrol dan supervisi	14	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi serta pelatihan berkelanjutan	3 bulan - 6 bulan	6	SPO alur pelayanan resep rawat jalan dan resep pulang pasien rawat inap. Jumlah TTK/ apoteker terpenuhi sesuai dengan kebutuhan tenaga. Terdapat diklat dan motivasi kerja	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
3	IFRS	Apoteker/ TTK	Pasien	Klinis	Kesalahan penulisan pada etiket obat	Kontrol dan supervisi	7	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	Motivasi dan kinerja petugas meningkat. SPO penulisan etiket di Instalasi Farmasi	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
4	IFRS	Apoteker/ TTK	Pasien	Klinis	Obat tidak dilengkapi <i>expired date/ beyond use date</i>	Kontrol dan supervisi	7	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	4	Motivasi dan kinerja petugas meningkat. SPO penulisan etiket di Instalasi Farmasi	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
5	IFRS	Apoteker/ TTK	Pasien	Klinis	Kesalahan identifikasi pasien	Kontrol dan supervisi	5	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	2	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas

6	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Kesalahan pemberian obat pada pasien	Kontrol dan supervisi	14	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	SPO telaah obat, SPO verifikasi pemberian obat rawat inap. Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
7	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Insiden kelebihan/ kekurangan penyerahan obat pada pasien rawat jalan	Kontrol dan supervisi	5	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	3	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
8	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Insiden kelebihan/ kekurangan penyerahan obat pada pasien rawat inap	Kontrol dan supervisi	3	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	2	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
9	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Insiden reaksi alergi obat	Kontrol dan supervisi	11	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas
10	IFRS	Apoteker / TTK	Pasien	Klinis	Insiden kesalahan dosis obat	Kontrol dan supervisi	8	Ekstrim	Kemungkinan besar	Turun	Kontrol dan supervisi	3 bulan - 6 bulan	6	Motivasi dan kinerja petugas meningkat	Meninjau ulang kemampuan dan kompetensi petugas

3.2.1.7 Tabel Jumlah Pelayanan Resep pada Bulan Maret - Mei 2025

UNIT	JUMLAH RESEP					
	MARET 2025		APRIL 2025		MEI 2025	
	RACIK	NON RACIK	RACIK	NON RACIK	RACIK	NON RACIK
IRNA	220	8506	207	9245	164	9011
IRJA	1686	7529	1676	7533	1590	7611
IKO	0	919	0	1058	0	1045
IGD	122	1940	94	2073	87	2028
TOTAL	2028	18894	1977	19909	1841	19695
JUMLAH RESEP OBAT	20.922		21.886		21.536	

3.2.1.8 Grafik Jumlah Pelayanan Resep pada Bulan Maret – Mei 2025



Analisis :

Secara keseluruhan total resep pada Bulan Mei 2025 mengalami penurunan namun tidak signifikan, hal ini sebanding dengan penurunan kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan. Penurunan yang tidak signifikan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- 1. Jumlah pasien baru tidak banyak.
- 2. Target PRB rawat jalan juga tetap berjalan, dimana pasien rujuk balik ke FKTP dikarenakan pasien sudah stabil dan retur obat tertinggal rawat jalan yang tidak diambil pasien.
- 3. Penurunan resep rawat jalan tidak signifikan dikarenakan pasien dr Heriyatmo, Sp.PD tetap dikunjungi iterisasi meskipun dokter sedang off selama sebulan.
- 4. Tidak ada promo Poli Sakura dan subsidi PRIMANTARA pada Bulan Mei 2025.
- 5. Terdapat batasan inacbgs sehingga tidak semua obat dapat dicover sesuai kebutuhan pasien dengan pertimbangan biaya obat.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Meningkatkan promosi tarif dan tindakan RS di sosial media RS agar kunjungan pasien meningkat.
- 2. Meningkatkan pelayanan resep yang tepat, cepat, dan akurat sehingga meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan di Farmasi.
- 3. Mengajukan fitur cek hasil laboratorium dalam batas waktu 6 bulan dari IRNA dan IRJA untuk memudahkan pemberian obat sesuai dengan retriksi yang ditentukan.
- 4. Menciptakan inovasi pengembangan pelayanan pengantaran obat dengan penambahan jumlah driver.
- 5. Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan. Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru dan obat tertinggal.

6. Perubahan alur distribusi obat, petugas melebur menjadi satu. Penambahan petugas shift malam supaya tidak terjadi lembur menyelesaikan obat rawat jalan.
7. Penambahan admin IKO untuk focus pada mutase barang di Floorstok IKO.

3.2.1.9 Tabel Hasil Kinerja Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Bulan Maret - Mei 2025

No	Kegiatan	Standard	Pencapaian			Keterangan
			Maret 2025	April 2025	Mei 2025	
1.	Pengkajian Resep	100%	99.14%	98.83%	98.86%	Jumlah pengkajian resep, yaitu Januari 2025 = 22.046 Februari 2025 = 20.361 Maret 2025 = 20.922 April 2025 = 21.886 Mei 2025 = 21.536 Jumlah ketidاكلengkapan penulisan resep, yaitu Januari 2025 = 128 Februari 2025 = 168 Maret 2025 = 180 April 2025 = 255 Mei 2025 = 246
2.	Dispensing sediaan steril	100%	100%	100%	100%	Dispensing sediaan steril dilakukan oleh apoteker di Ruang Pencampuran Obat Steril (LAF).
3.	Pemantauan Terapi Obat (PTO)	100%	100%	100%	100%	Form PTO sudah terlaksana dimana apoteker melakukan seleksi pasien berdasarkan kriteria PTO. Form PTO diletakkan dalam RM.
4.	Kejadian Efek Samping Obat	0	0	0	0	Tidak ditemukan pelaporan efek samping obat pada Bulan April 2025.
5.	Edukasi Obat pada pasien dan keluarga	100%	100%	100%		Data berdasarkan rekam medis dan resep obat yang ditandatangani oleh penerima obat.
6.	Konseling	100%	100%	100%	100%	Konseling sudah dilakukan apoteker dibuktikan dengan bukti edukasi di Lembar Edukasi (pasien rawat inap) dan tanda-tangan penerima obat di resep (pasien rawat jalan).
7.	Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah	TDD	TDD	TDD	TDD	Tidak punya alat untuk pemantauan kadar obat dalam darah. TTD RS tipe C tidak wajib.
8.	Visite Ronde Besar	100%	0.08%	0%	0%	Koordinasi dengan PPA (Professional Pemberi Asuhan) agar dilakukan visite ronde besar. Dilakukan pada hari Kamis, 27-03-2025 dengan dr Adhya Aji, Sp.PD.
9.	Visite Pasien/ Farmasi Klinik	100%	100%	100%	100%	Seluruh pasien rawat inap dilakukan visite mandiri dibuktikan dengan pengisian CPPT oleh Apoteker di RM.
10.	Pelayanan	100%	100%	100%	100%	Data berdasarkan map informasi

	Informasi Obat (PIO)					obat, MIMS, aplikasi Medscape.
11.	Obat tidak bertuan	0	3.801	5.718	1.496	Ditemukan retur obat tidak bertuan dilakukan penyesuaian saat stok opname
12.	Obat tertinggal yang tidak diambil pasien	0	34	30	42	Obat tertinggal yang tidak diambil pasien dilakukan Penerimaan Hibah Lainnya ke gudang retur, sudah tidak ada subsidi pengantaran obat gratis.
13.	Penempelan label obat rawat inap	100%	100%	100%	100%	Tidak ada laporan penempelan label obat rawat inap yang tidak ada dan tidak ada laporan IKP kejadian kesalahan penulisan etiket obat.

3.2.1.10 **Tabel Analisa dan Tindaklanjut Hasil Kinerja Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada pada Bulan Mei 2025**

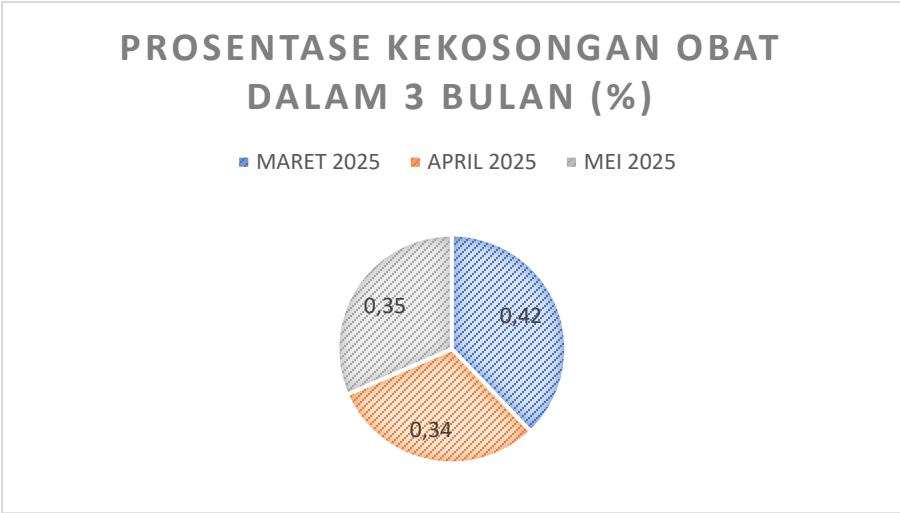
Kinerja	Analisa	Tindaklanjut
Pengkajian Resep	Penulisan resep yang lengkap bulan Mei 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan April 2025, dengan prosentase resep yang tidak lengkap yaitu : bulan April 2025 sebanyak 98.83% dan bulan Mei 2025 sebanyak 98.86%. Dari data di atas ditemukan pengkajian resep : - Dari segi telaah adminitrasi : sudah lengkap karena menggunakan e-resep melalui SIMRS. - Dari segi telaah farmasetik : masih ditemukan dokter salah input dosis dan jumlah obat, aturan dan cara penggunaan serta rute pemberian tidak lengkap terisi. - Dari segi telaah klinis : sudah terlaksana oleh Apoteker karena jika ada interaksi obat langsung diberi jeda pemberian obat oleh Apoteker.	- Koordinasi dengan tim SIMRS untuk membuat sistem jika resep tidak terinput dengan lengkap maka resep tidak dapat masuk ke IFRS. - Inputan resep harus dilakukan oleh dokter/ dokter spesialis yang kompeten dan berwenang mulai dari identitas pasien, nama obat, dosis, rute pemberian, waktu pemberian, nama dan tandatangan dokter (untuk resep manual). - Pelatihan penulisan resep untuk semua dokter dan dokter spesialis.
Kejadian Efek Samping Obat	- Hasil monitoring pelaporan MESO bulan April 2025 tidak ditemukan terjadinya efek samping obat. - Kurangnya pelaporan kejadian efek samping obat oleh tenaga kesehatan.	- Kolaborasi dengan komite medik, kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis untuk sosialisasi pentingnya pelaporan kejadian efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD oleh tenaga kesehatan. - Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) dilaksanakan secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ditulis di dalam dokumen rekam medik pasien dan dilaporkan selambat - lambatnya 1 x 24 jam dalam bentuk laporan MESO dan dicatat dalam status pasien. - Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki (ESO). - Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO. - Menganalisa laporan ESO. - Mengisi formulir ESO (lihat di lembar pelaporan ESO). - Melaporkan ke Tim MESO dan ROTD.
Edukasi Obat Pada Pasien dan Keluarga	- Hasil supervisi dari rekam medis di rawat inap pada form edukasi bahwa apoteker sudah melakukan edukasi dibuktikan dengan ttd pasien/ keluarga di form edukasi. - Hasil supervisi dirawat jalan petugas farmasi sudah melakukan edukasi ke pasien dibuktikan dengan ttd penerima obat beserta KIE.	Supervisi berjenjang terkait pelaksanaan edukasi obat di rawat inap dan rawat jalan.
Pelayanan Informasi Obat (PIO)	PPA dapat mengakses Map informasi obat berisi : daftar dosis maksimal prorenata (jika perlu), daftar obat automatic stop order, daftar obat high alert update, daftar obat resiko jatuh, informasi cara pengenceran obat, informasi pembatasan resep, tabel rekonstitusi untuk pemberian intravena; MIMS; aplikasi Medscape di Nurse Station atau di Poli.	Map informasi obat, MIMS, aplikasi Medscape sudah tersedia di unit pelayanan

Obat Tidak Bertuan	- Retur obat tidak bertujuan dikarenakan proses retur yang tidak optimal dari rawat inap dan rawat jalan (perawat tidak input retur disistem). - Obat di retur ke depo farmasi tanpa etiket sehingga farmasi kesulitan tracking obat tidak beretiket. - Retur obat dan alkes di Floorstok IKO yang belum terinput di SIMRS.	- Obat tidak layak dimusnahkan dengan berita acara pemusnahan. - Obat layak di retur ke gudang retur farmasi dengan berita acara obat/ alkes tidak bertujuan yang sudah di tandatangani oleh Direktur RS, kemudian keuangan PT memberikan persetujuan akhir dan dilakukan Penerimaan Farmasi Lain di SIMRS. - Pembuatan fitur khusus untuk obat tidak bertujuan dan pengembangan fitur approval berjenjang. - Peningkatan akurasi manajemen stok obat.
Obat Tertinggal Yang Tidak Diambil Pasien	Data obat tertinggal yang tidak diambil pasien bulan Mei 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan April 2025, dengan total resep yang di retur yaitu bulan April 2025 sebanyak 30 dan bulan Mei 2025 sebanyak 42. Hal ini disebabkan beberapa pasien tidak mengetahui mendapatkan resep sehingga obat ditinggal dalam waktu 3x24 jam dan keterlambatan penyiapan obat sehingga waktu tunggu obat lama.	Menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal.

3.2.1.11 Tabel Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Maret - Mei 2025

No	Tanggal	Nama Obat	Golongan Obat	Distributor	Tindak Lanjut
MARET 2025					
1.	1/3/2025-31/3/2025	Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
2.	1/3/2025-31/3/2025	Quetvell tab 200 mg	Anti psikosis	PT. Antar Mitra Sembada	Soroquin tab 200 mg
3.	1/3/2025-31/3/2025	Methylergometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Substitusi dengan Bledstop tab 0,125 mg
4.	1/3/2025-31/3/2025	Itraconazole caps 100 mg	Anti fungi	PT. Tri Sapta Jaya	Tanpa saran substitusi
5.	1/3/2025-31/3/2025	Haloperidol tab 5 mg - Yarindo	Anti psikosis	PT. Parit Padang Global PT. Kebayoran Pharma	Substitusi ke Haloperidol tab 0.5 mg
Total prosentase Januari 2025 = 0.42%					
APRIL 2025					
1.	1/4/2025-31/4/2025	Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
2.	1/4/2025-31/4/2025	Quetvell tab 200 mg	Anti psikosis	PT. Antar Mitra Sembada	Soroquin tab 200 mg
3.	1/4/2025-31/4/2025	Methylergometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Substitusi dengan Bledstop tab 0,125 mg
4.	1/4/2025-31/4/2025	Itraconazole caps 100 mg	Anti fungi	PT. Tri Sapta Jaya	Tanpa saran substitusi
Total Prosentase Februari 2025 = 0.34%					
MEI 2025					
1.	1/5/2025-31/5/2025	Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg	Diuretik	PT. Kimia Farma	Tanpa saran substitusi
2.	1/5/2025-31/5/2025	Methylergometrin tab 0,125 mg	Oksitosik	PT. Kimia Farma	Substitusi dengan Bledstop tab 0,125 mg
3.	1/5/2025-31/5/2025	Itraconazole caps 100 mg	Anti fungi	PT. Tri Sapta Jaya	Tanpa saran substitusi
4.	1/5/2025-15/5/2025	Ketoprofen tab 100 mg	Analgesik	PT. Antar Mitra Sembada	Tanpa saran substitusi
Total prosentase Maret 2025 = 0.35%					

3.2.1.12 Grafik Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Maret - Mei 2025



Analisis :

- 1. Hasil monitoring ketersediaan obat selama 3 bulan ditemukan masih sering terjadi kekosongan di distributor karena kekurangan bahan baku, delisting produk (pabrik tidak produksi), stok di distributor habis, kekosongan produk originator seperti Hydrochlorothiazide (HCT) tab 25 mg dan Itraconazole caps 100 mg sehingga tidak tersedia di pabrik lain dengan kandungan yang sama.
- 2. RS belum bisa melakukan pembelian lewat e-purchasing sehingga belum bisa order obat fast moving khusus obat kronis.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Evaluasi mutu perjanjian kerjasama dengan distributor untuk memberikan konfirmasi apabila stok barang tidak tersedia di distributor setelah menerima pesanan dari RS.
- 2. Mencari substitusi obat lain yang isi/ kandungannya sama.
- 3. Evaluasi stok minimal depo farmasi dan Gudang farmasi serta alur pengadaan.
- 4. RS sudah mempunyai akun e-purchasing dan koordinasi dengan pengadaan terkait e-purchasing.
- 5. Memberitahukan info kekosongan obat di distributor ke DPJP melalui surat edaran beserta saran substitusi.

3.2.1.13 Tabel Pemusnahan Obat, BMHP/ Alat Kesehatan Rusak (Substandar), dan Recall Bulan Mei 2025

No	Kegiatan	Nama Obat/ BMHP/ Alat Kesehatan	Jumlah	Alasan	Keterangan
1.	Pemusnahan	-		-	Tidak ada pemusnahan obat
2.	BMHP/Alat Kesehatan Rusak (Substandar)	IV Canulla no. 20 - Hospitech	Semua yang terpakai	Pada nylon jarum bocor	Form keluhan alat kesehatan substandard dari ruang 3C dilaporkan tanggal 16/05/2025 sudah diajukan ke Pengadaan PT. Penjadwalan oleh vendor pada awal Bulan Juni 2025.
3.	Recall	-	-	-	Tidak ada recall

3.2.1.14 Tabel Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Farmasi Pada Bulan Mei 2025

No	Monitoring dan Evaluasi	Hasil	Tindak Lanjut															
1.	Perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP	Perencanaan dilakukan dengan metode konsumsi dan rumus VEN-ABC. Evaluasi terhadap perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP digudang farmasi menggunakan sistem ROP dan Non ROP farmasi di SIMRS, dikarenakan sistem ROP belum mendeteksi penjualan obat slow moving namun tetap harus disediakan jadi petugas mendata obat menipis secara manual kemudian diinput Non ROP farmasi	Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP menggunakan sistem ROP di gudang farmasi.															
2.	Pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP ke distributor	Pengadaan sediaan farmasi dan BMHP dengan pembelian langsung, repacking dan donasi/hibah. Tersedia PKS dengan distributor; Semua pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, termasuk obat vaksin harus menjamin garansi keaslian yakni : a. Sediaan farmasi - No.Ijin Edar dari BPOM b. Alkes - No.Ijin Edar dari Dirjen Binfar dan CoA c. BMHP - No ijin edar dari Binfar d. B3 - MSDS; Kunjungan ke distributor; Surat Pesanan obat, alkes, dan BMHP di tandatangan oleh APJ	Monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP															
3.	Pemantauan suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin	Form monitoring suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin sudah tersedia namun petugas masih tidak rutin mengisi.	Monitoring dan evaluasi pengisian monitoring suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin di depo dan gudang farmasi oleh apoteker setiap hari.															
4.	Supervisi box emergency, trolley emergency, kit emergency, box HPP dan Eklamsi	Pengecekan obat yang mendekati ED (<i>expired date</i>) 6 bulan segera diganti dilakukan tiap 3 bulan sekali. Bedah box triwulan 2 pada Bulan April Tahun 2025 sudah dilakukan. Berikut temuan obat yang mendekati ED 6 bulan dan diganti dengan ED jauh yaitu : <table><tr><th>No</th><th>Temuan obat near ED < 6 bulan</th><th>Pergantian obat near ED</th></tr><tr><td>1.</td><td>Box emergency poli lantai 1: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dopamin inj 9/25, Furosemid inj 9/25, Infus D5% 9/25, Phenytoin inj 11/25.</td><td>Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dopamin inj 9/26, Furosemid inj 11/26, Infus D5% 11/26, Phenytoin inj 1/28.</td></tr><tr><td>2.</td><td>Box emergency poli treadmill: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dopamin inj 9/25, Furosemid inj 9/25, Infus D5% 9/25, Gelafusal 9/25.</td><td>Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dopamin inj 9/26, Furosemid inj 11/26, Infus D5% 11/26, Gelafusal 4/27.</td></tr><tr><td>3.</td><td>Box emergency poli lantai 2: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dopamin inj 9/25, Furosemid inj 9/25, Infus D5% 9/25, Phenytoin inj 11/25.</td><td>Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dopamin inj 9/26, Furosemid inj 11/26, Infus D5% 11/26, Phenytoin inj 1/28.</td></tr><tr><td>4.</td><td>Box emergency poli vaksin: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dexamethason inj 8/25, Dopamin inj 9/25, Epinephrin inj 8/25, Infus D5% 9/25,</td><td>Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dexamethason inj 6/26, Dopamin inj 9/26, Epinephrin inj 11/27, Infus D5% 11/26,</td></tr></table>	No	Temuan obat near ED < 6 bulan	Pergantian obat near ED	1.	Box emergency poli lantai 1: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dopamin inj 9/25, Furosemid inj 9/25, Infus D5% 9/25, Phenytoin inj 11/25.	Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dopamin inj 9/26, Furosemid inj 11/26, Infus D5% 11/26, Phenytoin inj 1/28.	2.	Box emergency poli treadmill: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dopamin inj 9/25, Furosemid inj 9/25, Infus D5% 9/25, Gelafusal 9/25.	Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dopamin inj 9/26, Furosemid inj 11/26, Infus D5% 11/26, Gelafusal 4/27.	3.	Box emergency poli lantai 2: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dopamin inj 9/25, Furosemid inj 9/25, Infus D5% 9/25, Phenytoin inj 11/25.	Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dopamin inj 9/26, Furosemid inj 11/26, Infus D5% 11/26, Phenytoin inj 1/28.	4.	Box emergency poli vaksin: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dexamethason inj 8/25, Dopamin inj 9/25, Epinephrin inj 8/25, Infus D5% 9/25,	Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dexamethason inj 6/26, Dopamin inj 9/26, Epinephrin inj 11/27, Infus D5% 11/26,	Dilakukan supervisi oleh apoteker terhadap penyimpanan obat <i>emergency</i> dan segera diganti apabila dipakai, kedaluwarsa, atau rusak. Pelaksanaan supervisi dilakukan sebagai berikut : a. Pengecekan segel, pengecekan kedaluwarsa di list daftar obat dan pengecekan suhu penyimpanan dilakukan setiap hari. b. Pengecekan jumlah dan dipakai dilakukan saat segel terbuka. c. Pengecekan obat yang mendekati ED (<i>expired date</i>) 6 bulan segera diganti dilakukan tiap 3 bulan sekali untuk mencegah kedaluwarsa saat dibutuhkan.
No	Temuan obat near ED < 6 bulan	Pergantian obat near ED																
1.	Box emergency poli lantai 1: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dopamin inj 9/25, Furosemid inj 9/25, Infus D5% 9/25, Phenytoin inj 11/25.	Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dopamin inj 9/26, Furosemid inj 11/26, Infus D5% 11/26, Phenytoin inj 1/28.																
2.	Box emergency poli treadmill: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dopamin inj 9/25, Furosemid inj 9/25, Infus D5% 9/25, Gelafusal 9/25.	Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dopamin inj 9/26, Furosemid inj 11/26, Infus D5% 11/26, Gelafusal 4/27.																
3.	Box emergency poli lantai 2: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dopamin inj 9/25, Furosemid inj 9/25, Infus D5% 9/25, Phenytoin inj 11/25.	Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dopamin inj 9/26, Furosemid inj 11/26, Infus D5% 11/26, Phenytoin inj 1/28.																
4.	Box emergency poli vaksin: Aminophyllin inj 8/25, Amiodaron inj 9/25, Dexamethason inj 8/25, Dopamin inj 9/25, Epinephrin inj 8/25, Infus D5% 9/25,	Aminophyllin inj 2/26, Amiodaron inj 8/26, Dexamethason inj 6/26, Dopamin inj 9/26, Epinephrin inj 11/27, Infus D5% 11/26,																

			Infus Manitol 8/25, Valisanbe inj 12/25.	Infus Manitol 1/26, Valisanbe inj 7/26.	
	5.	Trolley emergency IGD:			
		Aminophillylin inj 8/25, Inzana tab 9/25, Dexametason inj 12/25, Dopamin inj 8/25, Epinephrin inj 8/25, Furosemid inj 9/26, Infus D5% 8/25, Valisanbe inj 10/26.		Aminophillylin inj 2/26, Inzana tab 1/27, Dexametason inj 6/26, Dopamin inj 12/26, Epinephrin inj 11/27, Furosemid inj 11/26, Infus D5% 8/26, Valisanbe inj 10/26.	
	6.	Box emergency infant Ponek IGD:			
		Aminophyllin inj 9/25, Dexamethason inj 8/25, Diazepam Rectal 8/25, Dobutamin inj 8/25, Epinephrin inj 8/25, Suction cath no. 8 10/25.		Aminophyllin inj 9/28, Dexamethason inj 6/26), Diazepam Rectal 8/26, Dobutamin inj 12/26, Epinephrin inj 11/27, Suction cath no. 8 12/28.	
	7.	Box HPP – Eklamsi IGD:			
		Eklampsi set : Infus RL 8/26, IV cannul no. 18 3/28. BE HPP SET : Infus RL 8/26, iv canul no. 18 9/28		Eklampsi set : Infus RL 8/26, IV cannul no. 18 3/28. BE HPP set : Infus RL 8/26, iv canul no. 18 9/28	
	8.	Kit emergency IGD 1:			
		Lidocain inj 9/25, Spuit 3 cc 12/25.		Lidocain inj 12/28, Spuit 3 cc 6/29.	
	9.	Kit emergency IGD 2:			
		Tidak ada obat near ED -			
	10.	Box emergency ambulance:			
		Aminophillyne 8/25, Dobutamin inj 8/25, Dopamin inj 8/25, Infus D5% 8/26, Na-Phenytoin inj 1/28, Spuit 10 cc 9/29.		Aminophillyne 2/26, Dobutamin inj 12/26, Dopamin inj 12/26, Infus D5% 8/26, Na-Phenytoin inj 1/28, Spuit 10 cc 9/29.	
	11.	Trolley emergency IKO:			
		Infus D5% 1/26, Infus Gelafusal 8/25, Mannitol 1/26, IV 20 7/26, Amiodaron 2/26, Dopamin 10/25, Valisanbe 8/25, Inzana 11/25, Clopidogrel 3/26, Aminophillin 8/25, Dexametasone 3/26.		Infus D5% 6/26, Infus Gelafusal 4/27, Mannitol 4/26, IV 20 9/29, Amiodaron 1/27, Dopamin 12/26, Valisanbe 10/26, Inzana 02/27, Clopidogrel 12/26, Aminophillin 02/26, Dexametasone 2/27.	
	12.	Box emergency infant IKO:			
		Infus Gelafusal 10/25, Infus D10% 12/25, IV 24 11/25, Aminofilin 8/25, Dopamine 10/25, Spuit 1cc Terumo 8/25, Spuit 3cc Terumo 11/25, Spuit 5cc Terumo 3/26, Spuit 10cc Terumo 9/25		Infus gelafusal 4/27, Infus D10% 12/26, IV cannul no. 24 6/28, Aminophillin 2/26, Dexamethasone 2/27, Dopamine 12/26, Spuit 1 cc Terumo 5/29, Spuit 3 cc Terumo 9/29, Spuit 5 cc Terumo 8/29, Spuit 10 cc Terumo 9/29	
	13.	Box HPP-Eklampsi IKO:			
		Tidak ada obat near ED -			
	14.	Box emergency 2C:			
		Mannitol 1/26, Clopidogrel 2/26, Aminophillin 8/25, Phenytoin 1/26, Spuit 1 cc-Terumo 8/25		Mannitol 6/26, Clopidogrel 6/26, Aminophilli 2/26, Phenytoin 1/28, Spuit 1 cc 6/26	
	15.	Box emergency ICU:			
		Mannitol 1/26, Aminophillin 8/25		Mannitol 6/26, Aminophillin 2/26	
	16.	Box emergency ICU ventilator:			
		Tidak ada obat near ED -			
	17.	Box emergency HCU:			
		Aminophillin 8/25, Valisanbe injeksi 12/25, Phenytoin 1/26		Aminophillin 2/26, Valisanbe injeksi 11/26, Phenytoin 1/28	
	18.	Box emergency 3C anak:			
		Aminophillin 8/25, Aspilet 11/25,		Aminophillin 2/26, Aspilet 02/27,	

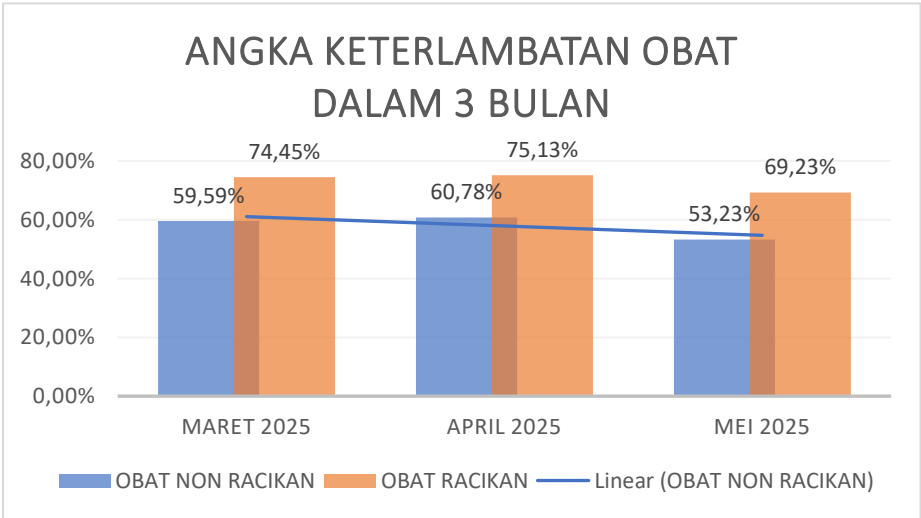
			Clopidogrel 01/26, Dobutamin 1/26, Dopamin 2/26, Mannitol 1/26, Na. Phenytoin 07/26, Furosemide 6/26, Valisanbe injeksi 1/26, Dexametasone 6/26	Clopidogrel 12/26, Dobutamin 01/26, Dopamin 09/26, Mannitol 01/26, Na. Phenytoin 01/28, Furosemide 11/26, Valisanbe Injeksi 10/26, Dexametasone 02/27	
		19.	Box emergency PICU Ventilator:		
			Amiodarone 5/26, Dopamin 2/26, Dexamethasone 2/26	Amiodarone 1/27, Dopamin 12/26, Dexamethasone 2/27	
		20.	Box emergency PICU:		
			Asam tranexamat 6/26, Amiodarone 5/26, Furosemide 5/26, Dexamethasone 6/26, Valisanbe 7/26, Infus D10 5/26	Asam tranexamat 12/26, Amiodarone 1/27, Furosemide 11/26, Dexamethasone 2/27, Valisanbe 10/26, Infus D10 12/26	
		21.	Box emergency 2A:		
			Aminophillin 2/26, Valisanbe injeksi 1/26, Aspilet 6/26, Clopidogrel 6/26	Aminophillin 2/26, Valisanbe injeksi 1/26, Aspilet 6/26, Clopidogrel 12/26	
		22.	Box emergency 3A:		
			Aminophillin 8/25, Amiodaron 6/26, Aspilet 11/25, Dexametasone 6/26, Mannitol 1/26, Valisanbe 10/25, Furosemide 6/26, Dopamine 2/26	Aminophillin 2/26, Amiodaron 1/27, Inzana 2/27, Dexametasone 2/27, Mannitol 6/26, Valisanbe 10/26, Furosemide 12/26, Dopamine 12/26	
		23.	Box emergency 4A:		
			Aminophillin 11/25, Amiodaron 6 /25, Aspilet 1/26	Aminophillin 2/26, Amiodaron 1/27, Aspilet 2/27	
		24.	Box emergency infant Maternitas:		
			Aminophillin 8/25, Dexametasone 10/25, Diazepam 9/25 Dopamin 9/25, Sduit 1cc 12/25, Suction Catheter 8 12/25	Aminophillin 2/26 Dexametasone 2/27 Diazepam 8/26 Dopamin 01/28 Sduit 1cc 02/28 Suction Catheter 8 05/29	
		25.	Trolley emergency Maternitas:		
			Infus D5 9/25, Sduit 5 cc terumo 12/25, Sduit 1 cc terumo 8/25, Aminophillin 8/25, Amiodaron 8/25, Miniaspi 11/25, Dexametasone 10/25, Dopamin 9/25, Na. Phenytoin 7/25, Valisanbe injeksi 12/25, Infus RL 8/25, Iv canule18 10/25, NS 0,9 % 6/25, Misoprostol 11/25	Infus D5 11/26, Sduit 5 cc terumo 09/29, Sduit 1 cc terumo 12/29, Aminophillin 02/26, Amiodaron 8/26, Miniaspi 07/26, Dexametasone 02/27, Dopamin 02/27, Na. Phenytoin 01/28, Valisanbe injeksi 11/26, Infus RL 8/26, Iv canule18 03/26, NS 0,9 % 1/27, Misoprostol 08/26	
		26.	Box emergency infant Perinatologi:		
			Aminophillin 8/25, Dexmetasone 6/25, Diazepam rectal 9/25, Dobutamin 7/25, Dopamin 9/25, Infus Gelafusal 6/25, Natrium Phenytoin 8/25, Suction Catheter 10/25	Aminophillin 02/26, Dexmetasone 2/27, Diazepam rectal 9/27, Dobutamin 12/26, Dopamin 09/26, Infus Gelafusal 2/26, Natrium Phenytoin 7/26, Suction Catheter 2/28	
		27.	Box emergency 5C:		
			Aminophillin 8/25 Dexametasone 6/26 Furosemide 6/26 Valisanbe 12/25	Aminophillin 2/26 Dexametasone 2/27 Furosemide 11/26 Valisanbe 10/26	
		28.	Box emergency 6A:		
			Aminophillin 11/25 Amiodaron 6 /25 Aspilet 1/26	Aminophillin 2/26 Amiodaron 1/27 Aspilet 2/27	

		29. Box emergency 7A: Aminophillin 11/25Aminophillin 2/26Amiodaron 6 /25Amiodaron 1/27Aspilet 1/26Aspilet 2/27 30. Box emergency 8A: Aminophillin 8/25Aminophillin 2/26Amiodaron 6/26Amiodaron 1/27Aspilet 11/25Inzana 2/27Dexametasone 6/26Dexametasone 2/27Mannitol 1/26Mannitol 6/26Valisanbe 10/25Valisanbe 10/26Furosemide 6/26Furosemide 12/26Dopamine 2/26Dopamine 12/26 31. Box emergency Radiologi: Aminophillin 8/25Aminophillin 2/26	
5.	Kartu stok obat	Kepatuhan penulisan kartu stok 70% di depo farmasi, petugas masih merapel pengeluaran kartu stok dan belum menulis sisa stok. Kepatuhan penulisan kartu stok 100% di gudang farmasi.	1. Supervisi petugas farmasi dalam melakukan pelayanan (barang masuk dan keluar) dengan tetap menuliskan pada kartu stok 2. Petugas lebih teliti ketika menghitung pemasukan atau pengeluaran.
6.	Penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3)	Penyimpanan bahan berbahaya dan beracun di ruangan terpisah dan didalam lemari B3 tersedia APAR dan diberi label B3 sesuai sifat dan risiko bahan.	Monitoring dan evaluasi terhadap penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3).
7.	Penyimpanan produk steril di unit	Ditemukan perawat anestesi IKO melakukan sharing dose KTM inj dan sisanya digunakan kembali besok hari (lebih dari 1x24 jam) sehingga melewati batas BUD.	Supervisi secara berkala dan edukasi ke perawat BUD produk steril tidak boleh lebih dari 3 jam.
8.	Pelaksanaan double check untuk pemberian obat high alert	Bulan Mei 2025 menggunakan sistem distribusi ODD (<i>One Daily Dose</i>). Serah terima obat menggunakan resep dan daftar pemberian obat (DPO) antar farmasi dan perawat. Double check dilakukan oleh farmasi sebelum distribusi obat.	Supervisi berkala. Evaluasi ODD setiap hari.

3.2.1.15 Tabel Angka Keterlambatan Obat Jadi dan Racikan Bulan Maret - Mei 2025

INDIKATOR	BULAN		
	MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025
Penyiapan Obat Jadi Rawat Jalan > 30 menit	59.59%	60.78%	53.23%
Penyiapan Obat Racikan > 60 menit	74.45%	75.13%	69.23%

3.2.1.16 Grafik Angka Keterlambatan Obat Jadi dan Racikan Bulan Maret – Mei 2025



Analisis :

Waktu tunggu obat rawat jalan pada Bulan Mei Tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan April 2025. Namun prosentasi tersebut masih jauh dari target (0%) dikarenakan libur tanggal merah dan poli tutup sehingga menyebabkan penumpukan kunjungan pasien pada saat hari aktif, kunjungan pasien yang tidak dibatasi sehingga terjadi penumpukan resep di jam-jam tertentu.

Rencana Tindak Lanjut:

- 1. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi dalam klik obat selesai maupun ambil obat, sehingga petugas farmasi diharapkan *real time* dalam pelaksanaannya.
- 2. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terkait alur pemberian obat kepada pasien, bahwa harus dihindari terjadi penumpukan obat yang telah siap diberikan.
- 3. Terdapat program pengantaran obat melalui Primantara sehingga mengurangi antrian pasien menunggu obat.
- 4. Petugas input dibagi menjadi resep kronis dan resep non kronis oleh TTK, resep iter dan PRB oleh Apoteker.
- 5. Terdapat perubahan jadwal penyiapan obat rawat onap, dimana penyiapan dilakukan pada malam hari saat tidak ada pelayanan rawat jalan.

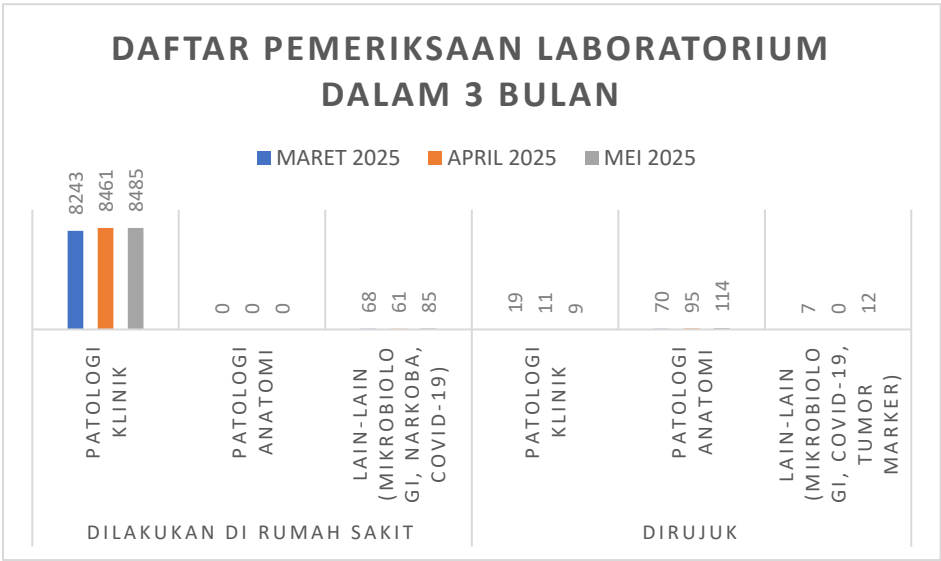
5.2.1 Laboratorium

5.2.1.11Tabel Daftar Pemeriksaan Laboratorium yang Dilakukan Didalam dan Diluar Maret - Mei 2025

No	Jenis Pemeriksaan	Bulan		
		Maret 2025	April 2025	Mei 2025
Dilakukan di Rumah Sakit				
1.	Patologi Klinik			
	Kimia darah	4789	4899	4911
	Hematologi	2583	2731	2714
	Serologi dan Molekuler	508	592	602
	Urine	355	231	253
	Liquor	-	-	-
	Transudat/Eksudat	-	-	-
	Feses	8	8	5
Total		8243	8461	8485
2.	Patologi Anatomi			
	Pemeriksaan Sitologi	0	0	0
	Pemeriksaan Histopatologi	0	0	0
Total		0	0	0
3.	Lain-lain			
	Bakteriologi/Mikrobiologi	30	34	40
	Narkoba	35	26	45
	Covid-19	3	1	0
Total		68	61	85
Dilakukan di Luar Rumah Sakit (Dirujuk)				
1.	Patologi Klinik			
	Kimia darah	2	3	0
	Hematologi	0	4	1
	Serologi dan Molekuler	16	4	8
	Urine	1	0	0
	Liquor	-	-	-
	Transudat/Eksudat	-	-	-
	Feses	0	0	0
Total		19	11	9
2.	Patologi Anatomi			
	Pemeriksaan Sitologi	14	11	15
	Pemeriksaan Histopatologi	56	84	99
Total		70	95	114
3.	Lain-lain			
	Bakteriologi/Mikrobiologi	7	0	10
	PCR	0	0	0

Tumor Marker	0	0	2
Cholinesterase	0	0	0
Total	7	0	12

5.2.1.12 Grafik Pemeriksaan Didalam Rumah Sakit Bulan Maret - Mei 2025



Analisis :

- Permintaan pemeriksaan laboratorium pada Bulan Mei 2025 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 8485 pemeriksaan. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kunjungan laboratorium, salah satunya adalah kunjungan pasien MCU.
- Angka rujukan pemeriksaan patologi anatomi di Laboratorium luar masih mendominasi diantara pemeriksaan lainnya dalam 3 bulan terakhir, yaitu :
 - Patologi Anatomi = 279 sampel
 - Patologi Klinik = 39 sampel
 - Lain-lain = 19 sampel
- Angka rujukan pemeriksaan patologi anatomi pada dalam 3 bulan terakhir mencapai 279 pemeriksaan. Hal ini disebabkan karena Rumah Sakit belum memiliki Laboratorium Patologi Anatomi, ditunjang dengan meningkatnya jumlah tindakan excise yang membutuhkan pemeriksaan penunjang (PA) untuk kebutuhan klaim.
- Hasil pemeriksaan PA masih mengalami keterlambatan, hal ini disebabkan karena adanya tindakan potong ulang dari hasil yang mengarah atau curiga keganasan dan 3 tanggal merah hari besar pada Bulan Mei 2025.
- Masih ditemukan pemeriksaan patologi klinik yang dirujuk pada Bulan Mei 2025 sebesar 9 pemeriksaan, yaitu antara lain pemeriksaan ANA Test, Serum Iron, TIBC, HB Elektroforesis, Alkali Fosfatase, Hbs Ag (ELISA), VDRL.
Rumah Sakit tidak melakukan pengadaan alat dan reagen karena permintaan hanya sedikit.

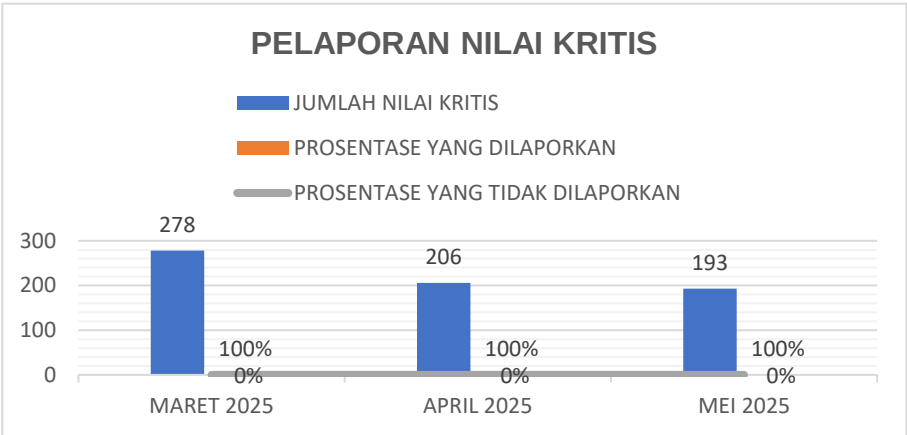
Rencana Tindak Lanjut :

- Proses pengembangan pelayanan dengan menggunakan LIS.
- Perbaikan serah terima hasil laboratorium menggunakan system digital.
- Melakukan pencatatan keluar masuk stok reagen pada kartu stok dan dilakukan SO.
- Follow up pengadaan reagen yang lama kosong.
- Mengajukan pengadaan Laboratorium PA di RS Prima Husada Malang.
- Membuat kesepakatan batas akhir bacaan hasil PA dan follow up secara berkala kepada Dokter Penanggungjawab Patologi Anatomi.
- Mengajukan review tarif pemeriksaan laboratorium kepada Kepala Keuangan PT.

5.2.1.13 Pelaporan Nilai Kritis Maret - Mei 2025

NO	BULAN	JUMLAH NILAI KRITIS	PROSENTASE YANG DILAPORKAN	PROSENTASE YANG TIDAK DILAPORKAN
1.	Maret 2025	278	100%	0%
2.	April 2025	206	100%	0%
3.	Mei 2025	193	100%	0%

5.2.1.14 Grafik Pelaporan Nilai Kritis Maret - Mei 2025



Analisis :

- 1. Pelaporan nilai kritis pada Bulan Maret 2025 sudah mencapai 100%.
- 2. Petugas sudah disiplin dalam melakukan dokumentasi pelaporan nilai kritis.
- 3. Tidak ada complain yang masuk karena keterlambatan pelaporan nilai kritis ke unit.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Supervisi berkala dilakukan oleh Karu dan Kabid Penunjang Medis
- 2. Kolaborasi dengan Kabid Keperawatan dan Kabid Pelayanan Medis terkait pelaporan complain DPJP terhadap keterlambatan pelaporan nilai kritis.
- 3. Kolaborasi dengan SDM terkait kedisiplinan petugas dalam melakukan pekerjaan.
- 4. Pertahankan kinerja yang sudah baik.

4.1.1.5 Tabel Pelaporan Kerusakan Sampel pada Bulan Maret - Mei 2025

No	Nama pasien	No RM	Tanggal Pengambilan sampel	Unit Asal	Sampel yang diterima
Bulan Maret 2025					
Tidak ada					
Bulan April 2025					
1.	Abd Rohman	229923	18/04/2025	ICU	Sampel Vena BGA
2.	Aqilla Putri	160607	19/04/2025	IRNA 3C	Sampel Clotting
3.	Rochmad	102166	29/04/2025	IRNA 5C	Sampel Clotting
Bulan Mei 2025					
1.	Andara	224145	01/05/2025	IGD	Sampel Clotting

Analisis :

Masih ditemukan sampel rusak ketika diterima oleh petugas laboratorium pada Bulan Mei 2025 sebanyak 1 sampel. Namun tidak sebanyak sebelum dilakukan sosialisasi pada Bulan Januari 2025. Hal ini bisa disebabkan ketidakteitian petugas saat melakukan sampling darah, tidak paham dengan kebutuhan dan prosedur penyimpanan sampai dengan pengiriman sampel ke laboratorium, sampel tidak segera dikirim ke Laboratorium.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Monitoring dan Evaluasi.
- 2. Memberikan pemahaman bahwa pengambilan sampel sesuai dengan batas garis indicator.
- 3. Kolaborasi dengan Kabid Keperawatan terkait training prosedur pengambilan darah, penyimpanan dan pengiriman sampel.
- 4. Supervisi ED reagen.

4.1.1.6 Tabel Pelayanan BDRS Bulan Maret - Mei 2025

Bulan	Permintaan Labu Darah				Total	Return Labu Darah				Total
	A	B	O	AB		A	B	O	AB	
Maret 2025	33	17	40	25	115	3	7	-	12	22
April 2025	13	10	25	20	68	2	7	5	4	18
Mei 2025	20	27	42	9	98	4	-	-	-	4

4.1.1.7 Tabel Hasil Incompatible pada Crossmatch pada Bulan Maret - Mei 2025

No	Nama Pasien	Jumlah pasien dan permintaan labu darah Incompatible				Total Permintaan Labu darah
		A	AB	O	B	
Bulan Maret 2025						
1.	Nur Mujiati	√				2 Labu
Bulan April 2025						
Tidak ada						
Bulan Mei 2025						
Tidak ada						

Analisis :

- 1. Permintaan labu darah Pada Bulan Mei 2025 mengalami peningkatan sebanyak 98 labu darah, hal ini disebabkan kasus dengan diagnosis kebutuhan labu darah meningkat, dan semua permintaan terpakai, tidak ada return dari unit.
- 2. Masih ditemukan return labu darah ke PMI sebanyak 4 kantong darah, mengalami penurunan.
- 3. Tidak ditemukan hasil incompatible pada crossmatch pada Bulan Mei 2025.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mengurangi stok maksimum labu darah dengan permintaan jarang.
- 2. Mengirimkan analis untuk magang di PMI selama 2 minggu secara bergantian, biaya free.
- 3. Melakukan penertiban penulisan kartu stok labu darah secara real time, pelaksanaan SO dilakukan setiap akhir bulan.
- 4. Mempertahankan ketelitian dalam melakukan *crossmatch*.

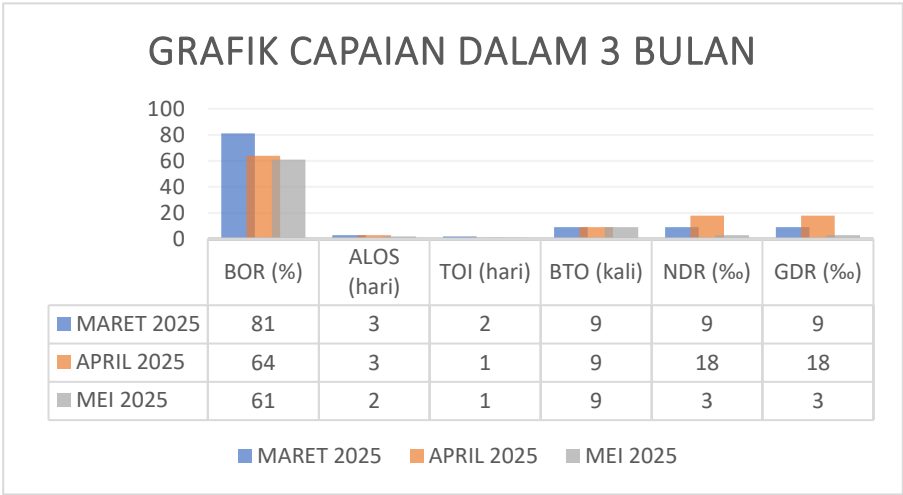
3.2.3 Rekam Medis – Pendaftaran

3.1.1.1 Tabel Kinerja Unit Rawat Inap Bulan Maret - Mei 2025

Indikator	Rumus	Data	Standar Depkes	Bulan	Unit												Total
					2C	3A	3C	4Ab	5C	6A	7A	8A	MTS	NICU	HCU	ICU	
BOR (Bed Occupancy Rate) “Prosesntase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu”	$(\Sigma HP / (\Sigma TT \times \text{jumlah hari dalam satu periode})) \times 100$	Jumlah hari perawatan, jumlah TT, jumlah hari dalam satu periode	60-80 %	Maret 2025	68	57	61	83	60	62	71	65	66	31	24	17	81%
				April 2025	65	59	69	97	58	79	77	75	67	33	25	19	64%
				Mei 2025	65	77	68	80	56	74	76	72	61	25	26	22	61%
ALOS (Average Length of Stay) “Rata-rata lama rawat seorang pasien”	$LD / \sum px \text{ keluar } (H+M)$	Jumlah lama dirawat, jumlah pasien keluar	6-9 hari	Maret 2025	4	3	3	3	4	3	3	1	3	3	2	2	3hari
				April 2025	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	2	2	3hari
				Mei 2025	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	1	1	2hari
TOI (Turn Over Interval) “Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati”	$((\sum TT \times \sum \text{hari}) - HP) / \sum \text{pasien keluar } (H+M)$	Jumlah tempat tidur, hari perawatan, pasien keluar	1-3 hari	Maret 2025	1	1	1	1	2	1	1	1	1	4	2	5	1hari
				April 2025	1	1	1	1	2	1	1	1	1	4	2	5	1hari
				Mei 2025	1	1	1	1	2	1	1	1	1	5	2	4	1hari
BTO (Bed Turn Over) “Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode”	$\sum Px \text{ keluar } (H+M) / \sum TT$	Jumlah pasien, Jumlah TT	4-5 kali (dalam hitungan bulan)	Maret 2025	8	9	9	11	8	9	10	8	12	6	7	5	9kali
				April 2025	9	10	9	12	8	9	10	9	10	5	10	5	9kali
				Mei 2025	7	9	10	11	8	10	9	9	6	5	11	6	9kali
NDR (Net	$(\sum Px \text{ Mati } > 48 \text{ jm}) /$	Jumlah	<25 ‰	Maret 2025	0	0	0	7	0	9	9	21	0	16	77	91	9‰

Death Rate) “Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit”	$\sum Px \text{ keluar (H+M))} \times 1000\text{‰}$	pasien meninggal >48jm, jumlah pasien keluar		April 2025	14	0	0	0	42	19	17	19	0	0	158	209	18‰
				Mei 2025	0	1	0	0	1	4	4	6	0	2	17	34	3‰
GDR (Gross Death Rate) “Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit”	$(\sum Px \text{ mati} / \sum Px \text{ keluar (H+M))} \times 1000\text{‰}$	Jumlah pasien keluar mati, jumlah pasien keluar	<45‰	Maret 2025	0	0	0	7	0	9	9	21	0	16	77	91	9‰
				April 2025	14	0	0	0	42	19	17	19	0	0	158	209	18‰
				Mei 2025	0	1	0	0	1	4	4	6	0	2	17	34	3‰

3.1.1.2 Grafik Kinerja Unit Rawat Inap Bulan Maret - Mei 2025 2025



Analisis :

Indikator	Nilai Mei 2025	Standar Ideal	Evaluasi Singkat
BOR	61%	60%-85%	Masih dalam standar, batas rendah
LOS	2 hari	BPJS : 3 hari UMUM : 6-12 hari	Dibawah standar BPJS, perlu dicermati
TOI	1 hari	1-3 hari	Sesuai standar, efisien
BTO	9 kali	4-5 kali	Konsisten tinggi, perlu evaluasi

Update Tren Tahun 2025

Indikator	Februari	Maret	April	Mei	Catatan
BOR	68%	81%	64%	61%	Penurunan signifikan sejak Bulan April
LOS	3 hari	3 hari	3 hari	2 hari	Penurunan LOS, dibawah standar SE PT DPM
TOI	1 hari	2 hari	1 hari	1 hari	Stabil, efisien
BTO	8 kali	9 kali	9 kali	9 kali	Konsisten tinggi, diluar standar ideal

Masalah :

5. BOR turun ke 61%

Masih dalam rentang standar, namun tren penurunan berkelanjutan sejak Maret bisa mengindikasikan :

- a) Penurunan jumlah pasien rawat inap.
- b) Kemungkinan ruang rawat tidur kurang dimanfaatkan optimal.

6. LOS semakin pendek (2 hari)

- a) Lebih rendah dari standar SE PT.DPM (3 hari) untuk pasien BPJS.
- b) Risiko pemulangan terlalu cepat, yang dapat meningkatkan risiko readmisi atau komplikasi.

7. TOI tetap ideal (1 hari)

Menandakan proses pergantian pasien berjalan lancar dan efisien.

8. BTO tetap tinggi (9 kali)

- a) Menunjukkan rotasi pasien yang sangat cepat.
- b) Bisa menyebabkan kelelahan staf dan potensi penurunan kualitas layanan.

Rencana Tindak Lanjut :

- 6. Audit LOS dan readmisi : Pastikan pasien tidak dipulangkan terlalu cepat demi menjaga mutu dan keselamatan.

- Evaluasi kapasitas dan pemanfaatan tempat tidur : Cek apakah BOR rendah disebabkan oleh penurunan permintaan atau masalah manajemen.
- Monitoring beban kerja staf : Kaji dampak BTO tinggi pada tenaga medis dan lakukan langkah mitigasi jika diperlukan.
- Penggunaan sistem manajemen tempat tidur digital : Untuk mengoptimalkan distribusi pasien dan pemakaian ruang.
- Sosialisasi dan pelatihan terkait discharge planning : Agar pemulangan pasien tetap berdasarkan indikasi klinis, bukan hanya efisiensi administratif.

3.1.1.3 Tabel Diagnosa Terbanyak Bulan Mei 2025

NO	KODE	DIAGNOSA	TOTAL
1.	I51.9	DECOMP CORDIS/HEART DISEASE, UNSPECIFIED	416
2.	I63.9	CVA INFARK/CEREBRAL INFARCTION, UNSPECIFIED	305
3.	I25.9	CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE, UNSPECIFIED	298
4.	E11.4	WITH NEUROLOGICAL COMPLICATIONS	282
5.	E11.9	DM TANPA KOMPLIKASI / WITHOUT COMPLICATIONS	252
6.	I11.9	HHD / HYPERTENSIVE HEART DISEASE WITHOUT (CONGESTIVE) HEART FAILURE	214
7.	J47	BRONCHIECTASIS	200
8.	F41.2	MIXED ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDER	164
9.	K04.1	NECROSIS OF PULP	163
10.	J44.9	COPD / CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE, UNSPECIFIED	150

3.1.1.4 Tabel Diagnosa Rawat Inap Bulan Mei 2025

NO	KODE	DIAGNOSA	TOTAL
1.	A01.0	TYPHOID FEVER (TF)	238
2.	P24.9	NEONATUS CUKUP BULAN	88
3.	I63.9	CVA INFARK	37
4.	A90	DENGUE FEVER	31
5.	E14.9	DM HYPERGLIKEMIA	27
6.	M72.6	NECROTIZING FASCITIS	21
7.	J18.9	PNEUMONIA	19
8.	I50.1	ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE	18
9.	J44.0	COPD / CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE	18
10.	N40.0	BENIGN PROSTATE HYPERPLASIA	16

Analisis :

- Diagnosa terbanyak di Rawat Jalan adalah Decomp Cordis/Heart Disease sebesar 416 kasus, sedangkan diagnose terbanyak di Rawat Inap adalah Typhoid Fever sebesar 238 kasus.
- Tarikan data diagnose rawat inap diambil dari hasil analisa pada resume medis saat pasien pulang, yaitu pada diagnose utama yang ditulis oleh DPJP. Sedangkan tarikan data diagnose rawat jalan diambil dari SIMRS.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan analisa pada resume medis saat pasien pulang berdasarkan diagnose sekunder.

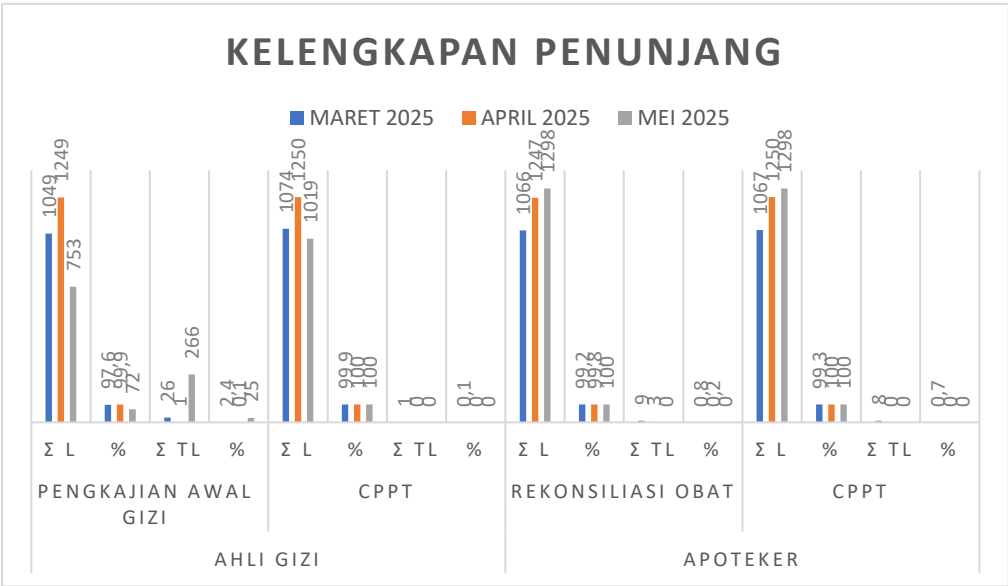
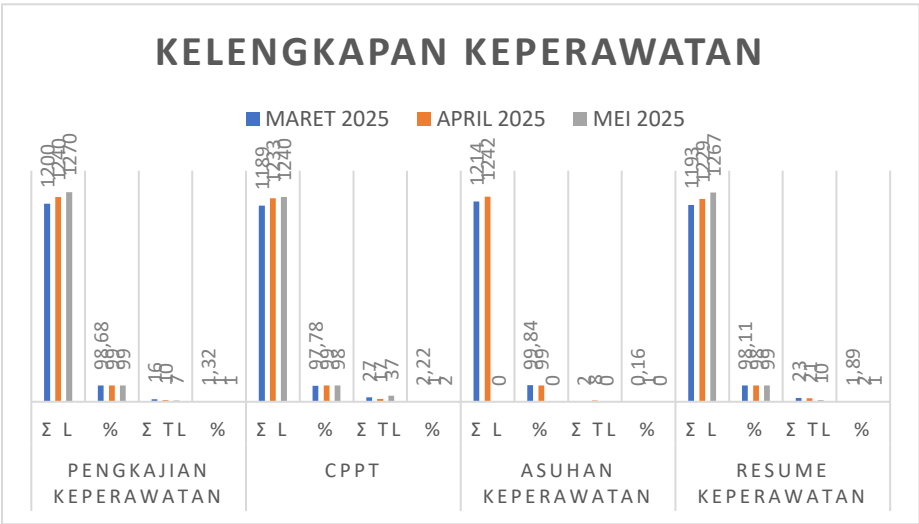
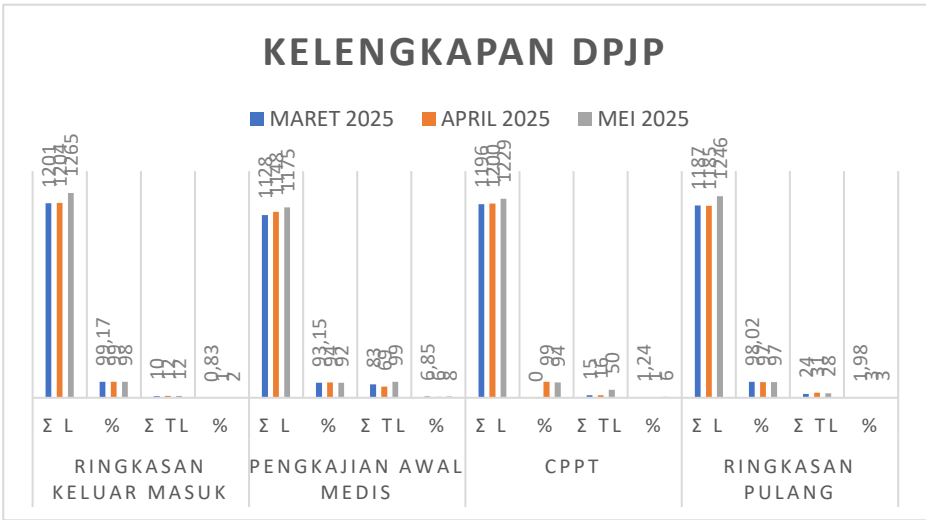
3.1.1.5 Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Maret - Mei 2025

KELENGKAPAN																
DPJP																
BULAN	Ringkasan Keluar Masuk				Pengkajian Awal Medis				CPPT				Ringkasan Pulang			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	1055	98.1	20	1.9	1019	94.8	56	5.2	1026	95.4	49	4.6	1061	98.7	14	1.3
Maret	1201	99.17	10	0.83	1128	93.15	83	6.85	1196	98.76	15	1.24	1187	98.02	24	1.98
April	1204	99	12	1	1148	94	69	6	1200	99	16	1	1185	97	31	3
Mei	1265	98	12	2	1175	92	99	8	1229	94	50	6	1246	97	28	3

KELENGKAPAN																
PERAWAT																
BULAN	Pengkajian Keperawatan				CPPT				Asuhan Keperawatan				Resume Keperawatan			
	Σ L	%	Σ TL	Σ L	Σ L	Σ L	Σ L	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	1070	99.5	5	1048	1048	1048	1048	1.8	1056	98.2	1	0.1	1074	99.9	1	0.1
Maret	1200	98.68	16	1.32	1189	97.78	27	2.22	1214	99.84	2	0.16	1193	98.11	23	1.89
April	1240	99	10	1	1233	99	17	1	1242	99	8	1	1229	98	21	2
Mei	1270	99	7	1	1240	98	37	2	-	-	-	-	1267	99	10	1

KELENGKAPAN																
BULAN	AHLI GIZI								APOTEKER							
	Pengkajian Awal Gizi				CPPT				Rekonsialisasi Obat				CPPT			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	944	92	82	8	944	92	82	8	1010	98	16	2	912	89	114	11
Maret	1049	97.6	26	2.4	1074	99.9	1	0.1	1066	99.2	9	0.8	1067	99.3	8	0.7
April	1249	99.9	1	0.1	1250	100	0	0	1247	99.8	3	0.2	1250	100	0	0
Mei	753	72	266	25	1019	100	0	0	1298	100	0	0	1298	100	0	0

3.1.1.6 3.1.1.6 Grafik Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Maret - Mei 2025



Analisis :
Kelengkapan DRM Ahli Gizi mengalami penurunan pada dokumen pengkajian awal medis gizi, dari 1019 DRM yang lengkap sebanyak 753.

Rencana Tindak Lanjut :

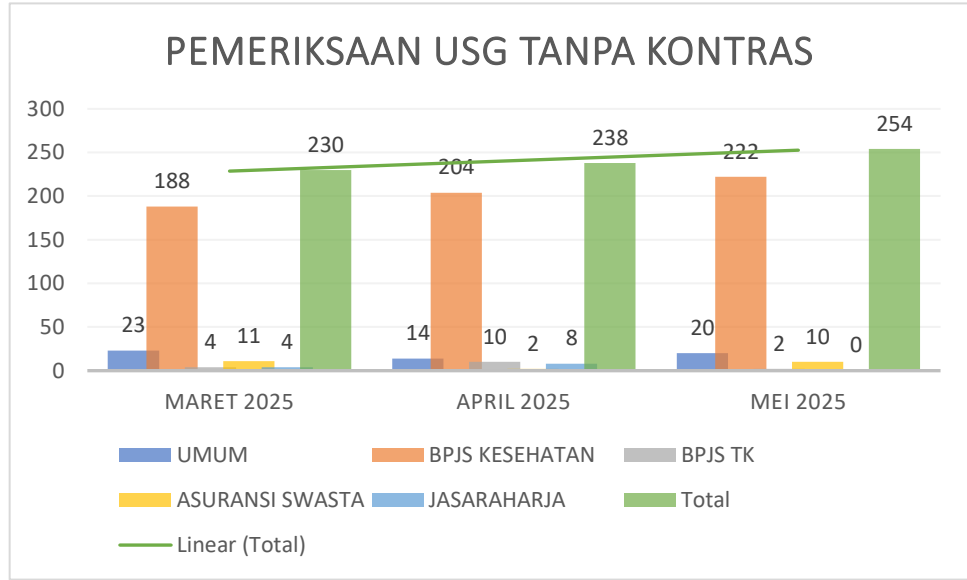
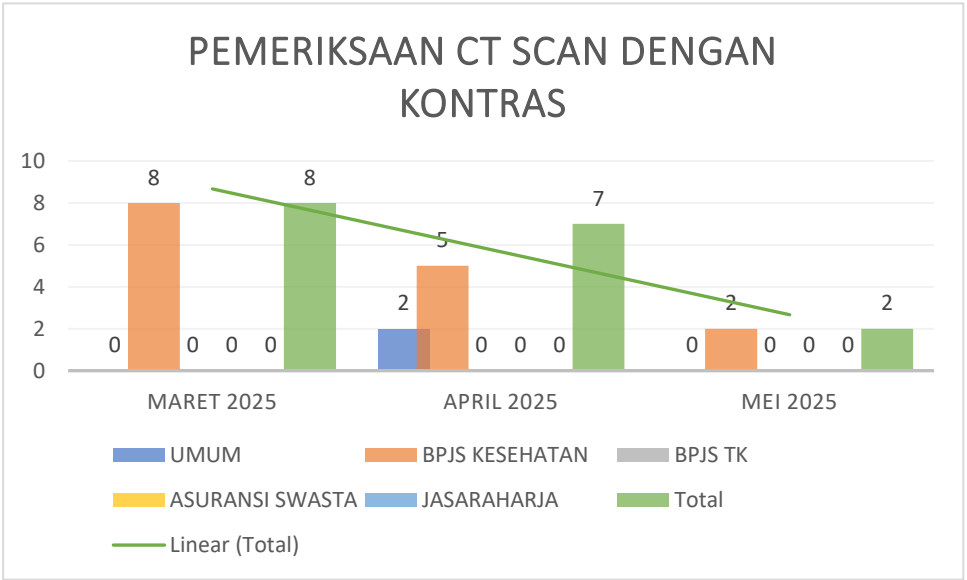
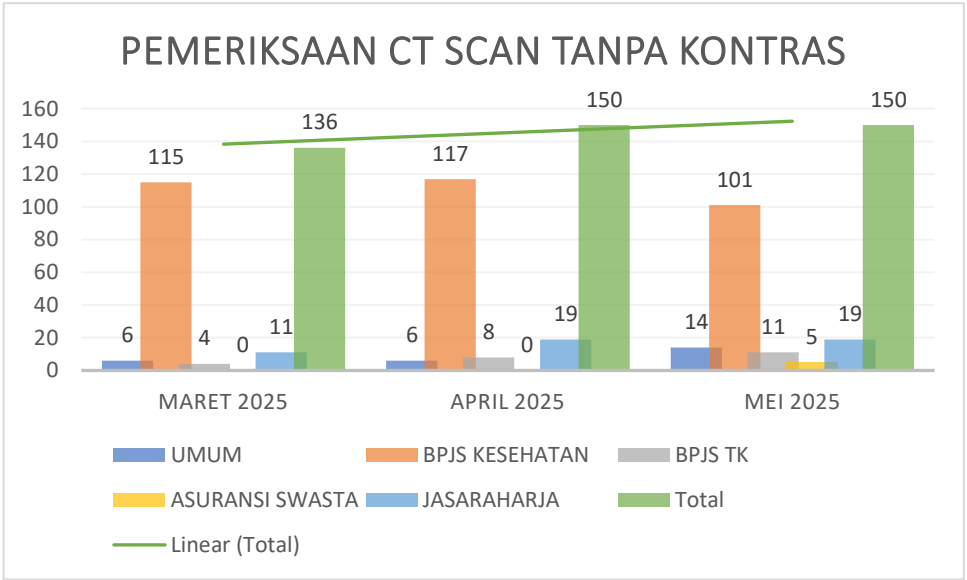
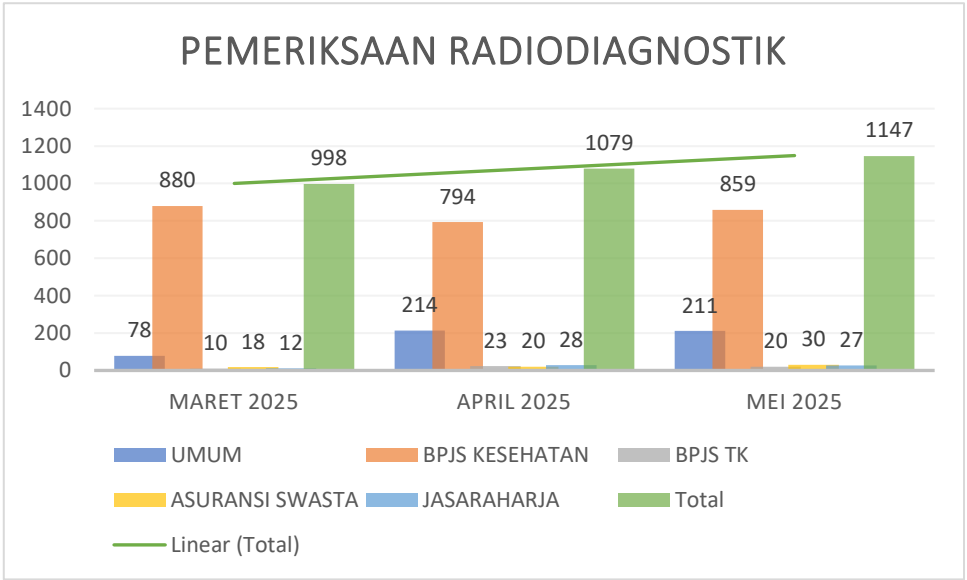
- 1. Menginformasikan kepada KARU hasil audit ketidaklengkapan DRM untuk melengkapi kekurangannya.
- 2. Melakukan supervise secara berkala.
- 3. Trial ERM Rawat Inap, diperlukan warning jika form belum terisi lengkap sehingga tidak bisa melanjutkan ke menu berikutnya.
- 4. Sosialisasi saat Rapat Unit, cara pengisian DRM.
- 5. Membuat rapot ketidaklengkapan .

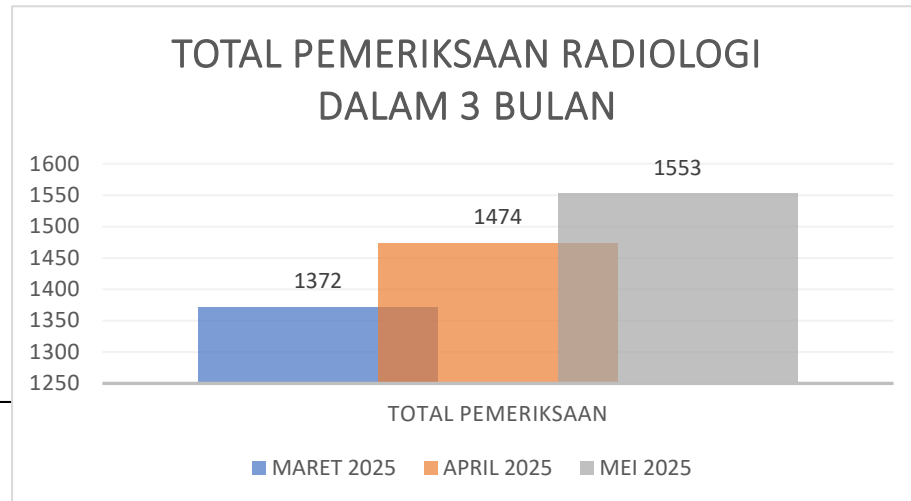
5.2.4 Radiologi

5.2.4.1 Tabel Jumlah Pemeriksaan Radiologi Maret - Mei 2025

NO	JENIS PEMERIKSAAN	PENJAMIN	BULAN		
			MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025
1.	RADIODIAGNOSTIK	UMUM	78	214	211
		BPJS KESEHATAN	880	794	859
		BPJS TK	10	23	20
		ASURANSI SWASTA	18	20	30
		JASARAHARJA	12	28	27
	TOTAL		998	1079	1147
2.	CT SCAN TANPA KONTRAS	UMUM	6	6	14
		BPJS KESEHATAN	115	117	101
		BPJS TK	4	8	11
		ASURANSI SWASTA	0	0	5
		JASARAHARJA	11	19	19
	TOTAL		136	150	150
3.	CT SCAN DENGAN KONTRAS	UMUM	0	2	0
		BPJS KESEHATAN	8	5	2
		BPJS TK	0	0	0
		ASURANSI SWASTA	0	0	0
		JASARAHARJA	0	0	0
	TOTAL		8	7	2
4.	USG TANPA KONTRAS	UMUM	23	14	20
		BPJS KESEHATAN	188	204	222
		BPJS TK	4	10	2
		ASURANSI SWASTA	11	2	10
		JASARAHARJA	4	8	0
	TOTAL		230	238	254
TOTAL KESELURUHAN			1372	1474	1553

5.2.4.2 Grafik Jumlah Pemeriksaan Radiologi Maret - Mei 2025





Analisis :

1. Pelayanan pemeriksaan selama Bulan Mei 2025 meliputi Radiodiagnostik, USG dan CT Scan, terbagi menjadi pasien UMUM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Swasta dan Jasaraharja.

Pada Bulan Mei 2025 pemeriksaan terbanyak, yaitu :

- a. Radiodiagnostik : 1147
 - b. USG Tanpa Kontras : 254
 - c. CT Scan Tanpa Kontras : 150
2. Produktivitas pemeriksaan radiodiagnostik mengalami peningkatan, hal ini disebabkan adanya tambahan pasien MCU haji dan MCU Perusahaan/mandiri.
 3. Jumlah total pemeriksaan selama Bulan Mei 2025 adalah sebanyak 1553 pemeriksaan.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Koordinasi dengan Humas & Marketing untuk meningkatkan kunjungan di Radiologi dengan cara :
 - 1) Melakukan kerja sama dengan RS yang belum memiliki CT Scan untuk meningkatkan pendapatan.
 - 2) Mengajukan MCU kepada perusahaan-perusahaan besar di Kab/Kota Malang.
2. Kolaborasi dengan Humas & Marketing untuk mengawal Polisi LAKA supaya tetap melakukan rujukan LAKA LANTAS ke RS Prima Husada Malang.
3. Mendokumentasikan respon time pelayanan Radiologi menggunakan Google Spreadsheet, sambil menunggu waktu selesai hasil dimunculkan di Hasil Bacaan oleh Programmer PT.

5.2.4.3 Tabel Laporan Ulang Hasil Bulan April – Mei 2025

NO	NAMA DOKTER	NAMA PASIEN	BACAAN AWAL	BACAAN ULANG	TOTAL
Bulan Maret 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	By Ny Zaimatus (227984)	Normal	Pneumonia	2
		Kasti (073280)	Normal	Infark Akut	
2.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	Agus Wahyu (114824)	Spondylosis	Compresi Fractura	1
Bulan April 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	Ny Sri Asnanik (224631)	CVA Infark	CVA Infark	2
		Dian Nihayatul (212732)	Normal	Normal	
2.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	0	0	0	0
Bulan Mei 2025					
1.	dr Agung, Sp.Rad (K)	Sumroti (231733)	Cardiomegali	Cardiomegaly dan Pneumonia	2
		Roeskandar	Lung Tumor	Lung Tumor dan Pneumonia	
2.	dr Rumbiyo Yudho, Sp.Rad	Rizka Anada	Normal	Fracture Scapulla	1

Analisis :

Pada Bulan Mei Tahun 2025 terdapat pembacaan ulang pemeriksaan ke radiologi. Hal ini disebabkan karena klinis tidak ditulis secara lengkap pada surat permintaan radiologi.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan MOD dan Kabid Pelayanan jika ada complain DPJP untuk melaporkan ke Radiologi dan Kabid Penunjang Medis.
2. Kolaborasi dengan Kabid Pelayanan dan Kabid Keperawatan untuk melengkapi pemeriksaan klinis pada surat pengantar supaya dapat menunjang hasil pemeriksaan.

5.2.4.4 Tabel Rata-Rata Respon Time Pembacaan Pemeriksaan Radiologi

NO	PEMERIKSAAN	RATA-RATA WAKTU (menit)			
		dr Agung, Sp.Rad (K)		dr Yudho, Sp.Rad	
		SELESAI PERIKSA	SELESAI PEMBACAAN	SELESAI PERIKSA	SELESAI PEMBACAAN
1.	Ro Thorax PA/AP	3	25-180	3	10-1440
2.	Ro Vertebrae	-	-	4	10-1440
3.	Ro Abdomen	4	25-60	10	10-1440
4.	Ro Extremitas	-	-	2	10-1440
5.	Ro Skull	-	-	2	10-1440
6.	USG Abdomen	8	5	15	10
7.	CT Scan Non Kontras	5	30-1440	-	-
8.	CT Scan Dengan Kontras	15	30-1440	-	-
9.	Radiologi CITO	-	-	-	-

Analisa :

1. Rata-rata pemeriksaan radiologi adalah 3 menit dengan rata-rata hasil pembacaan radiologi 25 menit untuk dr Agung, Sp.Rad (K), hal ini disebabkan karena hasil rontgen dapat dikonsultasikan via pesan whatsapp. (Sesuai target standar RS yakni waktu elektif 3 jam).
2. Rata-rata pembacaan radiologi oleh dr Yudho, Sp.Rad adalah 1440menit/24 jam, tidak sesuai dengan target standar RS. Hal ini disebabkan karena adanya pembagian jobdesk konsulan, dr Yudho, Sp.Rad tidak berkenan dikonsuli via pesan whatsapp dan dibacakan saat praktik keesokan harinya.
3. Pembacaan elektif dilakukan oleh dr Yudho, Sp.Rad saat praktik. (Semua foto Vertebrae, Ekstremitas, Abdomen, dan Skull).
4. Tidak terdapat pemeriksaan CITO dan kasus kritis selama Bulan April 2025.
5. Semua pemeriksaan CT Scan dibacakan oleh dr Agung, Sp.Rad (K).
6. Terdapat kekosongan jam pelayanan radiologi pada siang hari.
7. Pembacaan hasil pemeriksaan radiologi oleh dr Agung, Sp.Rad, diatas target standar RS yakni 420-1440 menit dikarenakan hasil jadi diatas pukul 00.00 WIB dan DPJP meminta dibacakan oleh dr Agung, Sp.Rad.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Menemui kedua DPJP Radiologi untuk menambah jam praktik.
2. Memberikan surat pemberitahuan kepada Kepala Kolegium Radiografer bahwa RS membutuhkan tambahan DS Radiologi untuk mengisi jadwal praktik siang hari, sudah diterima oleh dr Agung, Sp.Rad.
3. Melakukan supervise pencatatan respon time pada Google Spreadsheet.
4. Membuat perjanjian dengan Kains Radiologi (dr Agung, Sp.Rad (K)) selama belum terpenuhi dokter untuk merespon konsulan secara cepat.

5.2.4.5 Tabel Angka Komplain DPJP Terhadap Keterlambatan Hasil Pembacaan Radiologi pada Bulan April 2025

NO	NAMA PASIEN	NAMA DPJP	PEMERIKSAAN	WAKTU	
				SELESAI PERIKSA	SELESAI HASIL
1.	-	-	-	-	-

Analisis :

Pada Bulan April tidak ada komplain DPJP dan Dokter Umum karena keterlambatan hasil pembacaan radiologi.

Hal ini disebabkan, selain waktu tunggu cito tidak melebihi standar, bisa disebabkan ketidakpahaman petugas pelayanan dalam melaporkan complain sehingga tidak terdokumentasikan dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :

Kolaborasi dengan MOD dan Kabid Pelayanan jika ada complain DPJP untuk melaporkan ke Radiologi dan Kabid Penunjang Medis.

5.2.4.6 Tabel PMI dan PME di Radiologi

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Sasaran Kegiatan
Pemantapan Mutu Internal (PMI)			
1.	Mencatat waktu tunggu pelayanan foto	Mencatat waktu mulai pengerjaan hingga hasil diserahkan.	1. Respons time pelayanan radiologi terukur dan sesuai standar. 2. Pengendalian kegagalan foto dan meminimalkan pengulangan. 3. Mengendalikan penggunaan BMHP radiologi.
2.	Mencatat jumlah Reject Film	Mencatat kegagalan foto (review pembacaan dan review hasil radiograf)	
3.	Memonitor pemakaian BMHP	Memonitor penyimpanan, pemeliharaan dan pemakaian bmhp.	
Pemantapan Mutu Eksternal (PME)			
1.	Melakukan uji paparan radiasi	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	1. Peralatan radiologi dalam kondisi siap pakai. 2. Standarisasi pelayanan radiologi rujukan.
2.	Melakukan uji akurasi tegangan	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	
3.	Pengukuran TLD Badge	Kegiatan pengukuran dilakukan setiap 3 bulan sekali ke BPFFK (Balai Pengaman Fasilitas .Kesehatan)	
4.	Kalibrasi alat radiologi	Standarisasi peralatan radiologi setiap 1 tahun sekali.	
5.	Uji kesesuaian	Pengujian kondisi alat dilakukan setiap 4 tahun sekali oleh badan yang ditunjuk pemerintahan.	
6.	Sertifikat kalibrasi	Memastikan sertifikat kalibrasi rs rujukan masih berlaku	

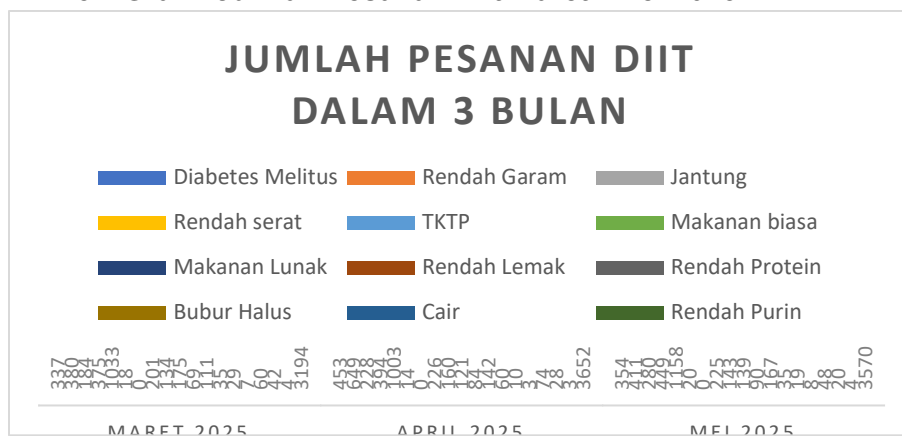
2.4.5 Gizi

2.4.5.1 Tabel Pemesanan Diit Maret – Mei 2025

NO	NAMA DIIT	BULAN			PROSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA (%)
		MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025	
1.	Diabetes Melitus	337	453	354	134
2.	Rendah Garam	380	649	411	170
3.	Jantung	184	228	280	123
4.	Rendah serat	375	394	449	105
5.	TKTP	1033	1003	1158	97
6.	Makanan biasa	18	14	20	77
7.	Makanan Lunak	0	0	0	0
8.	Rendah Lemak	201	226	225	112
9.	Rendah Protein	134	160	143	119
10.	Bubur Halus	175	121	139	69
11.	Cair	69	84	90	121

12.	Rendah Purin	111	142	167	127
13.	Tinggi Protein	35	60	35	171
14.	Blender	29	10	19	34
15.	Tinggi serat	7	3	8	42
16.	Tinggi Kalium	60	74	48	123
17.	Rendah Kalium	42	28	20	66
18.	Rendah Sisa	4	3	4	75
TOTAL		3194	3652	3570	117

2.4.5.2 Grafik Jumlah Pesanan Diit Maret - Mei 2025



Analisis :

1. Jumlah pemberian diit pasien rawat inap pada Bulan Mei mengalami penurunan, hal ini berbanding lurus dengan penurunan jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit.
2. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pemesanan diit terbanyak selama Bulan Mei 2025 adalah TKTP sebanyak 1158, berbanding lurus dengan diagnose terbanyak di rawat inap yaitu Thypoid Fever dengan kebutuhan diit TKTP.
3. Dari hasil survey kepuasan pasien terhadap menu makanan tidak ditemukan penurunan kepuasan terhadap variasi makanan.

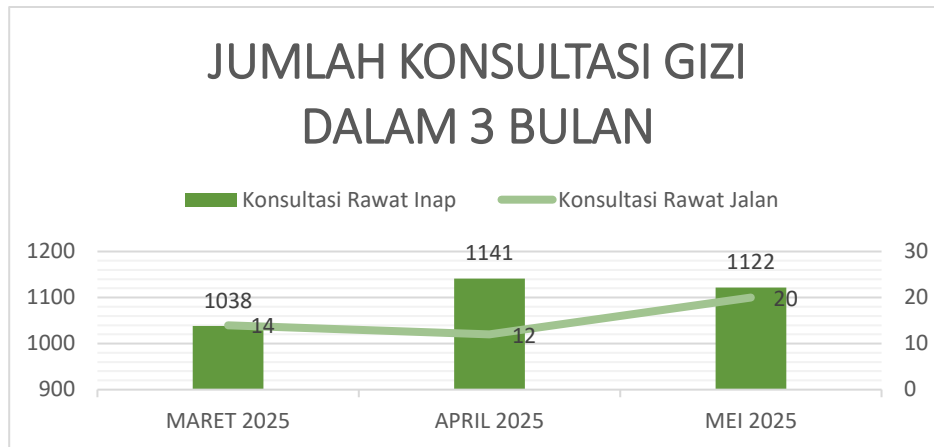
Rencana Tindak Lanjut :

1. Koordinasi dengan humas dan marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap. Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien terhadap variasi menu makanan.
2. Mengajukan pelayanan catering makanan untuk pemulihan pasien saat pulang rawat inap.
3. Kolaborasi dengan layanan primantara (pengantaran obat) untuk MCU Gizi gratis sebagai reward.
4. Melakukan perbaikan menu makanan dan plating sesuai dengan kelas pasien.
5. Kolaborasi dengan PKRS untuk membuat leaflet menu makanan dan diupload di Sosial Media.
6. Perbaikan pencatatan food waste dipisahkan setiap menu makanan untuk mengetahui menu makanan mana yang tidak diminati.

2.4.5.3 Tabel Jumlah Konsultasi Gizi Maret - Mei 2025

NO	INDIKASI	JUMLAH PASIEN		
		MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025
1.	Konsultasi Rawat Inap	1038	1141	1122
2.	Konsultasi Rawat Jalan	14	12	20

2.4.5.4 Jumlah Konsultasi Gizi



Analisis :

1. Jumlah konsultasi gizi rawat inap pada Bulan Mei 2025 menurun mengikuti jumlah pasien yang rawat inap.
2. Jumlah konsultasi gizi rawat jalan pada Bulan Mei 2025 mengalami peningkatan.
3. Tidak semua DPJP memberikan rujukan ke Poli Gizi, rujukan diterima dari Poli Jantung dan Poli IPD saja ketika pasien bertanya terkait pantangan makan saat control ke Poli Spesialis

Rencana Tindak Lanjut :

1. Merancang pengembangan pelayanan MCU Konsultasi Gizi dengan perusahaan.
2. Koordinasi dengan Humas Marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan.
3. Koordinasi dengan Kabid Pelayanan agar DPJP merujuk pasien ke Poli Giz

2.4.5.5 Tabel Rekap Data Komplain Pasien Terhadap Gizi Bulan Mei 2025

No	Jenis Komplain	Nama Pasien	Analisis	Rencana Tindak Lanjut	Total
Bulan Februari 2025					
1.	Makanan yang disajikan dan penjelasan mengenai menu makanan.	An Yuan (B3C-4 IRNA 3C Anak) Isi Komplain : Menu yang didapat tidak bervariasi dibandingkan dengan terakhir kali pasien	1. Siklus menu yang berlaku di RS Prima Husada Malang adalah siklus menu 10 hari+1 hari	Melakukan analisis asupan makan pasien selama rawat inap untuk melihat daya terima pasien tersebut	1

		rawat inap (siklus menu berulang)	2. Pasien MRS pada hari dimana siklus menu yang sama dengan hari MRS sebelumnya.	terhadap menu yang disajikan	
Bulan Maret 2025					
Tidak ada komplain					
Bulan April 2025					
Tidak ada komplain					
Bulan Mei 2025					
1.	Keluhan pasien dan OB yang belum mendapatkan makanan	An Abimanyu Putra Herlambang (C3C-8, IRNA 3C Anak) Isi Komplain : Ayah pasien menyampaikan bahwa jika pasien belum selesai makan maka jangan mengambil makanan pasien terlebih dahulu.	1. Jam pengambilan makan adalah 1 jam setelah pembagian makan. 2. Pasien mengalami penurunan nafsu makan sehingga mengkonsumsi makanan dalam waktu lebih lama.	1. Koordinasi dengan tim penyaji untuk memberikan edukasi terkait jam pengambilan alat makan yaitu 1 jam setelah pembagian makan. 2. Koordinasi dengan CS pantry untuk cara edukasi yang benar sebelum mengambil alat makan pasien.	1

2.4.5.6 Tabel Rekap Food Waste (Sisa Makanan) bulan Maret - Mei 2025

No	Menu	Rincian Menu	Total Sisa Makanan (kg)			Keterangan
			Maret 2025	April 2025	Mei 2025	
1.	Karbohidrat	Nasi	241,1	184,4	174,7	Sisa KH menurun dari bulan selumnya. Prosentase sisa KH bulan ini 68% dari total sisa makanan, sehingga meningkat 4% dari total sisa makanan.
		Nasi Tim	374	282,7	245,1	
		Total	615,1	467,1	419,8	
2.	Snack	Roti Kukus	0	0	0	Menu yang kurang diminati : 1. Setup Pisang 2. Bubur Kacang Hijau
		Setup Pisang	0	0,6	0,8	
		Kacang Hijau	0	0,3	0,7	
		Kue Hongkong	0	0	0	
		Terang Bulan	0	0	0	

		Bubur Sagu	0,8	1	1,1	3. Bubur Sagu 4. Tahu Fantasi
		Kue Lumpur	0	0	0	
		Puding	0,4	0,2	0	
		Donat	0	0	0	
		Tahu Fantasi	0	0	0,4	
		Sagu Mutiara	0	0	0	
	Total		1,2	1,1	3	
1.	Menu 1					Menu 2 adalah menu paling tidak diminati, sisa makanan sebanyak 27.8 kg. Menu 5 yang sebelumnya paling banyak sisa makanan, mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya dengan sisa makanan 19.7 kg.
	Pagi	Semur (Tahu, Buncis, Bakso)	5,7	3,5	2,6	
		Rolade Ayam	3,9	3,1	2,2	
	Tambahan VIP	Tempe Goreng	0,2	0,8	0,2	
	Siang	Sup Kemangi (Jagung, Wortel, Oyong, Kemangi)	2,2	2,2	2,1	
		Ayam Kecap	5,1	3,3	2,1	
		Tahu Bumbu Tomat	1,5	2,1	0,8	
	Tambahan VIP	Telur Ceplok	0,2	0,6	0,2	
	Sore	Rawon (Daging Slice, Manisah Dadu, Cambah Pendek)	2,4	3,1	0,8	
		Tempe Goreng	1,7	2,1	0,5	
	Tambahan VIP	Perkedel	0	0,4	0	
	Total		22,9	21,2	11,5	
2.	Menu 2					
	Pagi	Sup (Manisah, Ayam Dadu, Wortel, Bihun)	7,8	4,4	5,4	
		Tahu Rempah (Remet)	3,1	3,5	3,1	
		Abon	0	0,7	0,8	
	Tambahan VIP	Telur Rebus	0	1	0,2	
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Jagung, Wortel, Manisah)	5,7	2,8	3,9	
		Ayam Wijen	3,3	3,3	4	
		Bakwan Jagung	1,9	1,6	2,2	
	Tambahan VIP	Telur Gulung	0	0,5	0,2	
	Sore	Koloke (Ayam Goreng Fillet, Timun, Wortel)	4,7	2,5	5,4	
		Tempe Goreng	2,4	2,8	2,5	
	Tambahan VIP	Bakso Goreng Mekar	0,4	0,3	0,2	
	Total		29,3	23,4	27,8	
3.	Menu 3					
	Pagi	Sup (wortel, Sawi Putih, Ayam Dadu)	3,7	3,7	3,7	
		Tahu Krispy	2,7	2,2	2	
		Abon	0	0,4	0,3	
	Tambahan VIP	Telur Ceplok	0,6	0,1	0,3	
	Siang	Sayur Asem (Wortel, Kacang Panjang, Manisah)	4,7	3,1	1,9	
		Rolade Ayam	4	2,7	2,1	
		Tahu Goreng	1,3	1,5	0,9	
	Tambahan VIP	Tempe Bacem	0,5	0,4	0,3	
	Sore	Oseng (Jamur Kuping, Wortel, Bakso, Kacang Polong)	3,7	3,1	2,1	
		Ayam Bombay	3,9	4,9	2,8	
		Tempe Orek	1,6	2,3	1,5	
	Tambahan VIP	Telur Dadar	0,3	0,2	0,6	
	Total		26,4	24,6	18,5	
4.	Menu 4					
	Pagi	Sayur Bobor (Selada Air,	4,1	5,2	3,5	

		Manisah, Kemangi)			
		Tahu Nugget	3,8	3,6	1,8
		Abon	0	0	0,2
	Tambahan VIP	Oseng Bakso Mekar	0	0	0,5
	Siang	Sup (Oyong, Wortel, Jagung)	4,3	5,3	3,1
		Ayam Kecap	6,5	3,6	2,4
		Jamur Krispy	2,7	1,6	1,3
	Tambahan VIP	Tahu Bacem	0	0,7	0,3
	Sore	Soto Ayam (Soun, Kubis, Seledri, Ayam Suwir)	4,2	3,3	2,6
		Telur Rebus	2,8	2,3	1,7
		Tempe Goreng	3,2	2,3	1,5
	Tambahan VIP	Keripik Kentang	0,2	0,5	0
	Total		31,8	28,4	18,9
5.	Menu 5				
	Pagi	Sup (Bunga Kol, Sawi Daging, Bakso, Wortel)	5,3	3,2	3,4
		Opor Tahu	3,8	2,3	2,2
		Oper Telur	3,5	2,5	1
	Tambahan VIP	Tempe Goreng	0,2	0,7	0,5
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Jagung, Manisah)	6,4	6,6	3,4
		Ayam Bombay	6,3	5,7	4,5
		Bakwan Jagung	4,5	4,1	2,7
	Tambahan VIP	Tahu Krispy	0	0,1	0,1
	Sore	Sup Merah (Bakso, Ayam Dadu, Polong, Wortel)	6,9	3,5	1
		Tempe Goreng	4,2	3,4	0,7
		Telur Dadar	0	0,2	0,2
	Total		41,1	32,3	19,7
6.	Menu 6				
	Pagi	Semur (Tahu, Buncis, Bakso)	2,9	3,0	2,2
		Orak Arik (Wortel, Kubis, Daun Bawang, Telur)	3,6	2,1	2,1
		Tempe Goreng	4,1	3,6	1,9
	Tambahan VIP	Ayam Goreng	1,6	1,7	0,8
	Siang	Sup Kemangi (Jagung, Wortel, Oyong, Kemangi)	6,2	3,5	3,1
		Ayam Laos	5,4	4,7	4,5
		Tahu Bumbu Tomat	2,8	2,3	1,6
	Tambahan VIP	Telur Ceplok	0,1	0,1	0,6
	Sore	Rawon (Daging Slice, Manisah Dadu, Cambah Pendek)	3	3,4	2
		Tahu Krispy	1,8	2,1	1,5
	Tambahan VIP	Perkedel	0,2	0,4	0,7
	Total		31,7	26,9	21
7.	Menu 7				
	Pagi	Cah Sawi (Sawi Putih, Wortel Serut, Ayam Dadu)	4,9	3	2,8
		Telur Ceplok Bumbu Kuning	2,1	2,4	5,7
		Abon	0,5	1	0,3
	Tambahan VIP	Tempe Bacem	0,1	0,1	0,5
	Siang	Sup (Wortel Dadu, Jamur Es, Polong, Bakso)	4,4	4	1,8
		Perkedel	1,3	2,3	1,1
	Tambahan VIP	Jamur Krispy	0,2	0,6	0

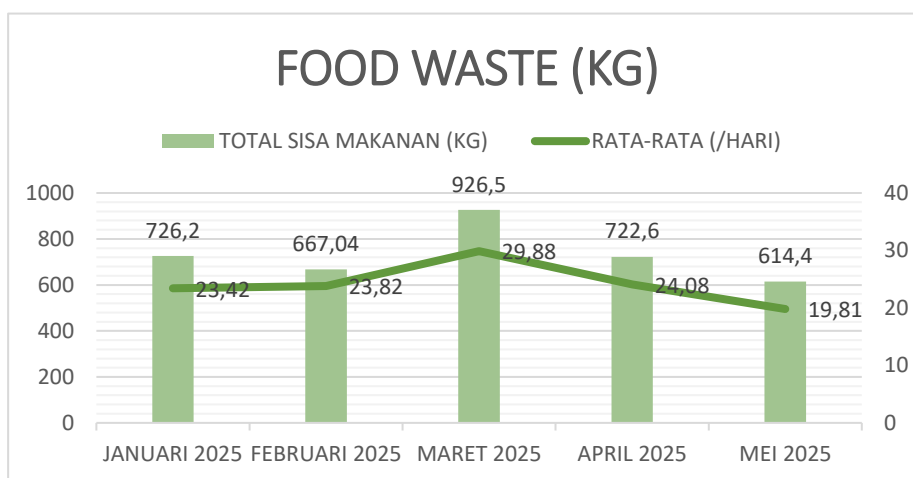
	Sore	Koloke (Ayam Goreng Fillet, Timun, Wortel)	5,5	3,7	1,8
		Tempe Goreng	4,2	2,3	1
	Tambahan VIP	Telur Dadar	0,1	0,5	0,2
	Total		27,3	23,4	17
8.	Menu 8				
	Pagi	Sayur Bobor (Manisah, Sawi Hijau)	4,6	5,4	2,2
		Tahu Nugget	3,7	3,1	2,3
		Abon	0	1,2	0,6
	Tambahan VIP	Ayam Fillet Tepung	0,4	0	0,5
	Siang	Sayur Asem (Wortel, Jagung, Manisah)	4,4	3,4	1,6
		Ayam Bakar	6,5	3,1	2
		Tahu Goreng	3,3	1,4	1
	Tambahan VIP	Nugget Ayam	0	0	0
	Sore	Semur (Ayam Fillet, Soun, Daun Bawang, Tomat)	4,7	3,6	1,5
		Botok Tahu	3,7	2,6	2,1
		Abon	0	0,8	0,2
	Tambahan VIP	Tempe Goreng	0,7	0,2	0
Total			32	24,8	14
9.	Menu 9				
	Pagi	Tumis (Bakso, Wortel, Buncis)	4,8	4	2,2
		Tahu Rempah	4,6	1,5	1,2
		Abon	0	0,4	0,1
	Tambahan VIP	Telur Dadar	0,5	1	0,7
	Siang	Sup (Bihun, Wortel, Pokcoy)	6,1	3,4	2,7
		Ayam Kemangi	7,2	4,8	2,4
		Tahu Krispi	2,7	1,9	1,5
	Tambahan VIP	Bakso Goreng Mekar	0	0,4	0,4
	Sore	Soto Ayam (Soun, Kubis, Seledri, Ayam Suwir)	4,9	3,4	2,3
		Telur Rebus	2,2	1,8	1,6
		Tempe Goreng	2,3	1,4	1,1
	Tambahan VIP	Keripik Kentang	0,3	0	0,1
Total			35,6	24	16,3
10.	Menu 10				
	Pagi	Sup (Wortel, Bakso, Sawi Putih)	4,5	6,3	1,8
		Telur Ceplok	3,3	2,8	1,6
		Abon	0	0,7	0,7
	Tambahan VIP	Tempe Bacem	0,9	0,5	0,3
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Wortel, Jagung, Manisah)	5,5	3,8	3,1
		Ayam Wijen	2,7	3,8	4,2
		Tahu Goreng	1,5	1,7	1,4
	Tambahan VIP	Telur Orak Arik	0,3	0,3	0
	Sore	Capjay (Wortel, Kembang Kol, Sawi, Bakso, Ayam Dadu)	6,6	3,5	2
		Tempe Goreng	3,1	2	1
	Tambahan VIP	Oseng Bakso Mekar	0,1	0	0,3
Total			27,6	25,4	16,4
11.	Menu 11				
	Pagi	Sapo Tahu (Tahu, Wortel, Kembang Kol, Bakso)	2,4	0	1
		Tempe Goreng	0,2	0	0,8

		Abon	0	0	0,3
	Tambahan VIP	Telur Rebus	0.4	0	0,2
	Siang	Sayur Asem (Wortel, Kacang Panjang, Manisah)	1	0	1,7
		Ayam Bakar	0.8	0	0,8
		Bakwan Jagung	0.2	0	0,9
	Tambahan VIP	Tahu Goreng	0	0	0,3
	Sore	Semur (Ayam Fillet, Soun, Daun Bawang, Tomat)	0.5	0	0,8
		Tahu Rempah	0.2	0	0,5
		Abon	0	0	0
	Tambahan VIP	Jamur Krispy	0	0	0,2
		Total	5.7	0	7,5
		Total Food Waste Menu	311,4	254.4	191,6
		Total Keseluruhan	926,5	722.6	614,4

4.4.5.7 Tabel Rekap Food Waste pada Bulan Mei 2025

No	Bulan	Total Sisa Makanan (kg)	Rata-Rata/Hari
1.	Januari 2025	726.2	23,42
2.	Februari 2025	667.04	23,82
3.	Maret 2025	926.5	29,88
4.	April 2025	722.6	24,08
5.	Mei 2025	614,4	19,81

4.4.5.8 Grafik Food Waste pada Bulan Mei Tahun 2025



Analisis :

1. Terdapat perubahan perhitungan sisa makanan pada Bulan Maret 2025, dimana perhitungan dipisahkan per menu dengan tujuan mengetahui menu makanan yang kurang diminati.
2. Dari data diatas, dapat diketahui bahwa ada penurunan sisa makanan pada Bulan Mei 2025, yaitu sebanyak 614.4kg, setelah dilakukan tindakanjunt mengurangi porsi nasi pada setiap penyajian dan memperbaiki dalam segi rasa dan penampilan.

-
3. Masih ditemukan sisa makanan selain karbohidrat sebanyak 191.6 kg (mengalami penurunan, rata-rata 19.81 kg/hari), hal ini dipengaruhi beberapa faktor, antara lain :
 - a) Ada batasan diit yang dapat mempengaruhi rasa dan tampilan sehingga kurang menggugah selera.
 - b) Tidak ada pantangan dari keluarga pasien, sehingga konsumsi makanan dari luar / dibawa dari rumah, komunikasi/edukasi Ahli Gizi kurang diperhatikan.
 - c) Suasana lingkungan perawatan dan kondisi fisik pasien.
 4. Tidak ada keterlambatan pengiriman makanan, jadwal makan sesuai.
 5. Dari total sisa makanan pada Bulan Mei 2025 sebanyak 614.4 kg, 68% berasal dari karbohidrat (nasi dan nasi tim).
 6. Menu snack yang tidak diminati adalah setup pisang, bubur kacang hijau, bubur sagu dan tahu fantasi.
 7. Menu 2 adalah menu yang paling banyak sisa makanan, terdiri dari Menu Pagi (Sup (Manisah, Ayam Dadu, Wortel, Bihun), Tahu Rempah, Abon, Telur Rebus), Menu Siang (Sayur Bening (Bayam, Jagung, Wortel, Manisah), Ayam Wijen, Bakwan Jagung, Telur Gulung) dan Menu Sore (Koloke (Ayam Goreng Fillet, Timun, Wortel), Tempe Goreng, Bakso Mekar Goreng).

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan edukasi kepada keluarga dan pasien terkait pemberian diit dan pembatasan makanan dari luar.
2. Melakukan plating secara menarik.
3. Mengadakan cooking class.
4. Memperbaiki dari segi rasa, tampilan dan menu.
5. Mengurangi porsi nasi pada setiap penyajian.
6. Mengganti menu snack yang tidak diminati.
7. Menimbang sisa makanan tanpa kuah.

Februari 2025							
1.	01/02/2025	Abid Fadhul Abyan	B3C-4	Sendok			Sendok hilang pasien sudah pulang
2.	01/02/2025	Cholifah	B5C-4	Sendok			Sendok hilang pasien sudah pulang
3.	04/02/2025	Widya Dwi Anandita	D6A-11	Sendok			Sendok hilang pasien sudah pulang
4.	05/02/2025	Arzanka Daneswara Ghazali	A1	Sendok Makan			Sendok terbawa pulang
5.	05/02/2025	Arzanka Daneswara Ghazali	A1	Sendok Snack			Sendok terbawa pulang
6.	06/02/2025	Chabibatul Aziizah	B3C-1	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
7.	06/02/2025	Mimi Eka	D4C-7	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
8.	19/02/2025	Ni'matul Udhma Himza	D3B-3	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
Maret 2025							
1.	11/03/2025	Muhammad Syifa	V3 (VIP)				Sendok hilang pasien sudah pulang
2.	24/03/2025	Pranata Dimas Ariansyah	C3C-10				Sendok hilang pasien sudah pulang
3.	25/03/2025	Mistianingsih	C3A-4				Sendok hilang pasien sudah pulang
April 2025							
1.	17/04/2025	Achmad Yogie Septiansyah	B2-5C	Gelas			Sudah pembayaran
Mei 2025							
1.	05/05/2025	Kasiati	D8A-12	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang
2.	12/05/2025	Adhibah Mahirah	C3C-3	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah

		Azizah					pulang
3.	28/05/2025	Ika Rodyana	D6A-8	Sendok Makan			Sendok hilang pasien sudah pulang

Analisis :

Dari table diatas dapat diketahui bahwa da 3 pasien yang menghilangkan alat makan, SPO tidak dijalankan, kehilangan alat makan tidak tertagihkan oleh Kasir saat pasien KRS.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Mencantumkan tata tertib menjaga fasilitas pada GC, sehingga petugas admisi dapat mengedukasi saat melakukan pendaftaran, jika pasien menghilangkan atau merusak fasilitas maka wajib mengganti. Sementara menggunakan catatan tertulis selama GC yang lama belum habis.
2. Melakukan supervisi “SPO Pengecekan Fasilitas RS Sebelum Pasien KRS”, sebagai panduan petugas dalam pelayanan dimana terdapat kolaborasi antara Instalasi Gizi, Perawat Ruangan , CS Pantry dan Ruangan, dan Kasir.

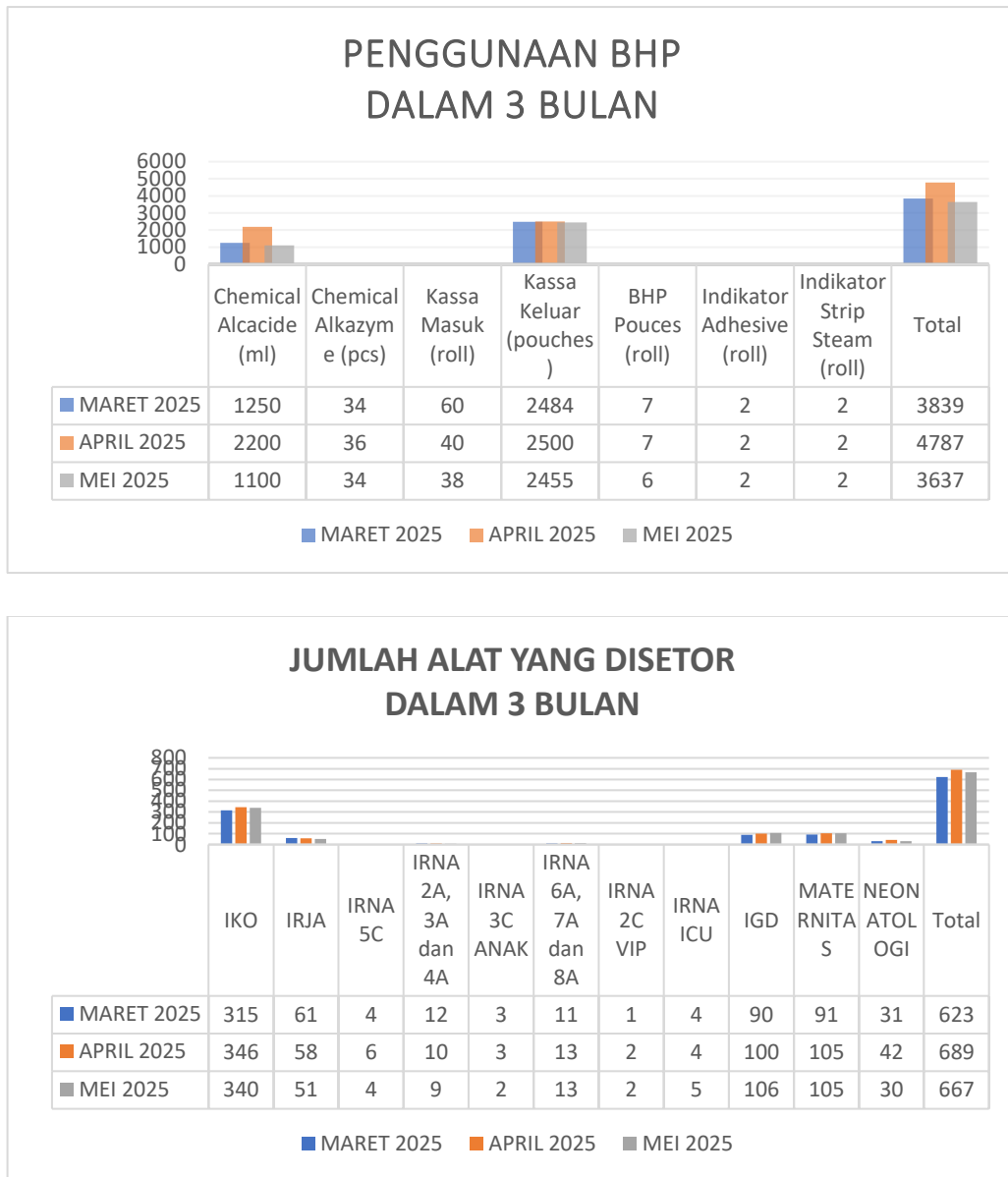
4.4.7 CSSD – Laundry

4.4.7.1 CSSD

4.4.7.2 Tabel Jumlah Pengeluaran Bahan Habis Pakai dan Alat yang Disetor ke CSSD Mei 2025

NO	HAL	BULAN TAHUN 2024		
		MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025
BHP				
1.	Chemical Alcacide (ml)	1250	2200	1100
2.	Chemical Alkazyme (pcs)	34	36	34
3.	Kassa Masuk (roll)	60	40	38
4.	Kassa Keluar (pouches)	2484	2500	2455
5.	BHP Pouces (roll)	7	7	6
6.	Indikator Adhesive (roll)	2	2	2
7.	Indikator Strip Steam (roll)	2	2	2
Alat Yang Disetor				
8.	IKO	315	346	340
9.	IRJA	61	58	51
10.	IRNA 5C	4	6	4
11.	IRNA 2A, 3A dan 4A	12	10	9
12.	IRNA 3C ANAK	3	3	2
13.	IRNA 6A, 7A dan 8A	11	13	13
14.	IRNA 2C VIP	1	2	2
15.	IRNA ICU	4	4	5
16.	IGD	90	100	106
17.	MATERNITAS	91	105	105
18.	NEONATOLOGI	31	42	30
Jumlah		623	689	667

4.4.7.3 Grafik Jumlah Alat Yang Disetor ke CSSD Bulan Mei 2025



Analisis :

1. Dari data diatas dapat diketahui bahwa, pengeluaran BHP dalam 3 bulan terakhir adalah stabil, ada penurunan tetapi tidak signifikan. Hal ini berbanding lurus dengan penurunan jumlah kunjungan pasien baik rawat inap maupun rawat jalan dan produktivitas CSSD membuat kassa steril meningkat (stok di CSSD untuk menghindari masa expired di Gudang Farmasi).
2. Jumlah alat yang disterilisasi paling banyak dari Unit IKO dengan jumlah setor alat pada Bulan Mei 2025 yaitu sejumlah 340 set, diikuti dari Unit IGD 106 set dan Unit Maternitas 105 set. Dimana dari ketiga unit tersebut paling sering melakukan tindakan.
3. Unit IRJA mengalami penurunan hal ini disebabkan karena penurunan jumlah kunjungan pasien rawat jalan karena pegajian cuti Dokter Spesialis meningkat.
4. Dengan perbaikan pencatatan menggunakan google spreadsheet data yang diambil valid,

namun penggolongan kategori alat tidak seragam, seperti gunting talpus terhitung 1 alat dan set partus juga terhitung 1 alat.

5. Penggunaan BHP meningkat tidak sebanding dengan jumlah alat yang disetor, hal ini disebabkan karena alat yang disetor terbanyak dari IKO dan Maternitas, dimana alat-alat tersebut kemungkinan besar terdapat noda membandel.
6. Terjadi peningkatan pengeluaran alcacide secara drastis, hal ini disebabkan karena unit IKO ada permintaan alcacide 1 jirigen untuk precleaning alat saat malam hari.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Memperbaiki pencatatan keluar masuk alat bersih dan kotor per bulan dengan kesepakatan alat yang dihitung.
2. Pendistribusian kasa steril dalam bentuk pouches terpusat di Gudang Farmasi, dengan jadwal permintaan BMHP seminggu 2x.
3. Monitoring dan Evaluasi pencatatan digital.
4. Melakukan orientasi petugas baru di CSSD.

4.4.7.4 Tabel Penggunaan Reuse Pada Bulan Mei Tahun 2025

Nama Alat	Reuse ke1
Junctionrees	-
Breathing circuit	-

Analisis :

Tidak ada permintaan alat reuse pada Bulan Mei 2025.

4.4.7.4 Tabel Hasil Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit CSSD

UNIT	BULAN			TOTAL 3 BULAN
	MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025	
Kejadian instrument kurang				
IKO	1	1	4	6
IGD	0	0	0	0
IRNA	0	0	0	0
IRJA	0	0	1	1
Kejadian Instrumen Hilang				
IKO	0	0	0	0
IGD	2	2	0	4
IRNA	0	0	0	0
IRJA	0	0	0	0

Analisis :

1. Ditemukan kejadian instrument kurang di IKO, sebanyak 4 kali, yaitu duk klem, handmess, suction, naldfudder. Hal ini ditemukan ketika perawat setor alat kotor dan langsung dicek oleh petugas CSSD, setelah ditelusur ditemukan di unit.
2. Ditemukan kejadian instrument kurang di IRJA, sebanyak 1 kali, yaitu gunting halus.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan pencatatan saat ada penemuan.
2. Melaporkan temuan kepada Kabid Keperawatan untuk dilakukan pendisiplinan petugas.
3. Melakukan penggantian alat hilang oleh unit yang bersangkutan.

4.4.7.5 Tabel Rekap Data Permintaan Instrumen Cito Selama Bulan Mei 2025

UNIT	JUMLAH PERMINTAAN CITO			KETERANGAN
	MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025	
IKO	0	0	0	
IGD	0	0	0	
IRNA	0	0	0	
IRJA	0	0	0	

Analisis :

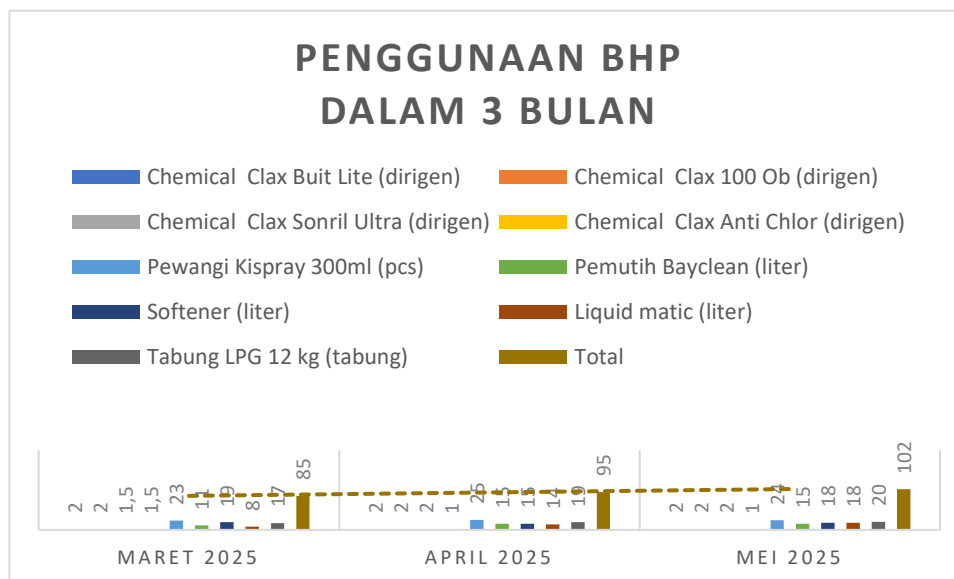
Tidak ada permintaan instrument cito selama 3 bulan terakhir, hal ini dipengaruhi ketertiban petugas dalam menyetorkan instrument kotor sehingga unit saat meminta alat selalu tersedia.

Rencana Tindak Lanjut : -**1.4.7.2 Laundry****1.4.7.2.1 Tabel Jumlah Pencucian Linen di Laundry pada Bulan Mei Tahun 2025**

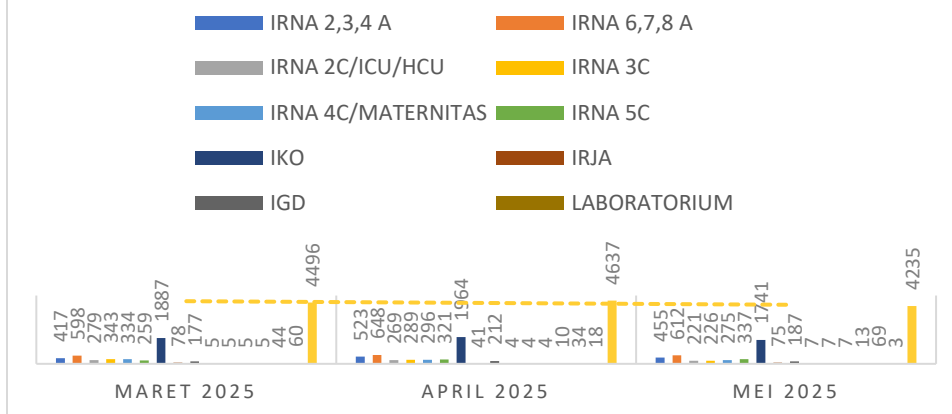
NO	HAL	BULAN		
		MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025
BHP				
1.	Chemical Clax Buit Lite (dirigen)	2	2	2
2.	Chemical Clax 100 Ob (dirigen)	2	2	2
3.	Chemical Clax Sonril Ultra (dirigen)	1.5	2	2
4.	Chemical Clax Anti Chlor (dirigen)	1.5	1	1
5.	Pewangi Kispray 300ml (pcs)	23	25	24
6.	Pemutih Bayclean (liter)	11	15	15
7.	Softener (liter)	19	15	18
8.	Liquid matic (liter)	8	14	18
9.	Tabung LPG 12 kg (tabung)	17	19	20
Total		85	95	102
LINEN (kg)				
1.	Linen Infeksius	2347	2556	2266
2.	Linen Non Infeksius	2149	2076	1969
3.	IRNA 2,3,4 A	417	523	455
4.	IRNA 6,7,8 A	598	648	612
5.	IRNA 2C/ICU/HCU	279	269	221
6.	IRNA 3C	343	289	226
7.	IRNA 4C/MATERNITAS	334	296	275
8.	IRNA 5C	259	321	337
9.	IKO	1887	1964	1741
10.	IRJA	78	41	75

11.	IGD	177	212	187
12.	LABORATORIUM	5	4	7
13.	RADIOLOGI	5	4	7
14.	DAPUR/GIZI	5	4	7
15.	CSSD	5	10	13
16.	Linen MS	44	34	69
17.	Umum	60	18	3
Total		4496	4632	4235

1.4.7.2.2 Grafik Jumlah Pencucian Linen di Laundry Pada Bulan Mei Tahun 2025



JUMLAH PENCUCIAN LINEN DI LAUNDRY DALAM 3 BULAN



Analisis :

1. Data diatas adalah jumlah pencucian linen pada Bulan Mei 2025 sebanyak 4235kg, mengalami penurunan karena sebanding dengan penurunan kunjungan pasien rawat inap.
2. Jumlah linen infeksius sebesar 2266 kg, sebagian besar berasal dari IKO. Meskipun produktivitas IKO pada Bulan Mei 2025 menurun.
3. Penggunaan BHP meningkat, tidak sebanding dengan jumlah pencucian linen. Hal ini disebabkan ada permintaan BHP di akhir bulan, perhitungan tidak valid.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan breakdown pencatatan linen infeksius/non infeksiun per unit.
2. Dilakukan perubahan alur permintaan linen bersih menggunakan digital form per unit, dilakukan pendistribusian sehari 2 kali untuk memenuhi kebutuhan unit sesuai dengan permintaan, yang dilaksanakan mulai awal Tahun 2025.
3. Rencana akan dilakukan pencatatan keluar masuknya linen menggunakan google spreadsheet per hari nya.
4. Rencana akan dilakukan stok opname setiap bulan.
5. Pemampatan jadwal dinas malam untuk memaksimalkan pekerjaan.
6. Perubahan alur pengambilan linen yang perlu disterilisasi, dilakukan oleh petugas CSSD karena petugas laundry yang kurang.

4.4.7.2.3 Tabel Inventarisasi Linen Laundry Pada Bulan Mei 2025

NO	NAMA / JENIS LINEN	MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025
1.	Sprei	140	220	205
2.	Sarung bantal	250	325	311
3.	Selimut	209	201	195
4.	Baju tim IKO	117	114	113
5.	Baju ganti pasien	44	41	40

6.	Skort	154	151	150
7.	Perlak	35	31	31
8.	Baju ganti laundry	15	15	15
9.	Duk lubang besar	21	21	21
10.	Duk pembungkus	59	59	56
11.	Duk kecil 1 meter	58	55	50
12.	Duk ortho	18	16	15
13.	Duk lubang kecil	17	17	17
14.	Duk kaki	11	11	11
15.	Meja mayo	21	20	20
16.	Skort IKO	62	61	61
17.	Waslap	66	64	64
18.	Handuk CSSD	10	10	10
19.	Bantal	122	140	131
20.	Baju Pasien	15	35	34

1.4.7.2.3 Tabel Rekap Kerusakan Linen dan Pemusnahan Pada Bulan Mei 2025

NO	NAMA / JENIS LINEN	MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025
1.	Sprei	45	20	15
2.	Sarung bantal	25	25	14
3.	Selimut	7	8	6
4.	Duk Pembungkus	0	0	3
5.	Duk Lubang Kecil	1	0	0
6.	Celana Tim IKO	0	3	1
7.	Baju Tim IKO	0	3	1
8.	Baju Pasien	0	0	1
9.	Skort	4	4	1
10.	Perlak	0	4	0
11.	Baju Ganti Laundry	0	0	0
12.	Duk Kecil	0	3	5
13.	Waslap	5	2	0
14.	Handuk CSSD	0	0	0
15.	Bantal	3	2	9
16.	Kerudung	0	0	0
17.	Kantung L	0	2	4
18.	Meja Mayo	0	1	0
PEMUSNAHAN (+)		TANGGAL 27/01/2025	DIJADWALKAN 6 BULAN SEKALI	DIJADWALKAN 6 BULAN SEKALI

Analisis :

1. Petugas melakukan sortir setiap hari, linen tidak layak dijadikan satu dan diajukan untuk dilakukan pemusnahan, BA sudah dikirim ke PT sebagai lampiran untuk penambahan linen pengganti.
2. Linen spre, selimut dan sarban yang rusak disebabkan karena sudah tipis dan bernoda yang sulit dikembalikan seperti semula.

3. Duk pembungkus dan duk kecil juga sudah tipis, sementara untuk baju tim yang rusak karena bolong dan tidak bisa dilakukan permak lagi.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Follow up Pengadaan PT
2. Jadwal pemusnahan linen selanjutnya pada Bulan Juli 2025

1.4.7.2.4 Tabel Pelaporan Limbah atau Benda Asing Tercampur Linen Pada Bulan Mei Tahun 2025

NO	NAMA BENDA	JUMLAH		
		MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025
1.	Masker IKO	3	1	3
2.	Tissue	3	6	5
3.	Jarum	0	1	0
4.	Bumbu Dapur	0	0	0
5.	Uang	0	0	0
6.	Alat Tulis	0	1	0
7.	Benda lainnya	0	1 (selang oksigen)	7 (underpad, selang oksigen)

Analisis :

1. Masih ditemukan benda asing tercampur dengan linen, karena pemilahan seharusnya dilakukan di Unit sebelum linen dimasukkan kedalam tong linen kotor.
2. Ketidaksiplinan paling banyak dari Unit IKO.
3. Hal ini dapat menyebabkan kontaminasi terhadap linen lainnya dan dapat menyebabkan kerusakan pada mesin.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan sosialisasi kepada unit.
2. Melakukan pendokumentasian dan pencatatan kemudian dilaporkan kepada Kabid Keperawatan dan SDM terkait hasil evaluasi.

4.4.7.5 Tabel Permintaan Linen Cito/Tidak Sesuai Jadwal Pada Bulan Mei 2025

UNIT	Tanggal	Jenis Linan	Jumlah	Alasan
-	-	-	-	-

Analisis :

Tidak ada permintaan linen cito dari unit, hal ini dikarenakan laundry memiliki jadwal permintaan linen sehari 2 kali, dan laundry standby 24 jam.

Rencana Tindak Lanjut : -

4.5 Kinerja Bidang Umum dan Keuangan

4.5.7 SDM

3.5.7.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	0	0
2	Kabid Pelayanan Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
3	Kabid Penunjang Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	1	0
5	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Satuan Pengawas Internal	SMK	1	1	1	0	0
7	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
8	Dokter Casemix	Dokter Umum	2	2	0	2	0
9	Farmasi	Profesi Apoteker	41	13	6	7	0
		S1 Farmasi		3	2	1	0
		D3 Analis Farmasi dan Makanan		1	1	0	0
		D3 Farmasi		9	2	7	0
		SMK		4	3	1	0
		SMA		1	1	0	0
10	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	10	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	7	1	0
		SMK		0	0	0	0
		SMA		1	1	0	0
11	CSSD	D3 Keperawatan	5	3	2	1	0
		SMA		1	1	1	0
		SMK		1	0	1	0
12	Fisioterapi	S1 Fisioterapi	5	1	0	1	0
		D3 Fisioterapi		3	2	1	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	0
13	Gizi	S1 Ilmu Gizi	17	2	2	0	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	2	0	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		7	0	7	0
		SMA		1	0	1	0
		SMP		3	2	1	0
14	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	1	0	1	0
		S1 Teknik Informatika		1	0	1	0
15	ICU dan HCU	Profesi Ners	12	6	6	0	0
		D3 Keperawatan		6	5	1	0
16	IGD	Profesi Ners	24	11	8	3	0
		D3 Keperawatan		8	6	2	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
17	IKO	Profesi Ners	12	7	7	0	0

		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
18	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
19	IPSRs	S1 Tenik Elektro	6	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	3	0	0
20	IRJA	Profesi Ners	27	8	7	1	0
		D3 Keperawatan		14	13	1	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
21	IRNA 2C	Profesi Ners	8	6	5	1	0
		D3 Keperawatan		2	2	0	0
22	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	18	5	4	1	0
		D3 Keperawatan		13	7	6	0
23	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	15	6	4	0	0
		D3 Keperawatan		8	7	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
24	IRNA 5C	Profesi Ners	9	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		6	4	2	0
25	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	25	12	6	6	0
		D3 Keperawatan		13	8	3	0
26	Maternitas	Profesi Kebidanan	12	2	0	2	0
		D4 Kebidanan		2	1	1	0
		D3 Kebidanan		8	8	0	0
27	Neonatologi	Profesi Ners	7	2	2	0	0
		D3 Keperawatan		5	4	0	1
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
28	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	10	2	2	0	0
		S1 Akuntansi		2	0	2	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
29	Laboratorium	D4 Analisis Kesehatan	10	2	1	1	0
		D3 Analisis Kesehatan		8	7	1	0
30	Laundry	SMK	5	1	0	1	0
		SMA		3	0	3	0
		SMP		1	0	1	0
31	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	10	10	10	0	0
32	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	18	1	1	0	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D4 Destinasi Wisata		1	0	1	0
		D3 Asuransi Kesehatan		2	0	2	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		6	4	2	0
		D1 Administrasi Perkantoran		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		4	4	0	0

33	PIPP & MPP	Profesi Ners	5	2	1	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
34	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	0	0
35	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	5	2	0
36	SDM	S1 Psikologi	2	1	0	1	0
		S1 Ilmu Sosial		1	1	0	0
37	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	0	0
38	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	0	0
39	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
40	Cleaning Service	SMK	46	17	8	9	0
		SMA		24	20	4	0
		SMP		5	5	0	0
41	Security	SMK	12	5	2	3	0
		SMA		7	6	1	0
42	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	5	1	1	0	0
		SMA		3	2	1	0
		SMP		1	1	0	0
43	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
44	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	5	4	1	4	0
45	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
46	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
47	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
48	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
49	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
50	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
51	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
54	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Orthopedi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0

	dan Traumatolog y						
56	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
59	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
61	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total			460				

Keterangan :
 Pada bulan Mei 2025 terdapat penambahan 1 Dokter Umum baru, 1 Dokter Spesialis Anestesi baru, dan 2 pengaktifan staf TTK.

3.5.1.1 Update STR / SIP

NO	NAMA	PROFESI	TANGGAL KEJADIAN	KETERANGAN
1	Diamirta Agustin Miftachul, A.Md.Farm	TTK	05 Mei 2025	SIP Baru
2	dr. Amanda Firmandani	Dokter Umum (Dokter Casemix)	05 Mei 2025	SIP Baru
3	Noor Rochmat Hidayatullah, S.Tr.Kep	Perawat	24 Januari 2025	SIP Perpanjangan
4	Oktavia Amelia Sari, A.Md.Kep	Perawat	09 Mei 2025	SIP Perpanjangan
5	Ikha Farida Octaviana, A.Md.Keb	Bidan	09 Mei 2025	SIP Perpanjangan
6	Fitri Octavia, A.Md.Kep	Perawat	15 April 2025	SIP Perpanjangan
7	Puput Sekar Nariratih, A.Md.Keb	Bidan	15 Mei 2025	SIP Perpanjangan
8	Kiki Sandra, A.Md.Kep	Perawat	15 Mei 2025	SIP Perpanjangan
9	Triasih, A.Md.Kep	Perawat	23 Mei 2025	SIP Perpanjangan
10	dr. Ageng Sunjoyo, Sp.An-Ti	Dokter Spesialis Anestesi	28 Mei 2025	SIP Baru

Keterangan : Pada bulan Mei 2025 3 SIP baru dan 7 SIP perpanjangan.

3.5.1.2 Rekrutmen

NO	PROFESI	JUMLAH YANG DIBUTUHKAN	TERPENUHI	KEKURANGAN	PENYEBAB	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Terapi Okupasi	1	0	1	Sulit mencari kandidat terapis okupasi	Menghubungi sosial media komunitas terapis okupasi,

						menghubungu kampus dengan jurusan terapis okupasi
2	Dokter Spesialis Bedah Mulut	1	0	1	Sulit mencari kandidat Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	Menghubungi kampus dengan jurusan tersebut
3	Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	1	0	1	Sulit mencari Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	Menghubungi kampus dengan jurusan tersebut
4	Dokter Spesialis Radiologi	1	0	1	Belum mendapatkan kandidat	Dibutuhkan yang Perempuan
5	Fisioterapis	5	4	1	Belum mendapatkan kandidat yang cocok	Sedang proses pemenuhan
6	Perawat Gigi	2	1	1	Sudah ACC dari PT DPM	Open recruitment setelah hari raya
7	Terapis Wicara	2	1	1	On proses pengajuan ke PT DPM	On proses pengajuan ke PT DPM

3.5.1.3 Orientasi Staf Baru

3.5.1.3.1 Orientasi Staf

NO	TANGGAL	JENIS ORIENTASI	NAMA STAF	PENDIDIKAN	PROFESI	SPMJ (TANGGAL MASUK)	KETERANGAN
1	01 Maret 2025	Orientasi Khusus	dr. Annishafira Widyawardhani	Profesi Kedokteran	Dokter Umum	01 Maret 2025	Orientasi khusus s.d 31 Mei 2025
2	9 April 2025	Orientasi Khusus	dr. Gusti Gandha Pandya	Profesi Kedokteran	Dokter Umum	09 April 2025	Orientasi khusus s/d 09 Juli 2025
3	01 Mei 2025	Orientasi Khusus	dr. Amanda Firmandani	Profesi kedokteran	Dokter Umum	01 Mei 2025	Orientasi khusus s/d 31 Juli 2025
4	01 Mei 2025	Orientasi Khusus	Nabila Rizki Amalia, S.Tr.Kes	D4 Analis Kesehatan	Analis Kesehatan	01 Mei 2025	Orientasi khusus s/d 31 Juli 2025

Keterangan :

Pada bulan Mei 2025 terdapat 4 staf yang menjalani orientasi khusus

3.5.1.4 Diklat

NO	JUDUL DIKLAT	JENIS DIKLAT	JUMLAH PESERTA		TANGGAL PELAKSANAAN	SERTIFIKAT	
			HADIR	TIDAK HADIR		ADA	TIDAK
1	Diklat PMKP Dasar	Internal	214	-9	13 Mei 2025	V	
2	Diklat PMKP Dasar	Internal	148	7	14 Mei 2025	V	
3	Diklat CSSD dengan Vendor PT Global Dispo Medika	Inhouse Training	42	3	19 Mei 2025		V
4	Diklat PPI Dasar	Internal	161	81	21 Mei 2025	V	
5	Diklat PPI Dasar	Internal	153	6	22 Mei 2025	V	

3.5.1.5 Evaluasi Kinerja Staf

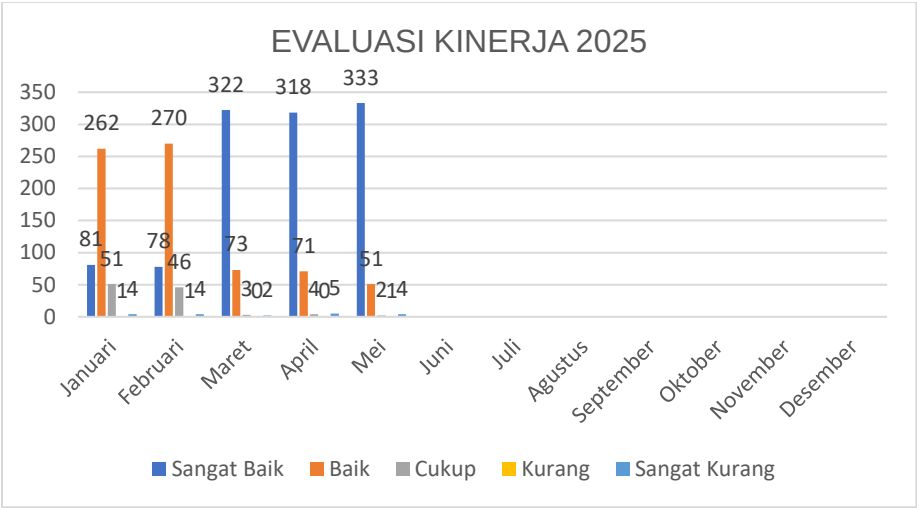
NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
1	Direktur	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit Direktur secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
2	Kabid Pelayanan Medis	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Pelayana Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
3	Kabid Penunjang Medis	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit KABid Penunjang Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
4	Kabid Keperawatan	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Keperawatan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
5	Kabid Umum & Keuangan	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Umum & Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
6	Satuan Pengawas Internal	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Satuan Pengawas Internal secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
7	Farmasi	Umum	40	2	22	18	2	0	Unit Farmasi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
8	Asuransi Center	Umum	10	0	10	0	0	0	Unit Asuransi Center secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
9	CSSD	Umum	5	0	5	0	0	0	Unit CSSD secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
10	Fisioterapi	Umum	5	0	3	2	0	0	Unit Fisioterapi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
11	Gizi	Umum	17	0	15	2	0	0	Unit Gizi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
12	Humas & Marketing & PKRS	Umum	2	0	2	0	0	0	Unit Humas Markrting & PKRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
13	ICU dan HCU	Umum	12	0	10	2	0	0	Unit ICU & HCU secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
14	IGD	Umum	25	0	21	4	0	0	Unit IGD secara keseluruhan mendapatcatatan baik dalam penilaian kinerja umum.
15	IKO	Umum	12	0	11	1	0	0	Unit IKO secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
16	IPCN	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit IPCNsecara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
17	IPSRs	Umum	6	0	5	1	0	0	Unit IPSRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	IRJA	Umum	27	0	23	4	0	0	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	IRNA 2C	Umum	8	0	7	1	0	0	Unit IRNA 2C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
19	IRNA 2A, 3A, & 4A	Umum	18	0	15	3	0	0	Unit IRNA 234A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
20	IRNA 3C Anak	Umum	15	0	13	2	0	0	Unit IRNA 3C Anak secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
21	IRNA 5C	Umum	9	0	7	2	0	0	Unit IRNA 5C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
22	IRNA 6A, 7A, & 8A	Umum	24	0	21	3	0	0	Unit IRNA 6A, 7A & 8A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
23	Maternitas	Umum	12	0	9	3	0	0	Unit Maternitas secara keseluruhan mendapat catatan

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
									baik dalam penilaian kinerja umum.
24	Neonatologi	Umum	9	0	8	1	0	0	Unit Neonatologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
25	Keuangan & Akuntansi	Umum	10	0	6	4	0	0	Unit Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
26	Laboratorium	Umum	10	0	9	1	0	0	Unit Laboratorium secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
27	Laundry	Umum	5	0	5	0	0	0	Unit Laundry secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
28	Rekam Medis	Umum	9	0	9	0	0	0	Unit Rekam Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
29	Pendaftaran	Umum	18	0	16	2	0	0	Unit Pendaftaran secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
30	PIPP & MPP	Umum	5	0	4	1	0	0	Unit PIPP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum. Terdapat 1 staf dengan evaluasi kinerja sangat kurang dikarenakan cuti melahirkan.
31	PMKP	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Mutu & PMKP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
32	Radiologi	Umum	7	0	7	0	0	0	Unit radiologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
33	SDM	Umum	2	0	2	0	0	0	Unit SDM secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
34	Sekretaris	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Sekretaris secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
35	SIMRS & IT	Umum	3	0	2	1	0	0	Unit IT SIMRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
36	Umum & Rumah Tangga	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
37	Cleaning Service	Umum	45	1	32	12	1		Unit Cleaning Service secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
38	Security	Umum	12	0	12	0	0	0	Unit Security secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
39	Driver	Umum	5	0	4	1	0	0	Unit Driver secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
40	Gudang Umum	Umum	1	1	0	0	1	0	Unit Gudang Umum secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

Analisis :
Hampir seluruh unit di RS Prima Husada Malang berada pada kategori Sangat Baik pada penilaian umum periode Mei 2025.

3.5.1.5.1 Grafik Evaluasi Kinerja Karyawan



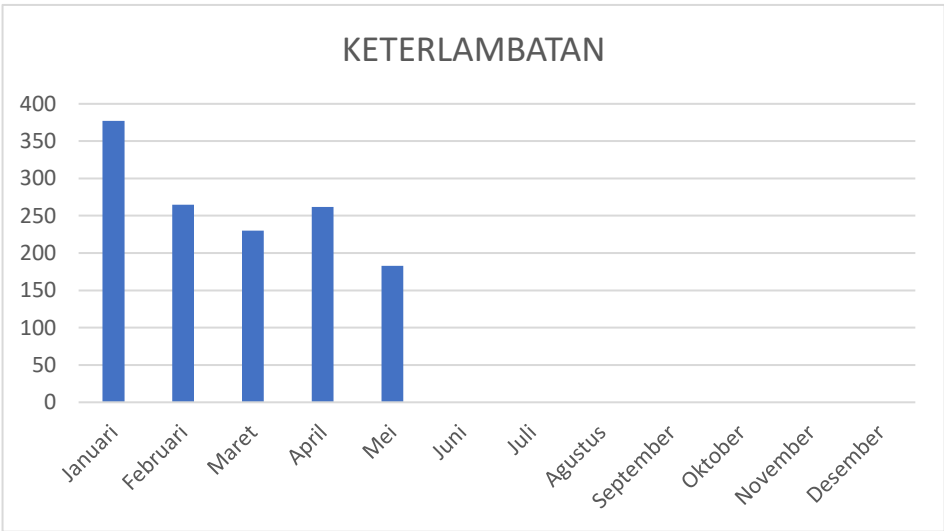
Kategori	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Sangat Baik	81	78	322	318	333							
Baik	262	270	73	71	51							
Cukup	51	46	3	4	2							
Kurang	1	1	0	0	1							
Sangat Kurang	4	4	2	5	4							
TOTAL	399	399	400	398	391							

Analisa :
Secara umum terdapat peningkatan kinerja dari staf dilihat dari jumlah kategori cukup yang naik menjadi kategori diatasnya.

Rencana Tindakanlanjut :

- 1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
- 2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
- 3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
KETERLAMBATAN	377	265	230	262	183							



Analisa :

Secara umum terdapat penurunan keterlambatan karyawan. Hal ini dikarenakan followup berkala oleh staf SDM kepada Karu.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
- 2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
- 3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.

3.5.1.6 Konseling

3.5.1.6.1 Tabel Capaian Konseling Perbulan Tahun 2025

NO	UNIT	JUMLAH KONSELING GRUP	JUMLAH KONSELING INDIVIDU					
			KONTRAK N-ED	TERKAIT TATA TERTIB	TERKAIT KETIDAKPATUHAN MUTU	TERKAIT KETIDAKPATUHAN PPI	TERKAIT MANRISK	KARIR
1	Manajerial RS	0	0	0	0	0	0	0
2	SDM	0	0	0	0	0	0	0
3	Asuransi Center	0	0	0	0	0	0	0
4	IRNA 2C	0	0	0	0	0	0	0
5	IRNA 3C Anak	0	0	0	0	0	0	0
6	IRNA 3A & 4A	0	0	0	0	0	0	0
7	IRNA 5C	0	0	0	0	0	0	0
8	IRNA 6A & 7A	0	0	0	0	0	0	0
9	Maternitas	0	0	0	0	0	0	0
10	Neonatologi	0	0	0	0	0	0	0
11	IGD	0	0	0	0	0	0	0
12	ICU	0	0	0	0	0	0	1
13	HCU	0	0	0	0	0	0	0
14	IKO	0	0	0	0	0	0	0
15	Gizi	0	0	0	0	0	0	1
16	Farmasi	0	0	0	0	0	0	0
17	Laboratorium	0	0	0	0	0	0	0
18	Radiologi	0	0	0	0	0	0	0
19	Rekam Medis	0	0	0	0	0	0	0
20	Pendaftaran	0	0	0	0	0	0	0
21	CSSD	0	0	0	0	0	0	0
22	Laundry	0	0	0	0	0	0	0
23	Keuangan & Akuntansi	0	0	0	0	0	0	0
24	PIPP	0	0	0	0	0	0	1
25	MPP	0	0	0	0	0	0	0
26	Umum Cleaning Service	0	0	0	0	0	0	0
27	SIMRS	0	0	0	0	0	0	0
28	Driver	0	0	0	0	0	0	0
29	Security	0	0	0	0	0	0	0
30	IRJA	0	0	0	0	0	0	0
31	Rehab Medik	0	0	0	0	0	0	0
32	Kasir Parkir	0	0	0	0	0	0	0
33	Parkir	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	3

Analisis :
Konseling staf dilaksanakan sesuai kebutuhan karir telah dilakukan
Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

Jenis	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Supervisi (2x/bulan)	0	100%	50%	100%	100%							

3.5.1.7 Mutasi

Tabel Daftar Staf Mutasi

NO	NAMA STAF	UNIT ASAL	UNIT BARU
1	Afni Nur Ainy, S.Kep., Ns	IGD	IRNA 5C
2	Ratih Aji Suryamanjari, S.Kep., Ns	IRNA 5C	IGD
3	Haris Fadilah, A.Md.Kep	IRNA 4A	IRJA

Analisis : Pada bulan Mei 2025 terdapat 3 rotasi staf.
Rencana Tindak Lanjut : Melengkapi SK Rotasi dan Penempatan

3.5.2 IPSRS

3.5.2.1 Pemeliharaan Alat Medis

Perhitungan capaian berdasarkan jumlah kunjungan per unit oleh elektromedis ke unit-unit di rumah sakit (33 unit) dalam satu bulan

3.5.2.1.1 Tabel Capaian Maintenance Alat Medis

	Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Capaian Maintenance Ruangan	90%	84.61	66.6	92.3	76,92	89,74							

BULAN	TOTAL ALAT	CAPAIAN	PROSENTASE
Januari	268	154	57.46%
Februari	270	135	50.00%
Maret	276	153	55.43%
April	276	150	54.34%
Mei	275	142	51.64%

TOTAL ALAT (PERBAIKAN)	TOTAL ALAT
Januari	21
Februari	22
Maret	21
April	17
Mei	26

Analisa :
Pada bulan ini, capaian maintenance alat berdasarkan ruangan 89.74% dan jumlah alat 51.64%. Beberapa factor yang menyebabkan fluktuatif antara lain : alat medis masih dipakai oleh pasien, ruangan atau unit masih ada tindakan pasien, perbantuan perbaikan alat medis diluar RSPHM serta beberapa kondisi alat servis yang membutuhkan waktu lebih lama.

Rencana Tindak Lanjut :
Koordinasi dengan PT untuk ATEM sesuai ABK

3.5.2.2 Pemeliharaan Alat Non Medis

3.5.2.2.1 Air Conditioner

3.5.2.2.1.1 Tabel Capaian Pemeliharaan AC Split

BULAN	MAINTENANCE / 1 BULAN	MAINTENANCE / 2 BULAN	MAINTENANCE / 3 BULAN	TOTAL
TARGET/BULAN	42	30	23	95
JANUARI	11	6	16	33
FEBRUARI	23	17	11	51
MARET	14	41	6	61
APRIL	7	30	6	43
MEI	19	18	18	45
JUNI				
JULI				
AGUSTUS				
SEPTEMBER				
OKTOBER				
NOVEMBER				
DESEMBER				

Analisa :

Pada awal januari digunakan metode baru pencatatan kinerja terutama terkait system pencatatan dan target perbulan. Sudah dilakukan pencatatan metode baru, hasil evaluasi lebih baik dari tahun 2024.Pada bulan ini capaian turun

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.3 Genset

1.5.2.2.3.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Genset

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
3	Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
4	April	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
5	Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target

Analisis :

Pada bulan ini, pemeliharaan genset dilakukan 4x dan sudah terlapor dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi berkala

1.5.2.2.4 Panel Listrik

3.5.2.2.4.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Panel

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
2	Februari	3x/bulan	3x/bulan	100%	Sudah mencapai target
3	Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
4	April	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target
5	Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	Sudah mencapai target

Analisis :

Pemeliharaan panel listrik di Gedung A,B,C,D,E dan LVMDP dilakukan 4x dalam satu bulan dan dilakukan rekapan dokumentasi. Kegiatan ini sudah berjalan sesuai target

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.5 Liquid Oksigen

1.5.2.2.5.1 Tabel Pencatatan Liquid Harian

Mei 2025							
Tanggal	Stok Liquid	Sebelum pengisian	Penggunaan	Satuan	Keterangan	Pengiriman	Satuan
01/05/2025	1435	1204	231	MMHG			MMHG
02/05/2025	1204	862	342	MMHG			MMHG
02/05/2025	862	3278	0	MMHG	sesudah pengisian	2416	MMHG
03/05/2025	3278	3064	214	MMHG			MMHG
04/05/2025	3078	2813	265	MMHG			MMHG
05/05/2025	2813	2567	246	MMHG			MMHG
06/05/2025	2567	2291	276	MMHG			MMHG
07/05/2025	2291	2049	242	MMHG			MMHG
08/05/2025	2049	1859	190	MMHG			MMHG
09/05/2025	1859	1561	298	MMHG			MMHG
09/05/2025	1561	3241	0	MMHG	sesudah pengisian	1680	MMHG
10/05/2025	3241	3106	135	MMHG			MMHG
11/05/2025	3106	2851	255	MMHG			MMHG
12/05/2025	2851	2593	258	MMHG			MMHG
13/05/2025	2593	2349	244	MMHG			MMHG
14/05/2025	2349	2090	259	MMHG			MMHG
15/05/2025	2090	1847	243	MMHG			MMHG
16/05/2025	1847	1633	214	MMHG			MMHG
17/05/2025	1633	1386	247	MMHG			MMHG
18/05/2025	1386	922	464	MMHG			MMHG
19/05/2025	922	3542	0	MMHG	sesudah pengisian	2620	MMHG

20/05/2025	3542	3213	329	MMHG			MMHG
21/05/2025	3213	2935	278	MMHG			MMHG
22/05/2025	2935	2657	278	MMHG			MMHG
23/05/2025	2657	2399	258	MMHG			MMHG
24/05/2025	2399	2191	208	MMHG			MMHG
25/05/2025	2191	1981	210	MMHG			MMHG
26/05/2025	1981	1745	236	MMHG			MMHG
27/05/2025	1745	1229	516	MMHG			MMHG
28/05/2025	1229	3336	0	MMHG	sesudah pengisian	2107	MMHG
29/05/2025	3336	3147	189	MMHG			MMHG
30/05/2025	3147	2902	245	MMHG			MMHG
31/05/2025	2902	2675	227	MMHG			MMHG
Jumlah total pemakaian oksigen bulan ini			7597	MMHG			MMHG
Jumlah total pengisian liquid oksigen bulan ini						6407	MMHG
Rata-rata penggunaan okisgen per hari			487,6551724	MMHG			
Rata- rata pengisian liquid per bulan ini						12814	MMHG

Analisis :
 Kegiatan sudah dilakukan dengan baik sesuai target, setiap hari dilakukan pengecekan. Stok oksigen selalu terjaga.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.6 IPAL

1.5.2.2.6.1 Tabel Capaian Pemeliharaan IPAL

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :

Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan. Pencatatan debit IPAL juga dilakukan dan di dokumentasikan.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.7 Filter Air

3.5.2.2.7.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Filter Air

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :

Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.8 Lift

1.5.2.2.8.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Lift

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :

Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.9 UPS

1.5.2.2.9.1 Tabel Capaian Pemeliharaan UPS

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

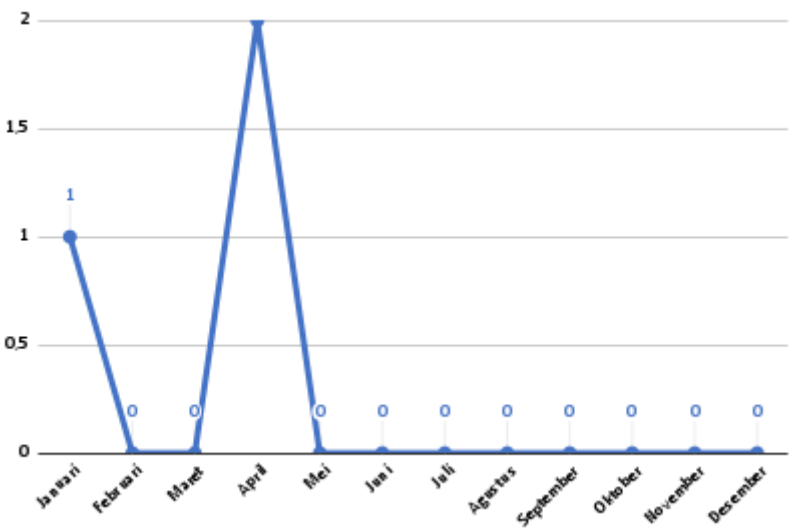
Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.3 Security

3.5.3.1 Tabel Angka Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Angka kejadian kehilangan barang	1	0	0	2	0						

3.5.3.2 Grafik Kejadian Kehilangan Barang



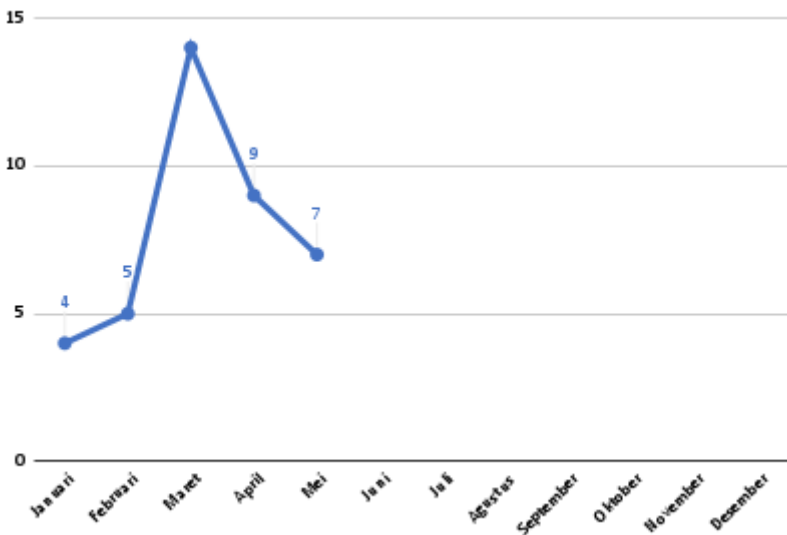
Analisa :
Pada bulan Mei tidak terdapat kehilangan barang

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.3.3 Tabel Angka Potensi Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Angka kejadian kehilangan barang	4	5	14	9	7						

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kehilangan Barang



ANGKA KEJADIAN BARANG BERPOTENSI HILANG		
TANGGAL	KETERANGAN	RTL
13 – 05 – 2025	Botol karyawan tertinggal saat doa pagi , diamankan di ruang cssd	Sudah di ambil pemilik
13 – 05 – 2025	Kunci motor karyawan tertinggal di area parkir karyawan di amankan di pos IGD	Sudah di ambil pemilik
14 – 05 – 2025	Kunci motor karyawan tertinggal di area parkir karyawan di amankan di pos IGD	Sudah di ambil pemilik
18 – 05 -2025	Telah ditemukan STNK kendaraan bermotor di depan pos DPM , diamankan di pos IGD	Masih di pos security IGD
18 – 05 -2025	Kunci motor karyawan tertinggal di area parkir karyawan di amankan di pos IGD	Sudah di ambil pemilik
22 – 05 – 2025	Telah ditemukan berkas foto rontgen milik pasien di amankan di CSO	Sudah di ambil pemilik
27 – 05 – 2025	Ditemukan tas milik pasien tertinggal di ruang tunggu farmasi ,barang diamankan di farmasi	Sudah di ambil pemilik

Analisis :

Barang hilang sudah dikembalikan ke pemilik. Alur berjalan baik. Pencatatan telah dilakukan dengan baik.

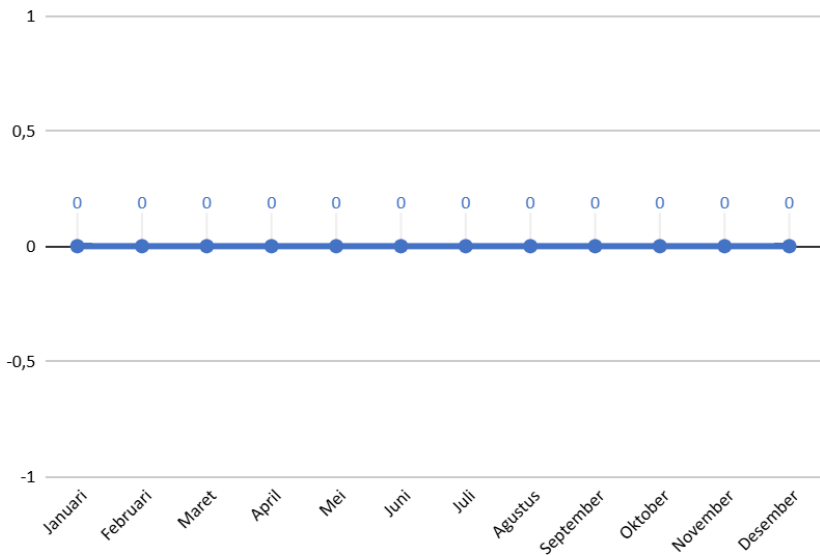
Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.3.3 Tabel Angka Kekerasan di Lingkungan Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1.	Angka kejadian kekerasan	0	0	0	0	0						

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kekerasan

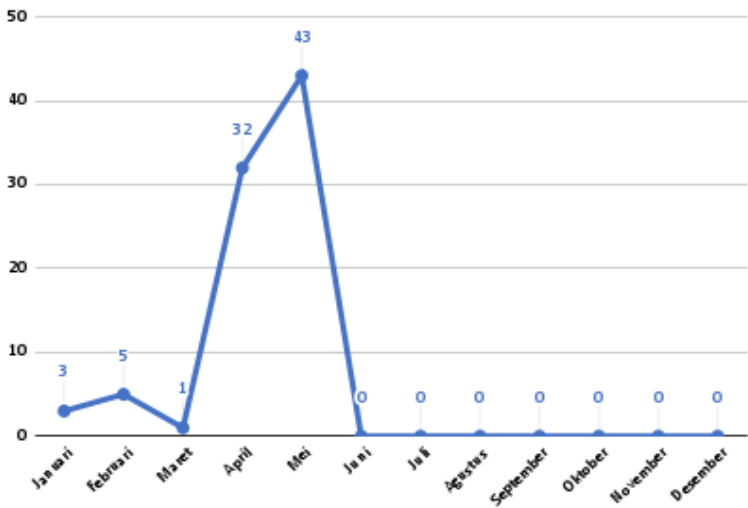


Analisis :
Tidak terdapat kejadian kekerasan karena pelayanan dilakukan dengan baik oleh seluruh karyawan dan tidak ada oknum yang menciptakan kerusakan.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.3.5 Tabel Angka Kejadian Merokok di Area Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Angka kejadian merokok di area Rumah Sakit	3	5	1	32	45							



Analisis :

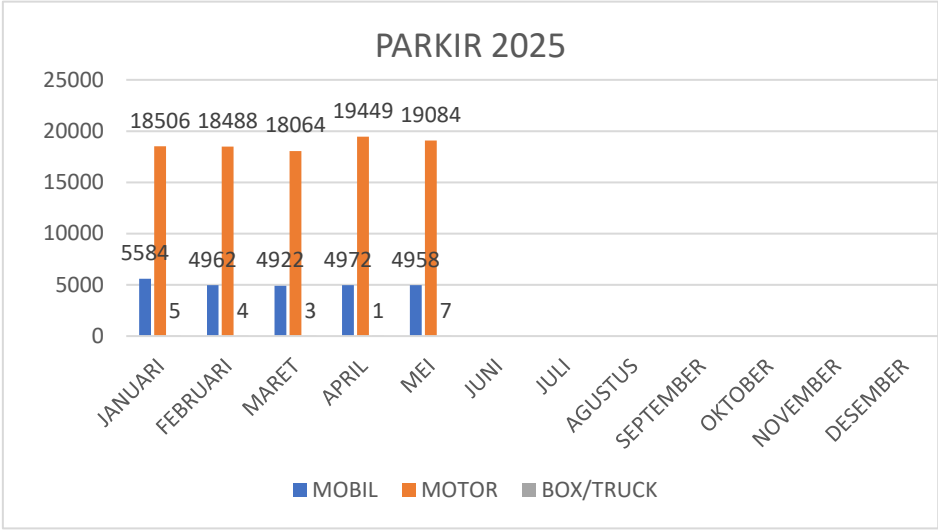
Security sudah mulai patuh dalam hal pelaporan dan rekap

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.4 Parkir

3.5.4.1 Grafik Jumlah Parkir Keluar Non Member



Analisis :

Progres parkir bulan ini menurun akibat jumlah hari aktif yang lebih sedikit serta fluktuatif kunjungan pasien.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.5 Humas Marketing

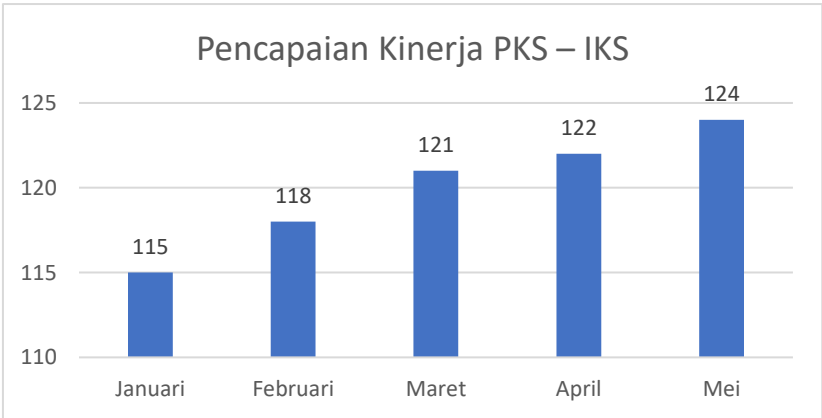
3.5.5.1 Perjanjian Kerjasama (PKS)

3.5.5.1.1 Pencapaian Kinerja PKS – IKS Mei 2025

No	Bulan	Target	Jumlah				Progres	Total Kurang
			Berlaku	ED	Baru	Kurang Baru		
1	Januari 2025	1 IKS baru	115	6	0	0	2 (review pihak kedua) 1 (progres evaluasi) 1 (tdk diperpanjang)	4
2	Februari 2025	1 IKS baru	118	1	1	0	3 (Proses Tanda Tangan Pihak kedua)	3
3	Maret 2025	1 IKS baru	121	1	1	0	1 (Proses review)	1
4	April 2025	1 IKS baru	122	1	1	0	1 (Proses Review Pihak ke 2)	1
5	Mei 2025	1 IKS baru	124	0	1	0	1 (Proses Review Pihak ke 2)	1
Analisis ; - Pada bulan Mei 2025, PKS dengan instansi pemerintah masih dalam progress, Proses PKS Sweety penyesuaian format eksternal dengan format PT DPM - Draft yang dikirim ke Pihak kedua masih dalam tahap Review Rencana Tindak Lanjut : - Memfollow up PKS yang sudah dikirim ke pihak kedua								

3.5.5.1.2 Tabel Progres IKS Baru Mei 2025

NO	NAMA PKS	PROGRES PENGURUSAN	KENDALA
1	PT Nayaka Era Husada	Review pihak kedua	Selesai
2	Klinik Brawijaya Lawang	Review pihak kedua	Selesai
3	PT. Asuransi Mandiri Inhealth Manage Care Indonesia	Review pihak kedua	Selesai
4	PT. Kasoem Hearing	Proses TTD	Selesai
5	PT Global Excel	Review	Perbedaan template draft PKS
6	PT Malang Intermedia Pers	Review	Proses Perpanjangan
7	PT BNI Life Insurance	Penambahan Addendum	Selesai
8	Dispenduk Kab. Malang Ketan Ireng	Review (konfirmasi terakhir bulan April masih menunggu pihak sekda)	Proses pihak Dispenduk
9	PT Softex Indonesia (Kimberly-Clark Softex)	Review	Proses Perpanjangan
10	Kirim Proposal Nestle Event Lacto Club	Proses Event	Kirim Dokumen Tambahan

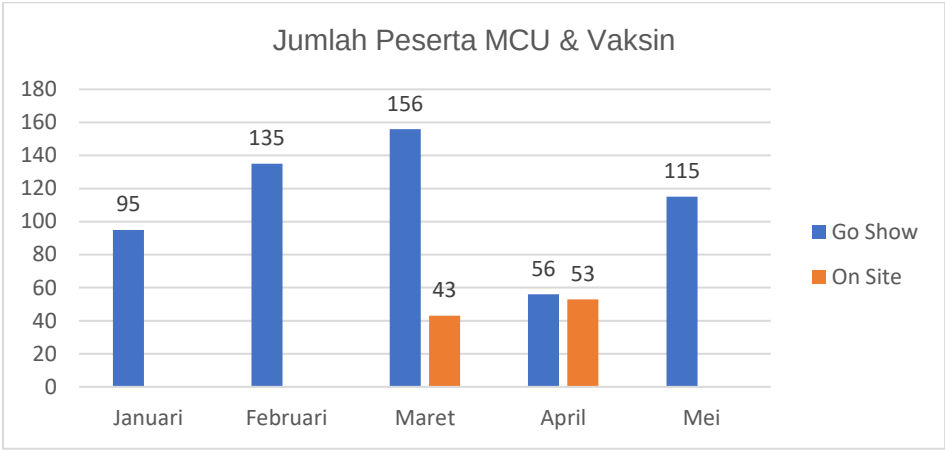


3.5.5.2 Medical Check Up (MCU)

3.5.5.2.1 Pencapaian Hasil Kinerja MCU dan Vaksin April 2025

NO	BULAN	TARGET	JUMLAH PASIEN GOSHOW	ON SITE
1	Januari	25	95	-
2	Februari	25	135	-
3	MARET	150	156	43
4	APRIL	150	56	53
5	MEI	150	115	-
6	JUNI	150		
7	JULI	150		
8	AGUSTUS	150		
9	SEPTEMBER	150		
10	OKTOBER	150		
11	NOVEMBER	150		
12	DESEMBER	150		

Analisis ;
Jumlah peserta MCU dan Vaksin bulan Mei Meningkat 1.05% dari bulan April
Rencana Tindak Lanjut :
1. Melakukan Promosi melalui Social Media
2. Kunjungan ke Universitas, SMA dan SMK untuk menawarkan program MCU Pelajar



3.5.5.2.2 Tabel Evaluasi Hasil Penawaran MCU Tahun 2025

NO	BULAN	INSTANSI	HASIL
1	Januari	PT Berca Kawan Sejati Cab. Malang Official	Tidak ada konfirmasi dan Jawaban setelah di lakukan Follow Up
2	Februari	PT Pesta Pora	Tidak ada konfirmasi dan Jawaban setelah di lakukan Follow Up
		PT Green Mountains Natural Food	Konfirmasi untuk Peserta 106 orang
3	Maret	Meteor Cell Singosari	Sudah terlaksana
		PT Green Mountains Natural Food	Konfirmasi untuk Perubahan Peserta menjadi 53 orang dan pengajuan dengan Bus MCU
4	April	PT Green Mountains Natural Food	Sudah terlaksana
5	Mei	PT Kencana Tiara Gemilang	Sudah terlaksana 10 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit
		Laboratorium Radika Diagnostik	Sudah terlaksana 11 Orang Pelaksanaan di Rumah Sakit

3.5.5.2.3 Kegiatan Kunjungan Eksternal

3.5.5.2.3.1 Tabel Jumlah Kunjungan Eksternal

NO	KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Jumlah Kunjungan	5	10	2	2	2						

Analisa :

Kunjungan eksternal mulai dilakukan Kembali untuk sosialisasi kebijakan yang berhubungan dengan rujukan pasien.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi berkala.

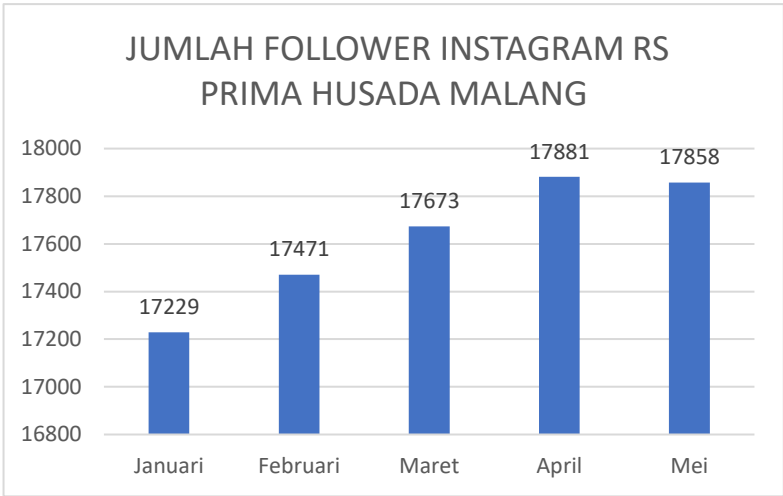
3.5.5.2.4 Digital Marketing

3.5.5.2.4.1 Daftar Kegiatan Digital Marketing

Platform Instagram

JUMLAH KONTEN BARU	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
FEED FOTO	3	7	9	10	10							
REELS	5	5	11	5	1							
STORY	6	10	14	8	12							
TOTAL	14	22	34	28	23	0	0	0	0	0	0	0

JUMLAH TOTAL POSTINGAN (BARU + LAMA)	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
FEED FOTO	6	11	16	19	10							
FEED VIDEO	0	0	0	0	1							
REELS	3	4	5	7	1							
STORY	29	33	28	38	12							
TOTAL	38	48	49	64	24	0	0	0	0	0	0	0
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH FOLLOWER (CUT OFF TANGGAL 1)	17,229	17,471	17.673	17.881	17850							
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH PENINGKATAN FOLLOWER	496	242	202	208	374	0	0	0	0	0	0	0
TARGET	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300



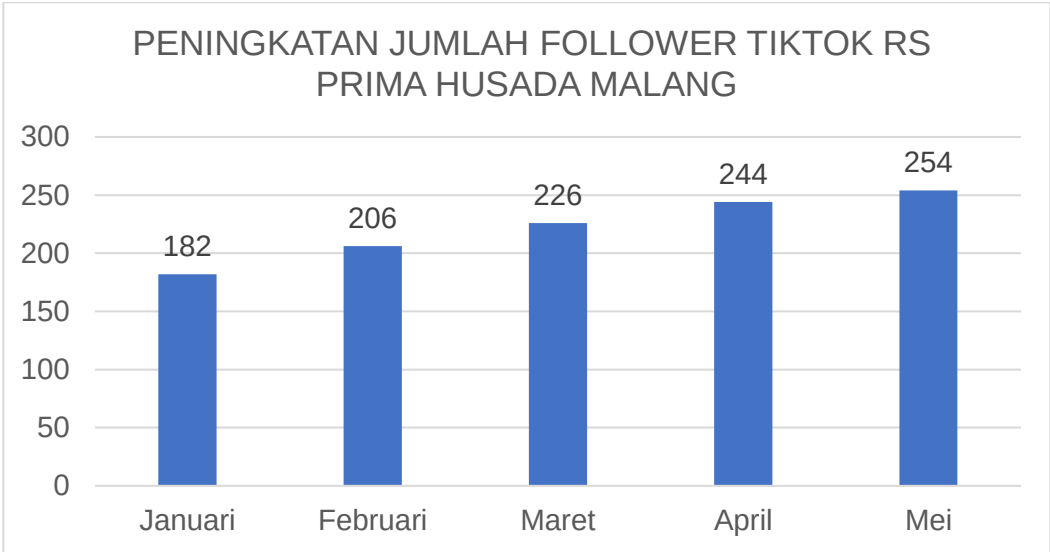
Analisa :
Jumlah Follower Instagram RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebesar 1.79% dari bulan Mei

- Rencana Tindal Lanjut :**
- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS setiap harinya
 - 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 - 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Platform Tik Tok

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH KONTEN BARU	2	3	4	0	2							
TARGET	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH FOLLOWER (CUT OFF TANGGAL 1)	182	206	226	244	254							

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH PENINGKATAN FOLLOWER	16	24	20	18	10	0	0	0	0	0	0	0
TARGET	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH LIKE	45	72	1023	1085	1187							



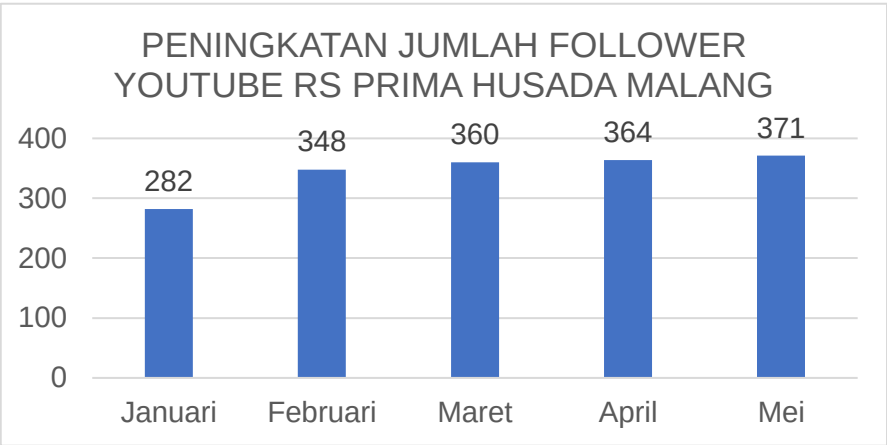
Analisa :
 Jumlah Follower Tiktok RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebesar 1.04% dari bulan April

- Rencana Tindal Lanjut :**
1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Platform Youtube

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH KONTEN BARU	0	2	0	0	0							
TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH SUBS	282	348	360	364	371							
JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH PENINGKATAN SUBS	4	66	12	4	7	0	0	0	0	0	0	0
TARGET	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

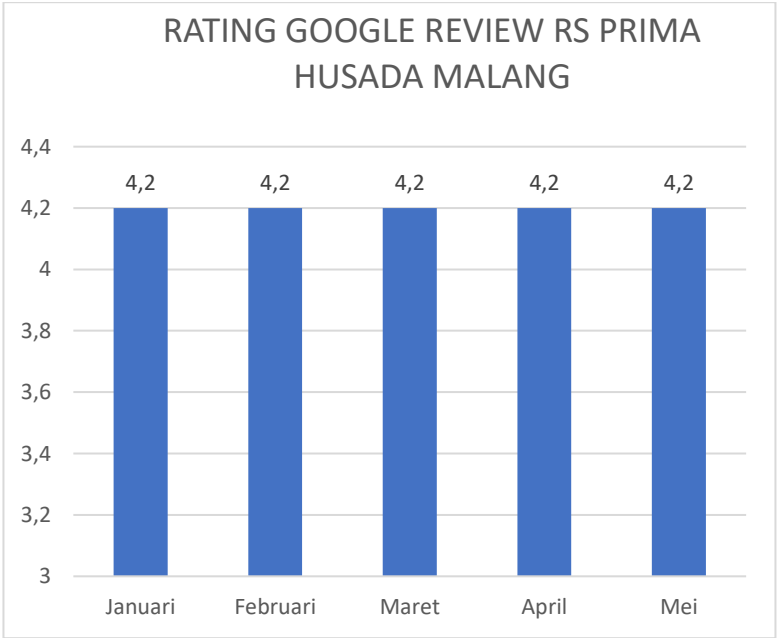


Analisa :
Jumlah Follower Youtube RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebesar 1.01% dari bulan Maret

- Rencana Tindal Lanjut :**
- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
 - 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 - 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Google Review

PROGRESS	JAN	FEB	MAR	AP	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH RATING	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2							



Analisa :
Progres untuk Rating Google Review RS Prima Husada Malang tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dari bulan Maret

- Rencana Tindal Lanjut :**
Meningkatkan Survei kepuasan pasien dengan melakukan pengisian Google Review

3.5.5 Penjaminan

3.5.5.1 Piutang

3.5.5.1.2 Analisa Progres Penyelesaian Piutang

PIUTANG RS PRIMA HUSADA MALANG PERIODE 2025													Y	Z	AA	AB	AC	
NO	DESKRIPSI	SALDO AWAL PIUTANG	PEMBAYARAN (BULAN SEBELUMNYA)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN SEBELUMNYA)	SISA PIUTANG (BULAN SEBELUMNYA)	PENAMBAHAN PIUTANG (BULAN BERJALAN)	PEMBAYARAN (BULAN BERJALAN)	SELISIH KURANG BAYAR (BULAN BERJALAN)	SISA PIUTANG (BULAN BERJALAN)	SALDO AKHIR PIUTANG	UMUR PIUTANG					JUMLAH PIUTANG		
		a	b	c	(a-b-c=d)	e	f	g	(e-f-g=h)	d+h	0-30 HARI	31-60 HARI	61-90 HARI	91-120 HARI	>120 HARI	Total		
PERIODE APRIL 2025 :																		
1	Asuransi	436.388.887	233.073.610	2.823.466	206.491.831	99.371.145	17.719.606	802.628	80.848.912	281.340.743	223.431.104	31.639.920	3.417.334	-	22.852.374	281.340.741		
2	Perusahaan	247.409.536	121.942.752	542.172	125.014.612	89.549.932	-	89.549.932	214.564.544	144.883.691	7.861.000	935.000	39.092.759	21.872.105	214.564.545			
3	Mandiri Inhealt	85.361.591	13.989.429	1.443.759	78.928.803	44.799.413	-	44.799.413	124.728.216	93.562.791	30.793.385	-	-	-	372.039	124.728.216		
4	Jasa Raharja	125.716.273	124.795.354	1	920.918	105.627.548	-	105.627.548	105.548.466	105.627.548	-	-	-	-	920.917	105.548.466		
5	BPJS Ketenagakerjaan	652.689.624	232.205.080	-	115	420.484.659	392.881.789	-	392.881.789	813.366.448	811.470.464	1.031.460	-	-	864.524	813.366.448		
										Total Saldo		1.540.548.418	1.378.895.598	71.257.765	4.352.334	39.092.759	46.881.960	1.540.548.418
PERIODE MEI 2025 :																		
1	Asuransi	281.340.741	212.194.993	1.498.018	67.657.731	193.798.839	27.718.664	1.224.357	164.855.817	232.513.548	212.875.249	2.751.066	4.420.820	2.086.392	19.449.374	232.513.548		
2	Perusahaan	212.534.591	115.270.904	-	96.263.675	113.084.993	1.810.000	283.500	199.091.493	207.255.168	126.407.244	1.053.019	93.863.778	935.800	59.796.127	207.255.168		
3	Mandiri Inhealt	124.728.216	49.825.247	297.917	74.694.988	29.251.607	-	20.251.607	94.946.605	86.524.570	-	-	-	-	372.039	94.946.605		
4	Jasa Raharja	106.548.466	105.627.549	0	920.917	157.789.439	84.249.415	-	0	73.540.024	74.560.942	-	-	-	920.917	74.560.942		
5	BPJS Ketenagakerjaan	813.366.448	481.895.540	-	331	331.470.240	407.420.851	-	407.420.851	738.891.091	739.620.806	375.100	1.031.460	-	864.524	738.891.091		
										Total Saldo		1.348.067.353	1.235.967.194	4.179.725	32.566.062	2.951.392	72.402.582	1.348.067.354

	dan 95.23 tidak sesuai, gunakan 95.01		
4	Tidak sesuai kaidah pengkodean klinis, dilakukan slittlamp kode 95.09 tidak sesuai gunakan 95.11	Klaim Pending	Menjawab Konfirmasi Pending

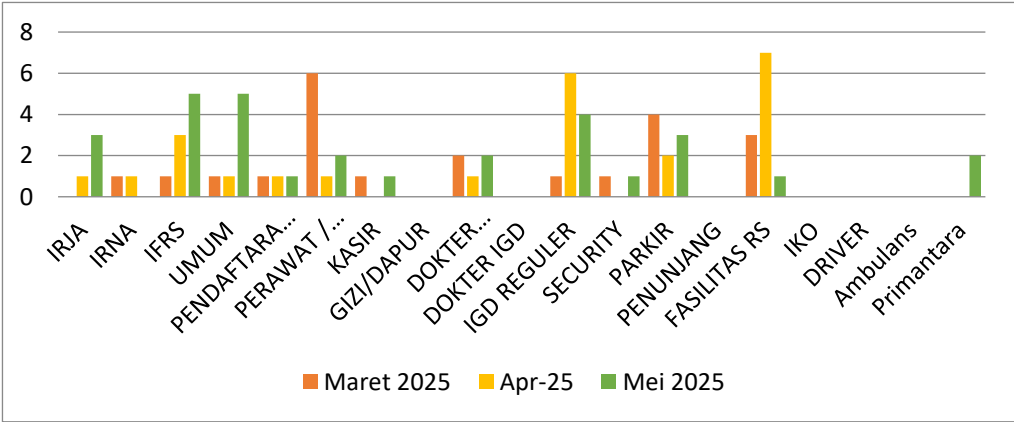
3.5.6 PIPP – MOD – MPP

3.5.6.1 Laporan Komplain Pasien

1.5.6.1.1 Tabel Distribusi Laporan Komplain Pasien Per Unit Bulan April 2025

NO	JUMLAH KOMPLAIN PASIEN TERHADAP UNIT	MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025
1.	IRJA	0	1	3
2.	IRNA	1	1	0
3.	IFRS	1	3	5
4.	UMUM	1	1	5
5.	PENDAFTARAN /CSO	1	1	1
6.	PERAWAT / BIDAN	6	1	2
7.	KASIR	1	0	1
8.	GIZI/DAPUR	0	0	0
9.	DOKTER SPESIALIS (KOMITE MEDIS)	2	1	2
10.	DOKTER IGD	0	0	0
11.	IGD REGULER	1	6	4
12.	SECURITY	1	0	1
13.	PARKIR	4	2	3
14.	PENUNJANG	0	0	0
15.	FASILITAS RS	3	7	1
16.	IKO	0	0	0
17.	DRIVER	0	0	0
18.	Ambulans	0	0	0
19.	Primantara	0	0	2
Total		22	24	30

3.5.7.1.1 Grafik Laporan Komplain Pasien Per Unit Mei 2025



Analisis :

Jumlah pasien complain selama Bulan Mei 2025 mengacu pada complain pasien. Asal complain pasien ditemukan dari beberapa unit yang ada di RS.

1. Jumlah complain Pada bulan Mei 2025 Meningkat dibanding pada bulan sebelumnya. Pada bulan maret 2025 sebanyak 22 pasien pada bulan April 2025 sebanyak 24 pasien Sedangkan pada bulan Mei 2025 sebanyak 30 pasien
2. Komplain terbanyak pada bulan Mei 2025 yaitu dari bagian farmasi dan umum sebanyak 5 kasus, IGD sebanyak 4 kasus, IRJA dan parkir sebanyak 4 kasus, Primantara, perawat, DPJP sebanyak 2 kasus dan CSO, kasir, fasilitas RS, security sebanyak 1 pasien yang disampaikan secara kuesioner, WA maupun tatap muka langsung.
3. Jumlah complain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 5 kasus complain dengan rincian :
 1. Parkir sebanyak 3 kasus yaitu terkait pembayaran parkir yang terlalu mahal, permintaan diberikan kartu bebas parkir untuk pasien rawat inap,
 2. Fasilitas RS sebanyak 1 kasus yaitu tersedia papan petunjuk arah yang update agar keluarga pasien tidak nyasar
 3. UMUM sebanyak 1 kasus yaitu disediakan sabun cuci tangan disetiap kamar mandi pasien

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.2 Tabel Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan Mei 2025

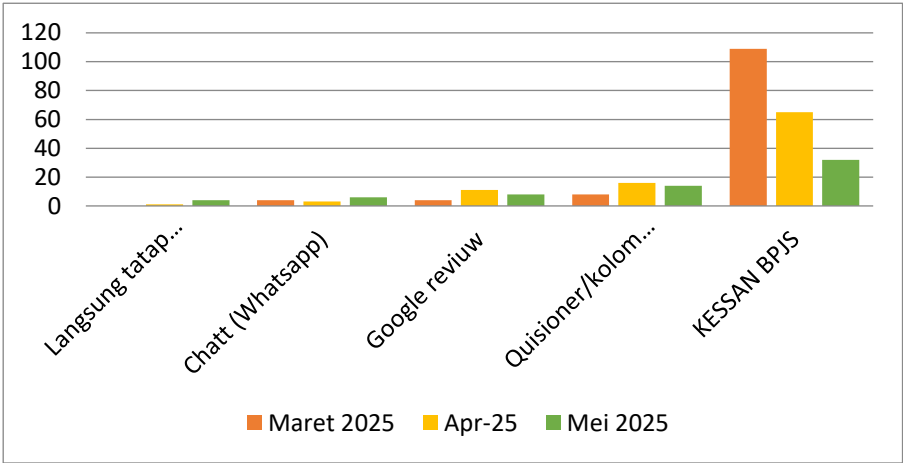
NO	JENIS PASIEN KOMPLAIN	MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025
1.	Langsung tatap muka	0	1	4
2.	Tidak Langsung :			
a	Chatt (Whatsapp)	4	3	6
b	Google reviuw	4	11	8
3.	Quisioner/kolom kritik saran	8	16	14
4.	KESSAN BPJS	109	65	32

Rincian KESSAN

KESSAN (Kesan dan Pesan Setelah Layanan) merupakan aplikasi dari BPJS Kesehatan untuk mendorong FKTP dalam meningkatkan layanan bagi peserta JKN-KIS serta memenuhi kewajiban terhadap kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan

NO	KETERANGAN	BINTANG 1	BINTANG 2	BINTANG 3	BINTANG 4	BINTANG 5
1.	KESSAN BPJS	0	0	0	13	19

3.5.7.3 Grafik Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan Mei 2025



Analisis :
Pada bulan Mei 2025 jumlah jenis pasien complain terbanyak didapatkan dari Quisioner yaitu sebanyak 14 kasus complain. Sedangkan terbanyak kedua yaitu dari WA/Chatt sebanyak 6 kasus.

Rencana Tindak Lanjut :
Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.4 Tabel Waktu Tanggap dan Penyelesaian Komplain Bulan Mei 2025

NO	Jenis pasien complain	Waktu tanggap		Waktu penyelesaian		< 3 hr Manajerial RS	7 hr ke PT
		Standard < 5 ‘	Pencapaian (dari waktu total dibagi jml komplain atau rata2 waktu tanggap)	Standard < 60 ‘	pencapaian		
1.	Langsung tatap muka	100%	100%	100%	100%	0	0
2.	Chatt (WA/Tele/SMS/IG)	100%	100%	100%	100%	0	0
3.	Google reviuw	100%	100%	100%	8	3	0
					70%	30%	
4.	Quisioner/kolom kritik saran	100%	100%	100%	8	8	0
					50%	50%	
5.	KESSAN	100%	0	100%	100%	0	0

Analisis :
Waktu tanggap dan penyelesaian komplain pasien pada bulan Mei 2025 masih ada yang belum sesuai target 100% yaitu complain melalui Quisioner dengan capaian 50% dan dari

google revium sebanyak 30% hal ini dikarenakan ada beberapa kasus complain yang tidak bisa langsung diselesaikan seperti fasilitas RS yang memerlukan diskusi dengan manajemen

Jumlah complain yang tidak bisa langsung diselesaikan sebanyak 5 kasus complain dengan rincian :

- 1) Parkir sebanyak 3 kasus yaitu terkait pembayaran parkir yang terlalu mahal, permintaan diberikan kartu bebas parkir untuk pasien rawat inap,
- 2) Fasilitas RS sebanyak 1 kasus yaitu tersedia papan petunjuk arah yang update agar keluarga pasien tidak nyasar
- 3) Umum sebanyak 1 kasus yaitu disediakan sabun cuci tangan disetiap kamar mandi pasien

Rencana Tindak Lanjut :

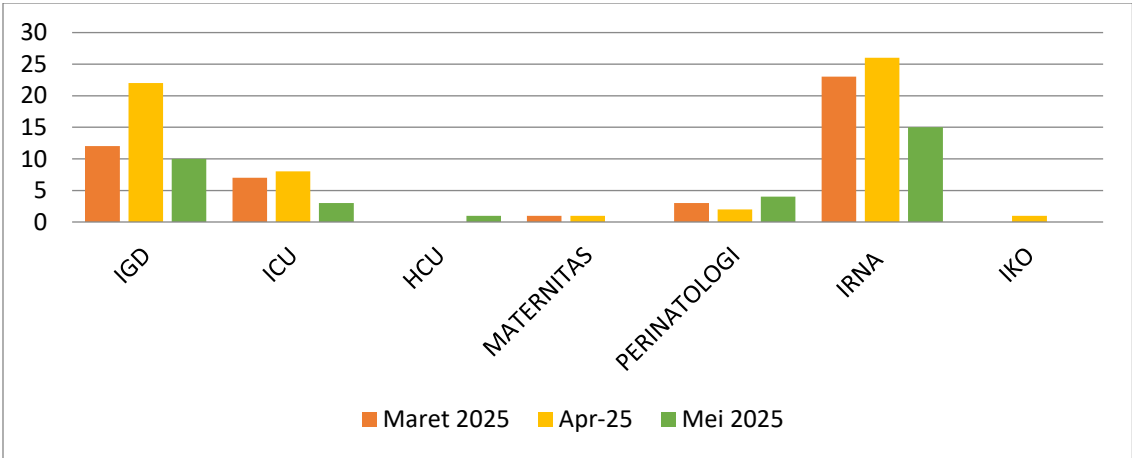
Penyelesaian komplain dilakukan dengan melakukan telusur lapangan sederhana dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.5 Laporan Pasien Rujuk

3.5.7.5.1 Tabel Distribusi Pasien Rujuk Per Unit Bulan April 2025

NO	UNIT PERUJUK	MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025
1.	IGD	12	22	10
2.	ICU	7	8	3
3.	HCU	0	0	1
4.	MATERNITAS	1	1	0
5.	NEONATOLOGI	3	2	4
6	IRNA	23	26	15
7	IKO	0	1	0
Total		46	60	33

3.5.7.5.2 Grafik Jumlah Pasien Rujuk Eksternal Bulan Mei 2025



3.5.7.5.3 Tabel Rincian Pasien Rujuk Mei 2025

NO	Nama Pasien	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP	RS TUJUAN	ALASAN RUJUK	LAMA RAWAT	PLAVON HABIS
1	ny. Zainab	ICU	Stemi inferior, RV Infarct onset >12 jam	dr. Miryanti, Sp. JP	RS UMM	Pro PCI	1	Tidak
2	Ny. Sunanik	ICU	Stemi anterior	dr.	RS UMM	Pro PCI	1	Tidak

			inferior	Miryanti, Sp. JP				
3	By ny. Eka feny	NEO	neonatal broncopneomonia , glandula thymus prominen,	dr. Fiona, Sp. A	RS Lavalette	Pro Ventilator	2	Tidak
4	Tn. AGUS WAHYUDI	IGD	Syok kardiogenik, NSTEACS	dr. Miryanti Sp.JP	RS UMM	pro immediate invasive strategy	1	Tidak
5	Tn. Suhadi	IGD	Syok kardiogenik	dr. Miryanti Sp.JP	RSSA	pro immediate invasive strategy	2	Tidak
6	By. Ny. Kartina Karnashera	NEO	Neonatal Pneumonia	DR Dicky, Sp.A	RS Soepraoen	Pro Ventilator	3	Tidak
7	Ny. Hertin	IGD	Ca Mammae, efusi pleura	dr. Andy Sp.P	RS Lavalete	pro onkologi + Paru	1	Tidak
8	JULAIKAH	ICU	doc dd uremic enchephalopaty	dr aji sp PD	RS Saiful anwar	Pro HD	2	Tidak
9	Ny. Tatik andayani	IRNA	sirosis hepatitis	dr Ardhany Sp.PD	RSSA	pro endoskopi	5	Tidak
10	SITI SAROPAH	IGD	Azotemia ec CKD	dr Heri, Sp.PD	RS LAVALETTE	Pro HD	2	Tidak
11	Ny. Satuni	IRNA	dm Hiperglikemi + Imobilisasi	dr. Ardhani Sp. PD	RS Saiful anwar	Pro Geriatrik sindrom	6	Tidak
12	Ny. Ni'matul Hasanah	IRNA	AML	dr. Ardhi Sp. PD	RS lavalet	Pro konsultasi + tata laksana Hematoonkologi medik (HOM)	1	Tidak
13	Tn. Faris Dwi Setiawan	HCU	Hematemesis melena, shock condition. Abses peritonsil susp difteri	dr Aji Sp PD	RSSA	Pro endoskopi dan ruang isolasi	2	Tidak
14	Ny. puji kadaryati	IGD	V. App Cruris S/ susp. rupture arteri	dr Arianto SP OT	RS Soepraoen	Pro debridement, emplorasi, repair arteri, repair soft tissue	1	Tidak
15	Ny. Rasemi	IRNA	Burst Fracture Lumbal	dr. Oka Sp. OT	RSSA	Pro MRI	2	Tidak
16	TN. basori	IRNA	NSTEMI, DM Hiperglikemia	dr. aji Sp. pd, konsul dr. ira sp.jp	RSSA (IGD reguler)	Pro PCI dan penatalaksanaan lebih lanjut	5	Tidak
17	Ny. Rahayu Ningsih	IRNA	Sirosis Hepatis	dr. Ardhany, Sp. PD KGH	RSSA (IGD reguler)	Pro Perawatan Sp.PD-KGEH	4	Tidak
18	Ny. Utami	IRNA	Decreased of BW + Change of bowel habit	dr. Aji, Sp. PD	RSSA (IGD infeksi)	Pro Kolonoskopi	6	Tidak
19	by. NOVERRO RADJA SYAHPUTRA	IGD	Eritroderma	dr.Vita, Sp.DVE	RSSA (IGD reguler)	Pro Pro punch biopsi	2	Tidak
20	Ny. Muftiyah	IRNA	Ileus Obstruksi	dr Zaki, SP.B	RSSA (IGD reguler)	Pro Laparatomy	4	Tidak
21	Tn. Titus	IRNA	DM, Bisitopenia	dr.	RSSA (IGD	Pro Perawatan	5	Tidak

	Sukriwani			Ardhany, Sp. PD	reguler)	Sp. PD-KHOM		
22	Tn Sutrisno	IGD	syok cardiogenik, NSTEMI, CAD Post PCI, Hiperglikemia in critical	dr. Miryanti, Sp. JP	RSSA (IGD reguler)	Pro PCI dan perawatan lebih Injut	1	Tidak
23	NY. SUNARSIH	IRNA	ACUTE ON CKD	dr.ARDHI SP. PD	RSUD LAWANG	ProHD	2	Tidak
24	Tn. Beny Sanyoto	IRNA	ileus obstruktif dt small bowel obstruction	dr. Aji SP.PD konsul dr. zaki Sp.B	RSSA	Pro Perawatan ke dr. Bedah Digesif	5	Tidak
25	Ny. Hani	IRNA	Syok condition dd syok sepsis	dr Ardhi Sp PD	RS Karsa Husada	Pro Perawatan Lebih Lanjut respon perbaikan infeksi jelek susp MDRO	2	Tidak
26	Tn. Moch Sochib	IRNA	Syok Cardiogenik, UAP, DM Cardiomyopathy, PAC, DM II, AKI	dr Mira SP JP	RSSA	Pro PCI	5	Tidak
27	Ny. Kastin	IRNA	GBS, Tetraparesis	dr Farid Sp S	RSSA	Pro IVGV	6	Tidak
28	Ny. Ponasih	IRNA	CVA Infark, hemiplegi	dr Farid Sp S	RSSA	Pro stroke Unit	6	Tarif rs : 7.735.324 Plavon : 4.585.300 Minus : 3.150.024
29	BY NY. KHUSNUL AMALIA	NEO	1. Neonatal Pneumonia, BBLR	dr. Dicky, Sp. A	RS Lavalette	pro ventilator	3	Tidak
30	NY. RIRIN WIJAYANTI	IGD	STEMI inferior, Krisis Hiperglikemia	dr Yoga Sp JP	RSI Aisyiyah	PRO PCI	1	Tidak
31	BY NY. ARISA FIRDAUS	NEO	Hipoglikemia Refrakter	dr. Dicky, Sp. A	RS Lavalette	Pro konsultan perinatologi dengan konsultan endokrinologi	4	Tidak
32	Tn. PUJIONO	IGD	Obs dysneu dd ADHF	dr. Ardhi, Sp. PD	RST dr. Soepraoem	pro HD	2	Tidak
33	An. Devina Rizki	IRNA	Pneumonia, Distress nafas	dr. Dicky, Sp. A	RSSA	pro perawatan lebih lanjut	2	Tidak

Analisis :

1. Terjadi peningkatan jumlah pasien yang dirujuk ke RS lain dalam bulan Mei 2025.
Pada bulan Maret 2025 yaitu 46 pasien pada bulan April 2025 sebanyak 60 pasien Sedangkan pada bulan Mei 2025 sebanyak 33 pasien
2. Alasan rujuk karena sarana dan prasarana tidak dimiliki oleh RSPH Malang, seperti :
 - a) Pro PCI
 - b) Pro CVCU
 - c) Pro stroke unit
 - d) Pro HD
 - e) Pro Bedah digestif
 - f) MRI
 - g) Pro bedah saraf lanjutan

- h) Membutuhkan alat khusus
 - i) Membutuhkan pengobatan ARV
 - 3. Alasan rujuk karena plavon habis menurun dari bulan sebelumnya.
- Pada bulan April 2025 sebesar Rp. 6.065.578 pada bulan Mei 2025 menurun sebesar Rp.3.150.024

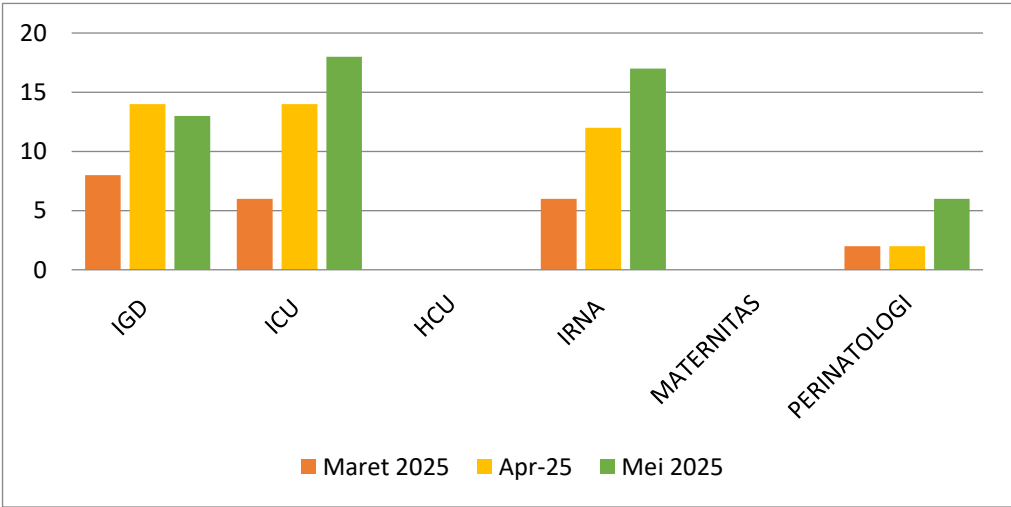
Rencana Tindak Lanjut:

- 1. Dilakukan evaluasi alasan terhadap rujukan pasien keluar yang semakin meningkat
- 2. Dilakukan komunikasi dengan DPJP melalui rapat komdik terkait plavon minus.

3.5.7.5.3 Jumlah Pasien Meninggal Bulan Mei 2025

NO	UNIT ASAL PASIEN MENINGGAL	MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025
1.	IGD	8	14	13
2.	ICU	6	14	18
3	HCU	0	0	0
4.	IRNA	6	12	17
5.	MATERNITAS	0	0	0
6	NEONATOLOGI	2	2	6
Total		22	42	54

Grafik Jumlah Pasien Meninggal Mei 2025



Tabel Rincian Pasien Meninggal Mei 2025

NO	NAMA PASIEN	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP
1	NN. DELA DIAN LESTARI	IGD	DOC + SUS CVA + HT EMERGENCY	DR. FARID, SP.S
2	Ny. Siti Mukhayanah	ICU	DOC ec Encelophaty Metabolik	dr. Ard hany Sp.PD.KGH rab er dr. Robby Sp.An, dr. Farid Sp.N
3	By ny. Felyanti	NEO	IUFD	dr. Humaira, Sp. OG
4	TN A M MUKAROMIN	ICU	Pneumonia	dr. Aji Sp.PD
5	TN SUSIAWAN	ICU	ARDS	dr. Aji Sp.PD Rab er dr. Heru Sp. An Rab er dr. Mira Sp. Jp
6	TN SUSILO	ICU	ARDS, DOC	dr. Farid Sp.N Rab er dr. Robby

				Sp.An
7	Ny. Paha	IRNA	Cholelithiasis, Syok hipovolemi	dr. Ard hany Sp.PD
8	ny. Ngatmini	IRNA	COLIC ABDOMEN SUSP ILEUS	dr. Zaki, Sp. B
9	Tn. Suryanto	ICU	DM hipoglikemi, hiponatremia, susp TB	dr. Ardhy Sp.PD rab er dr. Elvi Sp.P
10	By. Ny, Lusi	IGD	DOA	dr. Andira
11	M. TOHA	IRNA	ADHF,DM Cardiomyopathy	dr. Miryanti, Sp. JP
12	Ny. SULASTRI	IRNA	SOP Cerebri, AF RVR	dr. Dewi Sp.S konsul dr. Ira Sp.JP
13	Ny. Kasturi	ICU	Mitral Regurgitation	dr. Yoga Sp.Jp
14	Ny. TUNANIK	IGD	DOC Susp CVA ICH	dr. Farid, Sp. S
15	Tn. Moh Soleh	ICU	DOC, CVA Infark, resistensi Sputum	dr. Farid Sp.N rab er dr. Andy Sp.P rab er dr. Ardhi Sp.Pd konsul dr. Heru Sp. An
16	Tn. NGADIONO	ICU	COPD AE, ARDS, DM Hiperglikemi	dr Andy Sp P
17	Ny ST Asiyah	IRNA	gangren diabetic post debridemen + DM Hiperglikemia	dr Zaki Sp B
18	Tn. Nur Salam	ICU	RF dt ARDS, DOC dt Ureum dr Hipoxia, AKI	dr Aji SP PD
19	Ny. paini	IRNA	hematemesis profuse (ITP)	dr. Heri, Sp. PD
20	Ny. Siti Muslimah	ICU		dr. Arianto., Sp. OT, dr. Robby, Sp. An
21	SURJADI	IGD	AF	dr Yoga SP.JP
22	MOCHAMMAD MOCHTAR	IRNA	Hemiparase dt stroke, distensi abdomen, hematemesis	dr. Farid Sp. S konsul dr. Zaki Sp. B
23	SUWARNI	IGD	DOC + SUSP CVA ICH	dr. Endra
24	NYIMAS ZUBAIDAH	IGD	DOA	dr. Fira
25	Tn Kusnaeni	ICU	ards	dr. andy sp P
26	By. Ny. Puji Astutik	NEO	IUFD	dr Humaira, Sp.OG
27	By. Ny. Dewi Yuniarti	NEO	IUFD	dr Humaira, Sp.OG
28	Ny.Yuli Setia Rini	ICU	DOC ec CVA ICH	dr Farid, Sp.N
29	tn herdiono	IRNA	anemia aplastik, trombositopenia	dr Heri, Sp.PD
30	Tn. Achmad Arifin	ICU	CVA infark	dr Farid, Sp.N
31	Ny. Sri Rahayu Ningsih	IRNA	DOC dt uremic encephalopathy dd hepatic encephalopathy dd hipoxic encephalopathy	dr. Aji Sp.PD
32	SRI SUPRIHATIN	IRNA	Gagal cardio pulmonal	dr. Yoga, Sp. JP konsul dr. Andy, Sp. P
33	KALUNDRA ALOKANTARA VRAZKY	IGD	DOA	dr Ganda
34	OEMI JOELITAH	IGD	DOC, PNEUMONIA	dr Ard hany, SP.PD
35	TAUCHID	IGD	acs + RBBB	dr. Ira, Sp.JP co dr. Fahima, Sp.N
36	UMROTEN	IGD	Ca mammae metastase + acites + syock cardiogenic + Stemi anteroseptal	dr.Aji Sp,PD rab er dr. Ira, Sp.JP
37	Tn. Sunaryo	IRNA	CVA infark , AF, leukositosis	dr. Farid, Sp.S konsul dr.ira Sp.JP
38	By. Ny. Fitriyah	NEO	IUFD	dr Humaira Sp OG
39	By. Ny. Umamur rodiyah	NEO	IUFD	dr Humaira Sp OG
40	By. Ny. Umamur rodiyah 2	NEO	RDS, Prematur, Anemia	dr Dicky Sp A
41	Sdr.AHMAD DENI MAULANA	IGD	CKS + OTTORHEA + RINORHEA POST KLL	dr. Ganda
42	DENIS WAHYU UTOMO	IRNA	FATTY LIVER, CHOLELITIASIS, DM 2, AKI, ANEMIA, ACITES	dr Aji Sp PD

43	NAYUMI	IRNA	TB PARU ON THERAPY	dr Elvi, Sp.P
44	MOH ZAINI	IRNA	KISTA RENAL, COLIC RENAL, DM HIPOGLIKEMI	dr Ardhany, SP.PD
45	NY RIAMI	ICU	NSTEMI, PVC, HIPOKALEMI	dr. Yoga, Sp. JP
46	NY RUPIATIN	ICU	Impending reapiarory failure tipe 1	dr. Ira Sp. Jp Konsul dr Ardhi Sp. PD
47	Ny. Siti Nurul Huda	IRNA	ICH, Post EVD	dr. Fachri Sp. BS raber dr. Farid Sp. S, c/ dr. Nurhadi Sp. M, c/ dr. Ira Sp. Jp, c/ dr. Virginia Sp. KFR, c/ dr. Anton Sp. B
48	HERI SUYANTO	ICU	Cholelitis post op Cholilistectomy	dr. Zaky Sp.B raber dr. Heru Sp.An
49	ROESKANDAR MOEHAMMAD	ICU	ARDS	dr. Aji Sp. PD raber dr. Heru Sp.An
50	Tn. Nuryatim	ICU	CVA Infark, Susp COPD, Respiratory Failure, Takikardia	dr. Farid Sp.N raber dr. Heru Sp.An konsul dr. Andi Sp.p konsul dr. Yoga Sp.Jp
51	Tn Sokib	IGD	Shock cardiogenic dd shock Hipovolemik, ADHF, SVT Aberrant	dr Ira Sp JP
52	Tn Agus Widodo	IRNA	DM Hiperglikemia, Pneumonia, ARDS	dr Ardhany Sp PD
53	TN. TAUKHID	IGD	DOC Susp CVA ICH	dr. Farid, Sp. S konsul dr. Yoga, Sp. JP konsul dr. Heru, Sp. An
54	TN. ABDUL ROHIM	IRNA	DOC,DM, TF, CKD	dr. Aji Sp.PD

Analisa :

- Jumlah pasien meninggal dunia pada bulan Mei 2025 sebanyak 54 pasien
- Jumlah terbanyak yaitu dari ICU : 18 pasien IRNA 17 pasien IGD : 13 pasien, dan Neonatologi sebanyak 6 pasien.
- Pada bulan Mei 2025 Jumlah kasus DOA di IGD sebanyak 3 kasus.
- Pengisian EWS sudah dilakukan di IGD dan IRNA.

Rencana Tindak Lanjut

Dilakukan evaluasi terhadap pasien datang ke IGD dengan kasus DOA

3.5.7.6 Laporan MPP

3.5.7.6.1 Tabel Rekap Berdasarkan Skrining Pasien

NO	IDENTIFIKASI / SKRINING PASIEN	BULAN / JUMLAH		
		MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025
1	Usia lanjut	-	-	-
2	Kasus penyakit kronis / terminal katastrofik	-	-	-
3	Riwayat penggunaan alat bantu (kursi roda, walker, tongkat, dll)	-	-	-
4	Perkiraan biaya tinggi	-	-	-
5	Kemungkinan sistem pembiayaan yang kompleks (2 asuransi)	-	-	-
6	Pasien dengan fungsi kognitif rendah	-	-	-
7	Potensial komplain tinggi	-	-	-
8	Kasus yang melebihi rata-rata lama rawat	-	-	-
9	Kasus yang diidentifikasi rencana pemulangnya	-	-	-
10	Berisiko membutuhkan kontinuitas pelayanan	-	-	-
11	Berpotensi masalah hukum	-	-	-
12	Naik kelas pelayanan	-	-	-
13	Lain - lain	-	-	-

3.5.7.6.2 Tabel Jumlah Lain-Lain (Permasalahan Cara Bayar)

NO	IDENTIFIKASI / SKRINING PASIEN LAIN-LAIN (PERMASALAHAN CARA BAYAR)	BULAN / JUMLAH		
		MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025
1	Habis PKS	-	-	-
2	BPJS status Denda	-	-	-
3	BPJS status Premi	-	-	-
4	BPJS status Denda dan Premi	-	-	-
5	BPJS staus Usia lebih dari 21 tahun	-	-	-
6	BPJS status keluar atas kemauan sendiri	-	-	-
7	BPJS status penangguhan pembayaran	-	-	-
8	Rencana pengurusan BPJS	-	-	-
9	BPJS status tidak ditanggung	-	-	-
10	BPJS tidak aktif akhir bulan	-	-	-
11	BPJS peralihan Mandiri ke PBI	-	-	-

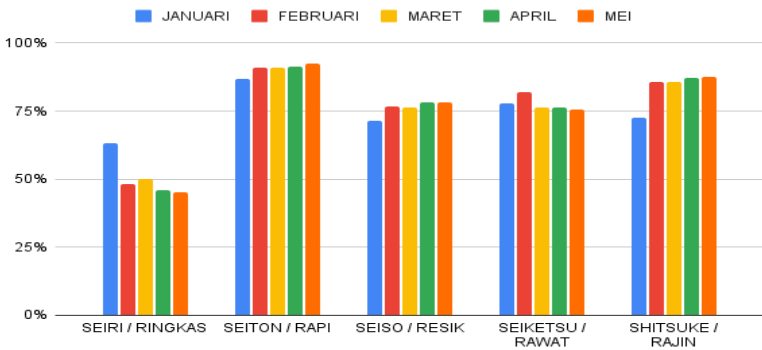
3.5.8 Cleaning Service

3.5.8.1 Indikator Kerja Cleaning Service

KATEGORI	DESKRIPSI
Seiri	Penempatan Alat Kebersihan Di Janitor/ Trolly
	Penempatan Alat Kebersihan Di Janitor/ Trolly
Seiton	Kerapian Baju Dan Kebersihan, Penampilan Petugas Cs
	Kerapian Baju Dan Kebersihan, Penampilan Petugas CS
Seiso	Membersihkan Area Kerja Secara Rutin Sesuai Jadwal
	Membersihkan Area Kerja Secara Rutin Sesuai Jadwal
Seiketsu	Mematuhi Sop Kebersihan
	Mematuhi SOP Kebersihan
Shiketsu	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan
	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan
	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan

3.5.8.2 Tabel Produktifitas Cleaning Service

NO	JENIS SPV	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI
1	SEIRI / RINGKAS	63%	48%	50%	50%	45%
2	SEITON / RAPI	87%	91%	91%	91%	93%
3	SEISO / RESIK	71%	77%	76%	76%	78%
4	SEIKETSU / RAWAT	78%	82%	76%	76%	76%
5	SHITSUKE / RAJIN	72%	86%	86%	86%	88%



Analisa :
 Produktifitas Unit CS dalam penilaian ini masih dalam money karena memakai instrument supervise yang baru. Hasil masih fluktiatif dan salam relative baik.

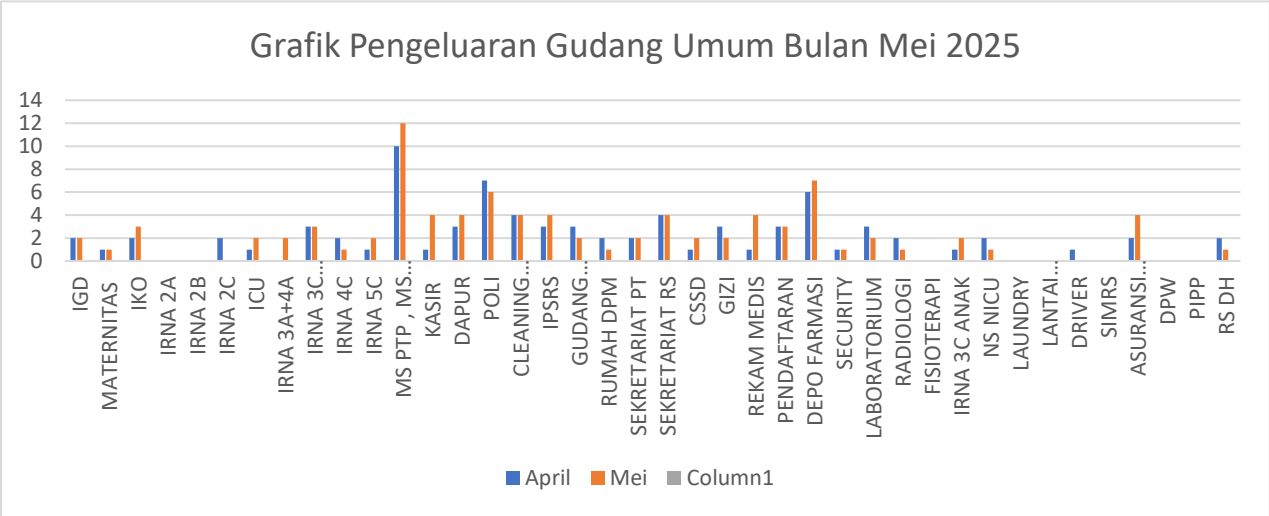
Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan Evaluasi

3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum

3.5.9.1 Tabel Laporan Pencatatan Pengeluaran Barang

NO	UNIT ASAL	JUMLAH BARANG		PERSENTASE
		APRIL	MEI	
1	IGD	2	2	↑0%
2	MATERNITAS	1	1	↓0%
3	IKO	2	3	↑33,33%
4	IRNA 2A	0	0	↓0%
5	IRNA 2B	0	0	↓0%
6	IRNA 2C	2	0	↓0%
7	ICU	1	2	↑0%
8	IRNA 3A+4A	0	2	↑0%
9	IRNA 3C DEWASA	3	3	↓0%
10	IRNA 4C	2	1	↓-50%
11	IRNA 5C	1	2	↓50%
12	MS PTP , MS LAWANG,MS KARLOS	10	12	↑16,66%
13	KASIR	1	4	↑75%
14	DAPUR	3	4	↑ 25%
15	POLI	7	6	↓16,66%
16	CLEANING SERVICE	4	4	↓0%
17	IPSRS	3	4	↑25%
18	GUDANG FARMASI	3	2	↓-50%
19	RUMAH DPM	2	1	↓-100%
20	SEKRETARIAT PT	2	2	↓0%
21	SEKRETARIAT RS	4	4	↑0%
22	CSSD	1	2	↓50%
23	GIZI	3	2	↓-50%
24	REKAM MEDIS	1	4	↑75%
25	PENDAFTARAN	3	3	↑0%
26	DEPO FARMASI	6	7	↑14,28%
27	SECURITY	1	1	↑0%
28	LABORATORIUM	3	2	↓-50%
29	RADIOLOGI	2	1	↓-100%
30	FISIOTERAPI	0	0	↓0%
31	IRNA 3C ANAK	1	2	↑100%
32	NS NICU	2	1	↓-100%
33	LAUNDRY	0	0	↑0%
34	LANTAI 6A,7A,8A	0	0	↓0%
35	DRIVER	1	0	↓0%
36	SIMRS	0	0	↓0%
37	ASURANSI CENTER	2	4	↓50%
38	DPW	0	0	↓0%
39	PIPP	0	0	↑0%
40	RS DH	2	1	↑-100%

3.5.9.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Barang Berdasarkan Asal Unit



Analisis :

Pada grafik diatas dapat kita lihat bahwa data barang paling banyak ada pada unit Mutiara sehat , Depo farmasi dan Poli

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mendisiplinkan kepatuhan jadwal pengambilan barang
- 2. Memberi edukasi ke unit agar tidak salah input barang atau salah unit
- 3. Menyarankan ke seluruh unit agar punya data inventaris ATK secara terperinci

3.5.10 IT SIMRS

3.5.10.1 Capaian Tata Laksana Keluhan

NO	JENIS KELUHAN	JUMLAH LAPORAN	JUMLAH TERSELESAIKAN	PROSENTASE (%)
1	Keluhan terkait software	30	30	100%
2	Keluhan terkait hardware	106	106	100%

Analisa : Untuk Keluhan dapat terselesaikan oleh Tim IT
Rencana Tindak Lanjut : Monitoring dan Evaluasi

3.5.10.2 Rekapitulasi Kejadian Downtime

NO	TANGGAL KEJADIAN DOWNTIME	JENIS DOWNTIME (TERENCANA/TIDAK TERENCANA)	LAMA DOWNTIME	PENYEBAB DOWNTIME	RTL
1.	2/5/2025	Tidak Terencana	30 menit (08.30-09.00)	Down server bpjs	Edukasi menunggu estimasi 30 menit info dari IT bpjs
4	27/5/2025	Tidak terencana	90 menit (05.00-06.30)	Server Vclaim down	Edukasi menunggu estimasi 90 menit info dari IT bpjs

3	24/5/2025	Tidak terencana	30 menit (06.30-07.00)	Server Bridging dan Sipp down	Edukasi menunggu estimasi 30 menit info dari IT bpjs
4	23/5/2025	Tidak terencana	30 menit (22.30-23.00)	Server Bridging dan Sipp down	Edukasi menunggu estimasi 30 menit info dari IT bpjs
5	20/5/2025	Tidak terencana	30 menit (15.30-16.00)	Server Bridging dan Sipp down	Edukasi menunggu estimasi 30 menit info dari IT bpjs
6	18/5/2025	Tidak terencana	30 menit (07.45-08.15)	Server Bridging dan Sipp down	Edukasi menunggu estimasi 30 menit info dari IT bpjs

3.6 Komite dan Tim

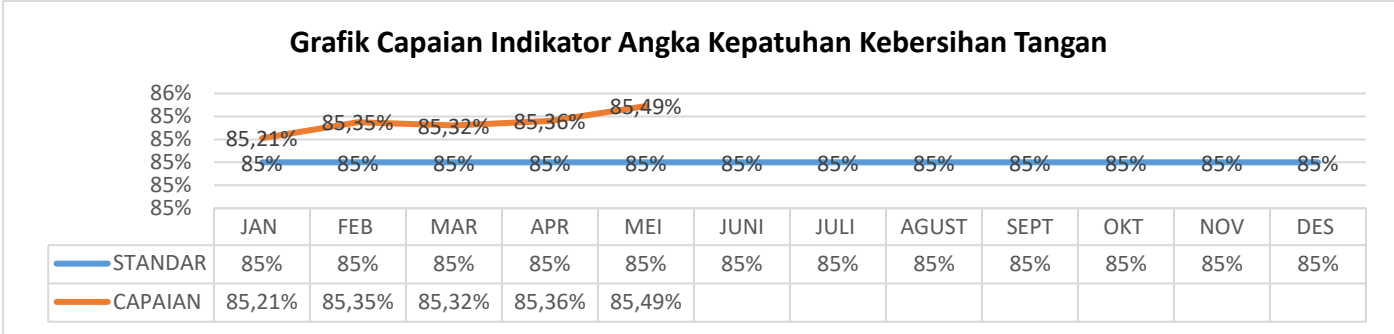
3.6.1 Komite Mutu

3.6.1.1 Indikator Mutu Nasional

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Juli '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	85,21%	85,35%	85,32%	85,36%	85,49%								85,29%
2.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	93,01%	93,06%	93,1%	93,22%	93,54%								93,05%
3.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	99,55%	99,92%	99,77%	99,96%	99,88%								99,74%
4.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%								100%
5.	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥ 80%	89,16%	89,38%	99,1%	98,21%	97,58%								92,54%
6.	Penundaan Operasi Elektif	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%								0%
7.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	75,9%	76,21%	74,93%	74,19%	72,26%								75,68%
8.	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%	96,9%	97,31%	100%	100%	100%								98,07%
9.	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%								100%
10.	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%								100%
11.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	99,75%	98,64%	99,1%	99,44%	97,65%								99,16%
12.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥ 80%	100%	99,92%	100%	100%	100%								99,97%
13.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	99,81%	99,79%	100%	99,88%	99,76%								99,86%

3.6.1.1Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

3.6.1.1.1 Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



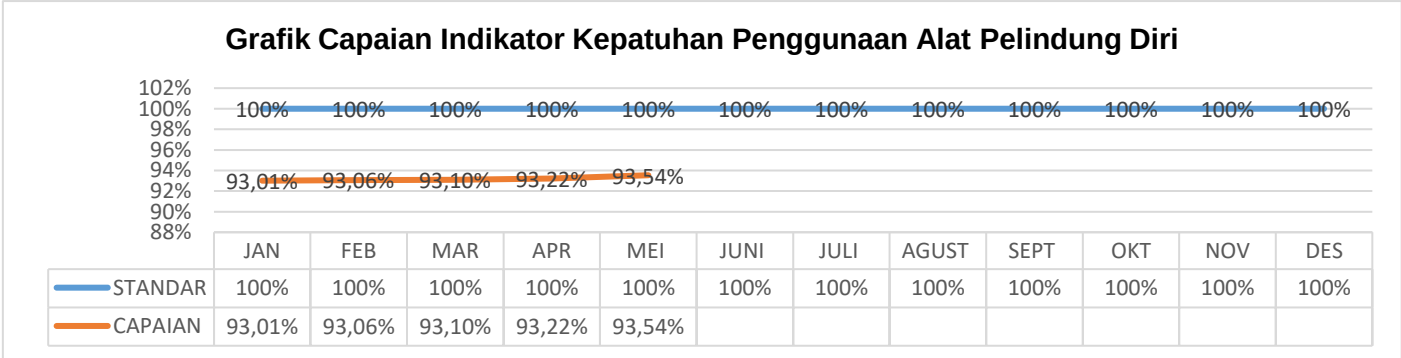
Dari grafik indikator angka keptuhan kebersihan tangan bulan Januari tahun 2025 diketahui bahwa capaian telah mencapai standart yaitu 85,21% dan pada bulan Februari capaian meningkat menjadi 85,35%, capian di bulan Maret yaitu 85,32%, capaian di bulan April yaitu 85,36% dan capaian di bulan Mei 85,49% dengan rata rata bulan Januari hingga Mei yaitu 85,32%. Meskipun belum mencapai 100% tetapi nilai tersebut telah mencapai standart. Petugas masih dengan anggapan bahwa tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Di harapkan capaian ini dapat ditingkatkan di bulan berikutnya.

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin hingga 100%.					
DO	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.					
STUDY	Dari grafik indikator angka keptuhan kebersihan tangan bulan Januari tahun 2025 diketahui bahwa capaian telah mencapai standart yaitu 85,21% dan pada bulan Februari capaian meningkat menjadi 85,35%, capian di bulan Maret yaitu 85,32%, capaian di bulan April yaitu 85,36% dan capaian di bulan Mei 85,49% dengan rata rata bulan Januari hingga Mei yaitu 85,32%. Meskipun belum mencapai 100% tetapi nilai tersebut telah mencapai standart. Petugas masih dengan anggapan bahwa tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Di harapkan capaian ini dapat ditingkatkan di bulan berikutnya.					
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		PELAKSANA	WAKTU

Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan
---------------------------------	---	----------------------------------	--	--	------------

3.6.1.1.1 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

3.6.1.1.2.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri



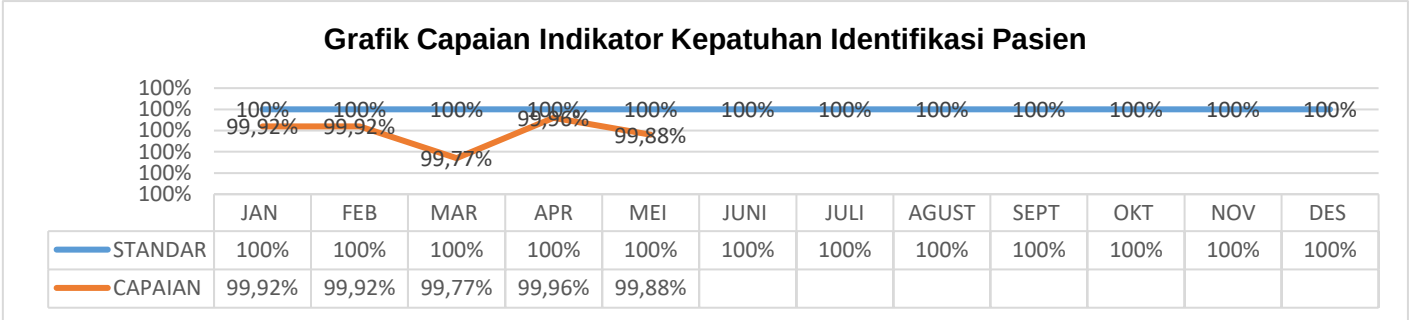
Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan penggunaan alat pelindung alat pelindung diri pada bulan Januari hingga Mei Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan penggunaan APD semaksimal mungkin hingga 100%.
DO	1. Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 2. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 3. Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 4. Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD petugas dapur). 5. Sudah dikeluarkan edaran terkait penggunaan jas dokter.

	6. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.				
STUDY	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart. Capaian di bulan Januari tahun 2025 yaitu 93,01%, bulan Februari sebesar 93,06%, bulan Maret sebesar 93,1%, bulan April 93,22% dan bulan Mei 93,54% dengan rata-rata 93,18%. Dari hasil monitoring dan supervise, masih ditemukan petugas perawat yang memakai APD tidak sesuai dengan jenis tindakan dan transmisi penyakit, misalnya seperti injeksi lewat selang infus / hanya TTV ke pasien non infeksi namun menggunakan handscoon. Kepatuhan APD petugas dapur terutama pengolah makanan masih sangat kurang terutama penggunaan masker. Untuk petugas medis, masih ditemukan DPJP yang masih menggunakan handscoon meskipun hanya visite tidak melakukan tindakan. Untuk petugas CS ditemukan masih menggunakan handscon medis untuk mengepel yang seharusnya menggunakan handscoon kerja.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Tercapainya kepatuhan APD hingga maksimal 100%.	1. Berkolaborasi dengan IPCD untuk melakukan edukasi terhadap para DPJP. 2. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan. 3. Lakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 4. Berikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 5. Berikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. 6. Tanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu Bulan

3.6.1.1.2 Kepatuhan Identifikasi Pasien

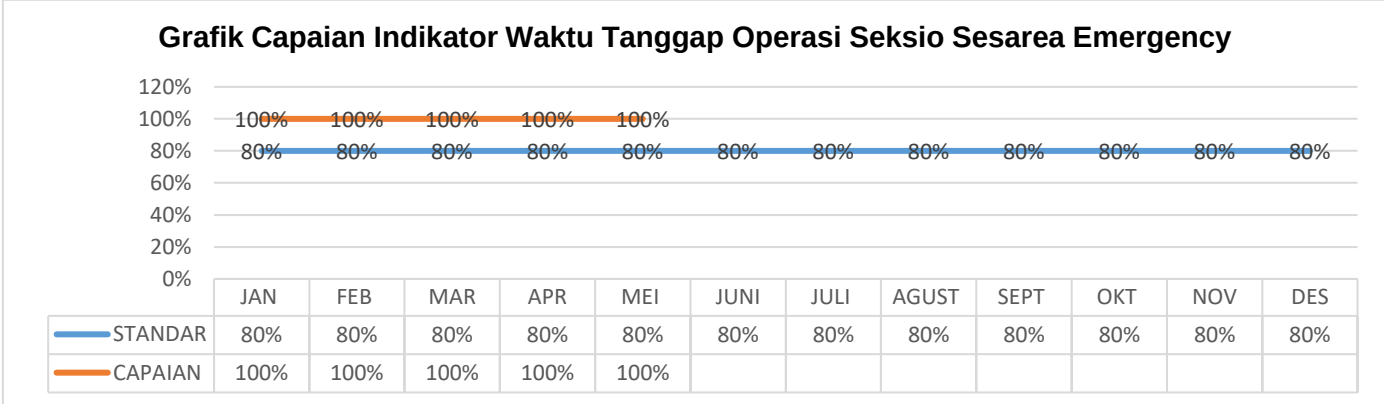
3.6.1.1.3.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pas



Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Januari hingga Mei Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka keatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	1. Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan 2. Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien 3. Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart dengan capaian bulan Januari tahun 2025 yaitu 99,92 %, bulan Februari sebesar 99,92%, bulan Maret sebesar 99,77% capaian di bulan April yaitu 99,96% dan capaian di bulan Mei 99,88% dengan rata rata 99,81%. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	1. Terus melakukan supervisi pada petugas unit 2. Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat.	Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	Satu Bulan

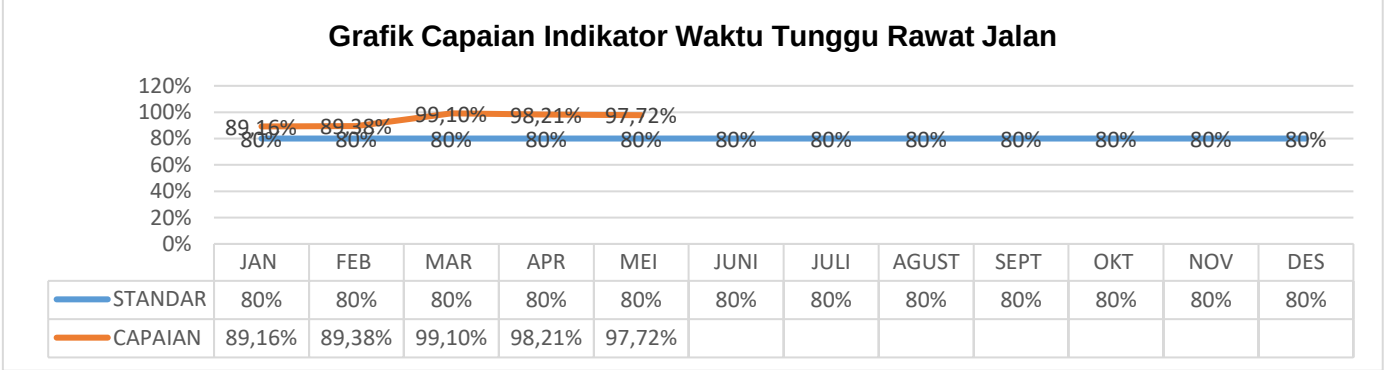
3.6.1.1.3 Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency



Dari grafik indikator waktu tanggap SC emergency bulan Januari hingga bulan Mei tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini berkat kerjasama yang baik antara unit Instalasi Gawat Darurat, Unit Maternitas dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian waktu SC emergency. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.1.1 Waktu Tunggu Rawat Jalan

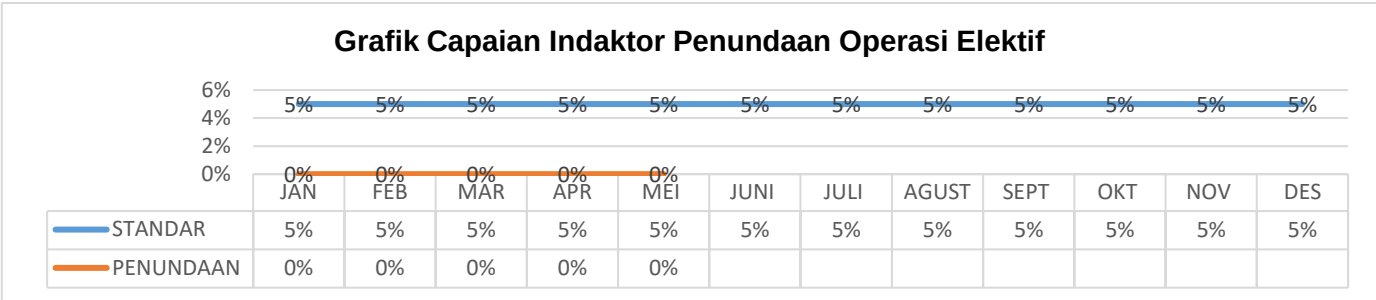
3.6.1.1.5.1 Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan



Berdasarkan grafik capaian indikator waktu tunggu rawat jalan pada bulan Januari Tahun 2025 capaian telah mencapai standart dengan capaian 98,16%, capaian di bulan Februari 89,38%, capaian di bulan Maret 99,1%, capaian di bulan April 98,22% dan capaian di bulan Mei yaitu 97,71%. Hal ini berkat kerjasama yang baik antara manajemen dan juga DPJP yang sudah berusaha datang tepat waktu dan evaluasi berkelanjutan yang telah dilakukan manajemen terhadap keterlambatan DPJP. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan dibulan berikutnya.

3.6.1.1.2 Penundaan Operasi Elektif

3.6.1.1.6.1 Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif

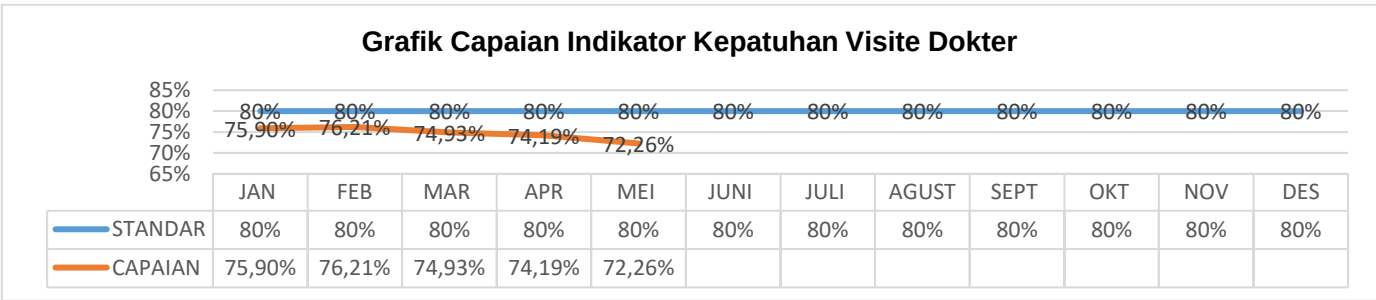


Dari grafik indikator penundaan operasi elektif bulan Januari hingga Mei tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 0%, hal ini berkat kerjasama yang baik antara unit Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian indikator penundaan operasi elektif . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.1.7 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

3.6.1.1.3 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

2.6.1.1.7.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter

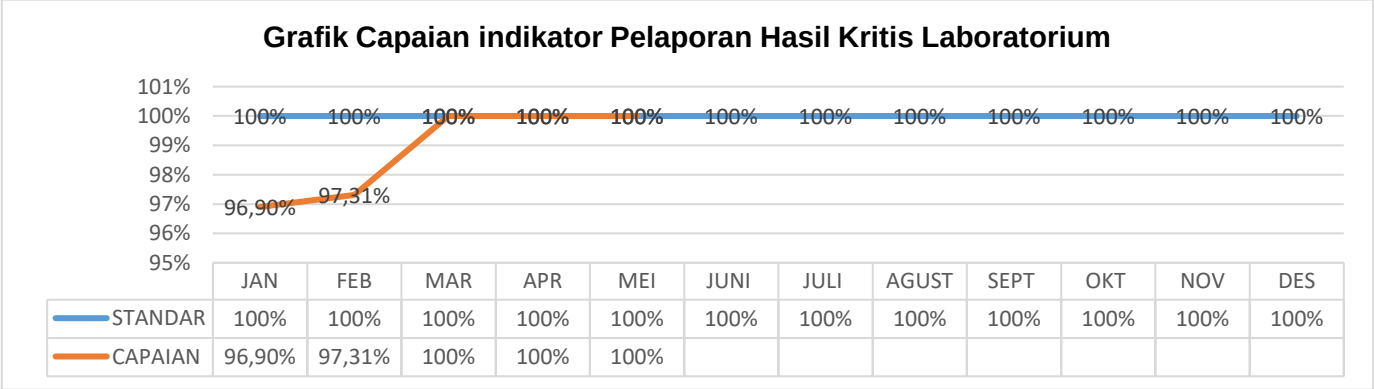


Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan visite Dokter pada bulan Januari hingga April Tahun 2025 belum mencapai standart, hal ini disebabkan karena Seluruh dokter Klinisi di Rumah Sakit Prima Husada adalah dokter tamu dari luar, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan waktu visite dokter hingga dapat mencapai standart 80%.				
DO	Memberikan masukan pada SDM dan Kabid pelayanan untuk melakukan rekrutmen home dokter lebih banyak				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian 75,9%, capaian di bulan februari yaitu 76,21%, capaian di bulan Maret yaitu 74,93%, capaian di bulan April yaitu 74,19%, dan capaian di bulan Mei yaitu 72,26% dengan rata-rata 74,67%. Dari hasil supervisi didapatkan Angka kepatuhan waktu visite Dokter belum mencapai standart karena masih banyak dokter yang visite diatas jam 14.00 karena masih bertugas di RS asal karena RS Prima Husada belum memiliki dokter tetap. Dokter visite jam 07.00-14.00 : dr. Ira, Sp.JP, dr. Mira, Sp.JP, dr. Anton, Sp.B, dr. dr. Dicky, Sp.A , dr. Elvi, Sp.P, dr. Dewi, Sp.S, dr. Ardhi, Sp.PD, dr. Humairoh, Sp.Og, dr. Aida, Sp.Og, dr. Nimim, Sp.THT.KL, dr. dr. Aji, Sp.PD. Dokter visite jam 14.00-21.00 : dr. Heriyatmo, Sp.PD, dr. Andi, Sp.P, dr. Farid, Sp.S, dr. Yoga, Sp.JP (Tidak menentu), dr. Ardani, Sp.DP (tidak menentu)				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	Capaian Kepatuhan Visite dokter bisa meningkat pada bulan selanjutnya	Melakukan KIE dan komunikasi dengan DPJP terkait waktu visite dokter, hal ini menjadi PR yang cukup besar bagi tim mutu dan manajemen karena sebagian besar DPJP tidak hanya bertugas di RS Prima Husada.	Manajemen RS	Satu Tahun

2.6.1.1.7.2 Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

3.6.1.1.8.1 Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

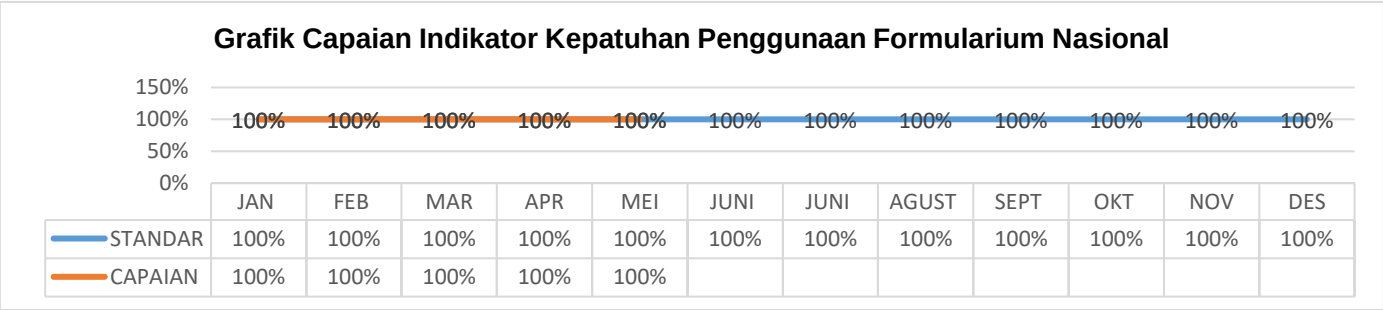


Berdasarkan grafik capaian indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium pada bulan Januari dan Februari Tahun 2025 diketahui capaian belum mencapai standart dan capaian meningkat hingga 100% di bilan Maret dan April. Capaian meningkat pada bulan Maret yang telah mencapai standart 100%.

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan pelaporan hasil kritis laboratorium hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan supervisi baik dari komite mutu maupun kepala instalasi laboratorium supaya seluruh petugas laboratorium segera melaporkan hasil kritis dan melakukan dokumentasi dengan baik dan lengkap.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator pelaporan hasil kritis laboratorium pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian 96,9% dan bulan Februari 97,31%. Capaian meningkat pada bulan Maret hingga Mei yang telah mencapai standart 100%. Berdasarkan hasil supervisi masih ada petugas yang melaporkan hasil kritis laboratorium tetapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan lengkap.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	Capaian pelaporan hasil kritis laboratorium dapat mencapai standart 100% pada bulan berikutnya	1. Menganalisa jumlah hasil kritis laboratorium yang terlapor dan tidak terlapor 2. Memasukkan catatan ketidak patuhan staf kedalam evaluasi kinerja staf secara langsung kepada petugas laboratorium yang tidak melaporkan hasil kritis laboratorium ataupun yang melapor tapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan baik dan lengkap.	1. Komite mutu 2. Kepala instalasi laboratorium	Satu Tahun

3.6.1.1.4 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

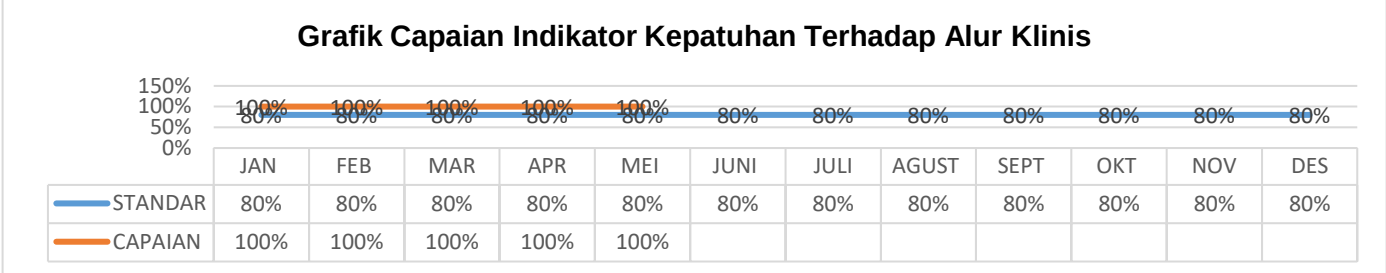
3.6.1.1.9.1 Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



Dari grafik indikator Formularium Nasional bulan Januari hingga Mei tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini kerjasama yang baik antara dokter penanggungjawab pasien, instalasi farmasi dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepatuhan penggunaan formularium Nasional . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

3.6.1.1.5 Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)

3.6.1.1.10.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis



Dari grafik indikator kepatuhan terhadap alur klinis bulan Januari hingga Mei tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini kerjasama yang baik antara dokter penanggungjawab pasien, instalasi farmasi dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepatuhan penggunaan formularium Nasional . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

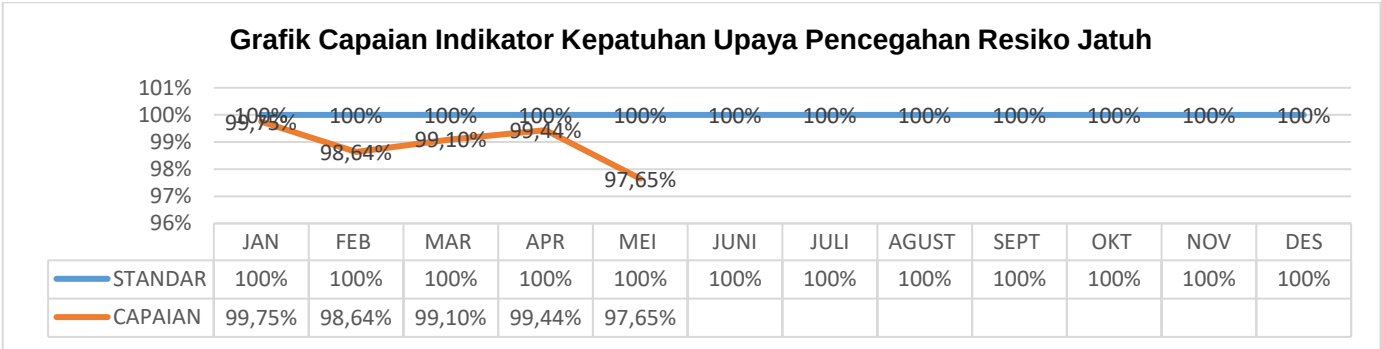
Daftar Clinical Pathway Bulan Mei 2025

Diagnosa	Jumlah	Patuh	Tidak Patuh
DF			
CVA Infark			
Gastritis			
Batu Ureter			
DM			
GEA			
CHF			
FAM			
TB Paru			
HT			
CA Mammae			
HIV			
STEMI			

NSTEMI/UAP			
Pneumonia			
Sectio Caesarea	29		
Partus Normal	32		
Jumlah	61	61	

3.6.1.1.6 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

3.6.1.1.11.1 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



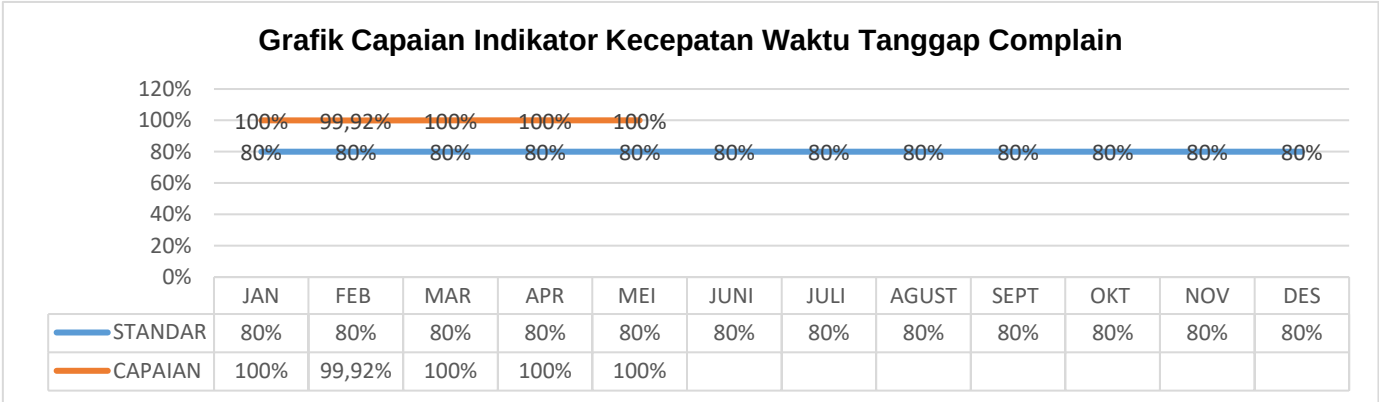
Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari hingga Mei Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%					
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh					
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian yaitu 99,75%, capaian di bulan Februari yaitu 98,64%, capaian di bulan Maret yaitu 99,1%, capaian di bulan April yaitu 99,44%, capaian di bulan Mei yaitu 97.65% dengan rata-rata 98,91%. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalu memasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi.					
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		PELAKSANA	WAKTU

Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	Melakukan supervisi berjenjang mulai dari PJ shift, kepala ruangan, kepala bidang keperawatan dan tim mutu guna memastikan perawat ruangan telah melakukan KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan.	Perawat instalasi rawat inap	Satu Bulan
--	--	--	---	------------------------------	------------

3.6.1.1.7 Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

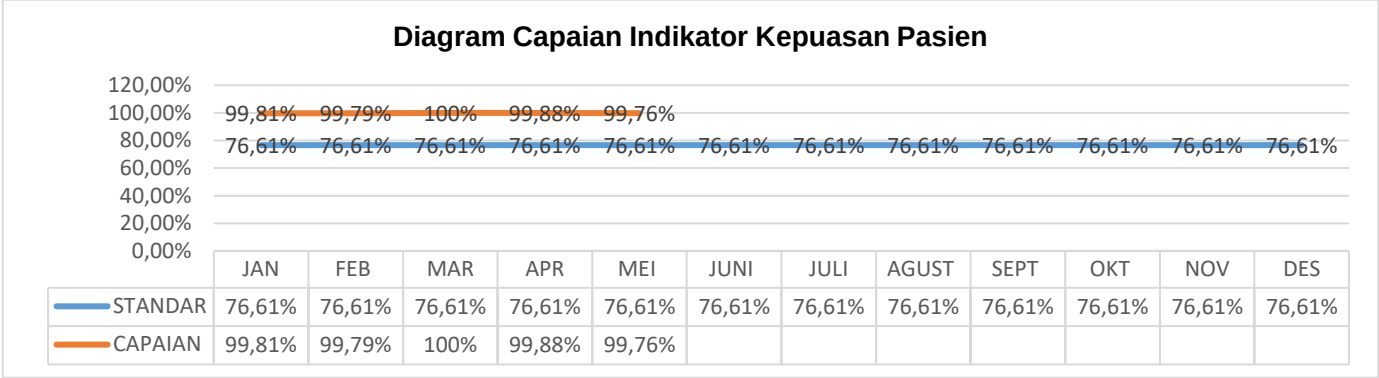
3.6.1.1.12.1 Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Komplain



Dari grafik indikator waktu tanggap kompalian bulan Januari hingga Mei tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart lebih dari 80% dengan rata-rata 99,85%, hal ini berkat kerjasama yang baik antara PIPP dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk segera menanggapi dan melakukan tindak lanjut terkait komplain yang diterima. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.1.12.2 Kepuasan Pasien

3.6.1.1.12.2.1 Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



Dari grafik indikator kepuasan pasien bulan Januari hingga April tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart lebih dari 76,61% dengan rata-rata 99.87%, meskipun belum mencapai nilai sempurna 100% tetapi capaian ini telah melebihi standart. Hal ini karena kerjasama yang baik antara seluruh karyawan Rumah Sakit Prima Husada Malang dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepuasan pasien . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

3.6.1.1.1 Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,55%	99,92%	99,77%	99,96%	99,88%								99,74%
2.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis (IRNA,IRJA, IGD,IKO)	100%	99,55%	99,92%	99,73%	99,51%	99,33%								99,73%
3.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi (IRNA,IGD,IKO)	100%	100%	100%	100%	100%	90,86%								100%
4.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	91,38%								100%
5.	Kejadian Ketidaklengkapan Lembar Operan Pasien (IRNA,IRJA, IGD,IKO)	0	0	0	0	0	0								0
6.	Angka Kelengkapan Penyiapan Dan Pengelolaan Obat Yang Perlu di Waspadai / High Alert (Farmasi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								100%

7.	Kepatuhan penyiapan, pengelolaan, pemberian sesuai standar obat elektrolit pekat (Farmasi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								100%
8.	Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi Sesuai Prosedur (IGD,IRNA,IKO)	100%	100%	100%	99,57%	99,77%	90,41%								99,85%
9.	Kepatuhan Pengisian Daftar Tilik Keselamatan Pasien Operasi (IKO)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								100%
10.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan) (IRNA,IRJA,IGD,IKO)	100%	98,64%	98,64%	99,32%	99,63%	98,74%								98,86%
11.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko jatuh	100%	98,64%	98,65%	98%	99,44%	97,65%								98,43
12.	Kepatuhan kebersihan tangan	85%	85,21%	85,35%	85,32%	85,36%	85,49%								85,29%

3.6.1.1.2 Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Apendicitis akut	100%	100%	100%	100%	100%	100%								100%
2.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi STT	100%	100%	100%	100%	100%	100%								100%

3.6.1.1.3 Tujuan Strategis

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Juli '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61	99,81%	99,79%	100%	99,98%	99,76%								

3.6.1.14 Perbaikan Sistem

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kesesuaiaan Penarikan Data SIMRS Dengan Data Manual Pada Laporan Unit	100%	80,39%	81,69%	82,73%	87,5%	89,35%								

1.6.1.2.5 Mutu Unit

1.6.1.2.5.1 Instalasi Gawat Darurat

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agust '25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Batas waktu pasien menunggu tempat tidur kurang dari 6 jam (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	99,71%	99,7%	97,2%								
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	98,2%	98,36%	98,37%	98,44%	98,72%								
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
5.	Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%								
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
7.	Kepuasan pasien	85%	97,36%	97,29%	100%	98,2	98,92%								
8.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
9.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
10.	Kepatuhan pelaporan pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
11.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
12.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis di IGD	100%	100%	100%	100%	95,43%	92,7%								

13.	Angka tindak lanjut screening nyeri pasien di IGD	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
14.	Angka kepatuhan triage untuk penyakit menular di IGD	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
15.	Respon time IGD kurang dari 5 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
16.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	4,65%	3,7%	2,38%	1,9%	1,67%								
17.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
18.	Kepatuhan pemasangan gelang identitas pasien kurang dari 30 menit setelah pasien terdaftar rawat inap	100%	73,21%	73,32%	75,11%	100%	100%								
19.	Kejadian merujuk pasien berdasarkan aspek pilihan pasien	0	0	0	0	0	0								
20.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
21.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, anak, remaja, risiko bunuh diri)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
22.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
23.	Kegiatan merujuk pasien (horizontal)	0	1	4	3	2	1								

1.6.1.2.5.2 IRNA 2A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	-	-	-	-	-						
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	-	-	-	-	-						
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	5.	-	-	-	-						
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	-				-						

5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	-	-	-	-	-						
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-						
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	-	-	-	-	-						
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	-	-	-	-	-						
9.	Kepuasan pasien	85%	-	-	-	-	-						
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	-	-	-	-	-						
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	-	-	-	-	-						
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	-	-	-	-	-						
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	-	-	-	-	-						
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	-	-	-	-	-						
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	-	-	-	-	-						
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	-	-	-	-	-						
17.	Angka efektivitas discharge planning	100%	-	-	-	-	-						
18.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	-	-	-	-	-						
19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	-	-	-						
20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-						

21.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	-	-	-	-	-							
22.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	-	-	-	-	-							

3.6.1.2.6.3 IRNA 3A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	92,8%	94,7%	95,23%	95,31%	97,22%								
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	93,7%	94,5%	94,61%	95,22%	96,34%								
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	90,6%	89,82%	92,22%	93,33%	98,85%								
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-								
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	88,98%	100%	100%	100%	96,03%								
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	88,98%	100%	100%	100%	98,71%								
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%								
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	96,04%	100%	100%								
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	97,93%	100%								
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	95,48%	100%								
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	87,25%								
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	0	-	4,52%								
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	0	-	100%								
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	95,31%	100%	82,4%								
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0								
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	97,75%	93,79%								

3.6.1.2.6.4 IRNA 4A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25		
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	98,74%	100%								
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	96,72%	96,88%	97,12%	97,22%	98,21%								

3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,6%	96,9%	96,7%	97,8%	98,88%								
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	88,98%	95,17%	96,38%	99,46%	98,3%								
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-								
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	97,14%	100%	89,11%	89,19%	97,62%								
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	97,14%	100%	100%	95,15%	97,79%								
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%								
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	89,8%								
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	95,38%	100%								
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	90,75%	96,52%								
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	82,41%								
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	-	-	2,1%								

19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	100%							
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	98,7%							
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	98,06%	84,21%	92,14%							
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizantal)	0	0	0	0	0	0							
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	96,32%	100%							

3.6.1.2.6.5 IRNA 2C

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	96,55%								
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	98,9%	97,5%	99,2%	99,31%	99,44%								
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	95,8%	97,3%	97,8%	98,2%	88,24%								
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	81,25%	81,44%	82,47%	80,15%	78,62%								
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-								
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	87,91%	94,07%	94,92%	89,05%								
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	87,91%	100%	100%	97,78%								
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%								

10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	97,73%								
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	93,75%	100%								
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	85,71%								
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	-	-	-	-	-								
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-								
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	85,71%								
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0								
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	97,79%								

3.6.1.2.6.6 IRNA 3C ANAK

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	96,7%	97,1%	97,54%	97,57%	97,22%								
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	94,8%	96,1%	96,19%	96,34%	96,1%								
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	100%	80,72%	100%	100%	100%								
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-								
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	88,1%	100%	100%	100%								
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	88,1%	100%	100%	100%								
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%								
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajenen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0,43%	1,53%								
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	100%	100%								
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0								
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

3.6.1.2.6.7 IRNA 5C

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	92,11%	98,95%	98,78%								
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	99,6%	99,8%	99,7%	99,78%	99,72%								
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,7%	99,1%	99,5%	99,62%	99,66%								
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	99,61%	94,65%								
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	81,25%	81,44%	80,68%	81,44%	75%								

6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-								
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	87,91%	100%	100%	84,15%								
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	87,91%	97,27%	99,51%	97,9%								
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%								
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	98,71%	92,24%	96,88%								
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	88,24%	100%	100%								
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	99,38%								
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	97,47%	97,47%								
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	75%	95,12%	100%								
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	92,64%	98,88%	100%								
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0,97%	1,06%	0,43%	0%	100%								
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	-	0%								
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	-								

21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	100%								
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	0								
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

3.6.1.2.6.8 IRNA 6A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannya edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89,2%	90,3%	93,3%	93,7%	95,6%								
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,1%	97,3%	97,1%	97,31%	98,5%								
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	82,14%	78,72%	82,02%	68,31%	63,64%								
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-								
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%								
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	1,75%	0%	0,32%	0%	0%								
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	-	100%	-	-								
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0								
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

3.6.1.2.6.9 IRNA 7A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89,98%	93,4%	96,12%	96,16%	97,22%								
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	87,24%	89,22%	92,33%	92,41%	94,62%								
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	99,1%								
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	80,36%	80,58%	63,95%	67,13%	53,89%								
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-								
7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	95,69%								
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%								
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	87,15%								
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajenen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	81,18%								

16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	1,23%	0%	0,64%	0%	0%								
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	-	100%	-	-								
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	1	1	0	0								
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

3.6.1.2.6. 10 IRNA 8A

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agt'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Dilaksanakannyaa edukasi dan orientasi pada pasien dan keluarga (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	97,8%	99,8%	99,62%	99,64%	98,92%								
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	92,1%	95,6%	95,71%	95,82%	97,21%								
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	97,92%								
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	80,36%	72,79%	82,52%	73,6%	52,88%								
6.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥ 80%	-	-	-	-	-								

7.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
8.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
9.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%								
10.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
11.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
12.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
13.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
14.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
15.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	92,86%								
16.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
17.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%								
19.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
20.	Kelengkapan pengisian edukasi pasien dan keluarga tentang perawatan lanjutan dan obat yang dibawa pulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
21.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

22.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0								
23.	Kelengkapan Pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
24.	Angka Kelengkapan Komunikasi Serah Terima Pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

3.6.1.2.6.11 ICU

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89.9%	95,5%	97,7%	97,8%	98,22%								
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,2%	99,8%	99,6%	99,8%	99,88%								
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	95,64%	97,81%	100%	100%	100%								
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	96,72%	96,89%	100%	100%	92,14%								
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	92%	93,2%	88,2%	100%	100%								
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesauaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
8.	Kepuasan pasien	85%	-	-	-	-	-								
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

12.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
14.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
15.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
16.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0	0	0	0	1,4%								
17.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	100%								
18.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
19.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU	100%	100%	100%	93,33%	100%	100%								
20.	Angka kelengkapan pengkajian pasien tahap akhir kehidupan	0%	100%	100%	100%	100%	100%								
21.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	92,37%	100%	100%								
22.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, pelayanan intensive)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
23.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0								
24.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

3.6.1.2.6.12. HCU

NO	JUDUL	STAND	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri (Mutu Prioritas Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	88,99%	96,22%	97,61%	98,17%	99,24%								
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99,5%	99,2%	99,36%	99,42%	99,56%								
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	95,71%	98,92%	100%	100%	100%								
5.	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	96,21%	96,71%	95,32%	100%	94,8%								
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	94%	97,1%	82,18%	100%	100%								
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
8.	Kepuasan pasien	85%	-	-	-	-	-								
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
12.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
14.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
15.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

16.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0	0	0	0	0								
17.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-								
18.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
19.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk ICU	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
20.	Angka kelengkapan pengkajian pasien tahap akhir kehidupan	0%	100%	100%	100%	100%	100%								
21.	Angka kelengkapan penilaian risiko jatuh (awal, ulang, lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
22.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (koma, gaduh gelisah, geriatric, menular, pelayanan intensive)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
23.	Kejadian merujuk pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0								
24.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

3.6.1.2.6.13 IRJA

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Agus'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kelengkapan pengkajian medis rawat jalan (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%	100%	S	100%								
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	99,2%	98,72%	99,02%	99,32%	98,72%								
3.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	98,35	98,71%	99,24%	99,44%	98,94%								
4.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	99,11%	100%	100%								

5.	Waktu tunggu rawat jalan	≥ 80%	89,16%	89,3%	99,11%	99,02%	98,72%								
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
7.	Kepuasan pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%								
8.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
9.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
10.	Angka kelengkapan pengkajian keperawatan rawat jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
11.	Ketepatan waktu jam praktek dokter	100%	78,92%	77,8%	72,59%	79,58%	79,64%								
12.	Kejadian merujuk pasien	0	0	0	48		15								
13.	Angka kelengkapan inform concent	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
14.	Angka kelengkapan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
15.	Kelengkapan profil pasien rawat jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

3.6.1.2.6.14 MATERNITAS

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kematian ibu (mutu prioritas unit)	0%	0%	0%	0%	0%	0%								
2.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
3.	Waktu tanggap operasi Seksio Sesarea Emergensi.	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%								

4.	Kepatuhan waktu visite dokter.	≥80%	25,95%	24,56%	34,51%	39,04%	39,06%								
5.	Kepatuhan terhadap alur klinis (Clinical Pathway)	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%								
6.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
7.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
8.	Kejadian keterlambatan operasi sectio caesaria (SC) > 30 menit	<5%	0%	0%	0%	0%	0%								
9.	Angka keterlambatan penyediaan darah > 60 menit	<10%	0%	0%	0%	57,14%	0%								
10.	Kejadian perdarahan post partum	0	0	2	5	4	2								
11.	Kejadian partus macet	0	0	0	13	8	12								
12.	Kejadian eklamsi	0	1	0	0	0	0								
13.	Kejadian pre eklamsi	0	5	2	4	4	1								
14.	Kejadian infeksi nifas	0	0	0	0	1	0								
15.	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP	100%	13,6%	12,5%	18,75%	11,67%	22%								
16.	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	100%	13,6%	12,5%	18,75%	11,67%	22%								
17.	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	0	108	77	86	102	72								
18.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%								
19.	Kepuasan pasien	≥ 76,61	100%	100%	100%	100%	100%								
20.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
21.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

22.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
23.	Angka kelengkapan lembar operan pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
24.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
25.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
26.	Kelengkapan forum edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
27.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
28.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%								
29.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
30.	Angka kelengkapan pengkajian awal gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
31.	Kejadian tidak dilakukan edukasi RSSIB pada pasien post partum dan post SC	0	0	0	0	0	0								
32.	Angka kelengkapan komunikasi serah terima pasien (SBAR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
33.	Kejadian tidak dilakukannya IMD pada bayi baru lahir	0	0	0	0	0	0								

3.6.1.2.6.15 NICU

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian kematian bayi (mutu prioritas unit)	0	0	1	2	0	1								
2.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	98,31%	99,02%	99,45%	99,57%	99,88%								
3.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,98%	99,79%	99,71%	99,74%	99,81%								

4.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
5.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	85,11%	85,51%	81,18%	84,09%	78,13%								
6.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
8.	Kepuasan Pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%								
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	95,51%								
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
12.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
14.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
15.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	88,46%								
16.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
17.	Kelengkapan Follow Up Setelah Discharge	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
18.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
19.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%								

20.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-								
21.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
22.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk NICU	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
23.	Angka Kelengkapan Pengkajian Pasien Tahap Akhir Kehidupan	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
24.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
25.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (neonatus)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
26.	Kejadian Merujuk Pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0								

6.6.1.2.6.16 PICU

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kelengkapan pengkajian populasi khusus (Anak) (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
2.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	99,23%	99,44%	99,44%	99,61%	99,88%								
3.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,11%	98,79%	98,79%	98,82%	98,92%								
4.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
5.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%								
6.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
7.	Kelengkapan pengisian form transfer pasien dan kesesuaian derajat pasien dengan tenaga pengantar	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

8.	Kepuasan Pasien	85%	100%	100%	100%	100%	100%								
9.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
10.	Kepatuhan pelaksanaan readback dalam komunikasi via alat telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
11.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
12.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
13.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
14.	Kepatuhan pelaksanaan pengkajian dan manajemen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
15.	Kelengkapan form edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
16.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
17.	Prosentase pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0%	0%	0%	0%								
18.	Angka kelengkapan edukasi pasien pulang atas permintaan sendiri	100%	-	-	-	-	-								
19.	Angka kelengkapan pengkajian awal medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
20.	Angka kelengkapan form kriteria keluar masuk PICU	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
21.	Angka Kelengkapan Pengkajian Pasien Tahap Akhir Kehidupan	0%	-	-	-	-	-								
22.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
23.	Kejadian Merujuk Pasien (Horizontal)	0	0	0	0	0	0								

3.6.1.2.6.17 IKO

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian tidak dilakukannya skiren pada pasien operasi yg seharusnya diskiren (mutu prioritas unit)	0	0	0	0	0	0								
2.	Kepatuhan identifikasi pasien.	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
3.	Penundaan operasi elektif.	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%								
4.	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh.	100%	100%	100%	100%	100%	95,61%								
5.	Angka Kelengkapan Penilaian Risiko Jatuh (Awal, Ulang, Lanjutan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
6.	Kejadian keterlambatan operasi> 30 menit	0	0	0	0	0	0								
7.	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis pemulihan anestesi dan sedasi dalam	0	0	0	0	0	0								
8.	Kejadian tidak dilaksanakannya proses monitoring fisiologis selama anestesi	0	0	0	0	0	0								
9.	Kejadian tidak dilaksanakannya pengkajian pra sedasi dan pra anestesi	0	0	0	0	0	0								
10.	Kejadian diskrepansi diagnose pre dan post op	0	0	0	0	0	0								
11.	Kejadian tidak dilaksanakan SSC	0	0	0	0	0	0								
12.	Kejadian tidak lengkapnya pengkajian pra bedah	0	0	0	0	0	0								
13.	Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0	0	0	0	0	0								
14.	Kejadian ketidaklengkapan form daftar tilik pasien operasi	0	0	0	0	0	0								
15.	Kejadian Ketidakpatuhan Prosedur Pasien Yang Menggunakan Implan	0	0	0	0	0	0								

16.	Kejadian ketidaklengkapan formular penandaan pasien operasi	0	0	00	0	0	0								
17.	Ketidakhadiran dokter anak saat operasi SC	0	0	0	81,98%	19,84%	21,05%								
18.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan inform consent	100%	100%	100%	100%	98,37%	92,98%								
19.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Apendicitis	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
20.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi STT	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
21.	Angka kelengkapan identitas pasien pada semua berkas rekam medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
22.	Kepatuhan pencatatan pesan lewat telepon	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
23.	Kepatuhan waktu pelaporan hasil kritis gula darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
24.	Angka Kelengkapan Lembar Operan Pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
25.	Kelengkapan dan kesesuaian pelaksanaan informed consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
26.	Kepatuhan pelaksanaan asesmen nyeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
27.	Kelengkapan forum edukasi terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

28.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
29.	Angka kelengkapan form transfer pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
30.	Kelengkapan Asesmen pra sedasi dan pra anastesi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

3.6.1.2.6.18 Laboratorium

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian ketidaktersediaan Reagen esensial di laboratorium (mutu prioritas unit)	0	0	0	3	0	5								
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
3.	Pelaporan hasil kritis laboratorium	100%	96,9%	97,31%	100%	100%	100%								
4.	Ketersediaan kantong darah sesuai golongan	100%	100%	100%	100%	100%	98,44%								
5.	Survilen harian hemofiglen	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
6.	Angka kepatuhan Prosedur penggunaan produk darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
7.	Kejadian salah input hasil laboratorium	0	0	0	0	0	0								
8.	Waktu tunggu hasil laboratorium >140 menit	0%	0%	0%	0%	0%	0%								
9.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%	100%								
10.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
11.	Kepatuhan Pelaporan Kritis Gula Darah	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

12.	Angka kepatuhan pengelolaan POCT (proses pelaporan nilai kritis, kualifikasi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
13.	Waktu tunggu hasil laborat cito <30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

3.6.1.2.6.19 Radiologi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	97,88%	100%	100%	98,74%	100%								
2	Angka ketidaklengkapan permintaan form radiologi	0%	2,12%	3,54	5,5%	6,99%	7,4%								
3	Kepatuhan pelaporan nilai kritis hasil radiologi <30 menit	0	0	0	0%	100%	100%								
4.	Kepatuhan edukasi pada prosedur radiasi	100%	100%	100%	100%	99,49%	100%								
5.	Angka kelengkapan inform consen pada prosedur radiasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
6.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%	100%								
7.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

3.6.1.2.6.20 Gizi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian pasien baru tidak mendapatkan makan (mutu prioritas unit)	0	0	0	0	0	0								
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
3.	Kejadian kesalahan pemberian diit	0	0	0	4	1	2								
4.	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0	0	0	0	0	0								
5.	Kelengkapan pengkajian gizi (awal dam lanjut)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

6.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	99,44%	99,67%	99,21&	99,42%	99,82%								
7.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	99,01%	99,23%	98,92%	99,22%	99,54%								

3.6.1.2.6.21 Farmasi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka ketersediaan obat obatan emergency (mutu prioritas unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
2.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
3.	Kepatuhan penggunaan formularium Nasional	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%								
4.	Kejadian kesalahan penyiapan obat	0	0	0	1	0	1								
5.	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	0	0	0	0	0	0								
6.	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit.	0%	68,85%	61,98%	74,45%	75,13%	69,23%								
7.	Angka keterlambatan penyiapan obat racikan >60 menit.	0%	48,68%	44,17%	59,59%	60,78%	53,23%								
8.	Kejadian kesalahan pemberian obat	0	0	0	1	0	3								
9.	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat.	0	0	0	2	0	1								
10.	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat high alert	0	0	0	0	0	0								
11.	Kejadian kesalahan input e-resep	0	0	0	2	0	1								
12.	Kejadian terkena pemanas mesin press puyer	0	0	0	0	0	0								
13.	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0	0	0	20	13	0								
14.	Kejadian obat pasien rawat jalan yang tidak diambil	0	0	0	29	22	42								

15.	Kepatuhan penggunaan panduan antibiotik dan efektifitas jangka panjang dan jangka pendek	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
16.	Kepatuhan penyimpanan obat obatan emergency disimpan secara seragam	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
17.	Kepatuhan proses pengelolaan obat recal hingga pengembalian atau pemusnahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
18.	Angka Kepatuhan pengelolaan obat kedaluwarsa	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
19.	Angka Kepatuhan penyimpanan dan pengelolaan obat yang perlu di waspada	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
20.	Kepatuhan penyimpanan, pengelolaan dan pemberian obat elektrolit pekat	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
21.	Angka Kepatuhan peresepan dan interuksi medis	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
22.	Angka kepatuhan dispensing	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
23.	Angka kepatuhan pemberian obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
24.	Angka kelengkapan pencatatan efek samping obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
25.	Angka Kepatuhan Pelaporan Medication Error	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
26.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%	84,29%								
27.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%	93,10%	97,66%	100%								
28.	Kepatuhan pelaksanaan panduan penggunaan single dose vial	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
29.	Kepatuhan penggunaan risk based approach monitoring penggunaan obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

30.	Angka kepatuhan pengkajian risiko penggunaan obat yang dibawa pasien dari rumah	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
-----	---	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

3.6.1.2.6.22 Pengadaan Farmasi

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sep '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kekosongan stok farmasi	0%	0%	0%	0,42%	0,24%	0,35%								
2	Angka kepatuhan kolaborasi tim pengadaan obat	0%	0%	0%	100%	100%	100%								

3.6.1.2.6.23 PPI

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sep '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	0,27%	0,29%	0,29%	0,48%	0,53%								
2.	IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤3,5‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰								
3.	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 %	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰								
4.	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 %	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰								
5.	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 %	0,21%	0,23%	0,23%	0,1%	0,5%								
6.	Angka Decubitus	0%	0%	0%	0%	0%	0%								
7.	Angka kepatuhan kebersihan tangan	>85%	85,21%	85,35%	85,32%	85,36%	85,49%								
8.	Angka kepatuhan penggunaan APD oleh petugas	100%	93,01%	93,06%	93,1%	93,39%	93,59%								
9.	Kepatuhan Pemilahan Sampah Infeksius dan Non Infeksius di Unit Pelayanan	100%	93,44%	93,21%	93,27%	93,42%	93,51%								
10.	Kejadian petugas tertusuk benda tajam bekas pasien (pajanan)	0	0	0	0	0	0								

3.6.1.2.6.24 PIPP

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka Terhubungnya Display TT Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

2.	Angk Terhubungnya Operasi Dengan Mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
3.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain < 1 kali dari 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
4.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain < 1 kali dari 24 jam	100%	100%	1005	100%	100%	100%								
5.	Kepuasan Pasien	76,61%	99,81%	99,79%	100%	99,88%	99,76%								
6.	Kepatuhan Petugas Dalam Mengumpulkan Kuesioner Kompalin dan Kepuasan Pelanggan (Indikator baru 2024)	100%	14,12	18,94%	16,09%%	16,89%	18,12%								
7.	Angka Kepuasan Pasien BPJS	100%	99,9%	99,89	100%	100%	99,98%								
8.	Angka efektivitas discharge planning	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
9.	Kelengkapan Follow Up Setelah Discharge	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

3.6.1.2.6.25 SDM

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK.	0	0	0	0	0	0								
2	Angka kedisiplinan staf terhadap finger print.	100%	78%	98,51%	98,69%	98,79%	98,69%								
3	Angka keterlambatan kehadiran staf	0%	37%	2,39%	1,91%	2,31%	1,48%								
4.	Angka pemenuhan kompetensi sesuai dengan unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
5.	Angka kelengkapan file kepegawaian dimasing masing unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

3.6.1.2.6.26 Rekam Medis

No .	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat Inap (mutu prioritas unit)	100%	91,86%	29,3%	35,83%	51,74%	50,36%								
2.	Angka kejadian nomor rekam medis ganda	0%	0,14%	0,23%	0,35%	0,47%	0,32%								

3.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat jalan	100%	91,86%	70,8% %	98,04%	1,57%	7%								
4.	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien IGD	100%	100%	100%	90,25%	88,2%	10,23%								
5.	Kejadian Kendala Pada SIMRS Dalam Upaya Menunjang Pelayanan Rekam Medis Elektronik	0	0	0	0	0	0								
6.	Kelengkapan Keakuratan Pada Penginputan Data Pasien Di SIMRS	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
7.	Keterlambatan Pengumpulan DRM Pasien Rawat Inap Lebih Dari 24 Jam	0%	7,56%	7,89%	9,56%	15,3%	12,21%								
8.	Angka keterbacaan dokumen rekam medis	100%	100%	100%	98,17%	95,87%	95,88%								

3.6.1.2.6.27 K3RS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka kepatuhan petugas melakukan pengecekan APAR.	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
2	Kejadian kebakaran di ruangan.	0	0	0	0	0	0								
3	Kejadian tenaga Kesehatan sakit akibat kerja	0	0	0	0	0	0								

3.6.1.2.6.28 Asuransi Center

No.	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Kejadian dokumen rawat jalan tidak layak klaim	0	0	0	0	0	0								
2.	Angka pending klaim BPJS	0%	3,05%	2,54%	3,23%	3,23%	1,62%								
3.	Prosentase readmisi pasien rawat inap	0%	0,91%	1,9%	2,22%	2,18%	2,05%								
4.	Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS	100%	98,99%	98,96%	99,26%	98,89%	98,9%								
5.	Kejadian Pasien Tidak Di SEP	0	1	2	0	0	0								

3.6.1.2.6.29 IPSRS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka Keterlambatan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam	0%	46%	65%	78%	61%	68%								
2.	Angka keterlambatan respon dan penanganan pelaporan kerusakan oleh unit dalam 1x 24 jam (alat medis)	0%	97%	92%	94%	95%	95%								

3.6.1.2.6.30 UMUM

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Keterlambatan barang datang di Gudang	0	7	8	7	2	4								
2	Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit	0	10	8	2	2	4								

3.6.1.2.6.31 Cleaning Service

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Angka ketidakpatuhan penggunaan spillkit	0%	47,5%	59,26%	23,53%	45%	85,22%								
2.	Kejadian komplain Kebersihan Kamar Mandi	0%	0	0	0	0	0								
3.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	88,72%	91,33%	92,47	94,21%	96,62%								
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	92%	94,07%	94,28	96,82%	98,24%								

3.6.1.2.6.32 KESEKRETARIATAN

	No	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka keterlambatan pengumpulan laporan bulanan unit tanggal 4 setiap bulannya	0%	50%	40,48%	56,52%	50%	22,5%								
2	Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen meeting RS 1x 24 jam hari kerja	0%	27,27%	23,08%	31,82%	27,78%	38,1%								
3	Angka tindaklanjut balasan surat masuk eksternal lebih dari 2x24 jam	0%	29,41%	29,41%	34,88%	34,78%	31,25%								

3.6.1.2.6.33 Laundry

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka keterlambatan penyediaan linen	0%	2,14%	1,78%	2,23%	1,32%	2,06%								
2	Kejadian linen ruang perawatan hilang	0	0	0	0	0	0								
3.	Kejadian Tercampur Benda Asing	0	0	0	1	1	1								
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	98,82%	99,32%	99,04%	99,22%	99,85%								
5.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	97,23%	96,22%	96,48%	96,92%	98,72%								

3.6.1.2.6.34 CSSD

No	Judul	Stan	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian ditemukannya instrument hilang	0	0	0	0	0	1								
2	Kejadian instrument kurang	0	0	1	1	1	1								
3.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%	100%	100%	100%	100%	100%								
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	96,77%	97,11%	97,88%	98,22%	100%								

3.6.1.2.6.35 Humas dan Pemasaran

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Angka kunjungan rawat inap >90 pasien perhari	100%	98,71%	98,71%	99,86%	79,78%	84,44%								
2	Angka kunjungan rawat jalan >350 pasien perhari	100%	86,69%	93,82%	93,82%	79,81%	86,21%								
3.	Angka kunjungan pasien rencana operasi 15 pasien perhari	100%	92,34%	91,22%	92,46%	76,14%	79,22%								
4.	Angka kunjungan MCU dan vaksin 150 perbulan	100%	100%	98,82%	97,92%	72,67%	70,22%								

1.6.1.2.6.36 IT

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian downtime	0	0	0	0	0	0								
2	Respon time penanganan internet dan billing error < 30 mnt	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
3	Respon Time untuk penanganan computer < 15 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

3.6.1.2.6.37 Kamar Jenazah

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1.	Pencatatan kematian pasien di kamar mayat (registrasi) < 2jam	100%	100%	100%	100%	0	0								
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	-	-	-	100%	100%								
3.	Kepatuhan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

3.6.1.2.6.38 PKRS

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kepatuhan pelaksanaan edukasi kelompok	100	53,26%	68,38%	78,88%	82,44%	92,34%								

3.6.1.2.6.38 DRIVER

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Resptime Panggilan Driver < 10 menit On Side	100%	99,2%	99,68%	99,88%	100%	100%								
2	Resptime Panggilan Driver < 30 menit On Call	100%	100%	99,92%	99,82%	98,88%	98,64%								
3	Kepatuhan pemeliharaan alat transportasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
4	Angka kelengkapan alat emergency untuk ambulance emergency	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
5	Kepatuhan pelaksanaan decontaminasi pasca transport pasien menular pada ambulance	100%	100%	100%	100%	100%	100%								

3.6.1.2.6.39 SECURITY

No	Judul	Stand	Jan '25	Feb '25	Mar '25	Apr '25	Mei '25	Jun '25	Jul '25	Ags'25	Sept '25	Okt '25	Nov '25	Des '25	Rata-Rata
1	Kejadian ditemukannya merokok, puntung rokok di lingkungan RS (mutu prioritas unit)	0	6	11	7	14	21								
2	Kejadian Barang Hilang Di Area Rumah Sakit	0	0	0	0	0	0								
3	Kejadian potensial barang hilang	0	7	9	13	9	8								
4	Kejadian kekerasan di lingkungan RS	0	0	0	0	0	0								

1.6.2 Komite PPI

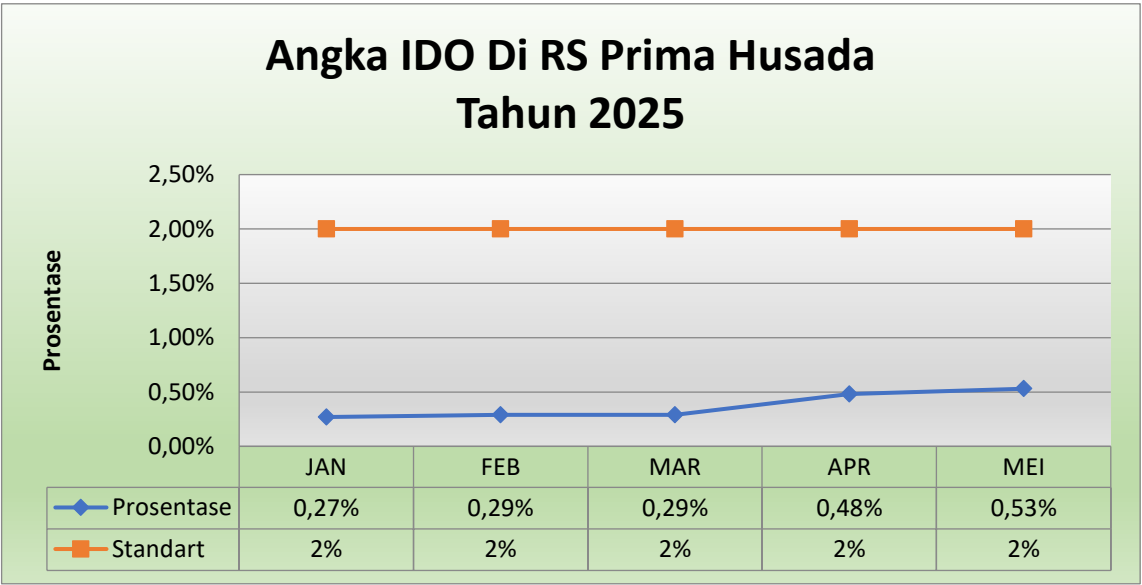
1.6.2.2 Hasil Surveilans dan Mutu PPI

1.6.2.2.5 IDO (Infeksi Daerah Operasi)

1.6.3.5.1 Tabel Data IDO berdasarkan Jenis Tindakan Operasi Sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

Jenis Tindakan Operasi di RS	SSI		
	Jumlah Kasus	Jumlah Tindakan Operasi	Insiden (%)
Bedah Orthopedi	0	64	0%
Seksio Sesaria	1	64	1,56%
Apendiktomi	0	3	0%
Herniotomi	0	8	0%
Katarak	0	36	0%
CABG	-	-	-
Tumor Payudara	0	12	0%
Semua Operasi	2	373	0,53%

1.6.3.5.2 Grafik Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO)



Analisa	Dari grafik diatas diperoleh data terdapat kejadian IDO pada 2 orang pasien yang menjalani operasi SC dan laparatomi. Dari hasil assesmen pasien diperoleh data bahwa pasien berusia 36 dan 9 tahun. Pasien dengan laparatomi didapatkan terjadi IDO pada saat hari ke 5 perawatan setelah operasi. Didapatkan luka terdapat rembesan cairan lambung yang seharusnya keluar melalui drain, namun cairan merembes melalui celah jahitan. Dari anamnesa dokter, hal tersebut dikarenakan pasien yang kurang mobilisasi (hanya tiduran di tempat tidur) dan kurangnya pemahaman keluarga terkait perawatan pasien paska operasi karena anak ini sering ditinggal sendiri di ruangan, sehingga asupan nutrisi yang diberikan pun kurang mendapat perhatian, ditambah dengan kondisi anemia yang dialami pasien. Sedangkan pada pasien post SC, ditemukan luka bernanah pada saat rawat luka di poli. Pasien tidak terlalu memperhatikan kondisi luka dan asupan nutrisinya dikarenakan masih berduka karena bayinya IUFD. Sedangkan dilihat dari segi peralatan pasien sudah dilakukan sterilisasi dengan indikator internal & eksternal, pasien juga sudah melakukan mandi sebelum operasi dilakukan, namun dari segi urutan pemakaian kamar operasi, pasien dioperasi pada urutan ke 3 hari itu dengan jeda waktu 30 menit setelah op SC dengan DPJP lain.				
Masalah saat ini	1. Belum adekuatnya edukasi perawatan pasien pasca operasi terutama perawatan setelah operasi / saat dirumah termasuk nutrisi dan mobilisasi yang harus dipenuhi untuk mempercepat penyembuhan luka dan bekal konseling pada pasien terutama pasien yang berduka. 2. Belum maksimalnya proses pembersihan ruang operasi pada operasi estafet dimana terjadi peningkatan jumlah pasien operasi pada waktu yang hamper bersamaan.				
Permasalahan sebelumnya	1. Masih belum berjalannya secara rutin terkait anjuran pasien untuk melakukan mandi sebelum operasi baik itu operasi elektif maupun cyto. 2. Belum adekuatnya edukasi perawatan pasien pasca operasi terutama perawatan saat dirumah termasuk nutrisi yang harus dipenuhi untuk mempercepat penyembuhan luka. 3. Belum maksimalnya proses pembersihan ruang operasi pada operasi estafet dimana terjadi peningkatan jumlah pasien operasi.				
Tindakan yang dilakukan	1. Monitoring proses edukasi pasien pasca operasi terutama pemahaman pasien saat perawatan setelah operasi termasuk kontroling mobilisasi. 2. Monitoring proses perawatan pasien yang terjadi IDO di ruang perawatan. Minta petugas untuk lebih memperhatikan kondisi pasien (sering mengingatkan ke ruangan pasien) untuk mobilisasi dan memastikan asupan makanan tepat waktu jika keluarga tidak kooperatif. 3. Menganjurkan petugas IKO untuk menjadwal penggunaan kamar operasi dan mendahulukan pasien dengan kategori operasi bersih terlebih dahulu dan memperhatikan jeda waktunya, serta memaksimalkan proses pembersihan. 4. Mengamati kembali proses pembersihan ruang operasi terutama jika terdapat operasi estafet. 5. Monitoring pelaksanaan audit bundle IDO sesuai di ruang perawatan pasien.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Memastikan bundle IDO berjalan dengan baik.	Resiko IDO pada pasien berkurang/hilang.	Pasien operasi	1. Berkolaborasi dengan PPA terkait kondisi penyakit penyerta serta memberikan edukasi untuk mencegah agar risiko infeksi tidak menjadi aktual. 2. Memastikan bundle IDO (pre, durante, dan post op dilakukan dengan baik) 3. Pastikan proses pembersihan kamar operasi diantara jeda operasi dilakukan dengan benar sesuai prosedur.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/PCN	Satu bulan

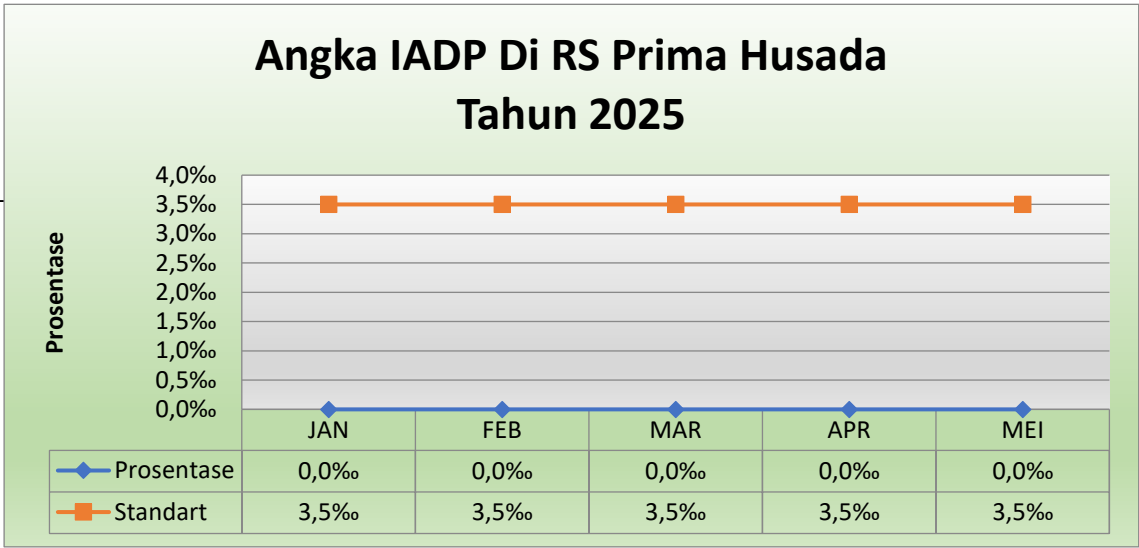
			4. Koordinasi dengan MOD terkait penjadwalan pasien operasi elektif lebih ditingkatkan. 5. Penggunaan alat tetap diperhatikan proses sterilisasi central di CSSD terutama jika dilakukan operasi estafet dengan kasus yang sama (SC). 6. Melakukan monitoring persiapan pasien operasi khususnya pasien dianjurkan untuk mandi antiseptic/sabun untuk mengurangi resiko infeksi.		
Lanjutkan evaluasi pemahaman pemberian edukasi perawatan pasien pasca operasi	Meminimalisir kesalahpahaman penangkapan terkait edukasi perawatan pasien post operasi.	Pasien post operasi.	1. Koordinasi dengan perawat ruangan untuk memastikan pasien dan sudah mendapatkan edukasi terkait perawatan saat di rumah. 2. Pastikan pasien paham saat diedukasi dengan menanyakan kembali inti edukasi yang telah diberikan. (Memastikan komponen edukasi tersampaikan dengan baik/Komunikasikan-komunikasikan-pesan-media-feed back) 3. Lakukan edukasi pada saat pasien terdapat pendamping keluarga terutama yang satu rumah dengan pasien. 4. Bantu berikan dorongan afirmasi positif atas keadaan yang terjadi pada pasien agar tidak mengganggu proses penyembuhan agar pasien lebih semangat untuk sembuh. 5. Berikan tambahan edukasi terkait kontrol pikiran pasien terutama terkait pantangan yang tidak perlu dipercaya di masyarakat.	1. Perawat /Bidan 2. Karu 3. IPCLN/PCN	Satu bulan

3.6.1.1.2 IADP

3.6.1.1.2.1 Tabel Data IDP Berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAIs Kemenkes

Ruang	SSI		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian CVC	Insiden (%)
ICU	0	11	0‰
HCU	0	0	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	0	0‰

3.6.1.1.2.2 Grafik Angka Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)



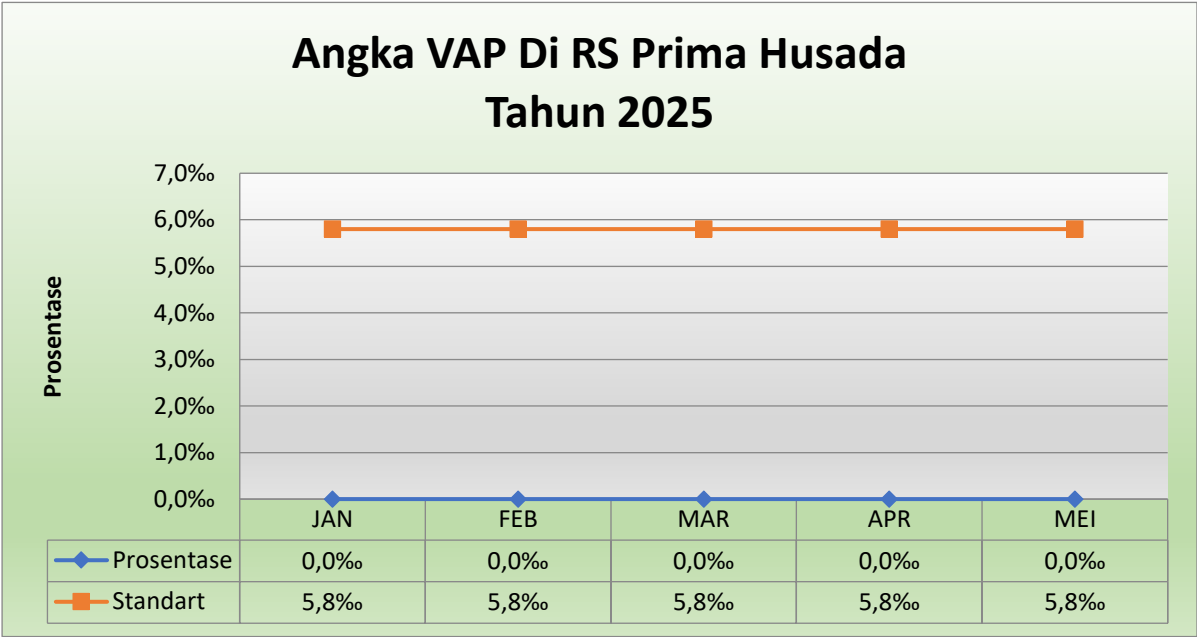
Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus IADP pada 11 hari total lama pemasangan CVC pada pasien bulan ini.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi IADP				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi IADP				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan tindakan pemasangan CVC. 2. Melakukan evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. 3. Melakukan monitoring kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. 4. Melakukan monitoring 5. perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle IADP.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IADP.	Pasien dengan pemakaian CVC.	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. 3. Monitoring evaluasi kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. 4. Monitoring evaluasi perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.6.1.1.3 VAP

3.6.1.1.3.1 Tabel Data VAP berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

Ruang	VAP		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian Ventilator	Insiden (%)
ICU	0	33	0‰
HCU	0	0	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	0	0‰

3.6.1.1.3.2 Grafik Angka Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator (VAP)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus VAP pada 33 hari total lama pemasangan ventilator pada pasien bulan ini.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi VAP				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi VAP				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan evaluasi perawatan pasien dengan terpasang ventilasi mekanik. 2. Melakukan audit monitoring saat pemasangan ventilator. 3. Melakukan observasi tanda-tanda dehidrasi (bibir kering) pada pasien yang terpasang ventilator. 4. Melakukan evaluasi saat pasien dilakukan penghisapan lendir / suction. 5. Melakukan koordinasi dengan Kabid keperawatan terkait edaran kewajiban melakukan oral hygiene pada pasien yang terpasang ventilator dan mendokumentasikan di CPPT/Askep.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Tingkatkan kepatuhan bundle VAP, khususnya pelaksanaan oral hygiene.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle VAP (oral hygiene).	Pasien yang terpasang ventilator mekanik	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan ventilator. 3. Monitoring evaluasi posisi tepat pasien head of bed >30°-45°. 4. Monitoring evaluasi tindakan pemasangan ventilator.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

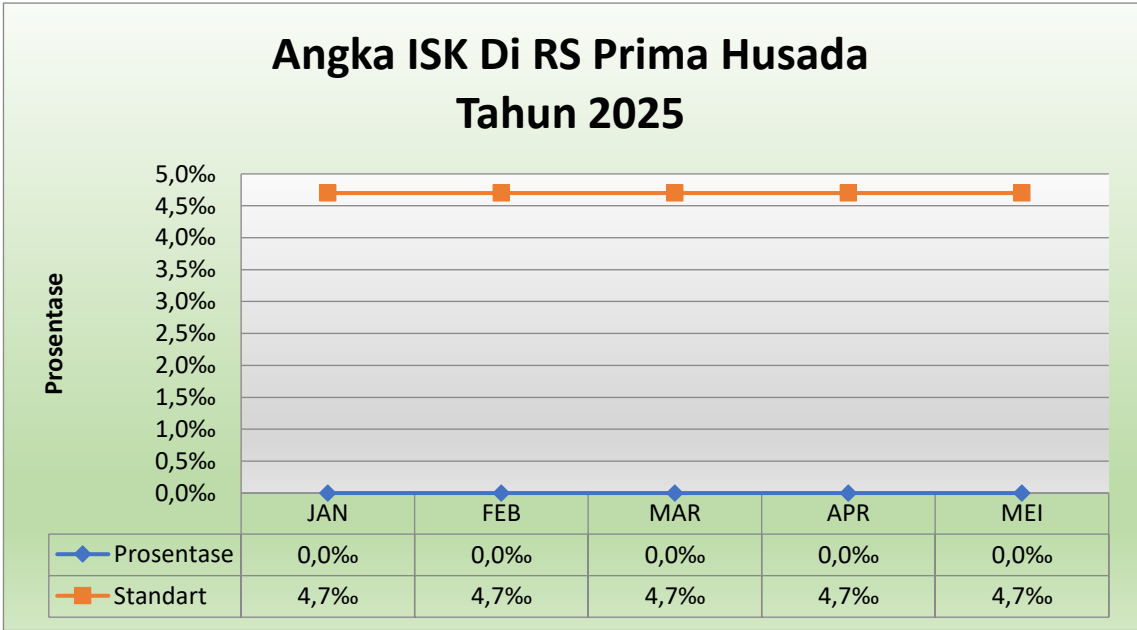
			5. Monitoring kegiatan oral hygiene dan pendokumentasian di RM. 6. Pemberian tindakan oral hygiene mewajibkan juga diedukasikan pada keluarga pasien, agar keluarga ikut aktif mengingatkan petugas untuk melakukan tindakan tersebut.		
--	--	--	---	--	--

3.6.1.1.4 ISK

3.6.1.1.4.1 Tabel Data berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR ((Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

Ruang	ISK		
	Jumlah Kasus	Jumlah Lama Hari Pemakaian Ventilator	Insiden (‰)
ICU	0	131	0‰
HCU	0	45	0‰
NICU	0	0	0‰
PICU	0	0	0‰

3.6.1.1.4.2 Grafik Angka Infeksi Saluran Kencing (ISK)

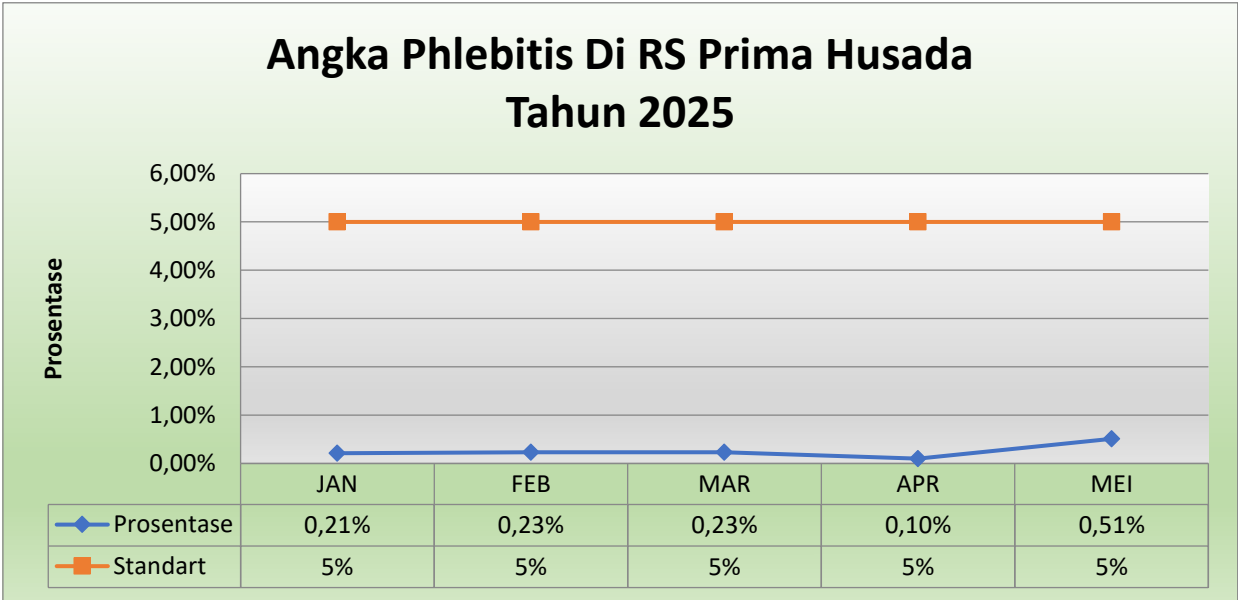


Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus ISK pada total 1252 hari lama pemakaian kateter pasien.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi ISK				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi ISK				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan perawatan pasien. 2. Melakukan monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. 3. Melakukan monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. 4. Melakukan monitoring perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

Pertahankan kepatuhan pencegahan dekubitus.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan pencegahan dekubitus.	Pasien yang tirah baring lama (> 3x24 jam)	1. Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. 2. Monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). 3. Anjurkan penggunaan kasur anti decubitus atau alternatif lain 4. Monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. 5. Lakukan perawatan luka rutin jika sudah terdapat luka supaya tidak melebar.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan
---	--	--	--	--	------------

3.6.1.1.6 Phlebitis

3.6.1.1.6.1 Grafik Angka Infeksi Jarum Infus (Phlebitis)

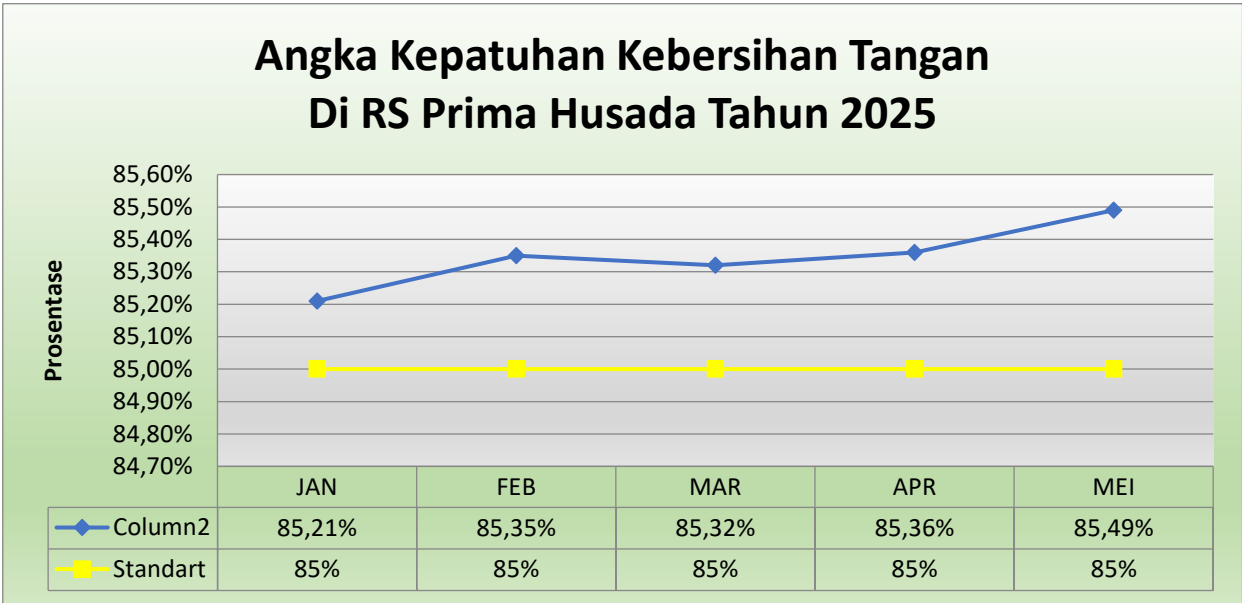


Analisa	Masih ditemukan kasus Phlebitis pada bulan ini dari total 2958 pasien yang terpasang infus setiap harinya dengan prosentase 0,51%, masih memenuhi standar nasional. Dari data yang diperoleh terdapat peningkatan kasus, 15 pasien yang mengalami phlebitis, 2 diantaranya merupakan pasien berusia >60 tahun, 5 pasien pada usia 50-60 tahun, 4 pasien balita dan sisanya pasien dewasa, dimana 73% masuk pada faktor usia beresiko phlebitis. 3 diantara ketiga15 pasien tersebut mengalami phlebitis karena mendapatkan cairan pekat seperti drip KCL, terapi transfusi PRC dan ada 1 pasien yang dobel antibiotik. Pasien lainnya tidak mendapatkan cairan pekat hanya mendapat 1 antibiotik dan injeksi pekat seperti metamizole. Dari 20 pasien yang ditanyai, tidak ditemukan pasien yang rawat inap mengalami infus slong (cairan infus pada indikator selang infus habis). Namun perawatan pada area luka tusuk infus yang dirasa masih kurang karena banyak ditemukan yang posisi luka infusnya tertutup plester sehingga kesulitan untuk memonitoring phlebitis atau tidak.
---------	---

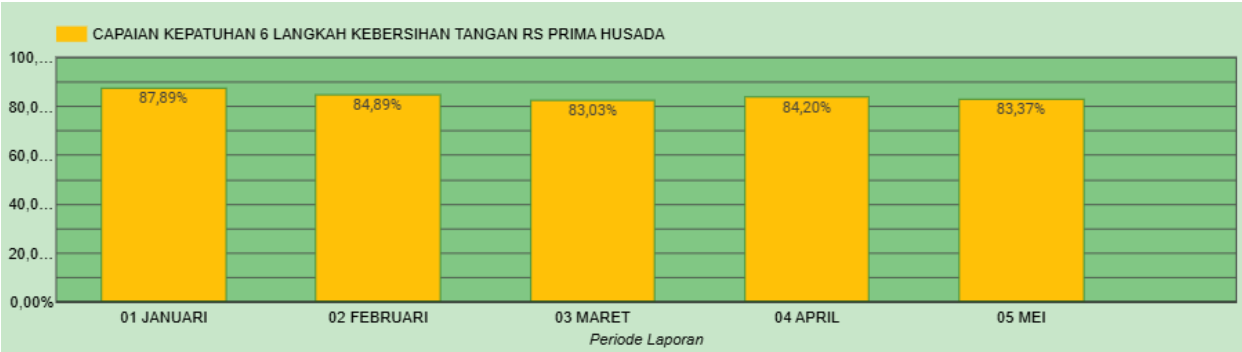
Masalah saat ini	1. Penggunaan cairan pekat masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, termasuk juga pemberian produk darah dan antibiotik dobel. 2. Faktor internal pasien seperti usia pasien yang beresiko phlebitis juga berpengaruh, perlunya edukasi lanjut terkait ini.				
Permasalahan sebelumnya	Penggunaan cairan pekat masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, seperti KCL meskipun sudah diberikan dengan pengencer cairan infus				
Tindakan yang dilakukan	1. Mengajarkan pada perawat pemasangan infus benar-benar harus menentukan posisi vena yang tepat dan memberikan edukasi setelah melakukan pemasangan infus terutama pada pasien beresiko tinggi. 2. Mengajarkan perawat untuk melakukan monitoring luka tusukan infus terutama pada pasien yang terpasang cairan pekat setiap hari setelah melakukan injeksi. 3. Menyarankan petugas untuk memberikan kompres hangat pada pasien yang mendapatkan cairan pekat pada area tangan yang terpasang infus untuk merilekskan pembuluh darah dan cairan pekat/darah tidak gampang menggumpal. 4. Mengajarkan perawat untuk memilih iv canula yang sesuai dengan kebutuhan pasien (lihat besarnya pembuluh darah & rencana pengobatan yang akan diberikan, usahakan menggunakan iv canula ukuran besar). 5. Mengkoordinasikan dengan kabid dan komite keperawatan terkait banyaknya kasus phlebitis untuk saran dilakukan pelatihan pemasangan dan perawatan luka infus.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Perbaikan kepatuhan bundle phlebitis.	Memperbaiki kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	Pasien yang terpasang infus	1. Monitoring penyuntikan yang aman benar dilakukan. 2. Monitoring penggunaan cairan pekat maupun double antibiotic diberikan secara aman. 3. Monitoring kondisi luka tusukan infus setiap selesai melakukan injeksi. 4. Memberikan injeksi obat secara perlahan untuk mengurangi nyeri dan memperkecil resiko phlebitis. 5. Mengedukasi perawat unit untuk mengeset tetesan infus secara benar supaya hitungan jam habis infus dapat diperkirakan dan tidak sampai kehabisan. 6. Monitoring kepatuhan pemakaian APD terutama sarung tangan saat pemasangan infus dan kebersihan tangan sebelum memakai sarung tangan. 7. Monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan infus. 8. Tertibkan pencatatan petugas yang melakukan pemasangan infus pada plester infus pasien beserta tanggal pemasangan untuk mengontrol mutu skill dari perawat.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/PCN	Satu bulan

3.6.1.1.7 Kebersihan Tangan

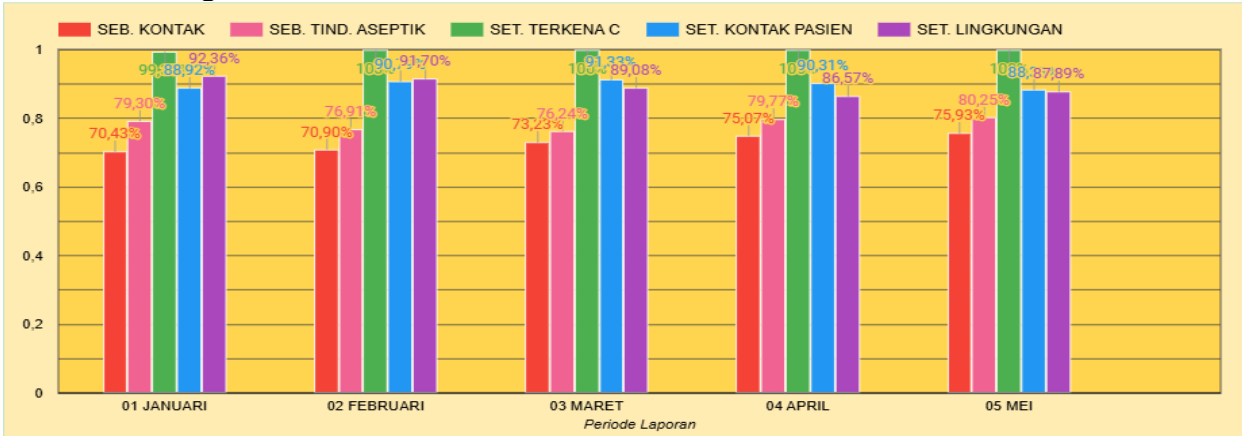
3.6.1.1.7.1 Grafik Angka Kepatuhan kebersihan Tangan (*Hand Hygiene*)



1.6.1.1.7.2 Grafik Kepatuhan 6 Langkah Kebersihan (Hand Hygiene)



1.6.1.1.7.3 Grafik Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan 5 Momen Cuci Tangan

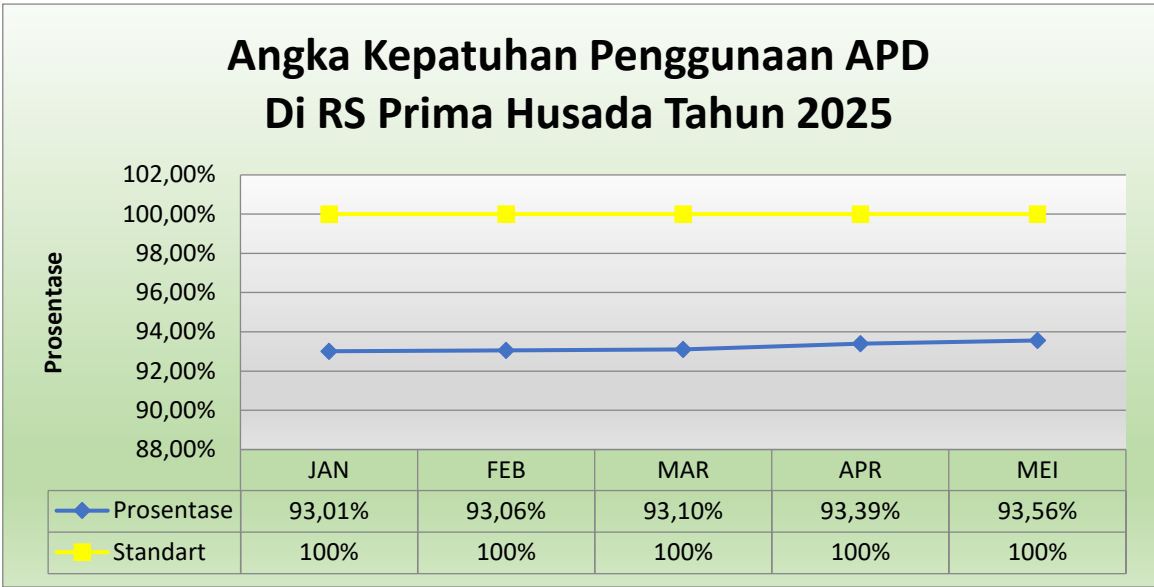


Analisa	Prosentase kepatuhan kebersihan tangan keseluruhan sudah mencapai standart minimal pada bulan ini yaitu sebesar 85,49%. Masih belum bisa mencapai target 100% karena memang masih ditemukan petugas yang tidak melakukan cuci tangan terutama pada momen sebelum kontak pasien (75,93%) dan sebelum melakukan tindakan aseptik (80,25%). Terdapat sedikit peningkatan prosentase pada bulan ini, dikarenakan pada bulan ini dilakukan survey perbaikan standar akreditasi dan kebanyakan dari petugas mempersiapkan diri dengan mulai membiasakan agar pada saat harinya tidak lupa atau bingung saat diharuskan praktek 6 langkah
---------	---

	cuci tangan. Namun masih banyak juga petugas yang beranggapan jika tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Dilihat dari segi kepatuhan 6 langkah cuci tangan, 83,37% dari petugas dapat melakukan 6 langkah cuci tangan dengan baik. Namun memang karena belum menjadi kebiasaan dari petugas sehingga masih ada yang tidak urut melaksanakan 6 langkah cuci tangannya terlebih pada akhir bulan setelah proses survey akreditasi selesai, petugas mulai malas kembali menjalankan dengan baik.				
Masalah saat ini	Petugas paham terkait 5 momen 6 langkah cuci tangan tetapi tidak dijalankan sepenuhnya saat pelayanan ke pasien (belum terbiasa), hanya pada saat ada event saja terjadi peningkatan, belum menjadikan suatu kebiasaan petugas.				
Permasalahan sebelumnya	Petugas paham terkait 5 momen 6 langkah cuci tangan tetapi tidak dijalankan sepenuhnya saat pelayanan ke pasien (belum terbiasa).				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Mengajarkan cuci tangan yang benar saat melakukan audit di ruangan. 3. Memberikan proses pembelajaran dengan membuat video pendek edukasi cuci tangan supaya lebih mudah untuk mengingat. 4. Melakukan kontrol monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kebersihan tangan.	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. 2. Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. 3. Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. 4. Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. 5. Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik. 6. Lakukan sosialisasi ke petugas langsung pada saat melakukan supervisi untuk mengingatkan kebiasaan petugas dalam kebersihan tangan.	1. Perawat /Bidan 2. Dokter 3. Karu 4. IPCLN/IPCN	Satu bulan

3.6.1.1.8 Kepatuhan APD

3.6.1.1.8 .1 Grafik Angka Kepatuhan Penggunaan APD oleh Petugas

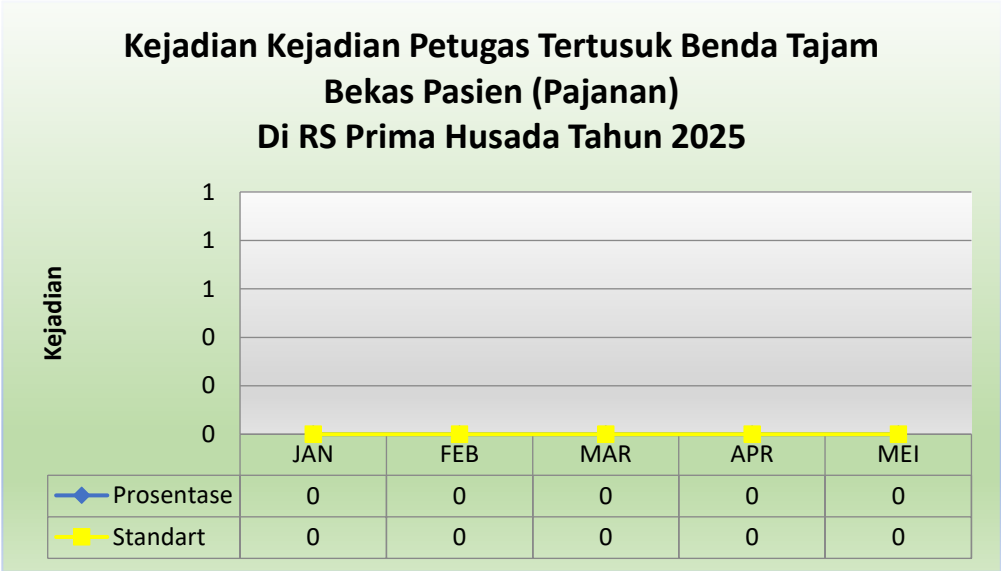


Analisa	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart, pada bulan ini yaitu sebesar 93,56%. Dari hasil monitoring dan supervise, terjadi sedikit peningkatan kepatuhan pemakaian APD, kepatuhan petugas nakes dalam pemakaian APD sudah baik, namun masih tetap tidak pada dokter DPJP yang sering berlebihan memakai APD, seperti visite saja namun memakai APD lengkap mulai skort masker, nurse cap, dan sarung tangan. Selain itu, Penggunaan APD pada petugas penjamah makanan juga mengalami peningkatan semenjak dilakukannya resosialisasi terkait hygiene penjamah makanan. Namun pada petugas laundry masih sering ditemukan petugas tidak memakai celemek saat mencuci linen kotor dan petugas CSSD tidak memakai sepatu boot saat mencuci alat kotor. Dan karena adanya event survey akreditasi menyebabkan peningkatan pada kebiasaan petugas dalam memakai APD meskipun tidak banyak.				
Masalah saat ini	Kesadaran petugas sedikit meningkat terkait pemakaian APD dikarenakan adanya event tertentu saja, belum tertanam dan belum menjadikan kebiasaan sehari-hari jika tidak ada event.				
Permasalahan sebelumnya	Kurangnya kesadaran petugas terhadap penggunaan APD yang sesuai untuk menghindari penyebaran infeksi dengan mementingkan keuntungan pemakaian APD pribadi dan tidak melihat kerugiannya pada orang lain.				
Tindakan yang dilakukan	1. Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. 2. Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 3. Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. 4. Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD, konfirmasi Karu dan SDM). 5. Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting. 6. Melarang perawat untuk memberikan handscoon jika ada CS yang meminta untuk membersihkan ruangan.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Tingkatkan sosialisasi pada petugas langsung saat melakukan supervisi unit. 2. Koordinasi dengan IPCD untuk membantu meningkatkan pemahaman terkait APD pada para DPJP. 3. Berkolaborasi dengan SDM terkait ketidak disiplin petugas dalam pemakaian APD. 4. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan. 5. Lakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. 6. Berikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD.	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan

Meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah unit.	Meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah unit.	Seluruh petugas pelayanan pasien	1. Peletakkan tempat sampah baik infeksius dan non infeksius harus ditata dengan benar. 2. Lakukan edukasi ulang pada staf tentang pemilahan sampah. 3. Berikan proses pembelajaran pada petugas unit saat itu yang salah melakukan pembuangan sampah dan segera menganjurkan untuk membenarkan bila memungkinkan. 4. Sampaikan kesalahan pembuangan unit pada kepala unit dan IPCLN unit dalam forum rapat PPI maupun grup WA (untuk menciptakan efek jera).	Seluruh petugas pelayanan di RS.	Satu bulan
---	---	----------------------------------	--	----------------------------------	------------

3.6.1.1.10 Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam

3.6.1.1.10.1 Grafik Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam Bekas Pasien (Pajanan)



benda tajam yang baik.			3. Biasakan petugas untuk membersihkan peralatan yang digunakan langsung tanpa mengoperkan pada shift berikutnya. 4. Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan untuk mencegah paparan. 5. Monitoring teknik recapping tutup jarum.		
------------------------	--	--	--	--	--

3.6.3 Tim PKRS

3.6.3.1 Edukasi Kelompok Unit

UNIT	TARGET	MAR	APR	MEI	%	MANDOK	KETERANGAN
IRNA 2C	4x/Bulan	100%	50%	100%	Tercapai	Lampiran B	IRNA meningkat terlihat bulan April ke Mei
ICU\HCU	4x/Bulan	0%	50%	0%	Tidak Tercapai	Lampiran B	ICU/HCU tidak tercapau dan tidak konsisten terlihat dari bulan Maret
IRNA 3C	4x/Bulan	50%	100%	0%	Tidak Tercapai	Lampiran B	IRNA 3c mengalami penurunan terlihat bulan April
MATERNITAS	4x/Bulan	75%	0%	100%	Tercapai	Lampiran B	MATERNITAS Tercapai dan mengalami kenaikan terlihat dari bulan Maret hingga Mei
PERINATOLOGI	4x/Bulan	75%	100%	100%	Tercapai	Lampiran B	PERINATOLOGI tercapai pertahankan
IRNA 5C	4x/Bulan	50%	100%	0%	Tidak Tercapai	Lampiran B	IRNA 5C tidak tercapai dan mengalami penurunan
IRNA 2A,3A,4A	4x/Bulan	25%	0%	50%	Meningkat	Lampiran B	IRNA 2A,3A,4A ada peningkatan kecil terlihat dari bulan Maret
IRNA 6A,7A,8A	4x/Bulan	75%	0%	50%	Meningkat	Lampiran B	IRNA 6A,7A,8A mengalami penurunan dari bulan Feb,Mar, hingga Apr
IGD	4x/Bulan	100%	0%	0%	Tidak Tercapai	Lampiran B	IGD Tidak mengalami peningkatan terlihat di bulan April hingga sekarang
FARMASI	4x/Bulan	25%	0%	75%	Meningkat	Lampiran B	FARMASI ada peningkatan
GIZI	4x/Bulan	100%	100%	50%	Menurun	Lampiran B	Gizi tidak tercapai dan mengalami penurunan
IRJA	4x/Bulan	50%	100%	50%	Menurun	Lampiran B	IRJA tidak tercapai dan mengalami penurunan

- ANALISIS**
 : Berdasarkan data edukasi kelompok unit pada bulan Mei Petugas PKRS tiap unit tidak terlaksana dengan baik, dari data tersebut Unit ICU, IRNA 3C, 5C, IRNA 2A,3A,4A, IRNA 6A,7A,8A FARMASI, IGD, IRJA belum melaksanakan Edukasi Kelompok dengan maksimal, dan beberapa UNIT mengalami penurunan
- RTL**
 : Menyampaikan kepada KARU unit yang belum tercapai kinerjanya untuk mengejar keteringgalan edukasi, edukasi dilakukan di bulan Maret.

3.6.3.2 Pembinaan Komunitas Berbasis RS Prima Husada

UNIT	TARGET	KEGIATAN	MAR	APR	MEI	%	MANDOK	KET
Komunitas Geriatri	2X/Bulan	Senam	100%	50%	100%	Tercapai	Ada	
		Hypnoterapi						
		KIE						
Komunitas Ibu Hamil	2X/Bulan	Senam	50%	50%	100%	Tercapai	Ada	
		Hypnoterapi						
		KIE						
Komunitas Shirothul Jannah Perempuan	2X/Bulan	Pengajian	100%	50%	100%	Tercapai	Ada	
		Karya wisata						
Komunitas Shirothul Jannah Laki Laki	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
Bimbingan Doa	8X/Bulan	Mendoakan Pasien	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
General Meeting Karyawan	1x/2Bulan		100%	0%	100%	Tercapai	Terlaksana	
Pembinaan Fatayat	1X/Tahun							

3.6.3.3 KIE Upaya Preventif Promotif PROGNAS

UNIT	TARGET	MAR	APR	MEI	%	BUKTI DI FORM EDUKASI TERINTEGRASI ATAU KOLABORASI	KET
PONEK	4X/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	Belum terlaksana
HIV	4X/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	Belum terlaksana
STUNTING dan WASTING	4X/Bulan	0%	25%	50%	Tidak Tercapai	√	Edukasi terkait materi Stunting terlaksana
KELURAGA BERENCANA RUMAH SAKIT (KABERUSA)	4X/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	Belum terlaksana
TB DOTS	4X/Bulan	25%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	Belum terlaksana

ANALISIS : Bulan Mei PROGNAS belum tercapai.
RTL : Koordinasi dengan Kepala Bidang Umum dan Pelayanan untuk dapat Meningkatkan produktivitas Tim Prognas.

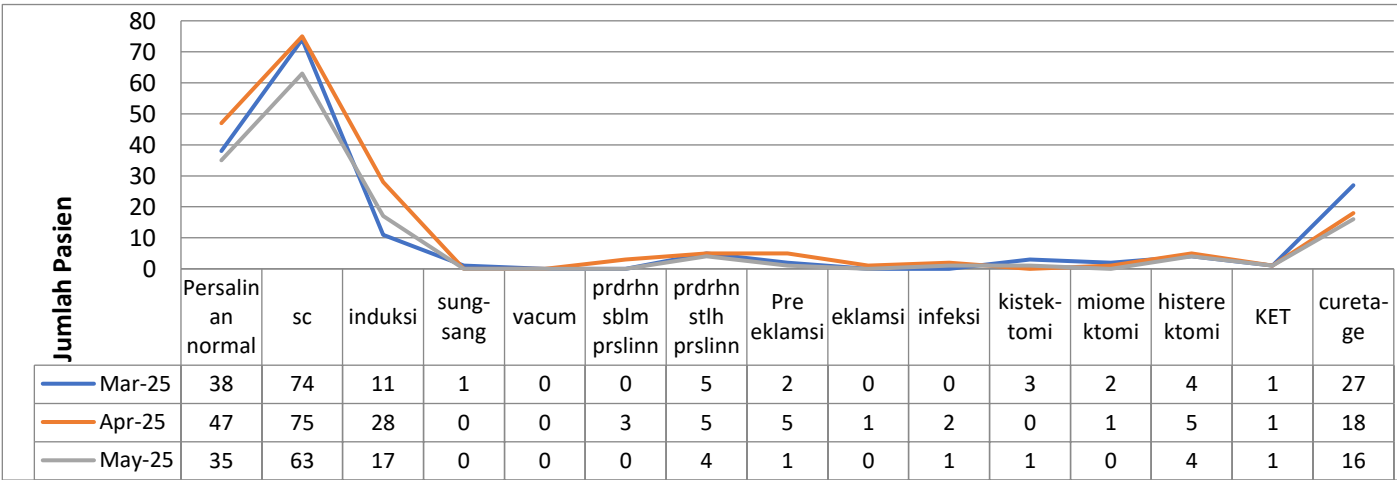
3.6.4 Tim Prognas

3.6.4.1 PONEK

3.6.4.1.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Ponek Mei 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		FEBRUARI 2025	MARET 2025	APRIL 2025
1	Persalinan			
	a. Persalinan Normal	38	47	35
	b. SectioCaesaria	74	75	63
2				
	a. Induksi / Drip	11	28	17
	b. Sungsang	1	0	0
	c. Vacum	0	0	0
3				
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	0	3	0
	b. Perdarahan setelah Persalinan	5	4	4
	c. Pre Eklamsi	2	5	1
	d. Eklamsi	0	1	0
	e. Infeksi	0	2	1
4				
	a. Curretage	27	18	16
	b. Kistektomi	3	0	1
	c. Miomektomi	2	1	0
	d. Histerectomy	4	5	4
	e. KET	1	1	1

3.6.4.1.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Bulan Mei 2025



Analisis :

1. Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada bulan Mei 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 63 pasien. Dan untuk persalinan normal pada bulan Mei 2025 juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 35 persalinan. Untuk persalinan normal, jika memang tidak ada penyulit maka persalinan bisa ditolong

- bidan terlebih dahulu. Jumlah persalinan secara SC dan Persalinan normal pada bulan Mei menurun, hal ini dikarenakan jumlah pasien di maternitas yang menurun pada bulan Mei 2025.
2. Kebanyakan pasien yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas sc, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya, atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal distress. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi sc cito.
 3. Tidak ada persalinan dengan sungsang pada bulan Mei dan April 2025, sedangkan pada bulan Maret sebanyak 1 pasien. Dan tidak ada persalinan dengan vacum pada bulan Mei 2025 dan 2 bulan sebelumnya.
 4. Induksi Persalinan pada bulan Mei mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 17 pasien
 5. Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan Mei 2025 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 1 pasien. Dan ada tidak ada kejadian eklamsi pada bulan Mei 2025 dan 2 bulan sebelumnya
 6. Jenis pelayanan curretage di bulan Mei 2025 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 16 pasien. *Curetage* dilakukan untuk Indikasi abortus, mola, blighted ovum, sisa plasenta dan pada kasus-kasus gynekology biasanya dengan indikasi menometroragi, hiperplasia endometrium, dan lainnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.
2. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
3. Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.
4. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.

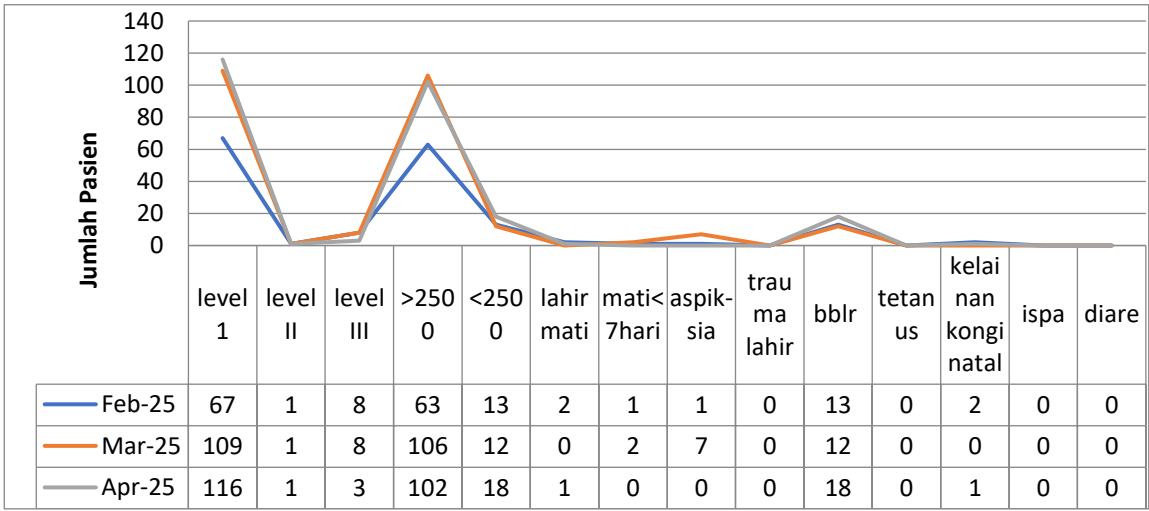
3.6.4.1.3 Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

3.6.4.1.3.1 Tabel Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Ponek April 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		Bulan Maret 2025	Bulan April 2025	Bulan Mei 2025
1				
	a. Level 1	109	116	87
	b. Level II	1	1	3
	c. Level III	8	3	6
2				
	a. ≥ 2500 gram	106	102	87
	b. ≤ 2500 gram	12	18	9
3				
	a. Kelahiran Mati	0	1	4
	b. Mati Neonatal < 7 Hari	2	0	2
4				
	a. Asphyxia	7	0	0
	b. Trauma Kelahiran	0	0	0
	c. BBLR	12	18	9

	d. Tetanus Neonatorum	0	0	0
	e. Kelainan Congenital	0	1	1
	f. ISPA	0	0	0
	g. DIARE	0	0	0
5	Lain-lain	0	0	0

3.6.4.1.3.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Di RS Prima Husada Mei 2025



Analisis :

1. Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1 di bulan Mei 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 87 bayi. Dan pada level 2 sedikit meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yaitu 3 bayi. Dan pada level 3 juga meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 6 bayi. Jumlah bayi bulan Mei 2025 menurun seiring dengan jumlah persalinan yang menurun pada bulan Mei 2025
2. Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah >2500 gram di bulan Mei 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 87 bayi.
3. Dan jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan Mei 2025 juga menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 9 bayi. Masih adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.
4. Kasus BBLR pada bulan Mei 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 9 bayi.
5. Ada 4 kasus kelahiran mati pada bulan Mei 2025, sedangkan pada bulan April 1 kasus, dan tidak ada kelahiran mati pada bulan Maret
6. Ada 2 kasus kematian neonatus <7 hari pada bulan Mei dan Maret 2025, sedangkan pada bulan April tidak ada kasus. Kasus kematian neonatus < 7 hari pada bulan Mei 2025 atas indikasi bayi BBLR dengan Anemia, dan yang satunya BBLR dg Multiple congenital Anomali

Rencana dan Tindak Lanjut

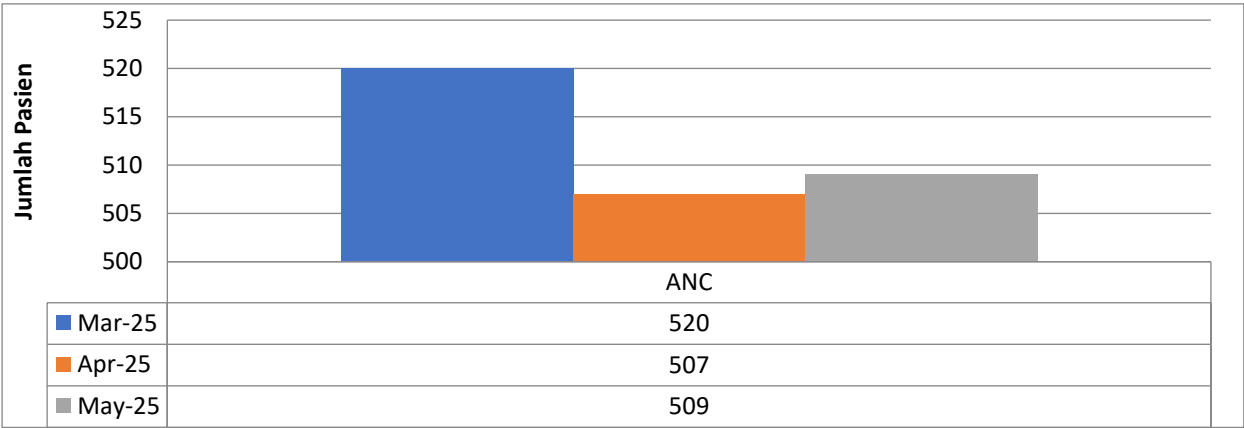
1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.

3. Melakukan edukasi pada ibu hamil agar melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau kehamilan

3.6.2.1.2.3 Pelayanan Ante Natal Care (ANC)
Tabel Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Ponpek Mei 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		Bulan Maret 2025	Bulan April 2025	Bulan Mei 2025
1	ANC	520	507	509

Grafik Jumlah Pelayanan Ante Natal Care Di RS Prima Husada Mei 2025



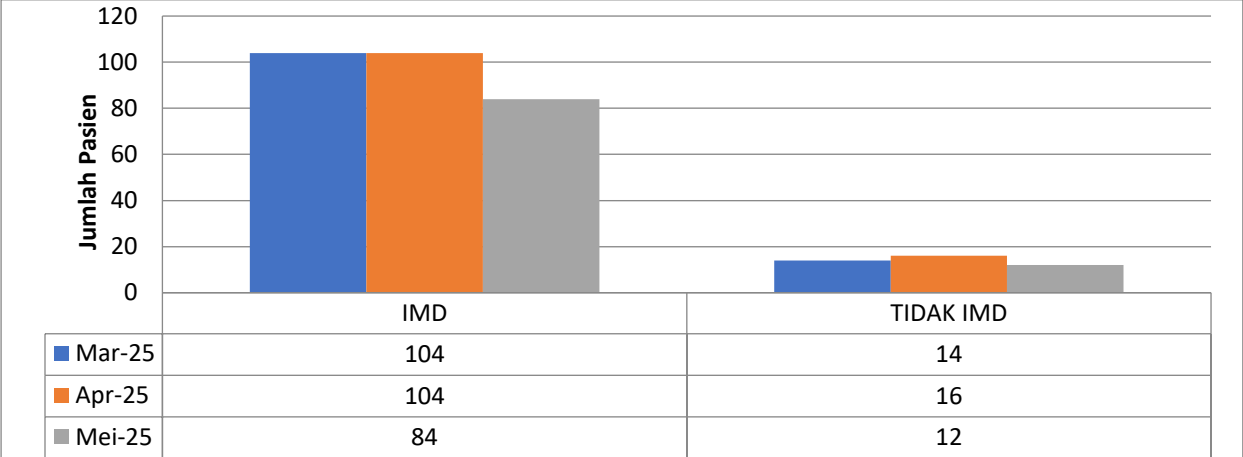
Analisis :
Pelayanan ANC pada bulan Mei 2025 mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 509 kunjungan.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan promosi terkait pemeriksaan ANC seperti USG 4 dimensi serta kegiatan senam hamil yang diharapkan menarik minat para ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya di RS.

3.6.1.2.4 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Tabel Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) April 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MARET 2025	BULAN APRIL 2025	BULAN MEI 2025
1	IMD	104	104	84
2	Tidak IMD	14	16	12

Grafik Jumlah Pelayanan IMD di RS Prima Husada Bulan Mei 2025



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Mei 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 84 bayi. Dan tidak semua bayi baru lahir dilakukan IMD, dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD.
- 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Mei menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 12 bayi, Sedangkan pada bulan April sebanyak 16 bayi, dan Maret 14 bayi.
- 3. Berikut ini bayi yang tidak dilakukan IMD pada bulan Mei 2025 :

NO	NAMA BAYI	DIAGNOSA	PERAWATAN BBL
1	Ny Khusnul Amalia	NKB +BBLR	memakai CPEP dan perawatan inkubator
2	Ny Dewi Y	NKB + BBLR+ Multiple congenital anomali	Memakai Oksigen
3	Ny Umamur 2	BBLR +RDS+Anemia	memakai CPEP dan perawatan inkubator
4	Ny Yulia	BBLR	Berat badan bayi <2500 gr
5	Ny Kartina	NCB+BBLR+Pneumonia	Perawatan inkubator
6	Ny Junaidatur	NKB+BBLSR	memakai CPEP dan perawatan inkubator
7	Ny Nur Laili	NCB+BBLR	memakai CPEP dan perawatan inkubator
8	Ny Arisa	BBLR + Hipoglikemia	memakai CPEP dan perawatan inkubator
9	Ny Wulandari	NCB +BBLR	memakai CPEP dan perawatan inkubator
10	ny Anis	NCB	Memakai CPEP
11	Ny Eka	NCB	Observasi
12	Ny Faradila	NCB+ ibu Hepatitis B	Ibu Hepatitis B

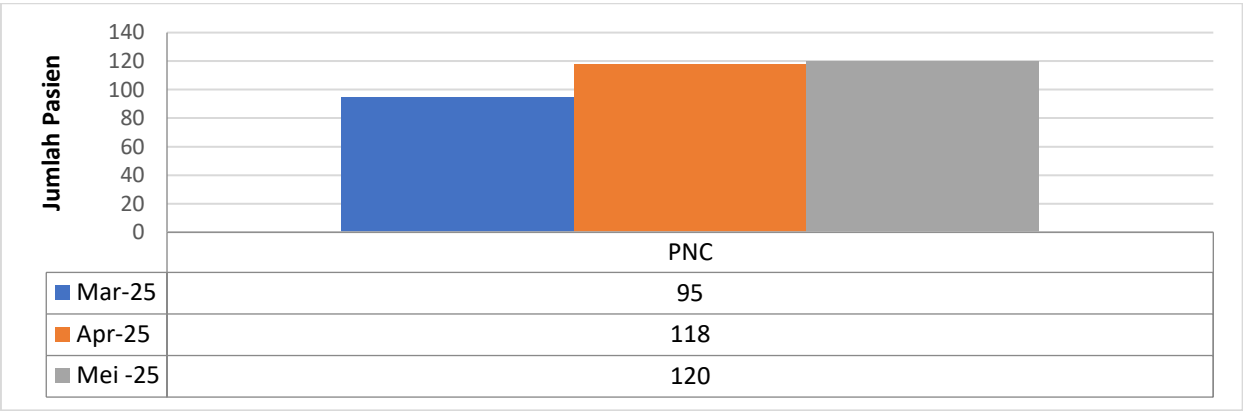
- 4. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat ataukah tidak.

3.6.1.2.5 Pelayanan Post Natal Care (PNC)
Tabel Pelayanan Post Natal (PNC) Ponek Mei 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN MARET 2025	BULAN APRIL 2025	BULAN MEI 2025
1	PNC	95	118	120

Grafik Jumlah Pelayanan Post Natal Care di RS Prima Husada Bulan Mei 2025



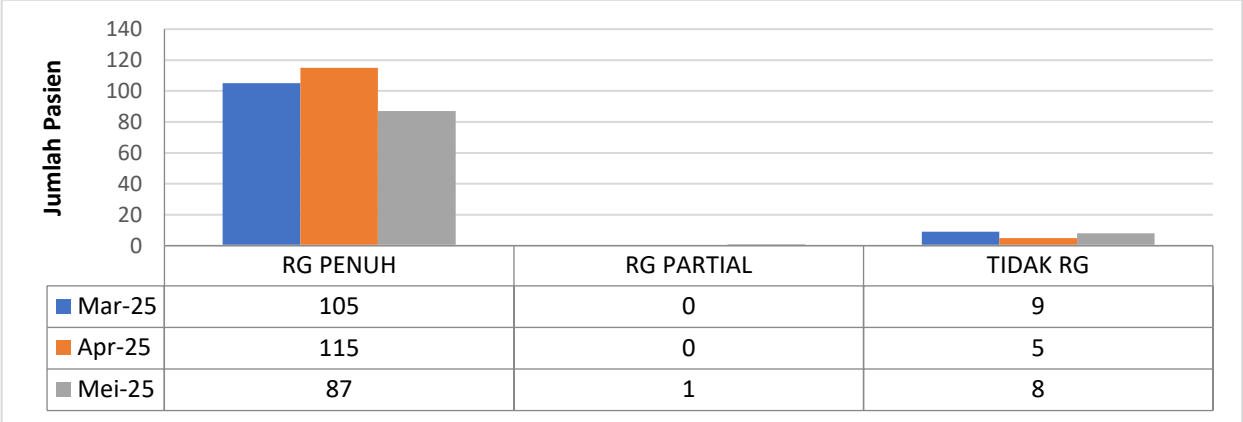
Analisis :
Pelayanan PNC pada bulan Mei 2025 mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 120 kunjungan.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Melakukan Edukasi ke pasien pasca bersalin untuk melakukan pemeriksaan PNC di RS Prima Husada

3.1.2.2.1.5 Pelayanan Rawat Gabung
Tabel Pelayanan Rawat Gabung Ponek Mei 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MARET 2025	BULAN APRIL 2025	BULAN MEI 2025
1	Rawat gabung penuh	105	115	87
2	Rawat gabung partial	0	0	1
3	Tidak Rawat gabung	9	5	8

Grafik Pelayanan Rawat Gabung Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Mei 2025



Analisis :

- 1. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan Mei 2025 menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 87 bayi. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat
- 2. Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan Mei 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 8 bayi.
- 3. Berikut bayi yang tidak dilakukan rawat gabung

NO	NAMA	DIAGNOSA	PERAWATAN BBL
1	Ny Khusnul Amalia	NKB +BBLR	memakai CPEP dan perawatan inkubator
2	Ny Dewi Y	KB + BBLR+ Multiple congenital anomali	Memakai Oksigen
3	Ny Umamur 2	BBLR +RDS+Anemia	memakai CPEP dan perawatan inkubator
4	Ny Kartina	NCB+BBLR+Pneumonia	Perawatan inkubator
5	Ny Junaidatur	NKB+BBLSR	memakai CPEP dan perawatan inkubator
6	ny Anis	NCB	Memakai CPEP
7	Ny Eka	NCB	Observasi
8	Ny Narti	NKB + RDS	memakai CPEP dan perawatan inkubator

- 4. Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di cuvis atau incubator karena berat bayi < 2500 gram atau masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan alat bantu pernafasan dan observasi.

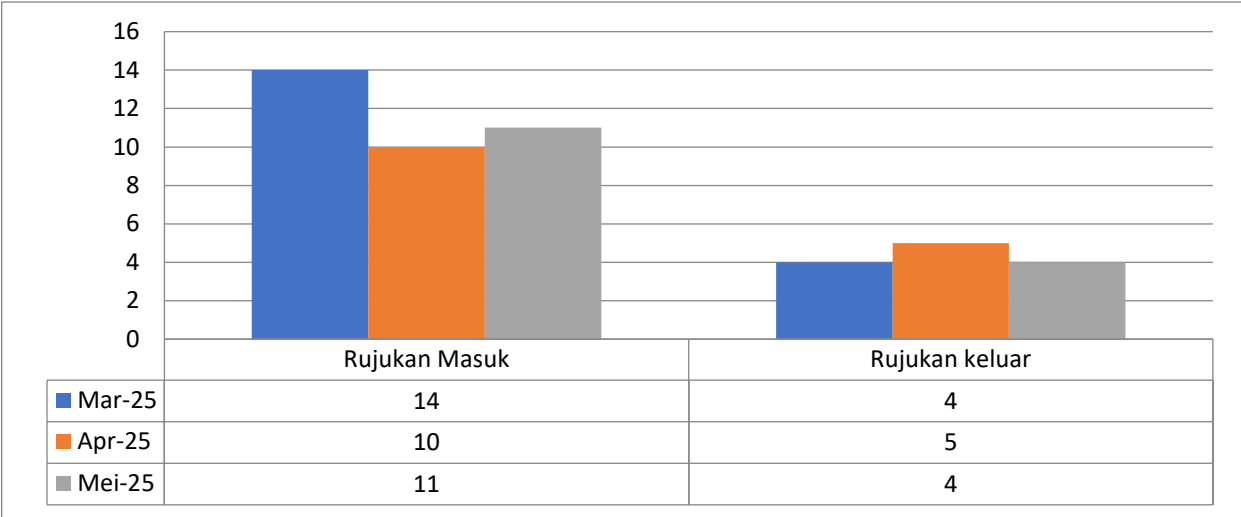
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan skrining awal untuk pasien yang layak dilakukan rawat gabung ibu dan bayi.

3.1.2.2.1.6 Pelayanan Jejaring Rujukan
Tabel Pelayanan Jejaring Rujukan Ponек Mei 2025

NO	RUJUKAN	BULAN MARET 2025	BULAN APRIL 2025	BULAN MEI 2025
1	Rujukan Masuk	14	10	11
2	Rujukan keluar	4	5	4

Grafik Pelayanan Rujukan RS Prima Husada Bulan Mei 2025

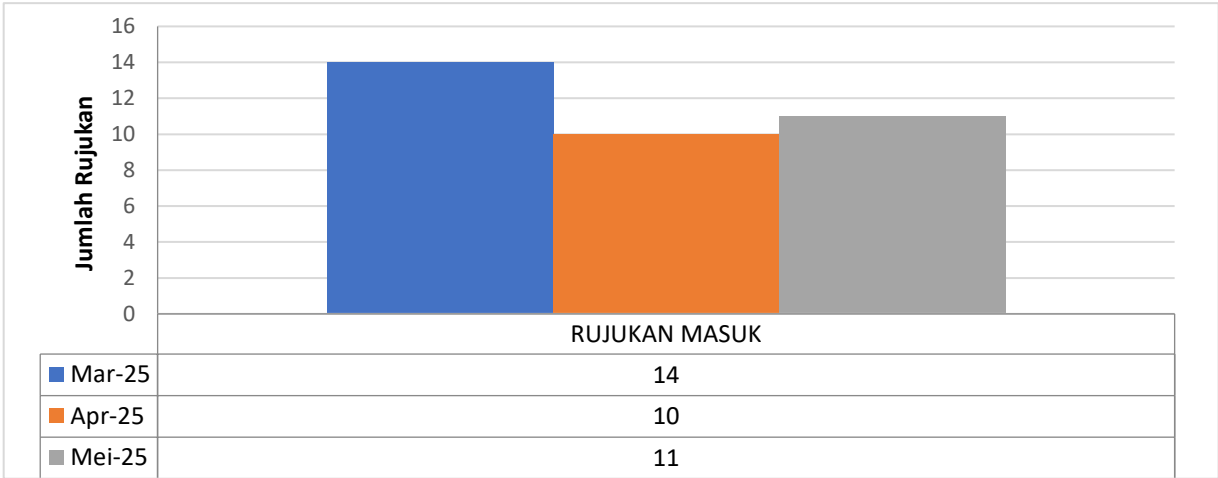


3.1.2.2.1.6.1 Rujukan Masuk
Tabel Rujukan Masuk Ponpek Mei 2025

BULAN MARET 2025			
1	Dwi Marfinta	G2 P1001 Ab000 UK 6-8 dg abortus inkomplit + Syok Hipovolemik	PMB Tri Widiyawati
2	Dwi yuwandita	G1 P0000 Ab000 UK 2-4 Mgg dg KET	KRI Idaman Hati
3	Reski nelawati	G2 P0101 Ab000 UK 28-30 mgg dg PPI	PMB Tri Widiyawati
4	Ainum Jariyah	G3 P2002 Ab000 UK 8-10 mgg dg abortus Inkomplit dan Anemia	PKM Ardimulyo
5	Dewi Ratih	G3 P2002 Ab000 UK 36-37 mgg dg KPD + KIFL	PMB Nuri Afanti
6	Iput M	Anemia Grafis + Kista Endometriosis	Klinik Tirto Husada
7	Rulia	G2 P1001 Ab000 UK 38-39 mgg dg KIFL + Autoimum + HT	PKM Singosari
8	Isnaini	G1 P0000 Ab000 UK 40 mgg dg KIFL + KPD	PMB Titik
9	Edis	G1 P0000 Ab000 UK 39 – 40 mgg dg prolong kala 1 fase aktif	PKM Ardimulyo
10	Yaning	G3 P2002 Ab000 UK 38 - 39 mgg dg letak lintang + HT gestasional	PMB titik
11	Puji Anik	P1001 Ab000 dg post partum normal dan rupture perineum D3	PMB Heni Budiasih
12	Uswatun hasanah	G1 P0000 Ab000 UK 32-34 mgg dg Gemeli, letsu, anemia grafis	RS Sahabat
13	Rosalina	G3 P1001 AB100 UK 39-40 mgg dg KIFA	PMB Titik Sunaryati
14	By Ny Madiyah	Asfiksia berat + BBLR + NKB	RSUD Lawang
BULAN APRIL 2025			
1	Lady Ayu	G1 P0000 Ab000 UK 40-41 MGG DG HT + FH	Klinik Mutiara Sehat
2	Ninis J	G2P1001AB000 UK 37-38 MG KPD + Prolong K1FA	PMB Tri Widiyawati
3	Novita A	G2 P1001 AB000 UK 37-38 MGG dgn KIFA	PMB Munawaroh
4	Elis S	G3P2AB0 UK 34-36 MGG dg PPI	PMB Tri Widiyawati

5	Nadia Marinka	G2P1001AB000 UK 10-12 MG dg susp.KET	RSUD lawang
6	Dela	G 2 P1001 AB0 UK 42-43 MGG dgn KIFL + Post date	RSUD lawang
7	Hima Aliyah	G1P000 ABOO UK 40- 41 mgg dg prolong KIFL	PMB Titik Sunaryati
8	Lusi A	G1 P0 AB 0 UK 41-42 MGG dgn KIFA + OF hari ke 3	PKM Ardimulyo
9	By Ny Ayu Agustin	Convulsion of Newborn	RSAU Munir
10	Lubna	Sust TTNB	BPM Tri Widiyawati
BULAN MEI 2025			
1	Triya Nanda	G2 P1001 Ab000 uk 37-38 mgg dg KIFA + IUD Insitu	Klinik Mutiara Sehat
2	Pinarti	P2002 Ab000 dg Post Partum + HPP ec Sisa plasenta	RSUD Lawang
3	Fernanda Alya	G1 P0000 Ab000 uk 30-32 mgg dg PPI	BPM Siti Nurcahyaningstih
4	Carrolyn	G1 P0000 Ab000 uk 39-40 mgg dg KPD + KIFL	BPM Titik
5	Ni'matul	G1 P0000 Ab000 Uk 39-40 mgg dg kala 2 lama	PKM Singosari
6	Sumiasih	G4 P3003 Ab000 uk 39-40 mgg dg KPD + letak Obliq	PKM Singosari
7	Novi Prajna	G2 P1001 Ab000 uk 8-10 mgg dg vomiting +OF	Klinik Mutiara Sehat
8	Wiwin Defa	G1 P0000 Ab000 UK 38-39 mgg dg KIFA + KPD	PKM Ardimulyo
9	Syafira	G1P0000 AB000 Uk 39-40 mgg dg KPD + KIFL	BPM Siti R
10	Sayidah	G2 P0000 Ab100 Uk 37-38 mgg dg KPD	PKM Singosari
11	Siska	G2 P1001 Ab000 uk 28-30 mgg dg PPI	BPM Tri

Grafik Pelayanan Rujukan Masuk RS Prima Husada Bulan Mei 2025



Analisis :
 Jumlah rujukan masuk pada bulan Mei 2025 sedikit meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 11 rujukan, sedangkan pada bulan April sebanyak 10 rujukan, dan Maret sebanyak 14 rujukan masuk

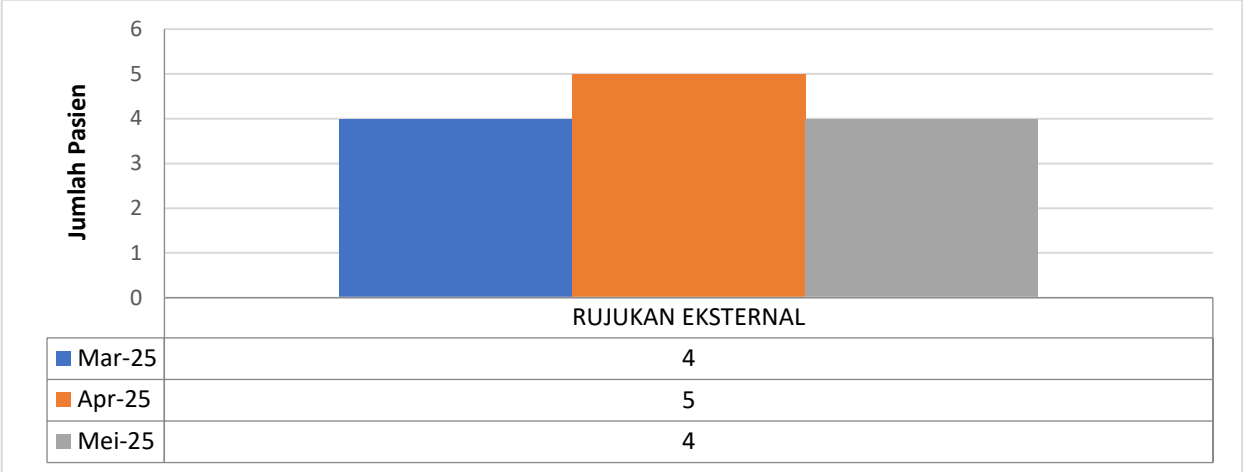
Rencana dan Tindak Lanjut

Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM atau RS setempat untuk bekerja sama.

3.1.2.2.7.2 Rujukan Keluar
Tabel Rujukan Keluar Ponpek Mei 2025

BULAN MARET 2025						
1	By Ny Sherlina Ika Rahayu	1 hari	NICU	NKB + RDS + Susp NEC, Pneumonia	Pro ventilator	RS Saiful Anwar
2	By Ny Shofiyah Mayu Arnofia	1 hari	NICU	NKB + BBLSR + RDS	Pro ventilator	RS Saiful Anwar
3	By ny Ifadatul Laili	2 hari	NICU	RDS ok Neonatal	Pro ventilator	RS Lavalette
4	Ny Des Maulidya	32 th	Maternitas	G1 P0000 Ab000 UK 28-30 mgg dg PEB + ALO	Perawatan Intensif	RS Saiful Anwar
BULAN APRIL 2025						
1	By ny siti ulifah	0 hari	NICU	Atresia Ani tanpa fistel undesensus testis	Pro tindakan bedah	RS Saiful Anwar
2	By. Ny. Rusda Fauziah	2 hari	NICU	RDS, Prematur, NEC	pro ventilator	RS Lavalette
3	Ny. Dian Nihayattul Islam	25 th	Maternitas	Post SC h-9, asites, dipsneu, anemia, anuria	Pro Penanganan Lanjut	RS Saiful Anwar
4	Ny. Nadia Marinka Oktaviani	31 th	Maternitas	Abdominal Pregnancy	Penanganan Lebih Lanjut	RS Saiful Anwar
5	Ny.Nanik	33 Th	IGD	G2 P1001 Ab000 Uk 26-28 mgg dg Eklamsia + BSC	Penanganan Lebih Lanjut	RS Saiful Anwar
BULAN MEI 2025						
1	By Ny Eka	1 hari	NICU	Neonatal bronchopneumonia, grandula thymus prominen, NEC	Pro ventilator	RS Lavalette
2	By Ny Arisa	3 hari	NICU	BBLR + hipoglikemia refrakter	Pro konsultan perinatologi dg konsultan endokrinologi	RS Lavalette
3	By Ny Kartina	2 hari	NICU	Neonatal pneumonia + BBLR	Pro ventilator	RS Soepraoen
4	By Ny Khusnul	3 hari	NICU	Neonatal pneumonia + BBLR	Pro ventilator	RS Lavalette

Grafik Pelayanan Rujukan Eksternal di RS Prima Husada Bulan Mei 2025



Analisis :

Pada bulan Mei 2025 jumlah rujukan eksternal sedikit menurun yaitu 5 pasien dirujuk, sedangkan pada bulan April 5 pasien dan Maret 4 pasien

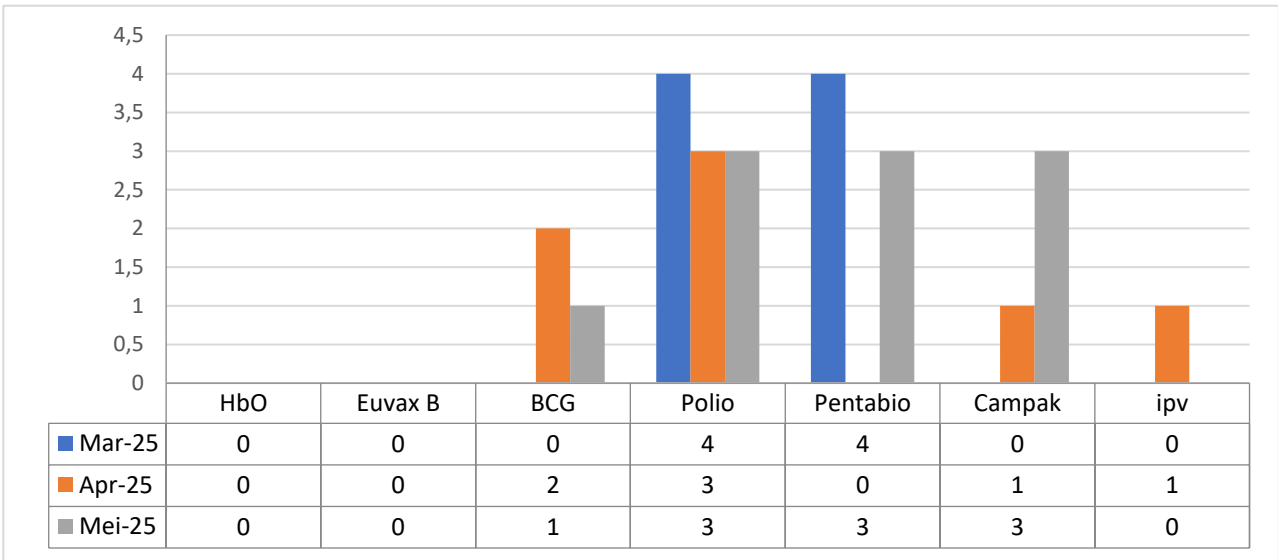
Rencana dan Tindak Lanjut :

Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

3.1.2.2.12.8 Pelayanan Imunisasi
Tabel Pelayanan Imunisasi Ponak Mei 2025

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN MARET 2025	BULAN APRIL 2025	BULAN MEI 2025
1	HbO	0	0	0
2	Euvax B	0	0	0
3	BCG	0	2	1
3	Polio	4	3	3
4	Pentabio	4	0	3
5	Campak	0	1	3
6	IPV	0	1	0

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Mei 2025



Analisis :

- 1. Tidak ada penggunaan vaksin euvax B pada periode Mei 2025 maupun 2 bulan sebelumnya, hal ini dikarenakan banyak nya pasien bayi baru lahir dengan status BPJS, sehingga tidak menggunakan vaksin euvax B
- 2. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi Hbo pada bulan Mei dan 2 bulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan ketidaktersedianya vaksin HB0 di RS prima Husada malang, dikarenakan stok vaksin dari dinas Kesehatan kabupaten malang terbatas sehingga Puskesmas belum bisa memeberikan ke RS swasta, sehingga bayi yang baru lahir diarahkan untuk imunisasi Hbo di Puskesmas wilayah masing-masing sebelum usia 7 hari
- 3. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Mei dan Maret, sedangkan April ada 1 bayi
- 4. Bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Mei sebanyak 1 bayi, April sebanyak 2 bayi, sedangkan pada bulan Maret tidak ada
- 5. Bayi yang melakukan Imunisasi campak pada bulan Mei sebanyak 3 bayi, dan bulan April ada 1 bayi, sedangkan pada bulan Maret 2025 tidak ada
- 6. Bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Mei dan April 2025 sebanyak 3 bayi, sedangkan pada bulan Maret 2025 sebanyak 4 bayi.
- 7. Bayi yg imunisasi Pentabio pada bulan Maret sebanyak 3 bayi, dan tidak ada pada bulan April, sedangkan pada bulan Maret sebanyak 4, imunisasi pentabio diberikan bersamaan dg rota dan PCV, sedangkan vaksin tersebut ada pembatasan dari puskesmas

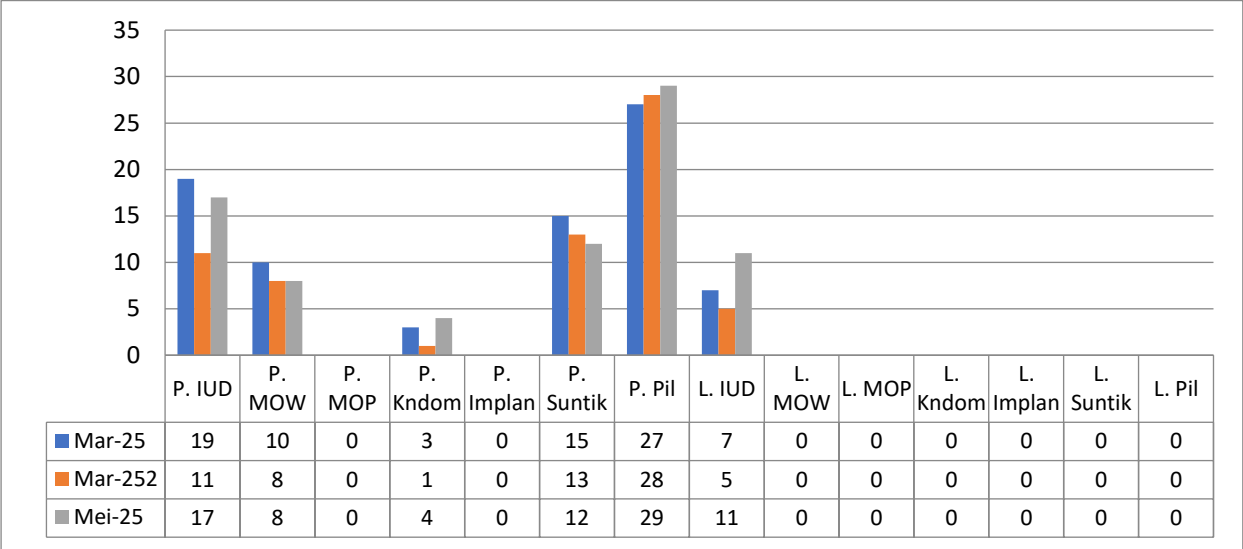
Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
- 2. Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.2.2.1.2.9 Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
Tabel Pelayan Keluarga berencana (KB) Ponok Mei 2025

NO	JENIS	JUMLAH PASANG			JUMLAH LEPAS		
		BULAN MARET 2025	BULAN APRIL 2025	BULAN MEI 2025	BULAN MARET 2025	BULAN APRIL 2025	BULAN MEI 2025
1	IUD	19	11	17	7	5	11
2	MOW	10	8	8	0	0	0
3	MOP	0	0	0	0	0	0
4	Kondom	3	1	4	0	0	0
5	Implant	0	0	0	0	0	0
6	Suntikan	15	13	12	0	0	0
7	Pil	24	28	29	0	0	0

Grafik Pelayanan KB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Mei 2025



Aanalisis :

- 1. Pemasangan KB IUD pada bulan bulan Mei 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebanyak 17 akseptor yang terdiri dari 9 akseptor IUD Nova T dan 8 akseptor IUD copper T, pemakaian KB belum maksimal dikarenakan KB IUD coper T pasca salin ada biaya jasa dokter Rp. 400.000, biaya gratis jika dipasang oleh bidan tetapi pasien tidak berkenan, memilih KB di faskes tingkat 1
- 2. Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan Mei 2025 sama dengan bulan sebelumnya yaitu 8 pasien. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder. Tindakan MOW dilakukan jika ada indikasi dari DPJP.
- 3. Pasien yang menggunakan metode kondom pada bulan Mei sebanyak 4 akseptor, meningkat jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 1 pengguna. Sedangkan pada bulan Maret 3 pengguna
- 4. Pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan Mei sedikit meningkat yaitu 29 pengguna, sedangkan bulan april 28 pengguna, dan maret 2025 sebanyak 27 pengguna
- 5. Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan Mei sedikit menurun yaitu 12 pengguna, April 13 pengguna, sedangkan Maret 2025 sebanyak 15 pengguna.

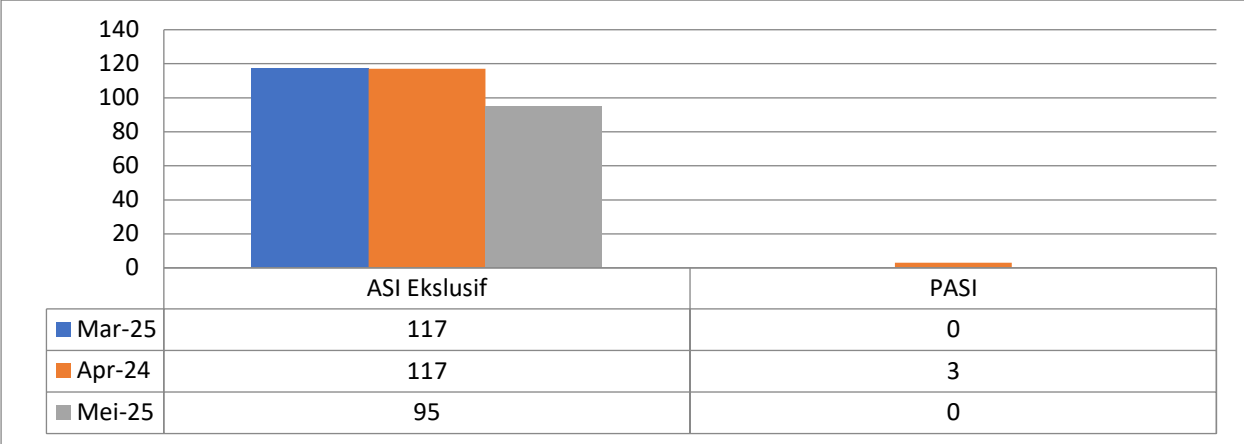
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

3.3 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif
Tabel 5.10 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif Mei 2025

NO	PEMBERIAN ASI	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MARET 2025	BULAN APRIL 2025	BULAN MEI 2025
1	Asi eksklusif	117	117	95
2	Asi /PASI	0	3	0

Grafik Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif Di RS Prima Husada Bulan Mei 2025



Analisis :

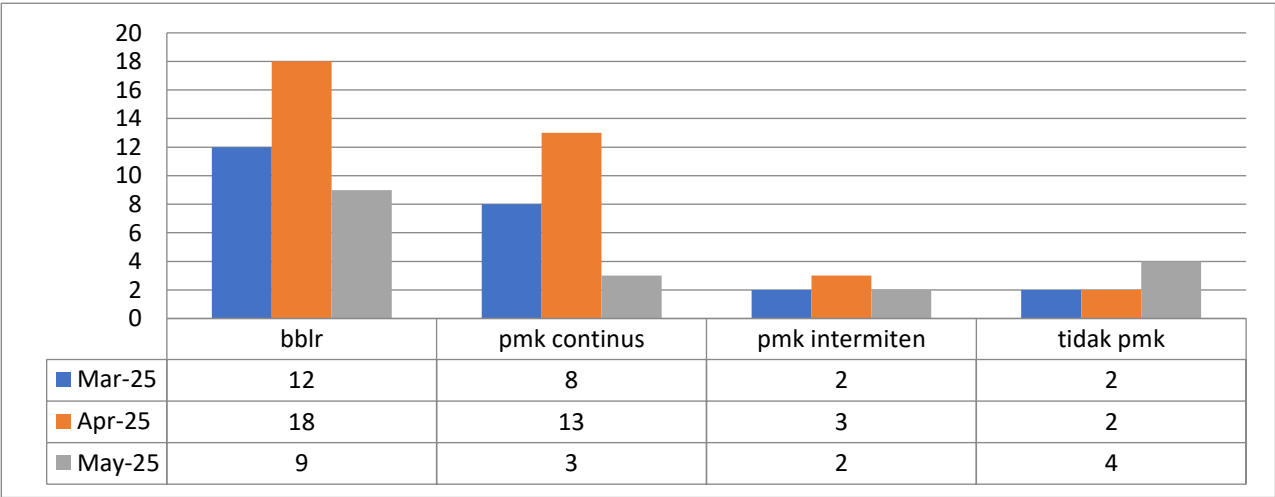
- 1. Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan Mei menurun, yaitu 95 bayi, sedangkan pada bulan April dan Maret 2025 sama, yaitu 117 bayi. Hal ini dikarenakan meskipun ada bayi dengan BBLR juga tetap diberikan ASI eksklusif
- 2. Bayi yang mendapat PASI pada bulan Mei 0 bayi. Diperbolehkan menggunakan sufor pada bayi dengan kondisi tertentu, dan pastinya atas rekomendasi dari dokter spesialis anak.

Rencana dan Tindak Lanjut :

Dilakukannya Edukasi dengan adanya kelas ibu menyusui saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Sehingga ada kegiatan tanya jawab, demonstrasi dan bertukar ilmu terkait pemberian ASI eksklusif

3.2.2.1.2.10 Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR
Tabel Pelayanan Perawatan metode kangguru (PMK) Pada BBLR di Ponek Mei 2025

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MARET 2025	BULAN APRIL 2025	BULAN MEI 2025
1	Bayi BBLR	12	18	9
2	PMK continuos	8	13	3
3	PMK Intermiten	2	3	2
4	Tidak PMK	2	2	4



Grafik Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR di RS Prima Husada Mei 2025

Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan PMK continus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500gram.
- 2. Pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan Mei 2025 sedikit menurun jika dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, yaitu 2 bayi,dikarenakan bayi sesak memakai c-pap dan bayi hipoglikemi, membutuhkan perawatan intensif, sedangkan pada bulan April sebanyak 3 bayi, dan Februari 2025 sebanyak 2 bayi
- 3. Sedangkan metode PMK continus pada bulan Mei 2025 menurun yaitu 3 bayi dengan BBLR kondisi bayi stabil sedangkan pada bulan April sebanyak 4 bayi, dan Maret 2025 sebanyak 8 bayi. hal ini seiring dg jumlah BBLR yang ada
- 4. Ada 4 bayi yang tidak dilakukan PMK pada bulan Mei dikarenakan karena 2 bayi sesak berat dirujuk , karena 2 bayi sesak meninggal dan pada bulan April dan Maret 2025 sebanyak 2 bayi. Hal ini dikarenakan kondisi bayi yg tidak mendukung untuk dilakukan PMK karena terpasang alat C-pep dan bayi di rujuk ke RS lain.

Rencana dan Tindak Lanjut

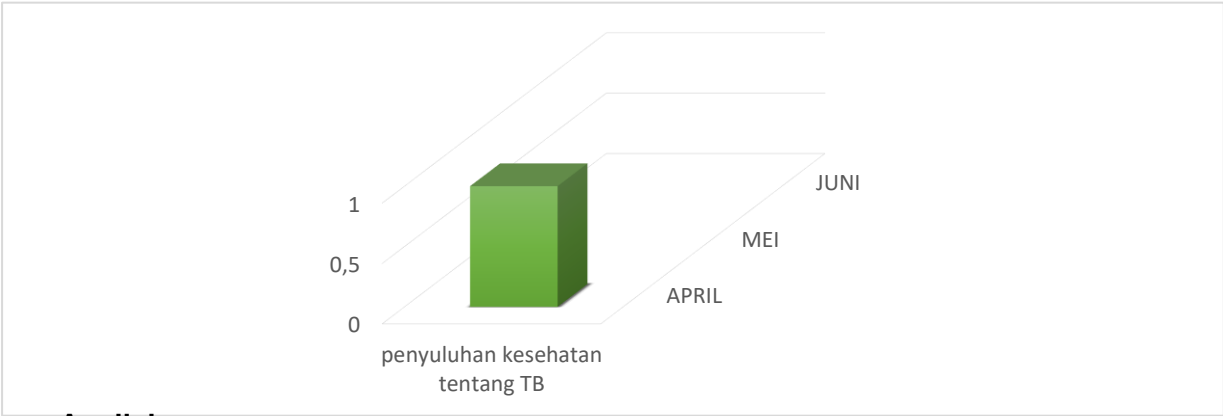
Perawatan Metode Kangguru sesuai dengan SPO yang berlaku

1.1.2.2. TB DOT'S

3.1.2.2.1 Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Tentang Tuberculosis

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH KEGIATAN		
		APRIL	MEI	JUNI
1	Penyuluhan kesehatan tentang tuberculosis	1	1	

Grafik Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan di RS Prima Husada



Analisis:

Peserta audiens ditujukan kepada pasien dan keluarga pasien, dengan harapan peserta memahami hasil penyuluhan.

Rencana dan Tindak Lanjut:

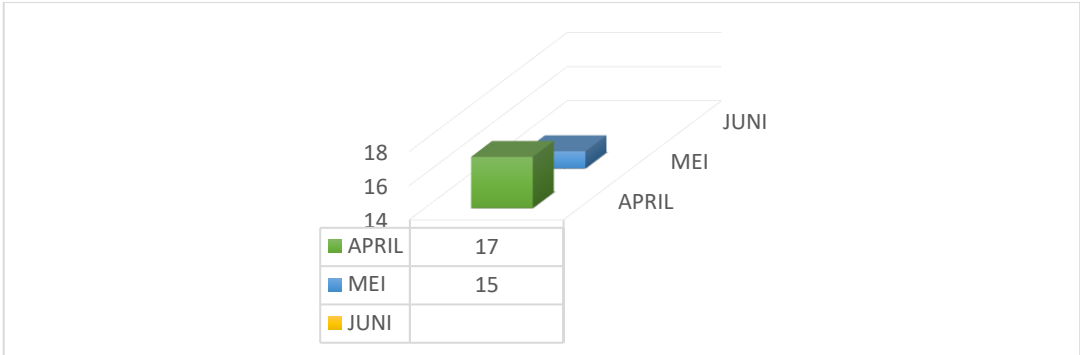
Harus diadakan promosi kesehatan secara berkala terkait TBC seperti; pentingnya patuh dalam pengobatan TBC, kapan waktu yang tepat minum obat TBC, apa tanda gejala TBC, dlls.

3.1.2.2.2 Skrining Pasien

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI

1.	Pemberian Masker	17	15	
----	------------------	----	----	--

Grafik Jumlah Pasien Dengan Skrining Awal Pemberian Masker di RS Prima Husada



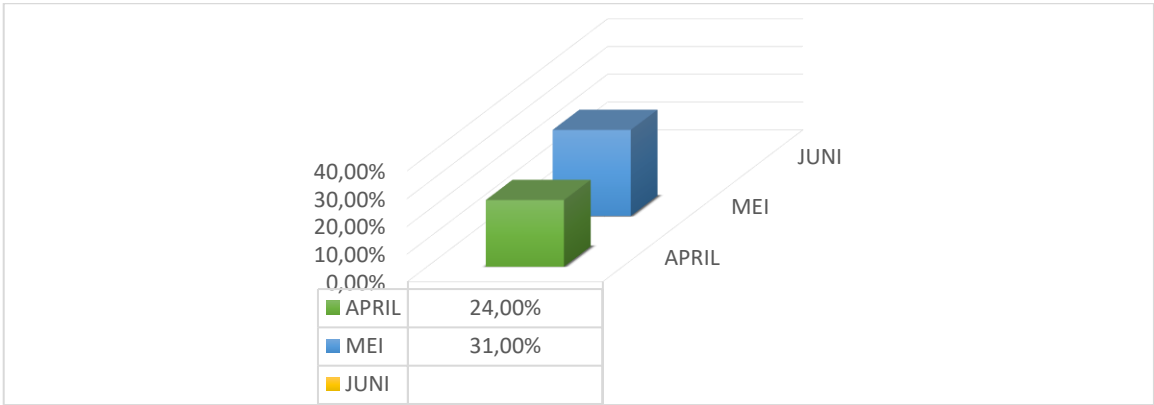
Analisis :
 Pada bulan April 2025 terdapat 17 pasien yang diberikan masker karena masker yang dipakai kotor atau tidak standart

- Rencana dan Tindak Lanjut:**
- Memfasilitasi ketersediaan masker
 - Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan)

3.1.2.2.3 **Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis**

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Proporsi pasien (terduga dan baru) tekonfirmasi bakteriologis	24	31	

Grafik Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis di RS Prima Husada



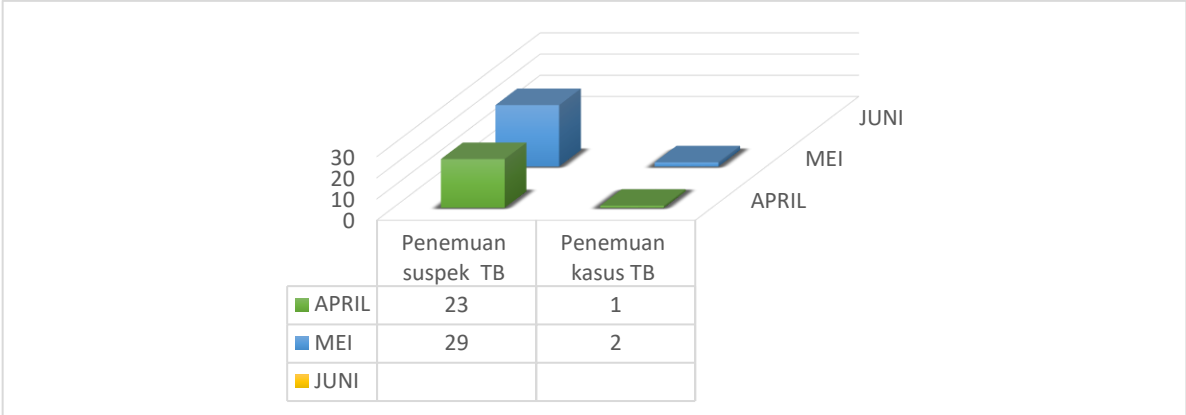
- Analisis :**
- Pada bulan April 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 24
 - Pada bulan Mei 2025 jumlah proporsi Pasien terduga TB 31

Rencana dan Tindak Lanjut :
 Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

3.1.2.2.4 Penemuan Kasus TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Penemuan suspek TB	23	29	
2	Penemuan kasus TB	1	2	

Grafik Penemuan Kasus TB Baru di Rumah Sakit Prima Husada



Analisis :

- 1. Pada bulan April 2025 terdapat 40 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 1 pasien
- 2. Pada bulan Mei 2025 terdapat 40 pasien jumlah penemuan suspek TB dan kasus TB positif sebanyak 2 pasien

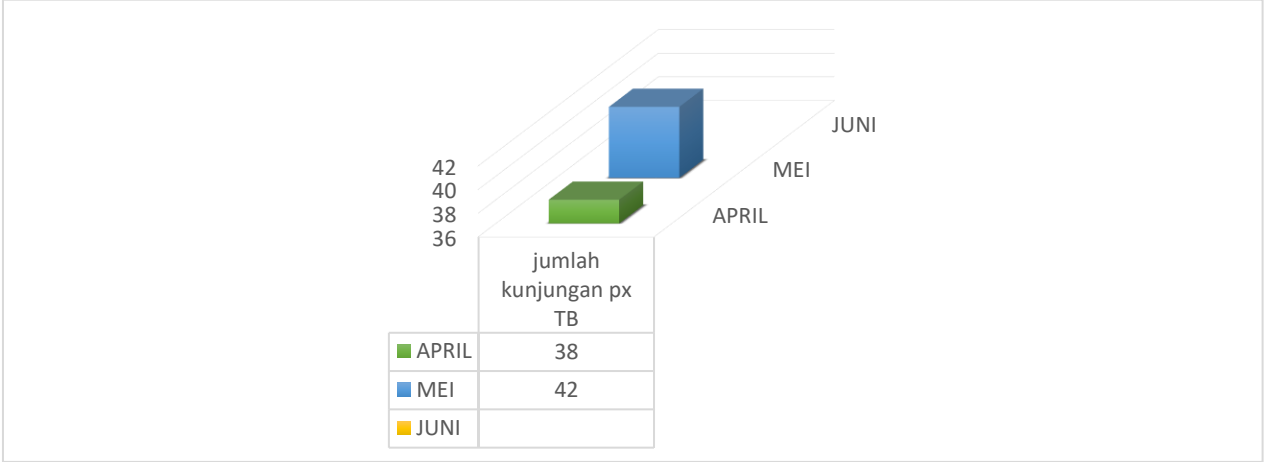
Rencana dan Tindak Lanjut:

Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasien untuk melakukan skrinning TB

3.1.2.2.5 Jumlah Kunjungan pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Pasien TB Kunjungan Keseluruhan	38	42	

Grafik Jumlah Kunjungan Pasien TB Baru di Rumah Sakit Prima Husada



Analisis:

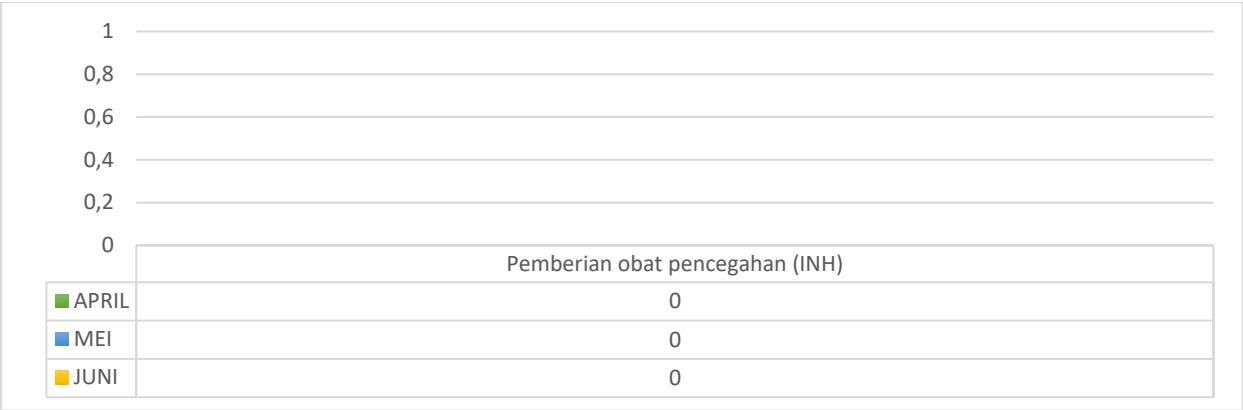
- 1. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan April 2025 di poli pasien TBC mencapai 38 pasien.
- 2. Jumlah keseluruhan kunjungan bulan Mei 2025 di poli pasien TBC mencapai 42 pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :
Meningkatkan kunjungan pasien

3.1.2.2.6 Pemberian Obat Pencegahan

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Pemberian obat pencegahan (INH)	0	0	0

Grafik Pemberian Obat Pencegahan di Rumah Sakit Prima



Analisis :

Tidak ada yang mendapat obat pencegahan (INH), hal ini dikarenakan kurang pengetahuannya pasien dan keluarga pasien mengenai pengobatan pencegahan (INH)

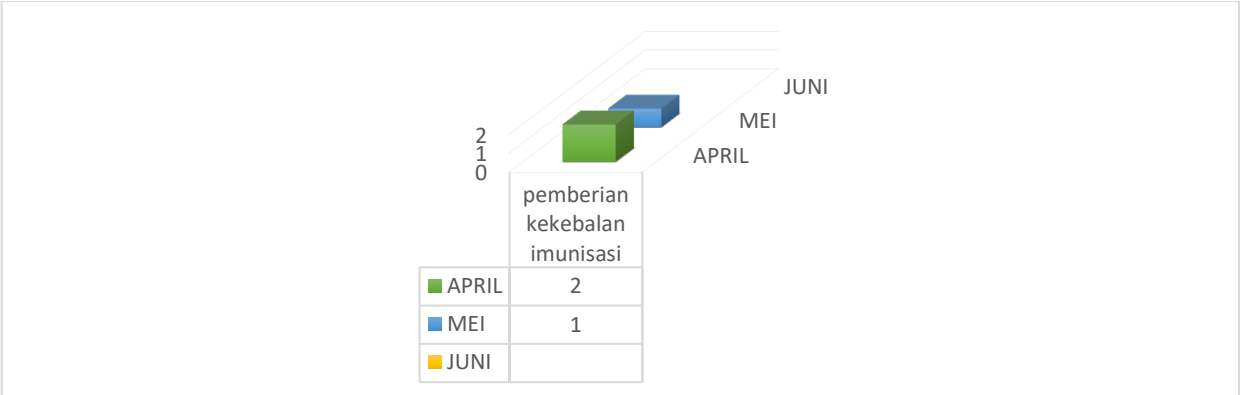
Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa jika ada salah satu keluarga yang terdiagnosa TB kemudian memiliki saudara dengan usia dibawah 17 tahun, agar segera memeriksakan dan bersedia di berikan obat pencegahan (INH)
- 2. Pemberian obat INH ditujukan pada anak usia dibawah 5 tahun yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosa TB

3.1.2.2.7 Pemberian Imunisasi BCG

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Pemberian imunisasi BCG	2	1	

Grafik Pemberian Kekebalan Imunisasi Di RS Prima Husada



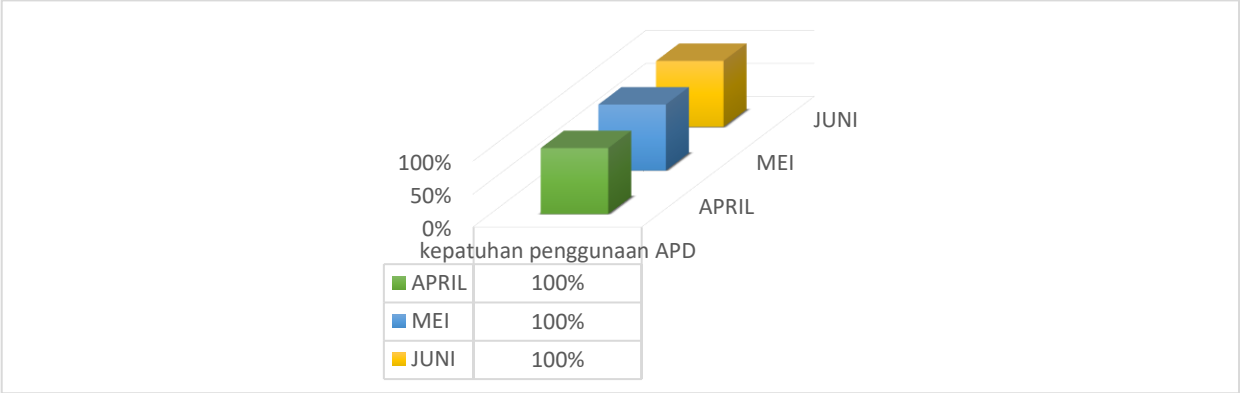
- Analisis :**
- 1. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 2 pasien yang diimunisasi pada bulan April
 - 2. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 1 pasien yang diimunisasi pada bulan Mei

- Rencana dan Tindak Lanjut :**
- 1. Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG
 - 2. Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulanya

3.1.2.2.8 Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD	100%	100%	

Grafik Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APDRS Prima Husada



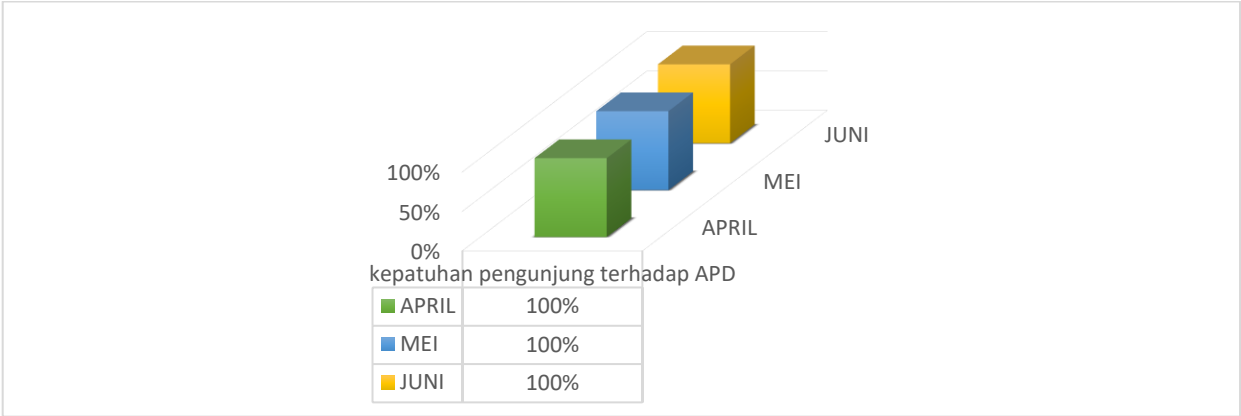
- Analisis :**
- Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

- Rencana dan Tindak Lanjut :**
- Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.1.2.2.9 Kepatuhan Pengunjung Pasien Terhadap APD

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Kepatuhan pengunjung pasien terhadap APD	100%	100%	

Grafik Kepatuhan Pengunjung Terhadap APD di RS Prima Husada



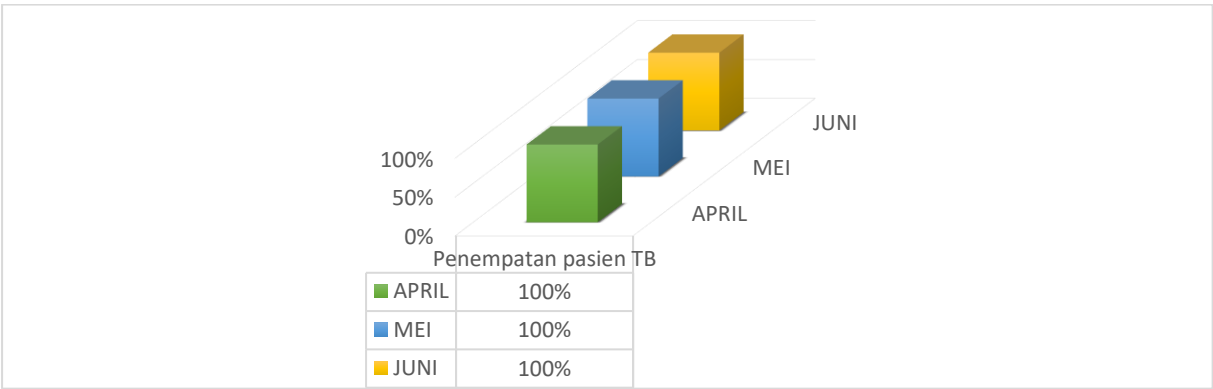
Analisis:
 Hasil diatas menunjukan (100%) kepatuhan terhadap APD. Hal ini terjadi karna peningkatan kesadaran pengunjung akan cara penulara.n karena disebabkan covid yang terus menularkan virus

Rencana dan Tindak Lanjut :
 Memperkuat kepatuhan pengunjung dengan cara wajib memberikan masker kepada pengunjung saat di nerstation dengan menanyakan keluarga dari pasien isolasi

3.1.2.2.10 Penempatan Pasien TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Penempatan pasien TB	100%	100%	

Grafik Penempatan Pasien TB Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Mei 2025



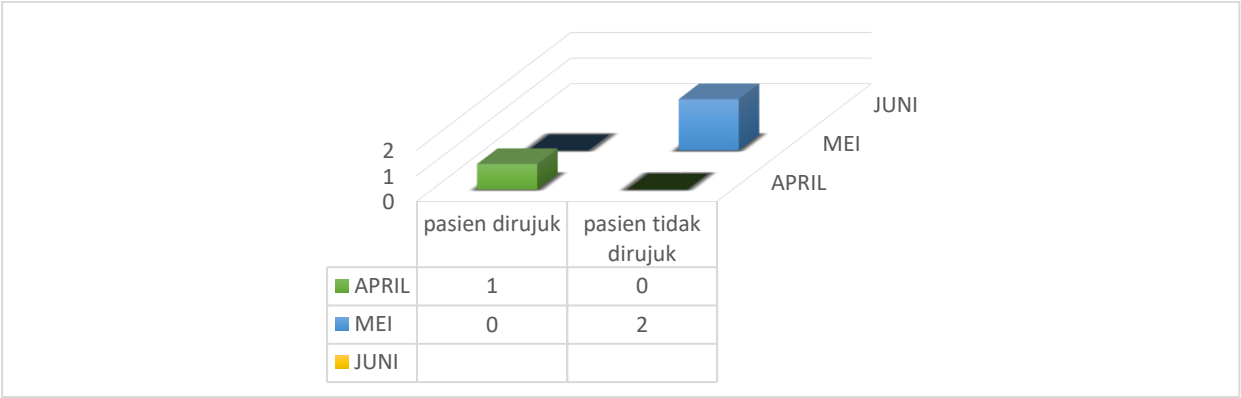
Analisis:
 Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang isolasi, hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.

Rencana dan Tindak Lanjut :
 Mempertahankan penempatan dengan benar

3.1.2.2.11 Pasien TB yang dirujuk

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Pasien TB yang dirujuk	1	0	
2.	Pasien TB yang tidak dirujuk	0	2	

Grafik Pasien TB yang dirujuk Di Rumah Sakit Prima Husada



Analisis :

- 1. Pada bulan April 2025 terdapat 1 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.
- 2. Pada bulan Mei2025 terdapat 0 pasien yang dirujuk ke FKTP I karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya.

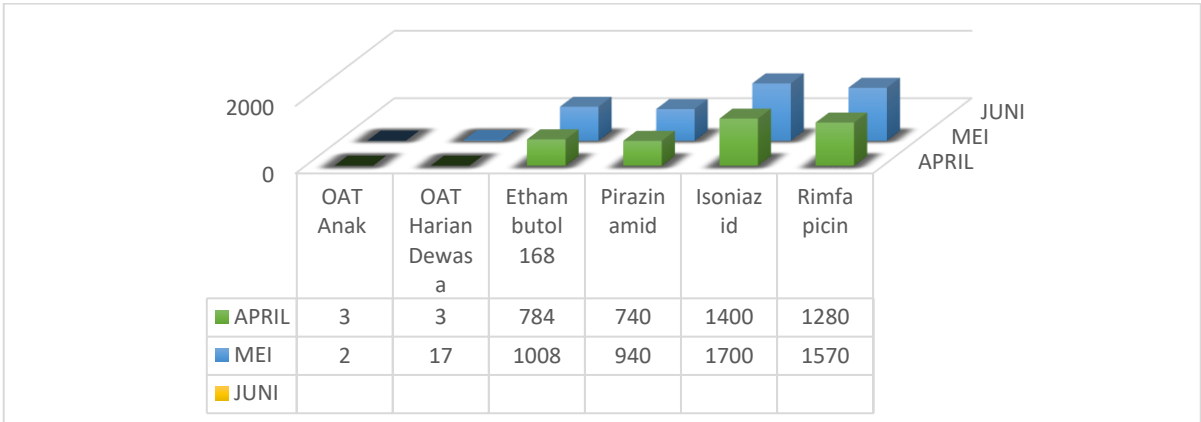
Rencana dan Tindak Lanjut :

Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

3.1.2.2.12 Stok OAT

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	OAT Anak	3	2	
2.	OAT Harian Dewasa	3	17	
3.	Ethambutol	784	1008	
4.	Pirazinamid	740	940	
5.	Isoniazid	1400	1700	
6.	Rimfapicin	1280	1570	

Grafik Stok Obat TBC Di Rumah Sakit Prima Husada



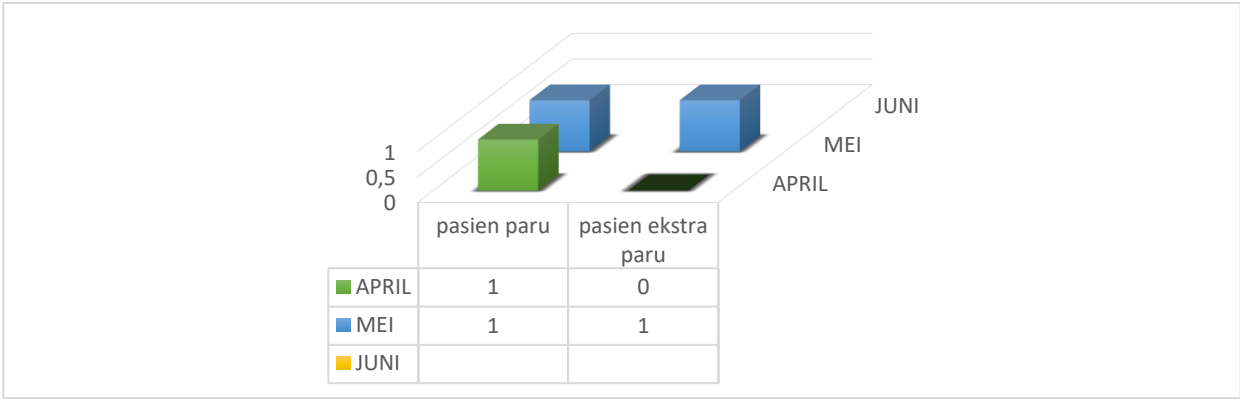
Analisis :
Setiap 1 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinkes

Rencana dan Tindak Lanjut :
Menetapkan pengambilan obat dengan sesuai jadwal.

3.1.2.2.13 Pasien Paru dan Ekstra Paru

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Pasien paru	1	1	
2.	Pasien Ekstra paru	0	1	

Grafik Pasien Paru dan Ekstra Paru di Rumah Sakit Prima Husada



Evaluasi :

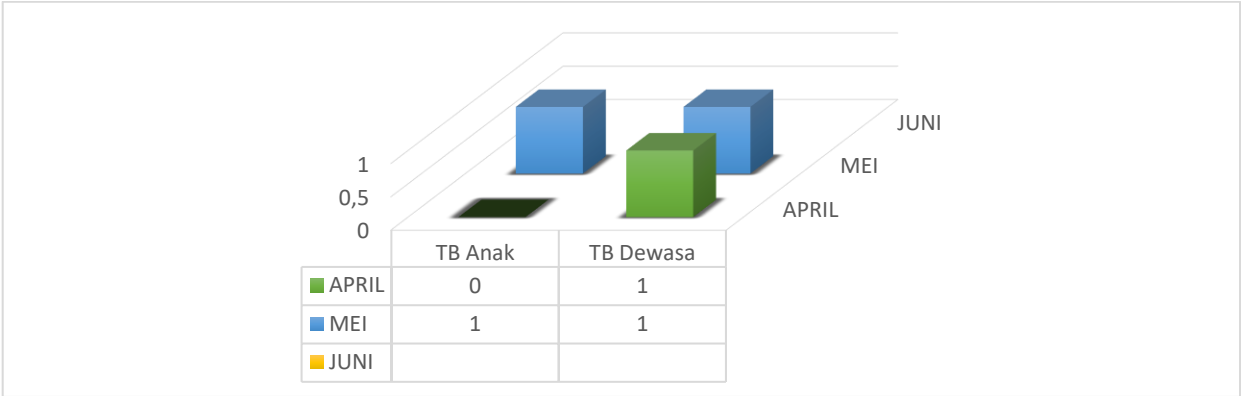
1. Pada bulan April 2025 terdapat 0 pasien ekstra paru
2. Pada bulan Meil 2025 terdapat 1 pasien ekstra paru

Rencana dan Tindak Lanjut :
Memberikan pengobatan yang sama pada ekstra paru meski pengobatannya akan lebih lama

3.1.2.2.14 Pasien Anak Dan Pasien Dewasa TB

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Pasien Anak	0	1	
2.	Pasien Dewasa	1	1	

Grafik Pasien Anak dan Pasien Dewasa di Rumah Sakit Prima



Analisis :

- 1. Pada bulan April terdapat 0 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 1 pasien
- 2. Pada bulan Mei terdapat 1 pasien TB Anak sedangkan pasien TB dewasa mencapai 1 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :

Mempertahankan pencatatan TB sesuai kategori pasien.

3.1.2.2.15 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK TB

NO	KEGIATAN	NAMA PASIEN	PATU H	TIDAK PATUH	ALASAN
1.	dr. Andy, Sp. P	Ny. S	V		
		Ny. I	V		
		Ny. S	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P				
		Tn. P	V		
3.	Dr. Yunita, Sp. P				
		Ny. S	V		

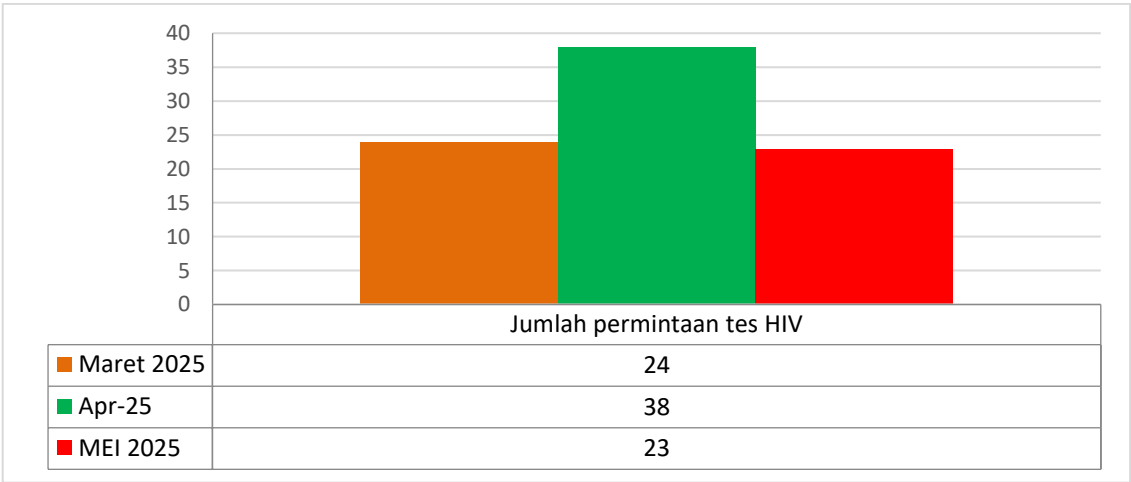
Analisis :
 Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan

Rencana dan Tindak Lanjut :
 Tetap mempertahankan kepatuhan dokter sesuai dengan PPK TB yang berlaku di RS Prima Husada Kabupaten Malang

3.1.2.3 **HIV**

Jumlah Permintaan Tes HIV				
NO	URAIAN	BULAN		
		MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025
1	Permintaan Test HIV	24	38	23

Grafik Jumlah Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada
 Bulan Mei 2025



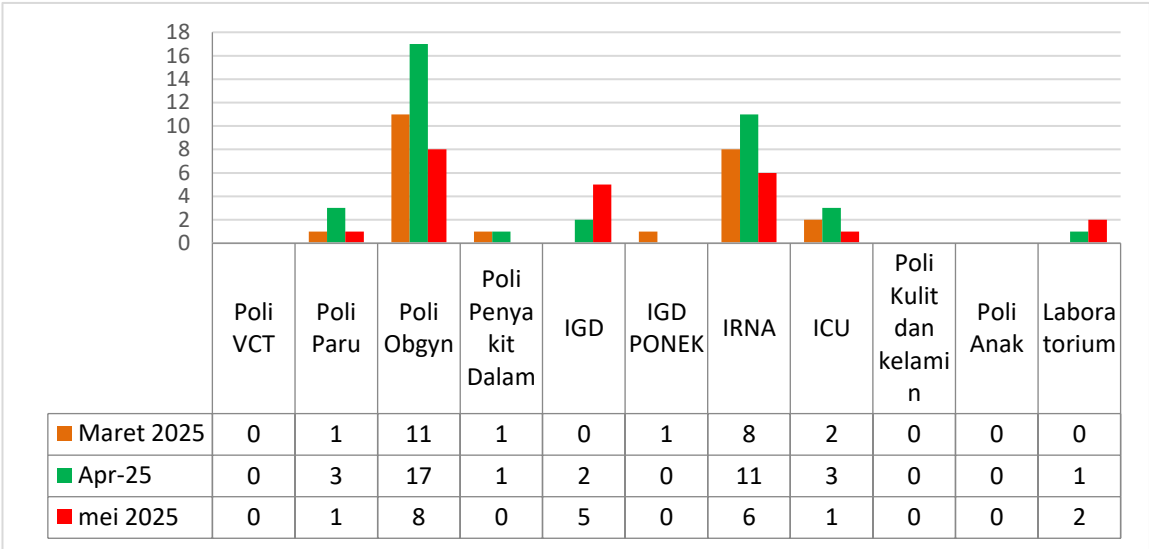
Analisis :
 Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah permintaan test HIV pada bulan maret 2025 turun menjadi 24 pemeriksaan. pada bulan April 2025 sebanyak 38 pemeriksaan Sedangkan pada buln Me 2025 sebnyak 23 pmeriksaan Hal ini dikarenakan terdapat pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya.

Rencana Tindak Lanjut :
 Dilakukan skrining ulang pada pasien-pasien yang terduga HIV, pasien hamil trimester 3 dan juga pasien-pasien mandiri yang ingin dilakukan pemertiksaan HIV sesuai sukarela baik pasien IGD, rawat jalan maupun rawat inap.

3.1.2.3.1. Asal Permintaan Tes HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025
1	Poli VCT	0	0	0
2	Poli Paru	1	3	1
3	Poli Obgyn	11	17	8
4	Poli Penyakit Dalam	1	1	0
5	IGD	0	2	5
6	IGD PONEK	1	0	0
7	IRNA	8	11	6
8	ICU	2	3	1
9	Poli Kulit dan kelamin	0	0	0
10	Poli Anak	0	0	0
11	Laboratorium	0	1	2

Grafik Jumlah Asal Permintaan Tes HIV Mei 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa jumlah asal permintaan test HIV di Poli kandungan tetap tinggi dibandingkan dari unit lain pada bulan Maret 2025 sebanyak 11 pasien. pada bulan April 2025 sebanyak 17 pasien Sedangkan pada bulan mei 2025 sebanyak 7 pasien

Hal ini dikarenakan sudah tersdianya Reagen HIV dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk program ibu hamil sehingga pasien dengan kriteria hamil trimester II sudah bisa dilakukan screening HIV.

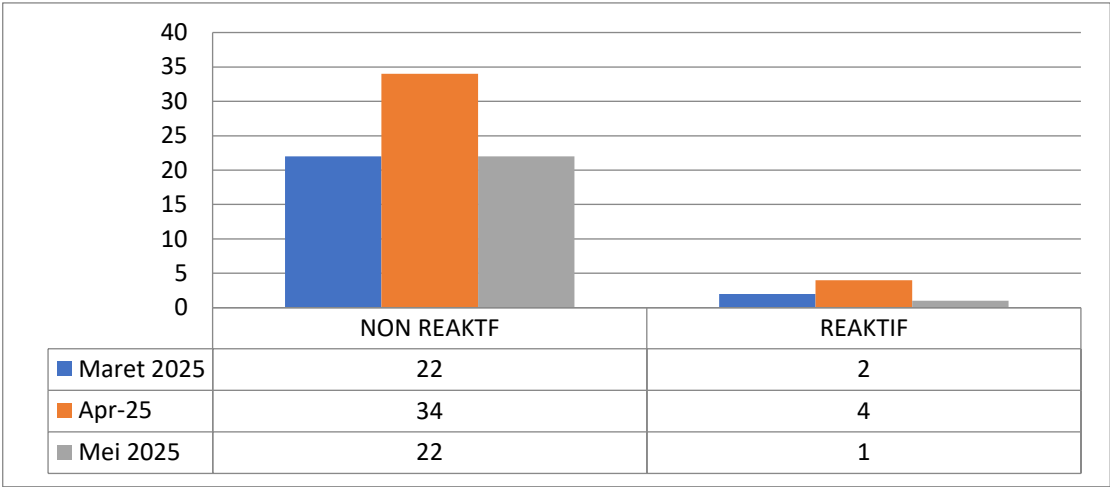
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan sosialisasi terkait Permintaan testing HIV dilakukan baik di IGD, rawat jalan, maupun rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga capaian permintaan testing HIV bisa berjalan.

3.1.2.3.2 Status HIV

NO	URAIAN	BULAN		
		MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025
1	Non Reaktif	22	34	22
2	Reaktif	2	4	1

Grafik Status HIV Mei 2025



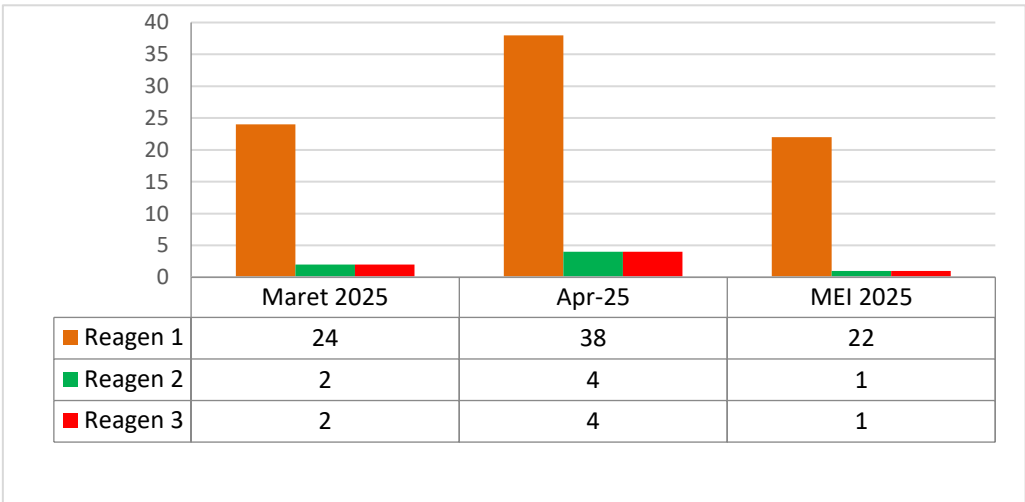
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan pasien dengan status HIV reaktif yang dilakukan pemeriksaan di RS prima Husada Malang pada pada bulan maret 2025 sebanyak 2 pasien pada bulan April 2025 sebanyak 4 pasien. Sedangkan pada bulan Mei 2025 sebnyak 1 pasien

Rencana Tindak Lanjut :
Rumah sakt prima husada malang masih belum bisa melakukan pelayanan pasien dengan HIV/AIDS, apabila ditemukan pasien dengan HIV reaktif maka akan kami lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah MOU dengan RS Prima Husada Malang.

3.1.2.3.3 Jumlah Pemakaian Reagen

No	URAIAN	BULAN		
		MARET 2025	APRIL 2025	APRIL 2025
1	Reagen 1	24	38	23
2	Reagen 2	2	4	1
3	Reagen 3	2	4	1

Grafik Jumlah Pemakaian Reagen Mei 2025



Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pemakaian reagen pada bulan Maret 2025 memakai reagen 3 dikarenakan ada pasien reaktif sebanyak 2 pasien. pada bulan April memakai reagen 3 dikarenakan ada pasien reaktif sebanyak 4 pasien. Sedangkan pada bulan mei 2025 memakai reagen 3 dikarenakan ada pasien reaktif sebanyak 1 pasien

Rencana Tindak Lanjut :

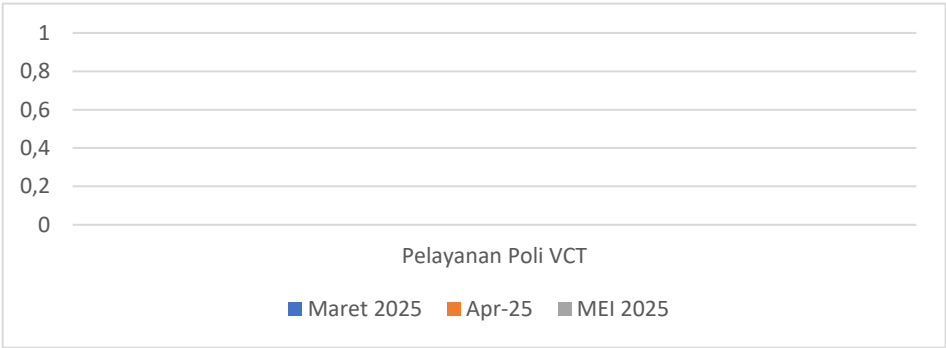
Pemakaian reagen HIV tergantung dari hasil pemeriksaan dengan Reagen 1. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan Reagen 1 hasil Non Reatif maka tidak dilanjutkan pemakaian Reagen 2 dan 3.

Tetapi apabila saat pemeriksaan dengan Reagen 1 ditemukan hasil Reaktif maka pemeriksaan dilanjutkan dengan penggunaan Reagen 2 dan Reagen 3

3.1.2.3.4 Pelayanan Poli Vct (Voluntary Conseling And Testing)

No	URAIAN	BULAN		
		MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025
1	Pelayanan Poli VCT	0	0	0

Grafik Pelayanan Poli VCT Mei 2025



Analisis pelayanan Poli VCT

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa tidak ada kunjungan di poli VCT di RS Prima Husada. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS

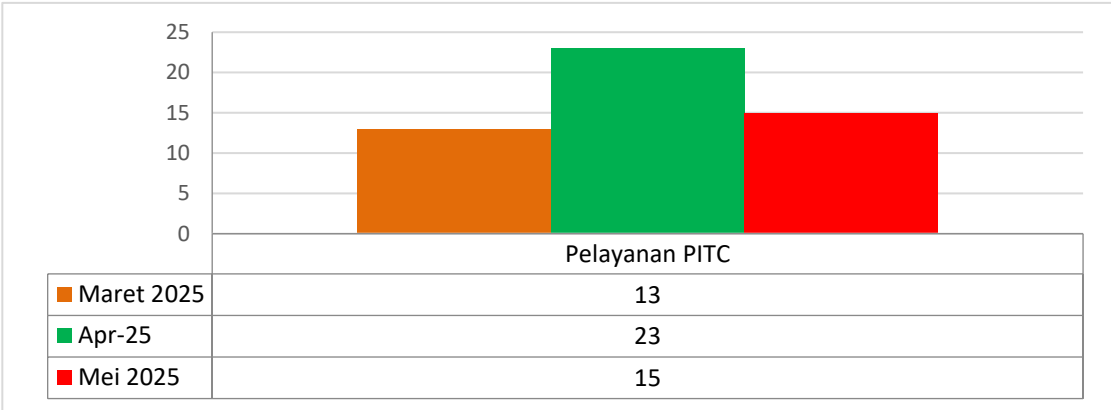
Rencana Tindak Lanjut

Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husadabelum berdiri sendiri, melainkan masih bergabung dengan oli penyakit Dalam di Rawat jalan. Hal ini dikarenaka asih belum adanya kunjungan pasien ke poli VCT

3.1.2.3.5 Pelayanan PITC (Provider Initiated Testing and Counseling)

No	URAIAN	BULAN		
		MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025
1	Pelayanan PITC	13	23	15

Grafik Pelayanan PITC Mei 2025



Analisis :

Dari data diatas terdapat keimpulan bahwa telah dilakukan edukasi pemeriksaan HIV oleh petugas kesehatan untuk dilakukan testing HIV pada bulan Maret 2025 13 pasien. pada bulan maret sebanyak 23 pasien. Sedangkan pada Bulan Mei 2025 sebanyak 15 pasien. Hal ini dikarenakan testing dan konseling dilakukan saat pasien menunjukan gejala HIV dan dilakukanya sreening baik di ruangan maupun IGD

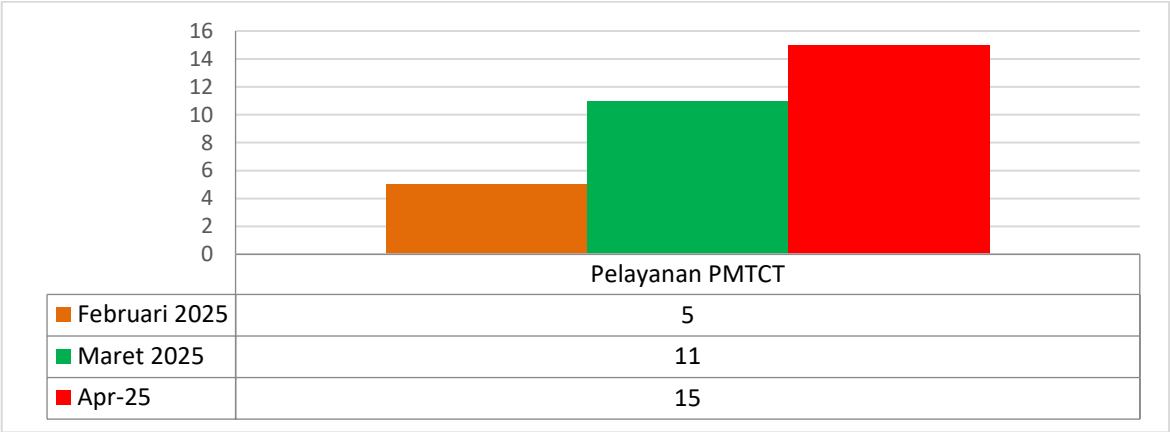
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan peningkatan terkait penjangrian pasien dengan dialkukanya edukasi pasien tentang testing HIV kepada pengunjung atau masyarakat sehingga pasien paham tentang pentingnya dilakukan pemeriksaan HIV.

3.1.2.3.6 Pelayanan Pmtct (Prevention to Mother Of Child Transmision)

No	URAIAN	BULAN		
		MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025
1	Pelayanan PMTCT	11	15	8

Grafik Pelayanan PMTCT Mei 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV sebagai screening dan deteksi pencegahan penularan dari ibu ke Bayi. Pada bulan maret 2025 sebanyak 11 pasien. pada bulan April 2025 sebanyak 15 pasien. Sedangkan pada bulan Mei 2025 sebnya 8 pasien.

Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

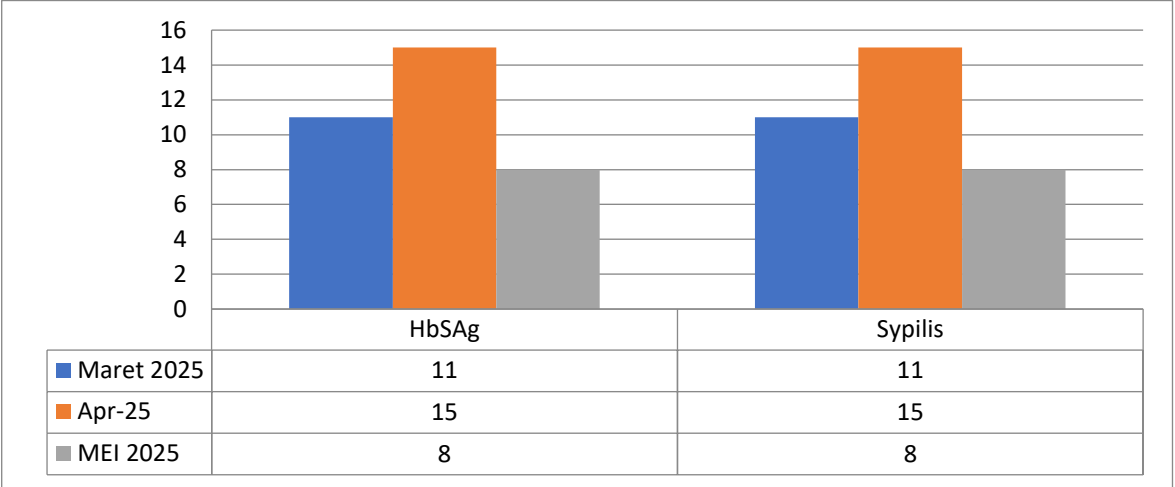
Rencana Tindak Lanjut :

Reagen pemeriksaan HIV yang diperoleh dari dinas kesehatan sudah tersedia di RS Prima Husada Malang sehingga Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

3.1.2.3.7 Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025
1	HbSAg	11	15	8
2	Sypilis	11	15	8

**Grafik Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
Mei 2025**



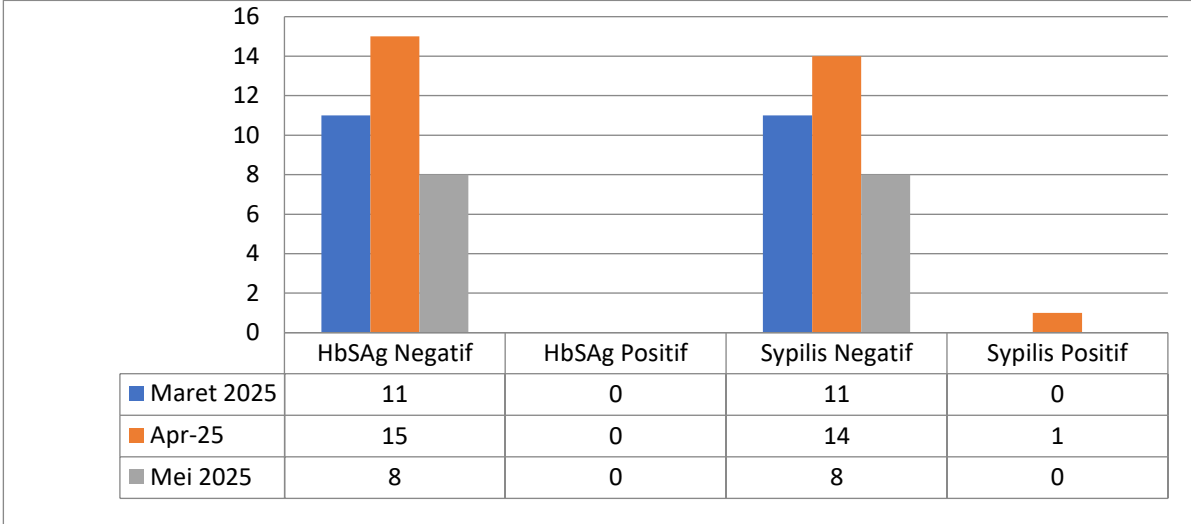
Analisis :
 Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HbSAg dan Sypilis pada bulan pada bulan maret 2025 sebanyak 11 pasien pada bulan April 2025 sebanyak 15 pasien Sedangkan pada bulan Mei 2025 sebanyak 8 pasien. Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan triple eliminasi dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan Triple eliminasi di RS Prima Husada Malang untuk pemeriksaan HbSAg dan Sypilis bisa dilakukan.

Rencana Tindak lanjut :
 Pemeriksaan Triple eliminasi untuk ibu hamil bersifat wajib dan dilakukan 1 kali saat awal kehamilan. Di RS Prima Husada skrining pemeriksaan triple eliminasi sudah berjalan dan dilakukan saat kunjungan pada Trimester 2.

3.1.2.3.8 Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025
1	HbSAg			
	Negatif	11	15	8
	Positif	0	0	0
2	Sypilis			
	Negatif	11	14	8
	Positif	0	1	0

Grafik Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
Mei 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data bahwa pada bulan Maret dan Mei 2025 tidak ditemukan pasien dengan HbSAg maupun Shypilis dengan hasil positif. Sedangkan pada bulan april 2025 ditemukan 1 pasien positif Syphilis.

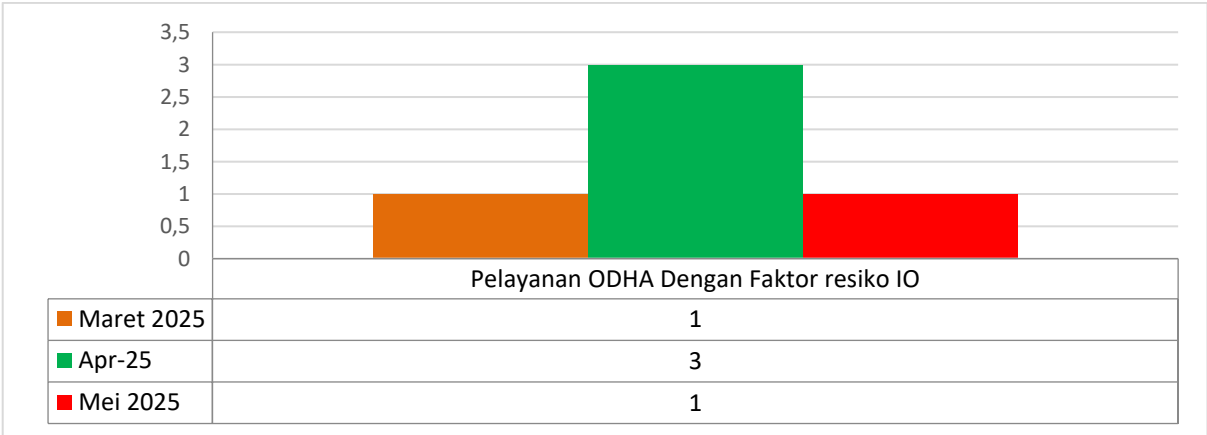
Rencana Tindak Lanjut :

- Pada pasien HbSAg
Saat kelahiran aka nada pemberian vaksin Hepatitis kepada bayi yaitu Hiper Heb dan juga Hb.O unijec yang diberikan saat bayi baru lahir sampai dengan maksimal 24 jam pemberian. Untuk ibu dengan HbSAg akan dilakukan pemberian vaksin hepatitis oleh Puskesmas sesuai domisili pasien.Penanganan pasien dengan HbSAg Rumah Sakit Prima Husada Malang Kolaborasi dengan puskesmas sesuai dengan domisili pasien.
- Pada pasien Syphilis
Di rumah sakit Prima Husada Malang sudah bisa melakukan pengobatan pasien dengan syphilis positif. Sehingga tidak lagi melakukan rujuk keluar.

3.1.2.3.9 Pelayanan Odha Dengan Factor Resiko Infeksi Oportunistik

No	URAIAN	BULAN		
		MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025
1	Pelayanan ODHA Dengan Faktor resiko IO	1	3	1

Grafik Pelayanan Odha dengan Faktor Resiko IO Mei 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa terdapat pasien dengan diagnose TB positif yang dilakukan pemeriksaan HIV di RS Prima Husada. Pada bulan pada bulan Maret 2025 didapatkan 1 pasien. pada bulan april 2025 sebanyak 3 pasien. Sedangkan pada bulan Mei 2025 sebanyak 1 pasien. Hal ini dikarenakan dilakukanya screening pasien TB di RS Prima Husada Malang.

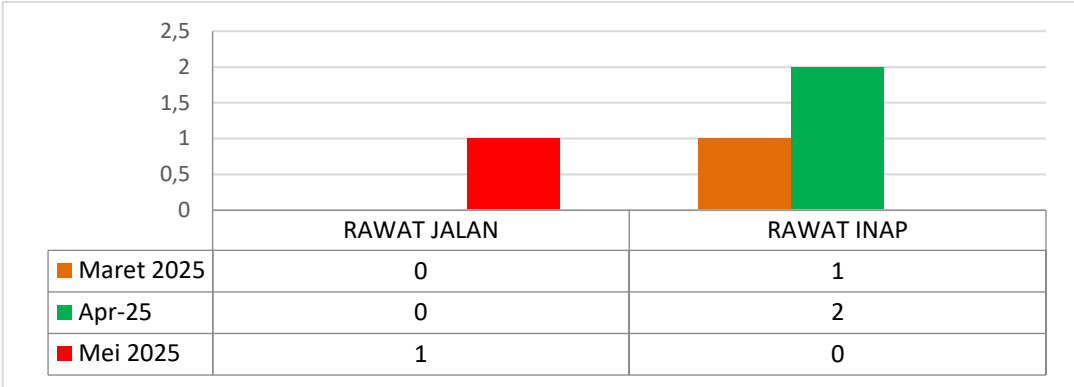
Rencana Tindak Lanjut :

Pasien-pasien dengan diagnose TB positif di Rumah Sakit Prima Husada Malang sudah patuh dilakukan screening pemeriksaan HIV/AIDS sesuai dengan SPO. Diharapkan bisa saling kerjasama antar tim yaitu TIM TB dan Tim HIV.

3.1.2.3.10 Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025
1	Rawat Jalan	0	0	1
2	Rawat Inap	1	2	0

Grafik Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS Mei 2025



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa Pada bulan maret 2025 terdapat 2 pasien yang dirujuk dari rawat inap pada bulan April 2025 terdapat 4 pasien yang dilakuka rujuk, 3 dari rawat inap dan 1 rawat jalan. Sedangkan pada bulan Mei 2025 erdaat 1 asien yang dirujuk dari rawat jalan. Pasien Dilakukan rujuk dikarenakan RS Prima husada malang belum bisa menangani pasien yang ditemukan positif HIV .

Rencana Tindak Lanjut :

Pelaksanaan Rujukan dilakukan apabila hasil pemeriksaan HIV Reaktif. Rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Malang.

3.1.2.4 Stunting & Wasting

3.1.2.4.1 Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting

Tabel Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting Mei 2025

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf , pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting	Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan edukasi pasien dan sosialisasi kepada seluruh staff mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan stunting dan wasting.

2	Program 1000 HPK	Pemberian Penyuluhan tentang pentingnya pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien
3	Suplementasi Folat Pada Ibu hamil	Suplementasi Folat Pada ibu hamil dilaksanakan di poli kandungan di RS Prima Husada Malang
4	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil	Pemberian PMT pada ibu hamil dilaksanakan pada saat kegiatan senam hamil di RS Prima Husada Malang
5	Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	1. Kegiatan konseling IMD dilaksanakan sesaat setelah ibu melahirkan 2. Konseling IMD dan ASI eksklusif dilaksanakan pada saat ibu telah memasuki rawat inap maternitas 3. Penyuluhan tentang pentingnya IMD dan pemberian ASI eksklusif juga dilaksanakan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan
6	Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita dilaksanakan di ruang rawat inap dan melakukan pendampingan di poli anak RS prima husada
7	Pemberian imunisasi	Pemberian imunisasi dilaksanakan di poli anak RS prima husada malang sesuai dengan jadwal praktek dokter spesialis anak dan di rawat inap sesaat setelah bayi baru dilahirkan.
8	Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Pemberian makanan tambahan balita gizi kurang dilaksanakan apabila ditemui balita dengan gizi kurang di rawat inap
9	Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi	1. Menyelenggarakan pelayanan konseling kesehatan maternal dan neonatal. 2. Konseling pemberian ASI eksklusif. 3. Penyediaan Pojok Laktasi untuk mendukung pemberian ASI eksklusif
10	Rumah Sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting	1. Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Stunting, Gizi Kurang, Gizi Buruk pada Balita 2. Memastikan kasus, penyebab dan tatalaksana lanjut oleh dokter spesialis anak. 3. Melakukan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian, pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting.
11	Rumah Sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan	Tidak terdapat kunjungan/ Pendampingan klinis kepada balita gizi kurang yang telah KRS dari RSPHM.
12	Program Pemantauan dan Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait edukasi yang sudah diberikan, serta membuat laporan dan evaluasi kegiatan.

Analisis

1. Melakukan tindakan pelayanan penurunan dan penanggulangan stunting dan wasting di Rumah Sakit.
2. Melakukan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting dan wasting kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien di rumah skait.

3.1.2.4.2
Kinerja Produktivitas

Tabel Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	LOKASI	MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025
Program	Penyuluha	Pengunjung	IRJA	1	1	1

1000 HPK	n mengenai kehidupan 1000 hari pertama	RS Prima Husada Malang	anak dan Kandungan			
Suplementasi Asam folat pada ibu hamil	1. Penyuluhan tentang pentingnya konsumsi asam folat pada ibu hamil 2. Pembagian tablet tambah darah dan asam folat	Ibu Hamil	Senam Hamil , Poli Kandungan, Hall gedung baru lantai 5	1	1	1
Pemberian PMT Ibu Hamil	Pemberian PMT dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil terindikasi KEK	Ibu Hamil	Hall gedung baru lantai 5	0	1	1
Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Ibu hamil	IRJA anak dan kandungan, irna maternitas	1	1	1
Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	1. Penyuluhan tentang stunting, makanan sehat pada bayi dan balita 2. Pembagian PMBA	IRNA Anak	IRJA	1	1	1
Pemantauan pertumbuhan	Melakukan Pencatatan	Pasien Anak	IRJA anak	1	1	1

an (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	n dan plotting pada buku KIA setelah pengukuran berat badan dan tinggi badan anak					
Pemberian Imunisasi	Memastikan ketersediaan imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	Pasien anak dan Bayi baru lahir	IRJA anak	1	1	1
Pemberian vitamin A	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian vitamin A	Pasien anak	IRJA anak	0	0	0
Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Memberikan PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun menu yang sesuai dengan ketersediaan bahan pangan di lingkungan	Pasien anak	Rawat Inap	1	1	1
Pemberian Taburia pada Baduta	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian	Pasien anak	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0

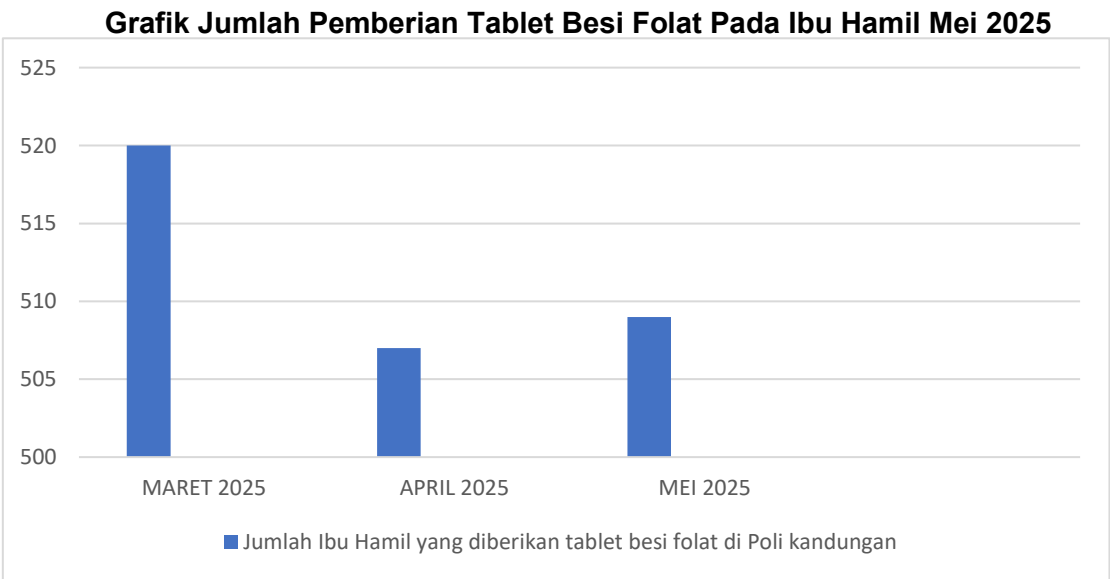
	bubuk taburia					
Pemberian Obat cacing pada ibu hamil	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian obat cacing pada ibu hamil	Ibu Hamil	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0

Analisis :
Sebagian besar intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Pemberian bubuk Taburia dan Mineral mix dilakukan pemberian kepada pasien apabila terdapat pasien rujukan dari puskesmas. Karena bubuk taburia dan mineral mix hanya terdapat di puskesmas. Sehingga jika ada pasien teridentifikasi wasting pihak RS baru mendapat distribusi dari puskesmas wilayah balita tersebut tinggal.

Rencana Tindak Lanjut :
Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit dan melakukan pemantauan kepada balita stunting.

3.1.2.4.3 Pemberian Tablet Besi Folat Bagi Ibu Hamil
Tabel Distribusi Tablet Besi Folat pada Ibu Hamil di RS Prima Husada Malang

BULAN	MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli kandungan	520	507	509



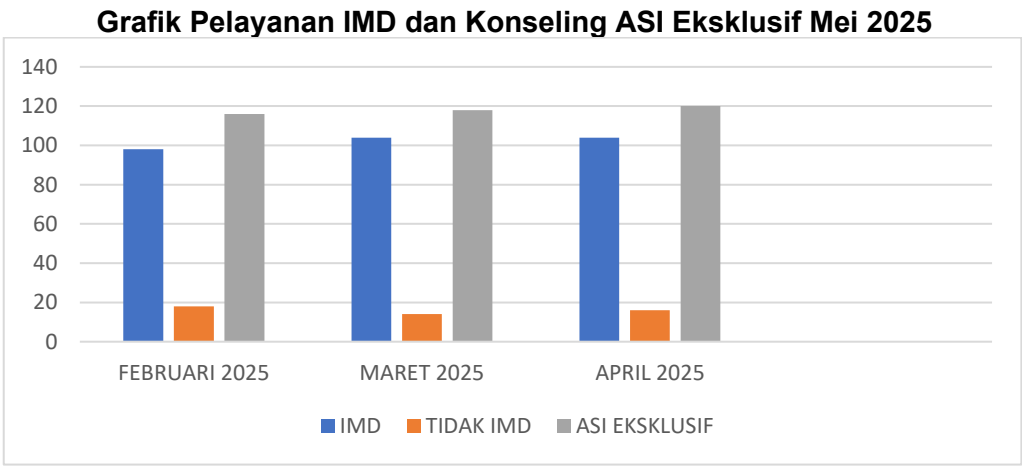
Analisis :
Pemberian asam folat diberikan kepada ibu hamil pada usia kandungan trimester pertama. Sedangkan pemberian tablet zat besi diberikan pada usia kandungan trimester 2 dan 3. Jumlah pemberian tablet besi folat naik dari sebelumnya 507 di bulan April menjadi 509 pada bulan Mei yang mendapat tablet besi folat untuk ibu hamil.

- Rencana Tindak Lanjut:**
1. Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
 2. Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

3.1.2.4.4 Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

Tabel Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MARET 2025	BULAN APRIL 2025	BULAN MEI 2025
1	IMD	104	104	84
2	Tidak IMD	14	16	12
3	Mendapat Konseling ASI Eksklusif	118	120	96



- Analisis :**
1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Mei sebanyak 84 bayi.
 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Mei 2025 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 12 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
 3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
 4. 100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Jumlah Ibu mendapat konseling ASI Eksklusif meningkat pada bulan Mei 2025 yaitu sebanyak 120 pasien.

Rencana Tindak Lanjut:
Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam

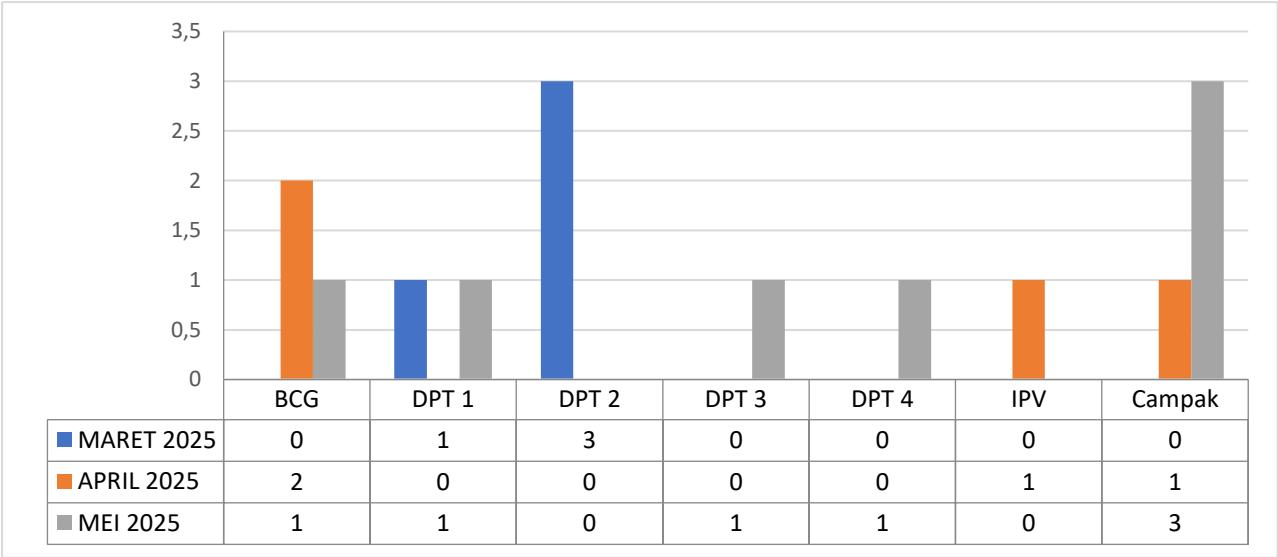
pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi.

3.1.2.4.5 Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

Tabel Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH		
		BULAN MARET 2025	BULAN APRIL 2025	BULAN MEI 2025
1	BCG	0	2	1
2	DPT 1	1	0	1
3	DPT 2	3	0	0
4	DPT 3	0	0	1
5	DPT 4	0	0	1
5	IPV	0	1	0
6	Campak	0	1	3
7	Polio Oral	4	3	3

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Mei 2025



Analisis:

- 1. Terdapat 1 balita yang melakukan imunisasi BCG di bulan Mei 2025.
- 2. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi DPT 2 dan IPV pada bulan Mei 2025.
- 3. Pada periode Mei 2025 terdapat 3 bayi yang melakukan Imunisasi Polio dan campak.
- 4. Terdapat 1 balita yang melakukan imunisasi BCG, DPT1, DPT2, DPT3, dan DPT4 di RS. Prima Husada Malang.

Rencana Tindak Lanjut :

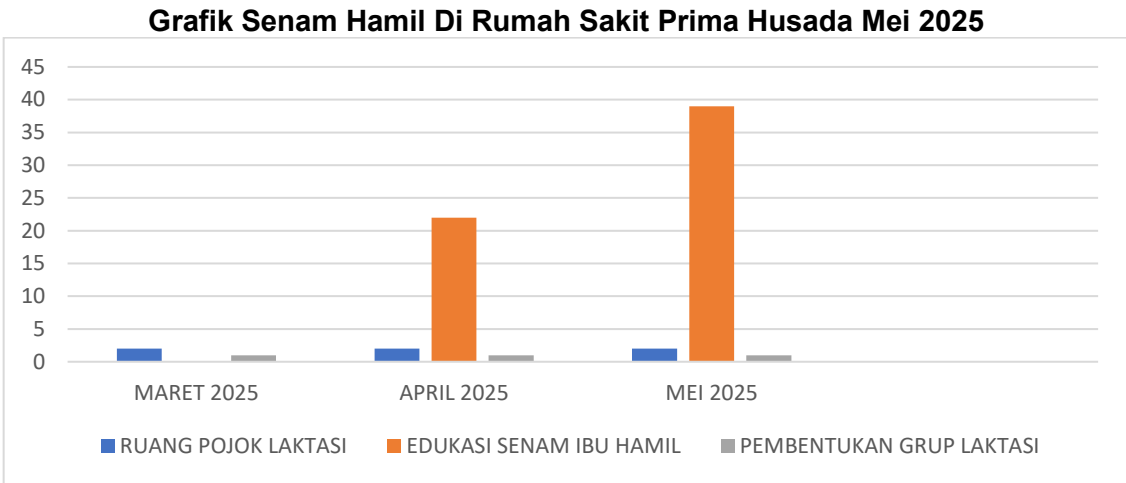
Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit. Bekerjasama dengan pihak puskesmas untuk keersediaan vaksin di RS.

3.1.2.4.6 Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi

Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

KEGIATAN PENERAPAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI	MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025
--	------------	------------	----------

Ruang Pojok Laktasi	2	2	2
Senam Hamil	0	22	39
Pembentukan Grup Laktasi	1	1	1



Analisis :

1. Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah rumah sakit prima husada malang sebanyak 2 ruangan, di lantai 1 dan di lantai 2.
2. Grup Laktasi dibentuk untuk memberikan tips menyusui.
3. Pada bulan Mei edukasi pada senam ibu hamil dilakukan dengan memberikan penyuluhan Anemia pada Ibu Hamil dan Grafik Pertumbuhan Stunting sebanyak 39 peserta senam ibu hamil.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti pampers dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.
2. Melakukan edukasi mengenai pentingnya mengikuti senam ibu hamil pada ibu hamil yang tidak memiliki kondisi penyulit saat hamil.

**3.1.2.4.7 Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting Dan Wasting
Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi**

RUJUKAN MASUK				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Asal Rujukan
Maret	-	-	-	-
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
RUJUKAN KELUAR				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Tujuan Rujukan
Maret	-	-	-	-
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-



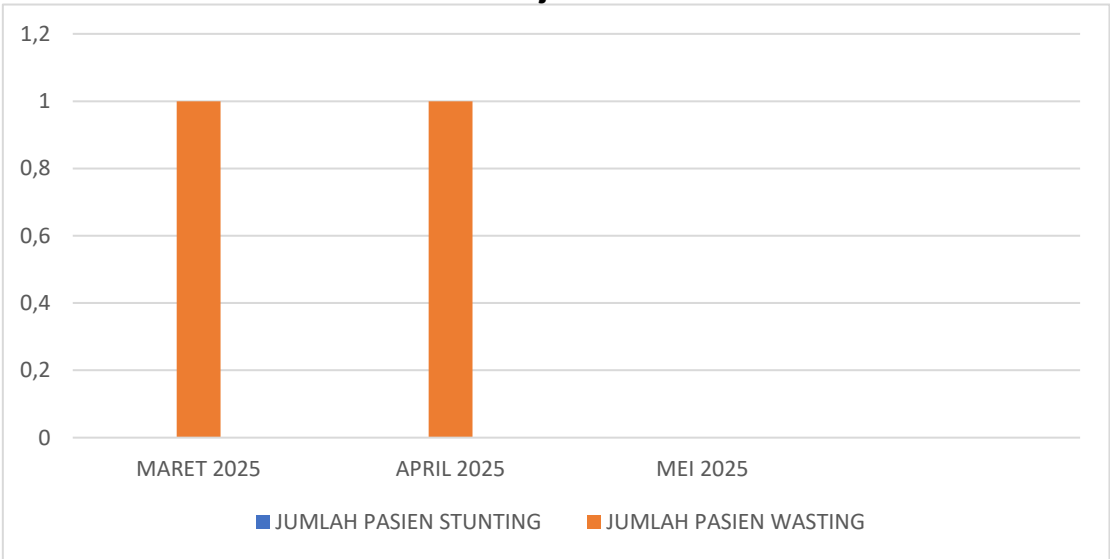
Analisis :
Tidak Terdapat pasien stunting atau wasting yang dirujuk keluar RS maupun rujuk masuk RS

Rencana Tindak Lanjut:
Perlu diadakan kerjasama lagi dengan puskesmas dan klinik faskes pertama untuk bekerjasama dalam menjaring pasien stunting dan wasting.

3.1.2.4.8 Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan
Tabel Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

BULAN	MARET 2025	APRIL 2025	MEI 2025
Jumlah Pasien Stunting	0	0	0
Jumlah Pasien Wasting	1	1	0

Grafik Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan



Analisis :
Tidak terdapat pasien *stunting wating* pada bulan Mei 2025.

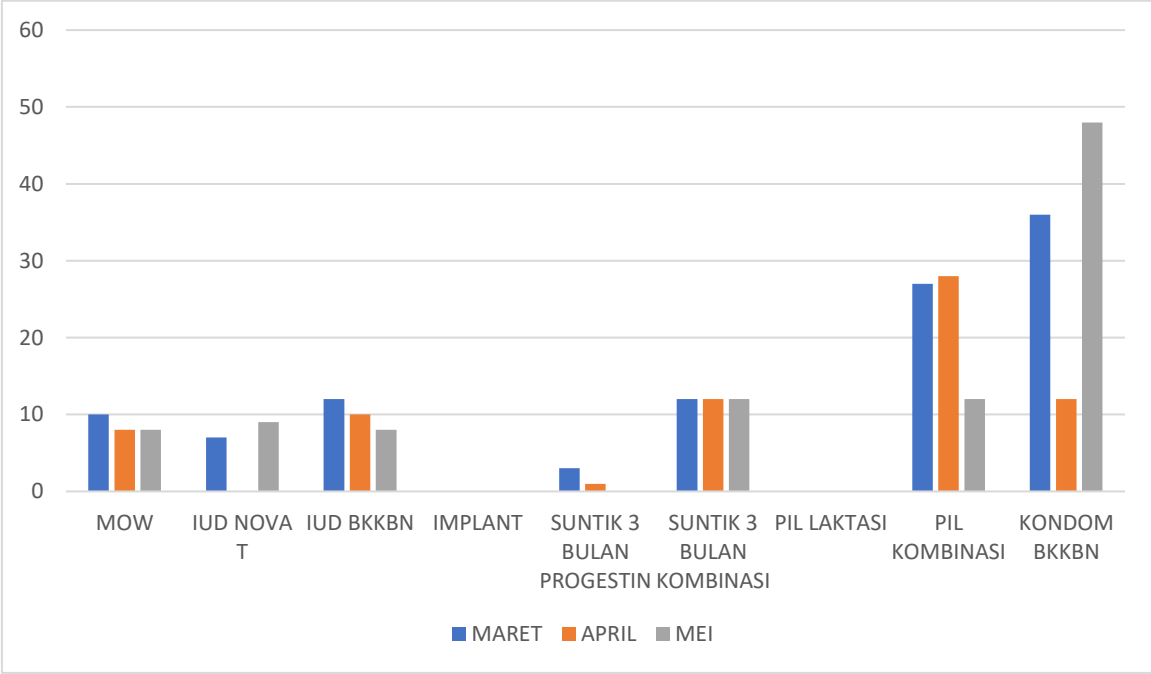
Rencana Tindak Lanjut :
Tim Stunting dan Wasting RS Prima Husada tetap melakukan pemantauan lebih lanjut kepada balita yang terdapan di RS Prima Husada Malang pada bulan Mei.

3.1.2.5 KBRs
3.1.2.6 Angka Capaian Pelayanan KB per Metode Kontrasepsi

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MARET 2025	BULAN APRIL 2025	BULAN MEI 2025
1	MOW	10	8	8

2	IUD Nova T	7	0	9
3	IUD BKKBN	12	10	8
4	IMPLANT	0	0	0
5	SUNTIK 3 BULAN KOMBINASI	3	1	0
6	SUNTIK 3 BULAN PROGESTIN	12	12	12
7	SUNTIK 1 BULAN	0	0	0
8	PIL KOMBINASI	27	28	29
9	PIL LAKTASI	0	0	0
10	KONDOM BKKBN	36	12	48

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Per Metode Kontrasepsi



Evaluasi :

1. Peserta MOW pada bulan Maret (10) April turun (8)Mei tetap(8)
2. Peserta IUD Nova T pada bulan Maret (7) April turun (0) Mei naik(9)
3. Peserta IUD BKKBN Maret (12) April turun (10) Mei (8)
4. Peserta KB suntik 3 bulan kombinasi, pada bulan Maret (3) April turun (1) Mei (0)
5. Peserta KB suntik progestin Maret tetap (12) April tetap (12) Mei tetap(12)
6. Peserta KB pil kombinasi pada bulan Maret (27) April (28) Mei naik(29)
7. Peserta KB Kondom pada bulan Maret tetap (36) April turun (12) Mei naik(48)

Analisis :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

Rencana Tindak Lanjut :

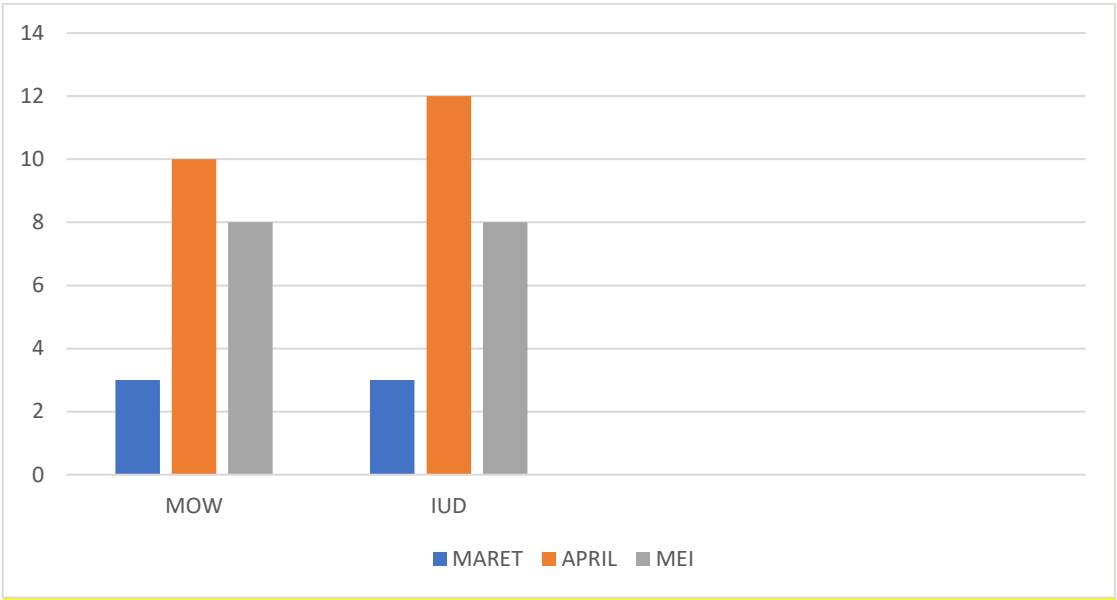
Demi meningkatkan capaian KB maka rumah sakit akan melakukan pelatihan internal bagi para

bidan dalam pemasangan IUD pasca plasenta,dan akan diadakan safari KB setiap 2 bulan sekali

Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Persalinan

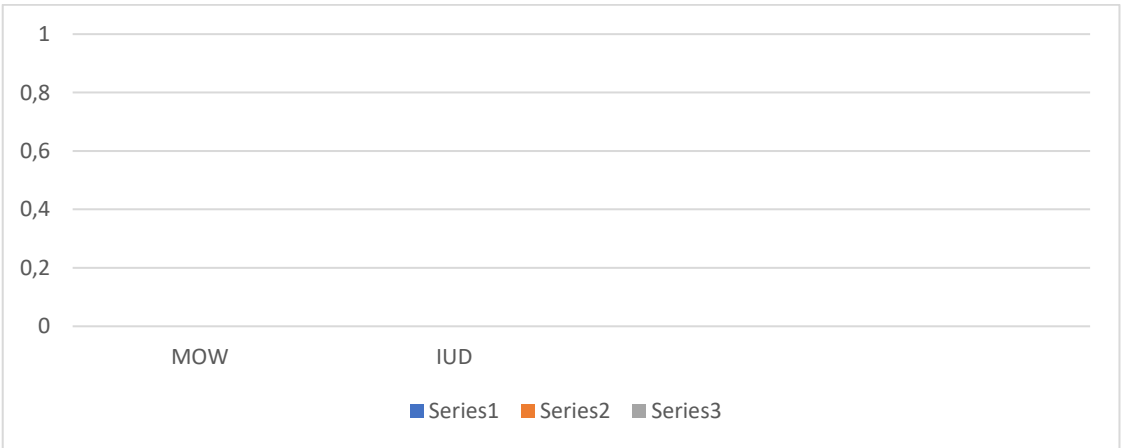
NO	JENIS PELAYANAN PASCA PERSALINAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MARET 2025	BULAN APRIL 2025	BULAN MEI 2025
1	MOW	10	8	8
2	IUD	12	11	8

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan



NO	JENIS PELAYANAN PASCA KEGUGURAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MARET 2025	BULAN APRIL 2025	BULAN MEI 2025
1	MOW	0	0	0
2	IUD	0	0	0

Grafik Angka Capaian Pelayan KB Pasca Keguguran



Evaluasi :

- 1. Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan pada bulan Maret-April-Mei menurun
- 2. Angka capaian pelayanan KB pasca keguguran pada bulan Maret-April-Mei menetap.

Analisis :

1. Peningkatan jumlah sasaran pada triwulan pertama kemungkinan didapatkan karena sasaran KB sudah mengetahui pentingnya KB dari pengetahuan yang didapatkan saat sosialisasi yang dilakukan tim setiap bulannya.
2. Capaian pelayanan KB pasca keguguran menetap dikarenakan peserta mempunyai alasan ingin segera hamil lagi.

Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.

3.2.3 Tim PPRA

3.2.3.1 Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif Triwulan III Tahun 2025

3.2.3.1.1 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Maret 2025

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	M Sueb	L/57	dr. Heri, Sp.Pd	227934	OF H-8	01/03/2025	07/03/2025	7	Levofloxacin po	2	1x0,75	5,25	0,5	10,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
2	Sanusi	L/72	dr. Andy, Sp.P	197323	Dyspnea	03/03/2025	07/03/2025	3	Azitromycin po	3	1x0,5	1	0,3	3,33
									Meropenem		2x1	6	3	2
									Levofloxacin inf		3x0,25	1,5	0,5	3
3	Anam Jumadi	L/44	dr. Aji, Sp.Pd	123986	Enchelophathy	09/03/2025	10/03/2025	2	Metronidazole inf	2	4x0,5	3,5	1,5	2,33
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
4	David Adi	L/23	dr. Zaki, Sp.B	093671	COS 345	10/03/2025	13/03/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	6	2	3
5	Friska Mey	P/27	dr. Humaira, Sp.OG	225378	Gravida SC	11/03/2025	13/03/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
6	Edis Adelia	P/16	dr. Aida, Sp.OG	228456	SC	11/03/2025	13/03/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
7	Revalino T	L/26	dr. Arianto, Sp.OT	103388	CF Patela	11/03/2025	14/03/2025	4	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
8	Muhammad Noer	L/21	dr. Farid, Sp. N	049242	Chronic intractable pain	11/03/2025	15/03/2025	5	Clindamycin	1	4x0,6	7,2	1,2	6
9	Siti Mukhayana	P/55	dr. Ard hany, Sp. Pd	222081	Vomiting ec urenia	12/03/2025	15/03/2025	4	Levofloxacin	1	1x0,5	0,5	0,5	1
10	Silviana C	P/29	dr. Humaira, Sp.OG	228119	Floating Head	14/03/2025	16/03/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
11	Yohana S	P/46	dr. Ard hany, Sp. Pd	228595	CKD stage 2	14/03/2025	16/03/2025	3	Levofloxacin inf	1	1x0,5	1,5	0,5	3
12	Irwan Rahman	L/38	dr. Anton, Sp.B	150624	Hidrocel testis	14/03/2025	16/03/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5

									Ceftriaxone		3x1	7	2	3,5
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
13	Kasnawi	L/70	dr. Ardhi, Sp.Pd	024214	DM + Hidronefrosis renal	15/03/2025	19/03/2025	5	Ceftriaxone	2	2x1	8	2	4
									Asam Pipemidat		2x0.4	1,6	0,8	2,5
14	Nisviyatul Amri	P/46	dr. Oka, Sp.OT	093688	Flexor Tenosynovitis	16/03/2025	18/03/2025	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
15	Ruminah	P/64	dr. Arianto, Sp.OT	228665	Ruptur tendon flexor	16/03/2025	18/03/2025	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
16	M Mukhlis	L/62	dr. Aji, Sp. Pd	228666	Chronic diarrhea	16/03/2025	20/03/2025	5	Ciprofloxacin po	1	2x0,5	3,5	1	3,5
17	M Firmansyah	L/25	dr. Pradana, Sp. U	045530	Strictur Uretra	18/03/2025	20/03/2025	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
18	Sudarsih	L/75	dr. Pradana, Sp. U	088276	Susp Nefroliasis	26/03/2025	29/03/2025	4	Gentamycin	1	2x0,04	0,28	0,24	1,167
19	Nurul Yaqin	L/58	dr. Anton, Sp.B	166085	Gangren anogenital	28/03/2025	30/03/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
20	Anggelina K	P/20	dr. Sigit, Sp. BP	229132	Injury of unspecified	28/03/2025	30/03/2025	3	Cefazolin	1	2x1	6	3	2

3.2.3.1.2 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan April 2025

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Nadiya F	P/27	dr.Aji, Sp.Pd	212900	TF	01/04/2025	03/04/2025	3	Azitromycin po	1	1x0,5	1,5	0,3	5
2	Titik Rustanti	P/60	dr. Zora, Sp.BP	159231	DM Hiperglikemi	03/04/2025	06/04/2025	4	Ciprofloxacin inf	2	2x0,2	0,8	0,8	1
									Ciprofloxacin po		2x0,5	2	1	2
3	Kunainah	P/44	dr. Ardhi, Sp.Pd	212694	General Weaknes + DM	05/04/2025	09/04/2025	5	Asam Pipemidate	2	2x0,4	3,2	0,8	4
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
4	Indy Belva A	P/18	dr. Sigit, Sp.BP	229437	CKR 456	06/04/2025	09/04/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
5	Sri Asnanik	P/68	dr. Yoga, Sp.JP	224631	Chest pain	07/04/2025	11/04/2025	5	Ceftriaxone	2	2x1	10	2	5
									Ciprofloxacin inf		1x0,4	1,6	0,8	2
6	Isman Hadi	L/42	dr. Zaky, Sp.B	228110	Hernia Ingunalis (S)	08/04/2025	10/04/2025	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
7	Askur	L/72	dr. Heri, Sp. Pd	229547	DM Hiperglikemi	09/04/2025	11/04/2025	3	Ceftriaxone	1	2x1	5	2	2,5
8	Moch Dja'far	L/49	dr. Elvi, Sp. P	229771	Hemaptoe	13/04/2025	15/04/2025	3	Ceftriaxone	1	2x1	3	2	1,5
9	Ninik Farida	P/53	dr. Anton, Sp.B	087303	CKR 456	13/04/2025	15/04/2025	3	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
10	Chindi M	P/30	dr. Aida, Sp.OG	075162	SC Eracs	14/04/2025	16/04/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
11	Parto	L/65	dr.Ardhany, Sp. Pd	229814	CKD st V + Pneumoni	14/04/2025	17/04/2025	4	Levofloxacin inj	1	1x0,5	1,5	0,5	3
12	Purnomo Edi	L/73	dr. Anton, Sp.B	162566	Gangren necrotic diabeticum	15/04/2025	17/04/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		3x1	4	2	2
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
13	Faizatul K	P/27	dr. Aida, Sp.OG	065799	SC	15/04/2025	18/04/2025	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
14	Hadi Mulyo	L/43	dr. Arianto, Sp.B	056807	Fracture of other parts	15/04/2025	17/04/2025	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1

									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
15	Suramah	P/64	dr.Ardhany, Sp. Pd	229894	DM Type 2	16/04/2025	20/04/2025	5	Levofloxacin inj	1	1x0,5	2,5	0,5	5
16	Sutiani	P/57	dr.Zora, Sp. Pd	178669	Gatroenteritis	17/04/2025	20/04/2025	4	Ciprofloxacin inf	1	2x0,2	1,4	0,8	1,75
17	Nofi C	P/42	dr. Zora, Sp.Pd	172291	TF	20/04/2025	24/04/2025	4	Levofloxacin po	2	1x0,5	1,5	0,5	3
									Levofloxacin inj		1x0,5	1	0,5	2
18	Anggi Annur	P/24	dr. Anton, Sp.B	230259	Necrotizing facitis coli	23/04/2025	25/04/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0.5
									Ceftriaxone		3x1	4	2	2
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
19	Moch Ridwan	L/60	dr. Yoga, Sp.JP	182365	DM krisis hiperglikemi, ALO	23/04/2025	28/04/2025	6	Levofloxacin po	2	1x0,5	2	0,5	4
									Ceftriaxone		2x1	11	2	5,5
20	Jumanah	P/71	dr. Ardhany, Sp.Pd	230369	CHF	25/04/2025	28/04/2025	4	Levofloxacin inj	1	1x0,5	1,5	0,5	3

3.2.3.1.3 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Mei 2025

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN /UMUR	DOKTER	NO. RM	DIAGNOSIS KRS	TGL MRS	TGL KRS	LOS (HARI)	ANTIBIOTIK	JUMLAH ANTIBIOTIK	DOSIS (GRAM)	TOTAL DOSIS (GRAM)	ATC	DDD
1	Rubi'ati	P/61	dr. Heri, Sp.Pd	204084	DM Type 2	04/05/2025	07/05/2025	4	Levofloxacin po	2	1x0,75	3	0,5	6
									Metronidazole inf		2x0,5	4	1,5	2,67
2	Kasiati	P/49	dr. Humaira, Sp.OG	203066	Endometriosis	06/05/2025	08/05/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
3	Ainun Ulumi	P/22	dr. Aida, Sp.OG	206805	SC	08/05/2025	10/05/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
4	Ida Rahmawati	P/27	dr. Aida, Sp.OG	071885	SC	09/05/2025	11/05/2025	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	2	2	1
5	Santoso	L/80	dr. Mira, Sp.JP	081276	Heart Failure	10/05/2025	13/05/2025	4	Asam Pipemidate	2	2x0,4	3,2	0,8	4
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2
6	Ari Anita	P/36	dr. Andi, Sp.BP	231095	Necrotizing Fascitis	12/05/2025	15/05/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Cefoperazone		2x1	4	4	1
7	Muchlis Hanafi	L/62	dr. Ardhi, Sp.Pd	186772	OF	13/05/2025	15/05/2025	3	Levofloxacin po	2	1x0,5	1	0,5	2
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
8	Elisabet G	P/27	dr. Ardhany, Sp.Pd	231152	TF	14/05/2025	18/05/2025	4	Levofloxacin po	2	1x0,5	1,5	0,5	3
									Levofloxacin inj		1x0,5	1,5	0,5	3
9	Sri Widodo	P/62	dr. Ardhany, Sp.Pd	058182	TF	15/05/2025	18/05/2025	4	Levofloxacin po	2	1x0,5	1	0,5	2
									Levofloxacin inj		1x0,5	1,5	0,5	3
10	Badriyah	P/61	dr. Anton, Sp.B	116956	Necrotizing Fascitis	16/05/2025	18/05/2025	3	Ceftriaxone	3	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	4	2	2
									Metronidazole po		3x0,25	1,5	2	7,5
11	Titus Sukriwani	L/64	dr.Ardhany, Sp. Pd	229894	DM Type 2	17/05/2025	21/05/2025	5	Levofloxacin inj	1	1x0,5	2,5	0,5	5

12	Catur Priyo	L/31	dr. Ardhi, Sp. Pd	231309	Febris	19/05/2025	22/05/2025	4	Ciprofloxacin po	1	2x0,5	3,5	1	3,5
13	Sumini	P/ 61	dr.Andy, Sp. P	143421	Hemoptysis	21/05/2025	23/05/2025	3	Azitromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
14	Adi Sumarto	L/48	dr. Oka, Sp.OT	231518	Injury of unspecified body region	21/05/2025	23/05/2025	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
15	Fikri	L/44	dr. Ardhi, Sp.Pd	231562	Cronic Fever	22/05/2025	25/05/2025	4	Ceftriaxone	2	2x1	7	2	3,5
									Levofloxacin inj		1x0,5	1,5	0,5	3
16	Siti Djumainah	P/56	dr. Zora, Sp.Pd	231203	Septic syok	22/05/2025	27/05/2025	6	Metronidazole inf	2	3x0,5	9	1,5	6
									Ceftriaxone		2x1	11	2	5,5
17	Ahmad Fikri	L/21	dr. Zaky, Sp.B	231019	Ganglion Curpi	23/05/2025	25/05/2025	3	Ceftizoxime	2	1x2	2	4	0,2
									Cefixime		2x0,1	0,4	2	3
18	Asri Ramasari	P/ 30	dr.Andy, Sp. P	201226	Atshma	24/05/2025	27/05/2025	4	Azitromycin	1	1x0,5	1,5	0,3	5
19	Siti Rochmah	P/53	dr. Andi, Sp.B	231691	Susp Appendic	25/05/2025	28/05/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	6	2	3
20	Nurhayati	P/65	dr. Zaky, Sp.B	101888	Colic Abdomen	26/05/2025	29/05/2025	4	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	6	2	3

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT

3.6.6.1 Tabel Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Mei Tahun 2025

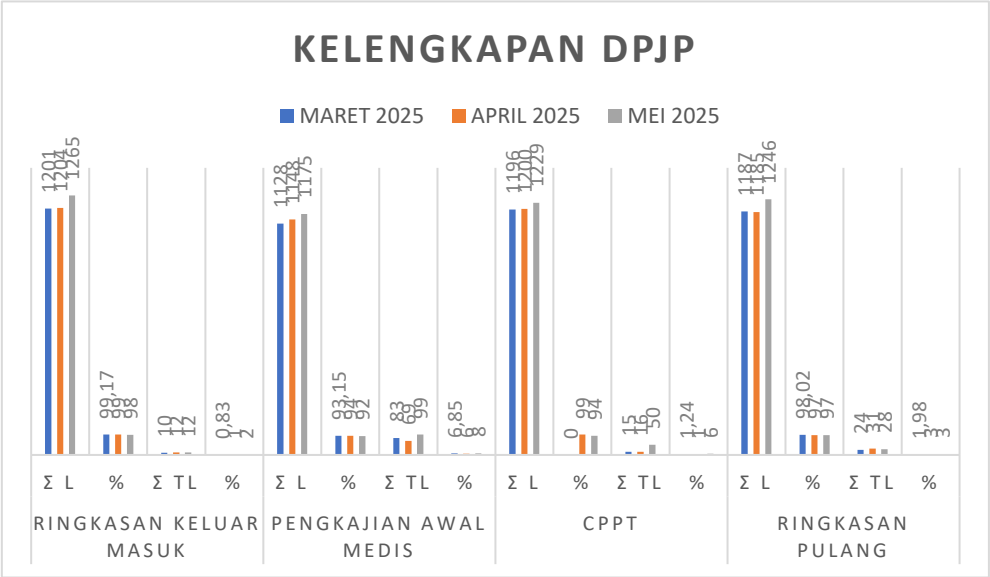
KELENGKAPAN																
DPJP																
BULAN	Ringkasan Keluar Masuk				Pengkajian Awal Medis				CPPT				Ringkasan Pulang			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	1055	98.1	20	1.9	1019	94.8	56	5.2	1026	95.4	49	4.6	1061	98.7	14	1.3
Maret	1201	99.17	10	0.83	1128	93.15	83	6.85	1196	98.76	15	1.24	1187	98.02	24	1.98
April	1204	99	12	1	1148	94	69	6	1200	99	16	1	1185	97	31	3
Mei	1265	98	12	2	1175	92	99	8	1229	94	50	6	1246	97	28	3

KELENGKAPAN																
PERAWAT																
BULAN	Pengkajian Keperawatan				CPPT				Asuhan Keperawatan				Resume Keperawatan			
	Σ L	%	Σ TL	Σ L	Σ L	Σ L	Σ L	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	1070	99.5	5	1048	1048	1048	1048	1.8	1056	98.2	1	0.1	1074	99.9	1	0.1
Maret	1200	98.68	16	1.32	1189	97.78	27	2.22	1214	99.84	2	0.16	1193	98.11	23	1.89
April	1240	99	10	1	1233	99	17	1	1242	99	8	1	1229	98	21	2
Mei	1270	99	7	1	1240	98	37	2	-	-	-	-	1267	99	10	1

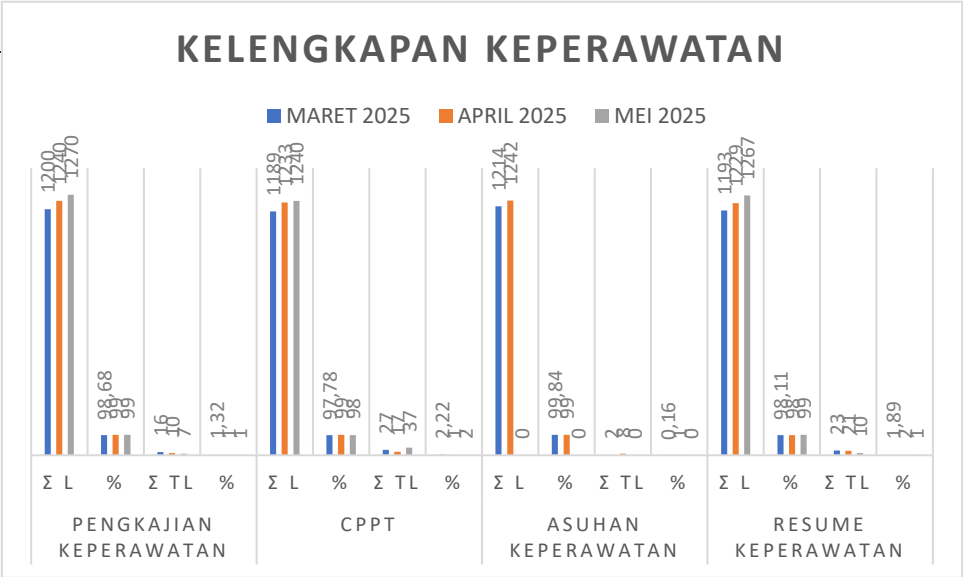
KELENGKAPAN																
BULAN	AHLI GIZI								APOTEKER							
	Pengkajian Awal Gizi				CPPT				Rekonsialisasi Obat				CPPT			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Februari	944	92	82	8	944	92	82	8	1010	98	16	2	912	89	114	11
Maret	1049	97.6	26	2.4	1074	99.9	1	0.1	1066	99.2	9	0.8	1067	99.3	8	0.7
April	1249	99.9	1	0.1	1250	100	0	0	1247	99.8	3	0.2	1250	100	0	0
Mei	753	72	266	25	1019	100	0	0	1298	100	0	0	1298	100	0	0

3.6.6.2 Grafik Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Bulan Mei 2025

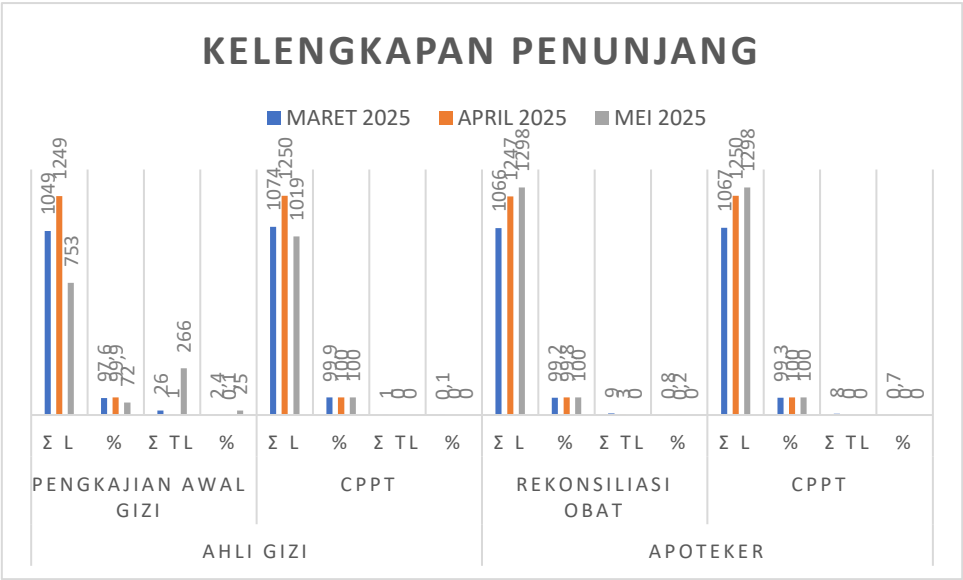
4
5



6
7



8



Analisis :

Kelengkapan DRM Ahli Gizi mengalami penurunan pada dokumen pengkajian awal medis gizi, dari 1019 DRM yang lengkap sebanyak 753.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Menginformasikan kepada KARU hasil audit ketidaklengkapan DRM untuk melengkapi kekurangannya.
2. Melakukan supervise secara berkala.
3. Trial ERM Rawat Inap, diperlukan warning jika form belum terisi lengkap sehingga tidak bisa melanjutkan ke menu berikutnya.
4. Sosialisasi saat Rapat Unit, cara pengisian DRM.
5. Membuat rapot ketidaklengkapan

8.6 Permasalahan Rumah Sakit**3.7.1 Permasalahan Instalasi Kamar Operasi (IKO)**

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Unit			
1	Awal awal ERM di iko banyak kendala terkait pengisian	P	Melakukan sosialisasi singkat penggunaan ERM Menyusun panduan pengisian ERM yang mudah di pahami Lakukan pendampingan saat awal awal ERM
		D	Pelatihan dilakukan selama 2 hari dengan focus pada fitur utama ERM Panduan pengisian dibagikan dalam bentuk file Petugas mendampingi secara terus
		S	Mengevaluasi pengisian rekam medis setelah dilakukan sosialisasi dan pendampingan untuk ERM
		A	Membuat video tutorial dalam pengisian

3.7.2 Permasalahan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Kabid/ Komite Terhadap Unit			
1	Banyaknya pemasangan infus yang kurang standart di IGD	P	Sosialisasi ulang SPO pemasangan infus kepada seluruh perawat IGD Supervisi langsung oleh kepala ruangan
		D	Sosialisasi selama 1 minggu secara berturut turut Kepala ruangan dan tim mutu melakukan supervisi harian selama 2 minggu
		S	Lakukan pendampingan pada jam sibuk Perlu membuat dokumentasi cepat
		A	Evaluasi berkala melalui audit kepatuhan pemasangan infus Menjadwalkan peserta mencari pasien untuk dilakukan penginfusan
2	Pelayanan di IGD yang masih sering ada komplain terkait komunikasi pasien	P	1.Identifikasi Masalah: Mengidentifikasi kebutuhan komunikasi pasien dan keluarga pasien di IGD 2.Pelatihan petugas:Memberikan pelatihan kepada petugas IGD tentang teknik komunikasi

			3.Pengembangan protokol komunikasi: Mengembangkan protokol komunikasi yang jelas dan standart untuk digunakan di IGD
		D	1.Implementasi pelatihan: Melakukan pelatihan kepada petugas IGD tentang teknik komunikasi yang efektif 2.Penggunaan protokol komunikasi: Menggunakan protokol komunikasi yang telah dikembangkan di IGD
		S	1.Evaluasi kualitas komunikasi: Mengevaluasi kualitas komunikasi di IGD melalui survei pasien dan keluarga pasien 2.Analisa Data: Menganalisis data yang diperoleh dari survei untuk mengetahui apakah kualitas komunikasi di IGD telah meningkat
		A	1.Mengambil tindakan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan analisa data
3	Awal awal ERM di iGD banyak kendala terkait pengisian	P	Melakukan sosialisasi singkat penggunaan ERM Menyusun panduan pengisian ERM yang mudah di pahami Lakukan pendampingan saat awal awal ERM
		D	Pelatihan dilakukan selama 2 hari dengan focus pada fitur utama ERM Panduan pengisian dibagikan dalam bentuk file Petugas mendampingi secara terus
		S	Mengevaluasi pengisian rekam medis setelah dilakukan sosialisasi dan pendampingan untuk ERM
		A	Membuat video tutorial dalam pengisian
4	Kurang patuhnya pengisian rigester di IGD terutama jam transfer pasien	P	1. Edukasi ulang tentang pentingnya jam transfer 2. Supervisi harian oleh kepala jaga untuk memeriksa rigester 3. Buat sistem pelaporan kepatuhan harian/mingguan
		D	1. Lakukan edukasi dalam 3 shif (pagi,sore,malam) 2.Kepala shift atau koordinator perawat IGD menegecek rigester setiap akhir shif 3.Membuat table monitoring mingguan untuk tracking kepatuhan pengisian
		S	1. 2 dari 5 shift masih menunjukan kelalaian, terutama saat IGD ramai 2. Petugas merasa terbantu dengan checklist dan pingingat visual
		A	1.Revisi SOP: sebelum pasien di pindahkan ,pengisian rigester wajib-verifikasi oleh kepala jaga 2.Buat sistem penanggung jawab pencatatan per shif
5	Banyaknya pengisian manual untuk rujukan dari luar	P	Membuat template goggle dok untuk rujukan dari luar Kolaborasi dengan perujuk kelengkapan pengisian form rujukan

		D	Mulai dilakukan di IGD kolaborasi dengan pendaftaran untuk rujukanya
		S	Pengisian manual di hentikan dengan adanya goggle dok hanya tinggal menarik
		A	Sosialisasi ke faskes perujuk sehingga perujuk paham Evaluasi berkala dan selalu dilakukan pengecekan berkala

3.7.3 Permasalahan Rawat Inap

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Operan keliling di unit rawat inap tidak berjalan dengan baik	P	Membuat checklist operan yang harus di bahas di unit
		D	Gunakan ceklist selama operan dan dokumentasikan secara konsisten Ambil catatan kendala atau resistensi dari staf
		S	1.Kumpulkan feedbacj dari staf 2.Lihat dokumentasi operan 3.Observasi langsung bebrapa operan untuk menilai kualitas komunikasi 4.Bandingkan data kepuasan pasien dan staf sebelum dan sesudah
		A	1.Jadikan checklist bagian dari sop operan keliling
2	Kurang pekanya petugas perawat ke pasien	P	1.Terapkan program 5 S 2. Supervisor melakukan observasi pendek harian ke pasien
		D	1.Implementasikan program 5S dan umpan balik harian selama 2 minggu 2. Supervisor mencatat observasi perilaku empatik
		S	1.Tingkat kepuasan pasien akan meningkat 2.Jumlah komplain akan menurun 3.Kedekatan pasien dan perawat akan lebih dekat
		A	1. Mengintegrasikan program empati ke dalam alur kerja, contoh mengganti infus 2. Lanjutkan observasi supervisor dan rotasi pelatihan untuk staf baru
3	Banyaknya pemasangan infus yang kurang standart di IRNA	P	Sosialisasi ulang SPO pemasangan infus kepada seluruh perawat IRNA Supervisi langsung oleh kepala ruangan
		D	Sosialisasi selama 1 minggu secara berturut turut Kepala ruangan dan tim mutu melakukan supervisi harian selama 2 minggu
		S	Lakukan pendampingan pada jam sibuk Perlu membuat dokumentasi cepat
		A	Evaluasi berkala melalui audit kepatuhan pemasangan infus Menjadwalkan peserta mencari pasien untuk dilakukan penginfusan
4	Banyaknya masalah terkait ERM terkait bug dan sistem yang belum sempurna	P	Koordinasi dengan tim programmer terkait ERM yang bermasalah
		D	Membuat group yang ada programernya sehingga jika ada masalah bug langsung bisal di tindak lanjut

		S	Respons cepat berhasil meningkatkan pengguna
		A	Sediakan bfeedback rutin ke user tentang status bug yang sudah di perbaiki

3.7.4 Permasalahan Rawat Jalan

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Pasien batal kunjungan di ERM sudah bersih tidak ada datanya tetapi di non ERM masih muncul	P	1.Identifikasi sistem non- ERM mana saja yang masih menyimpan data pasien batal. 2.Koordinasi dengan TIM programmer dan rekam medis untuk meninjau alur sinkronisasi 3.Buatkan SOP penghapusan data terintegrasi dari semua sistem
		D	1.Tim programmer menandai semua transaksi pembatalan kunjungan -dicatat dan di telusur 2.Lakukan sosialisasi kepada petugas pendaftaran untuk menggunakan “pembatalan resmi”
		S	Evaluasi 1 minggu auntuk mengetahui masalah yang ada di unit
		A	1.Membuat sistem terintegrasi agar ketika kunjungan dibatalkan di ERM,semua sistem lain ikut terintegrasi 2.Membuat penanggungjawab harian untuk validasi pasien batal
2	Kurangny sosialisasi dari pihak farmasi ke DPJP terkait kekosongan obat	P	1.Membuat sistem early warning list obat kosong/terbatas yang di update harian oleh farmasi 2.Menunjuk PIC farmasi yang bertanggungjawab menyampaikan update
		D	Farmasi membuat list obat kosong/kritis tiap pagi jam 08.00 PIC farmasi mencatat siapa saja yang sudah menerima informasi Uji coba sistem ini selama 2 minggu
		S	Jumlah resep kosong teratasi DPJP merasa lebih mudah mengantisipasi pergantian obat
		A	Terapkan sistem digital Evaluasi mingguan oleh tim farmasi
3	Kurangny service excellent dari petugas terkait keramahan petugas	P	Mengadakan pelatihan singkat terkait service excellent dan komunikasi empatik Supervisi harian diam-diam oleh kepala unit
		D	Laksanakan pelatihan di semua shift Supervisi melakukan pengamatan diam-diam terhadap minimal 3 interaksi petugas/hari
		S	Hasil evaluasi 1-2 minggu awal Ditemukan bahwa beberapa area (contoh:IGD) lebih sulit menerapkan service excellent saat over load
		A	Melanjutkan pelatihan jika evaluasi berhasil
4	Kebutuhan form lodingan di IRJA kurang	P	Identifikasi kekosongan form disebabkan karena apa Koordinasi dengan unit rekam medis untuk selalu menyiapkan form lodingan
		D	Menghubungi karu rekam medis terkait kekosongan form form lodingan

		S	Kendala terkait kekosongan form lodingan ini perlu lapor rekam medis
		A	Evaluasi untuk kekosongan form lodingan

3.7.5 Permasalahan Instalasi Farmasi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Retur barang dari rawat inap : 3) Obat tak bertuan → gudang retur (secara sistem), namun fisiknya dikembalikan ke rak barang retur di depo farmasi → setelah diretur ke gudang, kains akan order obat dengan jumlah sesuai yang ada di gudang retur agar dapat dimasukkan kembali menjadi stok depo. 4) Obat bertuan → depo farmasi melalui fitur Retur Penjualan. Retur barang dari rawat jalan → Depo Farmasi melalui fitur Retur Penjualan .	P	Pelaksanaan retur obat tidak bertuan dan obat bertuan berjalan rutin.
		D	Sosialisasi alur retur obat untuk meminimalkan selisih stok.
		S	Tidak perlu ada gudang retur karena menambah rantai proses retur yang tidak diperlukan. Untuk efisiensi, seluruh obat dari unit baik bertuan atau tidak harus dikembalikan melalui depo farmasi.
		A	1. Obat bertuan dikembalikan melalui fitur Retur Penjualan. 2. Obat tidak bertuan dikembalikan melalui fitur sesuai dengan kondisinya yaitu : 5) Penerimaan Barang Konsinyasi 6) Penerimaan Obat yang Dibeli Antar RS 7) Penerimaan Obat Tidak Bertuan 3. Fitur penerimaan farmasi lainnya dibuat berjenjang : diajukan oleh Kains Farmasi (dengan adanya fitur keterangan untuk menjelaskan alasan penerimaan obat lainnya) → diapprove oleh PT → baru bisa menambah ke stok depo. Berita Acara tetap dilampirkan sebagai arsip RS. 4. Buat PJ retur tiap shift di depo yang bertanggung jawab terhadap proses retur mulai dari penerimaan barang fisik, penginputan ke sistem, penilaian obat layak/tidak, pengembalian obat retur di rak obat depo.
2.	Perubahan alur iter resep BPJS Kesehatan karena adanya fitur surat kontrol di SIMRS	P	Sosialisasi dan pemahaman petugas terkait SPO Alur Iter Resep BPJS Kesehatan
		D	Sosialisasi SPO
		S	Kitir iter yang ditulis manual menimbulkan kesalahan resep tidak di centang iter oleh DPJP karena kurangnya double check antara perawat dan farmasi.
		A	Perubahan di Poli : 1. DPJP input e-resep ITER 1x atau 2x di Billing SIMRS sesuai dengan kondisi pasien 2. Input rencana lanjutan pasien dan pilih menu iterasi obat. 3. Poli input sesuai advice DPJP. 4. Cetak Surat Iterasi Obat (Kitir manual iter dihilangkan). Perubahan di Farmasi : 1. Menerima Surat Iterasi Obat dan KPO dari pasien.

			2. Menyerahkan Copy Resep-KPO yang dijepret jadi satu kepada pasien untuk kunjungan selanjutnya. Perubahan di CSO : 1. Beri paraf dan nama pada Surat Iterasi Obat
3.	Penertiban pasien yang mengambil obat diluar jam pelayanan rawat jalan	P	Sosialisasi dan pemahaman petugas agar tidak menolak pasien yang mengambil obat tertinggal di hari Sabtu dan Minggu di atas pukul 14.00 WIB.
		D	Sosialisasi ke Apoteker dan TTK
		S	Komplain pasien terkait penolakan dari farmasi untuk ambil obat tertinggal di hari sabtu dan minggu di atas pukul 14.00 WIB.
		A	Jika ada pasien yang sudah datang ke RS untuk mengambil obat tertinggal rawat jalan tetap dilayani walau diluar jam pelayanan rawat jalan, dan tetap di kie berulang untuk waktu pengambilan obat.
4.	Perubahan alur permintaan SPB (Surat Permintaan Barang) ke gudang farmasi menjadi 3 kali dalam seminggu.	P	Permintaan SPB (Surat Permintaan Barang) ke gudang farmasi menjadi 3 kali dalam seminggu
		D	Koordinasi dengan petugas Gudang farmasi
		S	Semua komposisi Gudang hari minggu setelah SO diliburkan karena telah melakukan kegiatan input SO malam. Evaluasi kegiatan serah terima setelah stok opname jika sertim selasa, kamis sabtu, minggu habis so tidak ada sertim. Barang yang diserahkan terimakan tidak terlalu banyak.
		A	1. Perubahan alur input SPB pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Hari serah terima barang tiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. 2. Gudang tetap libur semua di hari minggu, senin dilakukan SPB untuk tambahan permintaan untuk setelah SO. 3. Komposisi jaga Gudang farmasi pada hari serah terima tidak ada yang libur agar waktu sertim tidak mundur sampai pukul 13.00 WIB.
5.	Alur permintaan Breathing Circuit Bubble Cpap; Breating Circuit Double Heated Wire Neonatal; Breathing Circuit Ventilator Adult; Breathing Circuit Ventilator Child untuk pasien umum diinput BMHP ke gudang farmasi.	P	Perubahan alur permintaan bmhp breathing CPAP dan bmhp breathing ventilator untuk pasien umum
	Hal ini menyebabkan sering selisih stok dikarenakan perawat tidak ada stok breathing di ruangan. Jika ada permintaan pada malam hari dan gudang tutup jadi perawat ambil barangnya ke depo dan utang barang ke depo namun operan farmasi tidak jalan sehingga lupa tidak follow up ke perawat.	D	Melakukan koordinasi dengan Kabid Penunjang Medis, Kabid Keperawatan, dan Karu
		S	Breathing Circuit Bubble Cpap; Breating Circuit Double Heated Wire Neonatal; Breathing Circuit Ventilator Adult; Breathing Circuit Ventilator Child tarif BMHP sudah termasuk jasa tindakan CPAP dan Ventilator.
		A	Perubahan alur permintaan Breathing Circuit Bubble Cpap; Breating Circuit Double Heated Wire Neonatal; Breathing Circuit Ventilator Adult; Breathing Circuit Ventilator Child khusus penjamin UMUM : 1. Perawat input Breathing Circuit CPAP atau Breathing Ventilator pada fitur

			resep "Tambah Paket" di billing perawat artinya input resep tanpa tarif. 2. Farmasi cek resep sudah tercentang obat paket dan simpan resep. Tujuan : tidak ada tambahan tarif. 3. Perawat ambil barang ke depo farmasi 4. Permintaan BMHP ke Gudang Farmasi khusus Breathing Circuit Bubble Cpap; Breating Circuit Double Heated Wire Neonatal; Breathing Circuit Ventilator Adult; Breathing Circuit Ventilator Child ditiadakan.
6.	Alur paket kuret ODC di Rawat Jalan yang semula diinput perawat rawat jalan namun salah input resep di Tambah Paket sehingga tarif tidak muncul di keuangan.	P D S A	Evaluasi alur pereseapan paket kuret ODC Rawat Jalan. Melakukan koordinasi dengan Kabid Pelayanan Medis dan Verifikator. Resep paket kuret ODC rawat jalan tarif harus muncul di keuangan untuk di klaim. Alur pereseapan paket kuret ODC RJ disepakati diinput oleh bidan maternitas. Alurnya: 1. Apabila pasien berkunjung ke poli → advice tindakan kuret → paket di ambil oleh maternitas → bidan input resep paket kuret sesuai yg terpakai. 2. Apabila pasien dijadwalkan kuret → pasien ke igd → paket diambil bidan ponek igd → bidan input resep paket kuret sesuai yg terpakai. 3. Farmasi mengambil paket kuret dan menyiapkan tambahan sesuai list. 4. Farmasi cek inputan resep sesuai yg terpakai dan cek resep tanpa centang obat paket (agar tagihan tetap masuk dikeuangan).
7.	Hasil stok opname farmasi yang sudah stabil pada akhir tahun 2024 dan belum mencapai target selisih 0.	P D S A	Pertanggungjawaban Selisih Hasil Stok Opname Berdasarkan Surat Edaran dari RS Nomor 218/I-SE/DIR/III/2025 tentang Pertanggungjawaban Selisih Hasil Stok Opname Farmasi disampaikan beberapa kebijakan Evaluasi hasil stok opname belum mencapai target 0 1. Penyesuaian / Adjustment stock (akibat dari adanya selisih hasil stock opname) dengan acuan selisih wajar sebesar 1% dari total persediaan TIDAK LAGI DIBERLAKUKAN per 1 Januari 2025. 2. Acuan selisih hasil SO sesuai dengan BA (Berita Acara) hasil SO. 3. Selisih Kurang (jumlah fisik barang yang ditemukan saat SO < jumlah yang tercatat dalam sistem) dilakukan analisis selisih terlebih dahulu dan menentukan unit yang terlibat kemudian hitung beban 60% kepada Manajemen Rumah Sakit (Direktur Rumah Sakit, Kabid Penunjang, Kabid Pelayanan Medis, Kabid Keperawatan, Kabid Umum & keuangan, Kains. Farmasi).

			Penanggung jawab rak dan unit terlibat sebesar 40% dari jumlah selisih SO. Pembebanan langsung pada periode berjalan. 4. Selisih Lebih (jumlah fisik barang yang ditemukan saat SO > jumlah yang tercatat dalam sistem) dilakukan analisis selisih terlebih dahulu, jika selisih lebih masih dalam selisih wajar tidak dibebankan, jika terdapat selisih lebih yang mengalami peningkatan ekstrim, maka diberlakukan pembebanan selisih lebih hasil SO berupa teguran tertulis dari direktur rumah sakit kepada unit penyebab selisih SO dan penanggung jawab rak. 5. Hasil dari perhitungan selisih akan disesuaikan dalam penggajian setiap bulan
8.	Terdapat selisih stok opname yang fluktuatif. Februari 2025 : +5.439.289 Maret 2025 : +1.009.675 April 2025 : + 5.327.247 Belum berjalan scan barcode menunggu antrian Programmer PT	P Perencanaan scan barcode. D S A	1. Mengajukan proposal scan barcode dan mengajukan kebutuhan alat yang menunjang pelayanan. 2. Melakukan presentasi perencanaan scan barcode beserta tujuan dan manfaatnya. Scan barcode dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan akurasi data, pengendalian stok yang lebih baik, kepatuhan terhadap regulasi, pengurangan biaya operasional, tindak lanjut yang lebih efisien, integrasi sistem yang lebih baik, peningkatan pelayanan pasien. Pengajuan software aplikasi barcode ke progamer dan pengajuan alat scanner barcode, barcode printer, thermal paper ke Pengadaan Umum PT. DPM.
9.	Penulisan Kartu Pengambilan Obat (KPO) yang masih manual dan membuat waktu obat jadi lama. Prosentase waktu tunggu obat non racikan 75.13% dan waktu tunggu obat racikan 60.78%	P D S A	Menggunakan KPO digital dalam pelayanan resep. Koordinasi dengan Programmer untuk membuat fitur KPO digital di SIMRS yang bisa diakses oleh DPJP dan Apoteker. Penulisan KPO masih manual sehingga memakan waktu dan penulisan yang tidak baku dan tidak terbaca. Komplain pasien akibat pasien tidak membawa KPO. 1. Follow up ke Programmer. 2. Mendata KPO tertinggal sebagai bukti kuat bahwa KPO manual resiko hilang. 3. KPO tertinggal ada 126 KPO.
10.	Obat tertinggal 2x24 jam	P D S	Perbaikan kebijakan obat tertinggal. Membuat rekapan pasien yang sudah mendapat pengantaran gratis. 1. Obat tertinggal bulan April sudah mengalami penurunan namun masih ditemukan pasien mengambil obat lebih 2x24 jam. 2. Primantara sudah menghubungi pasien agar obat tertinggal dikirim oleh primantara namun banyak

			pasien menolak karna obat diambil sendiri ke farmasi.
		A	1. Pasien yang obatnya tertinggal dimintai data agar mudah diidentifikasi. 2. Pengantaran gratis membantu farmasi agar tidak terjadi penumpukan obat tertinggal, terkadang pasien memang ada yang tidak mau tapi tetap di edukasi untuk obat diantar.
11.	Penambahan daftar obat near ED	P	Mempercepat pengeluaran barang near ED.
		D	Membuat surat edaran untuk DPJP supaya membantu mengeluarkan barang near ED dari Depo Farmasi maupun Gudang Farmasi.
		S	Obat near ED yang tidak segera dikeluarkan akan mejadi deathmoving dan menyebabkan kerugian terhadap rumah sakit.
		A	1. Kolaborasi dengan Komite Medik untuk membantu pengeluaran barang near ED. 2. Melakukan negoisasi dengan DPJP untuk menggunakan barang near ED sesuai dengan kebutuhan. 3. Kolaborasi dengan Pengadaan PT untuk melakukan retur obat near ED kepada distributor.
12.	Tempat penyimpanan vaksin tidak sesuai dengan standar, ditemukan indikator vaksin pemerintah yang berubah warna sehingga tidak layak digunakan.	P	Mengadakan VR di Depo Farmasi sesuai dengan standar penyimpanan vaksin.
		D	Memperbaiki VR yang ada supaya bisa digunakan kembali. Menedukasi perawat dan petugas farmasi terkait penyimpanan yang benar.
		S	Vaksin yang tidak layak diberikan kepada pasien bisa dikembalikan ke Puskesmas Wilayah, tetapi RS harus memikirkan bagaimana vaksin tidak sampai diretur.
		A	1. Vaksin pemerintah disimpan di VR Gudang Farmasi. 2. Perubahan alur pengambilan vaksin oleh perawat poli.
13.	Fitur retur barang rusak tidak bisa mengeluarkan stok di monitoring stok.	P	Perbaikan fitur retur barang rusak.
		D	Koordinasi dengan Programmer PT.
		S	1. Barang expired date perlu dikeluarkan stoknya dari SIMRS menggunakan fitur retur barang rusak kemudian dilalukan pemusnahan obat namun fitur tersebut tidak dapat mengeluarkan stok dari sistem. 2. Sudah dilakukan receive retur namun stok masih muncul di monitoring stok, tapi di pengeluaran barang dan mutasi barang sudah 0.
		A	Follow up progamer.
14.	Floorstok IKO	P	Mendisiplinkan perawat untuk menjalankan SPO.
		D	Koordinasi dengan Kabid Keperawatan.

		S	Kendala di FS IKO dimana perawat anestesi belum menjalankan inputan resep terlebih dahulu kemudian disiapkan oleh farmasi dikarenakan tidak menyanggupi jika operasi berlangsung berturut-turut. Dan informasi SPO sudah diedarkan dan dijelaskan namun perawat belum menjalankan sesuai SPO.
		A	Monitoring dan evaluasi.
15.	Ditemukan resep IU (Ketidaksesuaian surat kontrol poli dengan jadwal ambil obat apotek online BPJS Kesehatan 30 hari). Februari 2025 = 31 resep Maret 2025 = 116 resep April 2025 = 47 resep	P	Koordinasi dengan Karu poli dan Kabid Keperawatan
		D	1. Sosialisasi fitur edit no apol. Koordinasi dengan Karu poli dan Kabid Keperawatan untuk edukasi ke perawat perhitungan obat 30 hari agar surat kontrol sesuai.
		S	1. Perawat salah perhitungan obat 30 hari sehingga surat kontrol tidak sesuai 30 hari. 2. Farmasi banyak pendingan resep di SIMRS karena belum bisa input no apol. 3. Farmasi utang input obat di apol. 4. Jika sudah waktunya input apol farmasi telpon verifikator bahwa resep sudah dikerjakan.
		A	1. Alur fitur "Edit No APOL" : a. Input resep IU di apol b. Copy no apol c. Klik kanan sesuai resep yang telah dikerjakan di apol d. Klik "Edit No APOL" e. Paste no apol f. Klik OK 2. Alur perubahan surat kontrol ; a. Farmasi menemukan IU di apol b. Konfirmasi ke grup whatsapp c. Surat Kontrol jika merubah surat kontrol pakai HP IFRS dengan format : Form Order Perubahan Tanggal Kontrol Nama pasien : No. RM : DPJP : Tanggal perubahan : Alasan perubahan : IU/TK tanggal berapa d. Pendaftaran mengubah di V-Claim e. Apoteker KIE pasien menuju CSO untuk mengambil surat kontrol, jika obat di primantara maka farmasi mencetak surat kontrol dan di steples ke obatnya. f. Pasien mengambil obat ke farmasi jika sudah ke CSO.

3.7.6 Permasalahan Laboratorium

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	LIS belum berjalan karena menunggu bridging SIMRS	P	Membuat target pelaksanaan LIS di Labortorium RSPH Malang.
		D	Mengingatkan programmer untuk segera menyelesaikan bridging.
		S	LIS belum bisa diaplikasikan dikarenakan belum bridging dengan SIMRS.
		A	Follow up berkala ke Programmer.
2.	Petugas belum kompeten dalam pelaksanaan crossmatch labu darah	P	Mendaftarkan pelatihan/magang secara bergilir.
		D	1) Melakukan pendampingan terhadap petugas yang melakukan crossmatch. 2) Melakukan pelatihan dengan vendor.
		S	Hasil crossmatch menentukan apakah labu darah bisa diberika kepada pasien atau tidak, jika hasil aglutinasi positif maka tidak bisa diberikan.
		A	1) Melakukan pencatatan pengulangan kegiatan crossmatch. 2) Permintaan labu darah cito ketika malam hari sementara permintaan ke PMI Lawang terlebih dulu. 3) Petugas magang secara bergilir setiap 2 minggu sekali.
3.	Tidak ada fitur nilai normal pada Billing SIMRS sehingga petugas melakukan klik manual.	P	Mengajukan fitur pengisian nilai normal kepada Programmer PT.
		D	Membuat surat pengajuan fitur batas atas dan batas bawah nilai normal untuk dilakukan pengisian oleh petugas laboratorium.
		S	Dengan adanya batas atas dan batas bawah yang ditentukan, system akan membaca hasil laboratorium setiap pasien apakah berada pada nilai normal atau tidak.
		A	Follow up ke Programmer PT.
4.	Reagen kadaluarsa dan datang terlambat.	P	Memperbaiki pengadaan reagen di Laboratorium.
		D	Melakukan analisa keterlambatan. Koordinasi dengan Kabid Pelayanan..
		S	Terdapat reagen yang kosong nasional seperti CKMB, DPJP memutuskan untuk menggunakan pemeriksaan Troponin.
		A	1. Melakukan perbaikan penataan FIFO FEFO pada kulkas Laboratorium. 2. Menjalankan kartu stok dan perencanaan SO. 3. Menentukan stok minimal untuk order reagen.
5.	Pengadaan rectal swab di Lab RS Prima Husada Malang	P	Mengajukan TOR pelayanan rectal swab.
		D	Diskusi dengan Kains Laboratorium RS, dr Ari Putri, Sp.PA
		S	Utilitas jarang tidak direkomendasikan, kecuali jika bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk MCU.
		A	Proses perhitungan unit cost, jika sudah maka akan diajukan TOR.

3.7.7 Permasalahan Rekam Medis

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Layanan Poli yang belum masuk kedalam E-RM -Poli KIA -Poli Gizi	P	Melakukan permintaan fitur kepada Programmer PT.
		D	Membuat flow chart alur pelayanan pada Poli KIA dan Poli Gizi untuk diterapkan pada E-RM.
		S	Kekurangan jika kunjungan Poli KIA dan Poli Gizi dilakukan pencatatan secara manual maka hasil konseling tidak terekap dengan baik dan tidak bisa diakses oleh DPJP, sehingga tidak bisa dilakukan tindakan lanjutan yang terintegrasi. Pencatatan manual resiko hilangnya sangat tinggi.
		A	Follow up ke Programmer PT. Hasil konseling disampaikan kepada asisten setiap DPJP.
2.	Kebijakan baru dari BPJS Kesehatan tentang Kunjungan Kontrol Poli Rawat Jalan	P	Menjalankan kebijakan baru dengan meminimalisir complain.
		D	Melakukan pemberitahuan melalui social media sebelum kebijakan dijalankan. Kolaborasi dengan Programmer PT untuk menambahkan fitur surat control fisioterapi.
		S	Perawat fisioterapi masih belum bisa menginput surat kontrol pasien bpjs yg berasal dari surat rujukan utama, sehingga masih pasien masih diarahkan ke pendaftaran untuk mencetak surat kontrol
		A	1. Menertibkan pasien control sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 2. Follow up ke Programmer PT.
3.	Pendaftaran masih mendaftarkan pasien pada waktu jam praktik dokter sudah selesai.	P	Membuat kebijakan terkait pendaftaran pasien.
		D	Mendisplinkan petugas menjalankan SPO.
		S	Dokter spesialis Gigi Anak drg. Ajeng, Sp.KGA komplain karena ada 1 pasien yang didaftar oleh pendaftaran pada waktu jam prakteknya sudah selesai.
		A	1. Menutup pendaftaran poli spesialis di H-10menit sebelum jam praktik selesai. 2. Konfirmasi DPJP jika ada tambahan pasien yang mendekati jam praktik selesai.
4.	ERM Rawat Inap belum terlaksana, ERM rawat jalan masih ditemukan kendala.	P	Merealisasikan pelaksanaan ERM rawat Inap dan rawat Jalan pada tahun 2025.
		D	Kolaborasi dengan Programmer PT.
		S	ERM Rawat jalan sudah terlaksana, tetapi masih banyak ketidaklengkapan dalam penginputan ERM.
		A	1. Follow up terus menerus ke programmer dengan cara screenshot permasalahan dan dikirimkan via whatsapp guna menindaklanjuti permasalahan tersebut agar proses validasi ERM

			berjalan lancar. 2. Trial ERM Rawat Inap Bulan Maret 2025.
5.	Pasien BPJS TK dari IGD tidak diberikan pengantar rujukan ke Poli Spesialis.	P	Perbaikan alur rujukan pasien.
		D	Mendisplinkan petugas menjalankan SPO.
		S	Ada 1 pasien dari IGD yg tidak diberikan pengantar rujukan untuk ke poli spesialis bedah plastik dan tidak diarahkan ke pendaftaran untuk informasi jadwal praktek dokter tersebut. Pasien ke pendaftaran pada hari H tidak membawa surat rujukan dan datang pada hari yang tidak ada jadwal dokter tersebut.
		A	Mengingatkan ke KARU IGD terkait alur pasien BPJS TK dan selalu mengarahkan pasien ke pendaftaran untuk informasi jadwal dokter apabila pasien ada kontrol Lanjutan.
6.	Ketidak lengkapan pengisian form rekam medis oleh PPA.	P	Perubahan alur analisa rekam medis.
		D	Mendisplinkan petugas menjalankan SPO.
		S	Ketidaklengkapan pengisian dokumen rekam medis oleh semua PPA.
		A	Sosialisasi ke semua PPA tentang ketepatan dan kelengkapan pengisian dokumen rekam medis sehingga tidak ada lagi DRM yang tidak lengkap.
7.	Surat Rujukan penuh masih manual belum SIMRS	P	Pengajuan fitur Rujuk Penuh di SIMRS ke programmer
		D	Karu koordinasi dengan programmer
		S	Surat rujukan penuh tidak lagi manual tetapi bisa langsung terhubung ke VCLAIM sehingga bisa mengurangi waktu tunggu di pendaftaran
		A	1. Follow up ke programmer 2. Monitoring dan evaluasi SIMRS
8.	Perubahan surat kontrol pasien tidak sesuai tanggal IU	P	Mengadakan rapat untuk alur perubahan surat kontrol
		D	Koordinasi dengan Karu IFSRS dan Karu Poli
		S	Untuk perawat poli lebih teliti kembali bila akan menginputkan surat kontrol pasien
		A	Bila terjadi perubahan surat kontrol maka farmasi menarik surat kontrol yang di bawa pasien untuk selanjutnya dan mengarahkan pasien ke CSO untuk ubah dan cetak surat kontrol terbaru

3.7.8 Permasalahan CSSD

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Kebutuhan mesin steam plasma belum terpenuhi.	P	Mengajukan kebutuhan mesin ke PT.
		D	Koordinasi dengan Vendor dan DPJP terkait kebutuhan mesin steam plasma.
		S	Instrument bedah saraf memerlukan

			perlakuan khusus terkait cara dekontaminasi dan sterilisasinya.
		A	1) Membuat telaah terkait mesin yang saat ini digunakan dan yang dianjurkan. 2) Koordinasi dengan DPJP (dr Fachri, Sp.BS) bahwa sterilisasi alat bedah saraf menggunakan autoclave dengan cara alat dikemas satu persatu.

3.7.9 Permasalahan Laundry

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Hasil pencucian membuat kain terkena bercak putih.	P	Memperbaiki alur pencucian.
		D	Menerapkan alur baru.
		S	Monitoring dan evaluasi alur baru, mencari penyebab kerusakan.
		A	1. Melakukan pemilahan baju dan linen dari unit menggunakan handscoon baru (tidak terkena zak kimia). 2. Melakukan pemisahan pencucian antara linen dan baju IKO.
2.	Pencatatan jumlah linen tidak valid.	P	Memperbaiki pencatatan menggunakan digital.
		D	Pencatatan jumlah linen menggunakan google spreadsheet.
		S	Pencatatan manual beresiko angka tidak terbaca dengan baik sehingga jumlah linen tidak valid.
		A	Pencatatan digital akan dimulai pada awal Bulan Januari 2025, sebelumnya akan dilakukan SO. Rencana dilakukan stok opname setiap bulan. Pencatatan real per lantai.

3.7.10 Permasalahan Radiologi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Respon Time Pelayanan Radiologi	P	Memperbaiki respon time pelayanan radiologi.
		D	Kolaborasi antara perawat dan radiographer dengan DS Radiologi.
		S	Pencatatan dapat diketahui respon time pelayanan radiologi dari selesai periksa sampai dengan selesai hasil.
		A	Melakukan pencatatan waktu permintaan dan selesai hasil di Google Spreadsheet.
2.	Menerima permintaan pemeriksaan pasien IGD tanpa ada inputan di SIMRS.	P	Perbaikan alur pelayanan pemeriksaan radiologi dari unit.
		D	Mendisiplinkan petugas menjalankan sesuai SPO.
		S	Petugas IGD sering kali meminta pemeriksaan sebelum dilakukan input untuk menegakan diagnosis. Perawat juga menghapus inputan tanpa konfirmasi petugas radiologi setelah selesai pemeriksaan dan hasil sudah dicetak.
		A	Pemeriksaan dilakukan jika sudah ada inputan di SIMRS. Pemeriksaan yang dihapus tanpa konfirmasi maka menjadi beban petugas

			yang menghapus.
3.	Pemeriksaan Cito Bed tidak sesuai dengan kriteria	P	1. Mengidentifikasi kriteria pemeriksaan cito bed yang sesuai. 2. Melakukan analisis akar masalah untuk mengetahui penyebab pemeriksaan cito bed tidak sesuai dengan kriteria. 3. Mengembangkan rencana untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan cito bed.
		D	1. Mengadakan pelatihan untuk tim medis dan tim keperawatan tentang kriteria pemeriksaan cito bed yang sesuai. 2. Mengembangkan checklist untuk memastikan pemeriksaan cito bed sesuai dengan kriteria. 3. Mengimplementasikan sistem pelaporan untuk memantau kualitas pemeriksaan cito bed.
		S	1. Peningkatan kualitas pemeriksaan cito bed sesuai dengan kriteria. 2. Identifikasi masalah yang masih ada dan perlu diperbaiki.
		A	1. Menyusun SPO pemeriksaan cito bed berdasarkan kriteria. 2. Mengimplementasikan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan cito bed. 3. Mengembangkan rencana untuk memantau dan mempertahankan kualitas pemeriksaan cito bed. 4. Mengadakan evaluasi berkala untuk memastikan kualitas pemeriksaan cito bed tetap sesuai dengan kriteria.

3.7.11 Permasalahan Instalasi Gizi dan Dapur

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1.	Pendistribusian alat makan tidak tercatat dengan baik	P	Memperbaiki alur pengecekan fasilitas RS sebelum pasien KRS.
		D	Kolaborasi Ahli Gizi dengan Pendaftaran IGD, Perawat, CS Pantry, CS Ruang dan Kasir.
		S	Fasilitas RS resiko hilang karena pasien jika tidak dibuatkan alur yang jelas. Petugas wajib memberikan edukasi untuk meminimalisir kehilangan/kerusakan.
		A	Membuat SPO "Pengecekan Fasilitas RS Sebelum Pasien KRS". Sosialisasi kepada Unit Terkait
2.	Selisih antara jumlah barang pada kartu stok dan jumlah fisik bahan makanan	P	Pendisiplinan pengisian kartu stok.
		D	Kolaborasi dengan tim pengolahan dan penyaji dalam pengisian kartu stok bahan makanan.
		S	Risiko kehabisan stok bahan makanan apabila tidak teratur mengisi kartu stok bahan makanan.
		A	Sosialisasi ulang kepada tim pengolahan dan tim penyaji dalam pengisian kartu stok bahan makanan.

3.8 Profil SDM

3.8.1 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	0	0
2	Kabid Pelayanan Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
3	Kabid Penunjang Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	1	1	0	1	0
5	Kabid Umum & Keuangan	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Satuan Pengawas Internal	SMK	1	1	1	0	0
7	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
8	Dokter Casemix	Dokter Umum	2	2	0	2	0
9	Farmasi	Profesi Apoteker	41	13	6	7	0
		S1 Farmasi		3	2	1	0
		D3 Analis Farmasi dan Makanan		1	1	0	0
		D3 Farmasi		9	2	7	0
		SMK		4	3	1	0
		SMA		1	1	0	0
10	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	10	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	7	1	0
		SMK		0	0	0	0
		SMA		1	1	0	0
11	CSSD	D3 Keperawatan	5	3	2	1	0
		SMA		1	1	1	0
		SMK		1	0	1	0
12	Fisioterapi	S1 Fisioterapi	5	1	0	1	0
		D3 Fisioterapi		3	2	1	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	0
13	Gizi	S1 Ilmu Gizi	17	2	2	0	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	2	0	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		7	0	7	0
		SMA		1	0	1	0
		SMP		3	2	1	0
14	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	1	0	1	0
		S1 Teknik Informatika		1	0	1	0
15	ICU dan HCU	Profesi Ners	12	6	6	0	0
		D3 Keperawatan		6	5	1	0
16	IGD	Profesi Ners	24	11	8	3	0
		D3 Keperawatan		8	6	2	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
17	IKO	Profesi Ners	12	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0

		D3 Kebidanan		1	1	0	0
18	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
19	IPSRS	S1 Tenik Elektro	6	1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	3	0	0
20	IRJA	Profesi Ners	27	8	7	1	0
		D3 Keperawatan		14	13	1	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
21	IRNA 2C	Profesi Ners	8	6	5	1	0
		D3 Keperawatan		2	2	0	0
22	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	18	5	4	1	0
		D3 Keperawatan		13	7	6	0
23	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	15	6	4	0	0
		D3 Keperawatan		8	7	1	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
24	IRNA 5C	Profesi Ners	9	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		6	4	2	0
25	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	25	12	6	6	0
		D3 Keperawatan		13	8	3	0
26	Maternitas	Profesi Kebidanan	12	2	0	2	0
		D4 Kebidanan		2	1	1	0
		D3 Kebidanan		8	8	0	0
27	Neonatologi	Profesi Ners	7	2	2	0	0
		D3 Keperawatan		5	4	0	1
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
28	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	10	2	2	0	0
		S1 Akuntansi		2	0	2	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
29	Laboratorium	D4 Analisis Kesehatan	10	2	1	1	0
		D3 Analisis Kesehatan		8	7	1	0
30	Laundry	SMK	5	1	0	1	0
		SMA		3	0	3	0
		SMP		1	0	1	0
31	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	10	10	10	0	0
32	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	18	1	1	0	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		1	1	0	0
		D4 Destinasi Wisata		1	0	1	0
		D3 Asuransi Kesehatan		2	0	2	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		6	4	2	0
		D1 Administrasi Perkantoran		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		4	4	0	0

33	PIPP & MPP	Profesi Ners	5	2	1	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
34	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	0	0
35	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	7	7	5	2	0
36	SDM	S1 Psikologi	2	1	0	1	0
		S1 Ilmu Sosial		1	1	0	0
37	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	0	0
38	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	0	0
39	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
40	Cleaning Service	SMK	46	17	8	9	0
		SMA		24	20	4	0
		SMP		5	5	0	0
41	Security	SMK	12	5	2	3	0
		SMA		7	6	1	0
42	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	5	1	1	0	0
		SMA		3	2	1	0
		SMP		1	1	0	0
43	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
44	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	5	4	1	4	0
45	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
46	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
47	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
48	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
49	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
50	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
51	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
54	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter	Pendidikan Dokter	3	3	0	3	0

	Spesialis Orthopedi dan Traumatologi	Spesialis					
56	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
57	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
58	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
59	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
61	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
62	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
63	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total			460				

Keterangan :
 Pada bulan Mei 2025 terdapat penambahan 1 Dokter Umum baru, 1 Dokter Spesialis Anestesi baru, dan 2 pengaktifan staf TTK.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

RS Prima Husada Malang yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sumber Daya Manusia ataupun dari sisi sarana dan prasarannya. Dimana masih terdapat beberapa Sumber Daya manusia yang masih belum tertib baik dari kelompok tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang masih belum tertib secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dengan penataan SDM yang disesuaikan dengan alur dan tata letak Gedung yang baru, maka dilakukan juga penambahan tenaga khususnya perawat untuk memenuhi kebutuhan setelah dilakukan evaluasi dan Analisa beban kerja. Proporsi antara karyawan kontrak/tidak tetap dengan karyawan tetap, dimana masih banyak karyawan kontrak/tidak tetap di RS Prima Husada Malang diperkirakan bisa mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah sakit

Kepatuhan DPJP dalam memvisite pasien dan melengkapi dokumen Rekam medis yang masih jauh dari standar juga mempengaruhi kualitas pelayanan di RS Prima Husada Malang dan menghambat proses klaim. Kinerja RS dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal Rumah Sakit. Jumlah kunjungan di RS Prima Husada Malang masih didominasi oleh kunjungan pasien lama dari BPJS Kesehatan. Pelayanan di beberapa unit yang belum optimal dikerenakan salah satu dampak kekurangan tenaga kerja membawa akibat pada pelayanan.

B. SARAN

1. Meningkatkan ketertiban administrasi di Unit SDM terutama ketertiban absensi dengan memanfaatkan SIM SDM yang baru
2. Membentuk dan mengoptimalkan kinerja dari komite – komite yang ada di RS Prima Husada Malang
3. Meningkatkan kepatuhan visite DPJP dengan mencatat dan melaporkan waktu visite DPJP serta mentertribkan DPJP dalm pengisian Dokumen Rekam Medis
4. Memperbaiki proses rekrutmen staf sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
5. Meningkatkan skill dan pengetahuan SDM dengan giat mengaktifkan diklat dan pelatihan internal serta mengikuti pelatihan secara eksternal
6. Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke RS Prima Husada Malang
7. Menjalin lebih banyak kerjasama dengan stakeholder dari luar RS Prima Husada Malang

BAB V
PENUTUP

Demikian laporan bulan Juni 2025 ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Malang pada Mei 2025, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Malang, 10 Juni 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN

NO	NAMA PKS	JENIS INSTANSI	MULAI BERLAKU	TANGGAL EXPIRED	KETERANGAN	NOMOR PKS RUMAH SAKIT	NOMOR PKS INSTANSI
1	ASURANSI DAYIN MITRA	ASURANSI	05 Februari 2015	05 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/269/XII/2014	003/MKT/HLT/PKS/I/2015
2	Batas Media 99	PERUSAHAAN	05 Juni 2024	05 Juni 2027	Pelayanan Kesehatan	158/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	-
3	BPJS KESEHATAN	ASURANSI	01 Januari 2025	31 Desember 2025	Pelayanan Kesehatan	2035/E-PKS/DIR/XII/2024	651/KTR/VII-05/1224
4	CV AUMERTA ANGGUN	PERUSAHAAN	28 Agustus 2023	28 Agustus 2026	PELAYANAN KESEHATAN	164.1/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2023	-
5	ESWEJE Aesthetic Center	INSTANSI KESEHATAN	01 Maret 2024	01 Maret 2027	Sterilisasi alat kesehatan	079/DPM/E-PKS/DIR/III/2024	9,1202E+12
6	Pelayanan Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu	AKRE	05 Desember 2022	04 Desember 2025	Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu	1754/E-PKS/DIR/XII/2022	-
7	Indonesia Smelting Technology	PERUSAHAAN	01 Juni 2024	01 Juni 2026	Rujukan Pelayanan	194/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	005/HRGA-IST/V/2024
8	Instruktur Zumba	AKRE	23 Februari 2024	23 Februari 2025	Instruktur Zumba	067/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	-
9	Klinik Mutiara Sehat (Karanglo, Lawang, Karangploso)	INSTANSI KESEHATAN	02 Agustus 2021	02 Agustus 2026	Pelayanan Laboratorium	429.77/I-PKS/DIR/VIII/2021	069/PKS/PDP/VIII/2021
10	Klinik Endisa Husada	INSTANSI KESEHATAN	01 Agustus 2023	01 Agustus 2026	Rujukan Pelayanan	148.3/DPM/E-PKS/DIR/VII/2023	PK/01/VII/2023-KEH
11	Klinik Losari Medika	INSTANSI KESEHATAN	06 Februari 2024	06 Februari 2027	Rujukan Pelayanan	-	021/DPM/E-PKS/DIR/II/2024
12	Klinik Pratama Beauty Medika Singosari	INSTANSI KESEHATAN	25 Mei 2024	25 Mei 2027	Rujukan Pelayanan	145/DPM.E-PKS/DIR/V/2024	001/PKS/12/2024
13	Klinik Rawat Jalan Mitra Prima Care	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2027	Pelayanan Kesehatan	346/DPM/E-PKS/DIR/XII/2024	025/MPC/E-PKS/KA/XII/2024
14	Klinik Utama Medika	INSTANSI	24	24 September	Rujukan Pasien	299/DPM/E-	-

		KESEHATAN	September 2024	2027		PKS/DIR/IX/2024	
14	Klinik Utama Rawat Jalan Akasia	INSTANSI KESEHATAN	25 April 2024	25 April 2027	Pelayanan Kesehatan	116/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	011/KUA/E-PKS/HMS/III/2024
15	Penerjemah Bahasa Isyarat untuk Difabel	AKRE	14 September 2022	13 September 2025	Penerjemah Bahasa Isyarat Untuk Difabel	1378/E- PKS/DIR/X/2022	-
16	Penerjemah Bahasa Madura	AKRE	01 Agustus 2022	02 Agustus 2025	Penerjemah Bahasa Madura	1305/E- PKS/DIR/IX/2022	-
17	Penerjemah Bahasa Asing	AKRE	01 Agustus 2022	01 Agustus 2025	Penerjemah Bahasa Inggris	1288/E- PKS/DIR/IX/2022	-
18	Persada Hospital	INSTANSI KESEHATAN	10 Oktober 2022	10 Oktober 2027	Pelayanan Kesehatan	152.45//DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	1083.b.HS/MOU/X/PH-2022
19	PMI Kabupaten Malang	INSTANSI KESEHATAN	19 Agustus 2024	19 Agustus 2026	Penyediaan Darah	246/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	0904/02.06.28/UTD/VIII/2024
20	PMI Kabupaten Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Juni 2023	30 Juni 2023	Rujukan Pelayanan	-	768/E-PKS/DIR/V/2023
21	PMI Kota Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Desember 2023	01 Desember 2025	Penyediaan Darah	1790/E- PKS/DIR/XI/2023	2214/02.06.27/UTD/XI/2023
22	PRAKTEK BIDAN MANDIRI NIA IRAWATI, S.TR.KEB	INSTANSI KESEHATAN	07 Februari 2024	26 Februari 2027	Rujukan dan Pelayanan Penunjang	081/DPM/E- PKS/DIR/III/2024	-
23	PT AA International Indonesia	ASURANSI	02 September 2019	02 September 2020	Pelayanan Kesehatan Grab	-	-
24	PT Administrasi Medika	ASURANSI	01 Juli 2024	01 Juli 2027	Asuransi		071/PKS/AdM/ManagedCare/VII2024
25	PT AIA Financial	ASURANSI	04 November 2020	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	No.069/DPM/E- PKS/DIR/X/2020	No. 639/AIA/-DPM/XI/2020
26	PT AJ Central Asia Raya	ASURANSI	02 Juni 2017	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	277/RSPH/E- IKS/DIR/VI/2017	DIR/PKS-RS/1455/VI/2017
27	PT AJINOMOTO SALES INDONESIA	PERUSAHAAN	01 Mei 2012	30 APRIL 2013 (selanjutnya)	PELAYANAN KESEHATAN		

				perpanjang otomatis)			
28	PT Alfiza Medika Utama	INSTANSI KESEHATAN	07 Maret 2024	07 Maret 2028	Pelayanan Kesehatan	090/DPM/E- PKS/DIR/III/2024	018/MOU/KAMU/07/III/2024
29	PT Aloita Prima (Harris Hotel Malang)	PERUSAHAAN	29 Juli 2024	29 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	221/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	-
30	PT ANTARMITRA SEMBADA CAB. MALANG	PERUSAHAAN	01 Desember 2024	01 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	304.1.DPM/E- PKS/DIR/X/2024	344/MLG/AMS/XII/2024
31	PT APLIKANUSA LINTASARTA	ASURANSI	25 Februari 2015	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/100/II/2015	095/LA/MOU/00300/2015
32	PT ASABRI	ASURANSI	13 Desember 2023	12 Desember 2026	PELAYANAN KESEHATAN	1902/E- PKS/DIR/XII/2023	PEFJ-182/HK.02.01/HBL.H/XII/2023
33	PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA	ASURANSI	12 Oktober 2023	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	PH/E- PKS/171/X/2013	499B/AAD-LEG-AGR/X/2013
34	PT Asuransi Allianz Life Indonesia	ASURANSI	12 Desember 2017	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	729/AZLI-LGL/AG/XII/2017
35	PT ASURANSI ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA	ASURANSI	18 November 2024	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	698.21/DPM/I- PKS/DIR/IX/2024	391/ALLISYA-LGL/AG/XI/2024
36	PT ASURANSI ASTRA BUANA	ASURANSI	01 September 2020	31 Agustus 2023	PELAYANAN KESEHATAN	1033/RSPHS/E- PKS/DIR/VIII/2020	26/HID-PM/ASURANSIASTRA/IX/2020
37	PT ASURANSI DAYIN MITRA	ASURANSI	05 Februari 2015	05 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/269/XII/2014	003/MKT/HLT/PKS/I/2015
38	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia	ASURANSI	01 Oktober 2023	01 Oktober 2028	Asuransi	183.3/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	157/GI/OPS/Prov-PKS/X/2023
39	PT Asuransi Jiwa In Health Indonesia (Mandiri Inhealth)	ASURANSI	01 Februari 2023	31 Januari 2025	Asuransi	028.2/DPM/E- PKS/DIRR/11/2023	0.32/AJII.KOP-SBY/PKS/0123
40	PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA	ASURANSI	01 Desember 2024	01 Desember 2025	PELAYANAN KESEHATAN	361/DPM/E- PKS/DIR/XII/2024	331-11/EB-CONT/2024

41	PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK (ASURANSI MAG)	ASURANSI	28 Januari 2020	27 Januari 2024	RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN	015/DPM/E- PKS/DIR/XI/2019	PKS-0097/XI/2019/MAG-R2
42	PT Asuransi Reliance Indonesia	ASURANSI	06 November 2024	06 November 2027	Asuransi	338/DPM/E- PKS/DIR/XI/2024	024/LGL-ARI/PKS-RS-IB/XI/2024
43	PT ASURANSI RELIANCE INDONESIA	ASURANSI	07 September 2020	07 September 2025	PELAYANAN KESEHATAN	368/DPM/I- PKS/DIR/VIII/2020	163/LGL-ARI/PKS-RS-COB/IX/2020
44	PT ASURANSI SINARMAS	ASURANSI	01 September 2019	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	010/DPM/E- PKS/DIR/IX/2019	364/PKS-RS/PH.RI.ASM/IX/2019
45	PT ASURANSI SINARMAS MSIG	ASURANSI	10 September 2012	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		063/PKS-AJSMSIG-RS/IX/2012
46	PT ASURANSI TAFAKUL KELUARGA	ASURANSI	02 Januari 2017	01 Januari 2020	PELAYANAN KESEHATAN	508/RSPH/E- IKS/DIR/XI/2016	0642/PKS-RS-01/I/2017
47	PT ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA	ASURANSI	30 Oktober 2021	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	612/RSPHS/E- PKS/DIR/X/2019	300/PKS/DIR/TKP/X/2019
48	PT AXA SERVICES INDONESIA (ADMEDIKA)	ASURANSI	15 Agustus 2013	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		067/AGR-LEG/ASI/VIII/2013
49	PT Bestari Murni Anugrah	PERUSAHAAN	04 Juni 2024	04 Juni 2027	rujukan pelayanan	159/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
50	PT BNI LIFE INSURANCE	ASURANSI	25 Juli 2016	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	082/RSPH/E- IKS/DIR/II/2016	274.PKS.BL.DIR.0716
51	PT CAKRA SURYA HUSADA	PERUSAHAAN	02 Agustus 2022	02 Agustus 2025	ASUHAN PASIEN & PELAYANAN PENUNJANG	112.1/DPM/E- PKS/DIR/VII/2022	138/MOU/VIII/CSH/2022
52	PT Citra Karsa Dinamika	PERUSAHAAN	01 Juli 2024	01 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	196/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
53	PT Docdoc Healthcare Indonesia	ASURANSI	12 Desember 2024	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	-
54	PT Equity Life Indonesia	ASURANSI	14 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	-	091/ELI/LGL/X/19

55	PT EQUITY LIFE INDONESIA	ASURANSI	14 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		090/ELI/LGL/X/19
56	PT Fullerton Health Indonesia	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis		-	640/IP-OP/PKS/FHI/VIII/2019
57	PT Global Assistance & Healthcare	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	-	640/IP-OP/PKS/GAH/VIII/2019
58	PT Green Mountains Natural Food	PERUSAHAAN	07 Agustus 2024	07 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	225/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	01/GMN/KS/VI/2024
59	PT HANWA LIFE INSURANCE INDONESIA	ASURANSI	16 Maret 2015	15 Maret 2016	PELAYANAN KESEHATAN		0088/HLI-GH/PKS-RS/03-2015
60	PT Indo Aneka Atsiri	PERUSAHAAN	07 Agustus 2024	06 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	222/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	066/IAA/HRGA/VI/2024
61	PT INDOLAKTO PANDAAN	PERUSAHAAN	10 Januari 2014	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		
62	PT Indonesia Marine	PERUSAHAAN	10 September 2024	10 September 2027	Pelayanan Kesehatan	-	-
63	PT INTERNATIONAL SERVICES PASIFIC CROSS	VENDOR	03 Oktober 2022	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	150/DPM/E-PKS/DIR/X/2022	953/ISPC/PKS/X/2022
64	PT JASA RAHARJA	ASURANSI	04 Juli 2022	04 Juli 2027	PENAGANAN DAN PENYELESAIAN SATUAN KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DAN LALU LINTAS JALAN	912.1/E-PKS/DIR/VII/2022	P/13/SP/2022
65	PT Java Smartindo	PERUSAHAAN	01 Agustus 2020	Perpanjangan Otomatis	Jasa Pengelolaan Administrasi Kesehatan	364/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	PKS.TPA-JSMART.290/VIII/20/RS.SW.C
66	PT JAYA OBAYASI	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	360/DPM/I-PKS/DIR/VIII/2020	
67	PT Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	ASURANSI	17 Juli 2020	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	034/DPM/E-PKS/DIR/VII/2020	092/KBM-DPM/PKS/VII/2020
68	PT LABBIOGEN ARTHA MEGA	INSTANSI KESEHATAN	02 September 2024	01 September 2027		262/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2024	B-MKT 01/001/623/VII/2024

69	PT MALANG INTERMEDIA PERS	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	025/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	103.1/PKS/DIR/JPRM/VIII/2020
70	PT Medilink Digital Media	ASURANSI	22 Maret 2024	22 Maret 2027	Pelayanan Kesehatan	09/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	229/L/PKS/MDM-DPM/III/2024
71	PT MEDLINX ASIA TEKNOLOGI	ASURANSI	28 November 2016	Perpanjangan Otomatis	APLIKASI LAYANAN KESEHATAN	150/PKS- RSPRIMAHUSADA- MAT/DIR/XI/2016	
72	PT MOOR SUKSES INTERNASIONAL	ASURANSI	08 Juli 2024	08 Juli 2027	PELAYANAN KESEHATAN	200/DPM/E- PKS/DIR/2024	001/MSI/VI/2024
73	PT PAN PACIFIC INSURANCE	ASURANSI	31 Agustus 2020	31 Agustus 2023	PELAYANAN PERAWATAN DAN PENGOBATAN	017/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	0593-01/PKS/PRV-PANFIC/RS- PHMS/VIII/2020
74	PT PANCAMAS ELITE	PERUSAHAAN	12 Juni 2024	12 Juni 2027	Pelayanan Kesehatan	172/DPM/E- PKS/DIV/VI/2024	-
75	PT PANCAMAS ELITE	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	032/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	
76	PT PLN (Persero)	ASURANSI	02 Juli 2024	31 Desember 2025		261/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	0017.Add/HKM.02.01/F010800300/2022
77	PT Prima Sarana Jasa - Asuransi SOS	ASURANSI	17 September 2018	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	735/E- PKS/DIR/IX/2018	296/GAN/PT-6/HOSP/SEP/2018
78	PT Prudential Life Assurance	ASURANSI	28 Januari 2021	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	047/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2020	1578/PMN-PLA/XI/2020
79	PT Suprima Mitra Adihusada	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	640/IP-OP/PKS/TIRTA/VIII/2019
80	PT TASPEN (PERSERO)	ASURANSI	11 Juni 2024	10 Juni 2026	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	110/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	JAN-09/C.5.1/2024
81	PT TASPEN (PERSERO)	ASURANSI	01 Januari 2023	31 Desember 2025	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	008/E- PKS/DIR/I/2023	JAN-01/DIR/2023
82	PT TIRTA INVESTAMA	PERUSAHAAN	31 Agustus 2020	31 Agustus 2025	PELAYANAN KESEHATAN		
83	PT Tonggak Ampuh	PERUSAHAAN	31 Agustus 2024	31 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	263/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	-
84	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA	PERUSAHAAN	01 Agustus	31 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	150.2/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	050/AK/2/VII/TBINA-Kenaf/2023

			2023				
85	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA PASURUAN PLANT	PERUSAHAAN	27 Oktober 2020	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	1076/RSPHS/E-PKS/DIR/IX/2020	002/AK/10/V/TBINA-Kenaf/2020
86	PT Unggul Anugrah Sejahtera	PERUSAHAAN	04 Juni 2024	04 Juni 2027	Rujukan Pelayanan	160/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	-
87	PT Uniplastindo Interbuana	PERUSAHAAN	29 Juli 2024	29 Juli 2027	Pelayanan Kesehatan	224/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	-
88	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA	PERUSAHAAN	04 Januari 2021	04 Januari 2024	PELAYANAN KESEHATAN	303/DPM/I-PKS/DIR/VI/2021	002/PKS-COB/I/2021
89	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA	PERUSAHAAN	22 Maret 2024	22 Maret 2027	PELAYANAN KESEHATAN	183/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	014/PKS-COB/III/2024
90	PT YAMAHA MUSICAL PRODUCTS INDONESIA (YMPI)	PERUSAHAAN	01 Juni 2022	01 Juni 2025	PELAYANAN KESEHATAN	004/DPM/E-PKS/VI/2022	/YMPI/HI/PKS/VI/2022
91	PT Yanmar Diesel Indonesia	PERUSAHAAN	15 April 2024	15 April 2027	Pelayanan Kesehatan	108/DPM/E-PKS/DIR/IV/2024	107/YADIN/Pdn/Pga/IV/2024
92	PT Zurich Asuransi Indonesia TBK	ASURANSI	25 Juni 2024	24 Juni 2029	Asuransi	151/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	268/ZAI-LEG-AGR/VI/2024
93	RS Islam UNISMA Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Januari 2024	31 Desember 2026	Rujukan Pelayanan	222.11/DPM/E-PKS/DIR/XI/2023	08/PKS/RSI-4/I/2024
94	RS Lavalette	INSTANSI KESEHATAN	07 Agustus 2024	07 Agustus 2027		236/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2024	DA01-ADDNM-BB/P-B/24-07-16/138
95	RS Prima Husada Sukorejo	INSTANSI KESEHATAN	01 Oktober 2022	01 Oktober 2025	Pelayanan Kesehatan	1376/E-PKS/DIR/X/2022	1608/RSPJS/E-PKS/DIR/X/2022
96	RS Siti Miriam Lawang	INSTANSI KESEHATAN	31 Agustus 2024	31 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	264/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024	566/HMS/RSSM/VIII/2024
97	RSIA Puri Bunda	INSTANSI KESEHATAN	06 Februari 2024	06 Februari 2026	Rujukan Pelayanan	020/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	001/PKS/PB/I/2024
98	RSUD Bangil	INSTANSI	22 Juli	22 Juli 2027	Rujukan Pelayanan	222/DPM/E-	400.7.5.2/1531.1/424.072.01/2024

		KESEHATAN	2024			PKS/DIR/VII/2024	
99	Yayasan Bhakti Luhur	AKRE	05 Desember 2022	04 Desember 2025	Pelayanan Rohaniawan Agama Kristen	1753/E- PKS/DIR/XII/2022	-
100	RS PANTI NIRMALA	INSTANSI KESEHATAN	07 Oktober 2022	06 Oktober 2025	PELAYANAN RUJUKAN	152.44/DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	3740/069/RSPN/X/2022
101	PKM SINGOSARI	INSTANSI KESEHATAN	12 April 2022	12 April 2027	TUBERKULOSIS DENGAN STRATEGI DOTS	593/I- PKS/DIR/IV/2022	440/894/35.07.103.135.2022
102	KLINIK IDAMAMUK	INSTANSI KESEHATAN	16 Juni 2021	PERPANJANG OTOMATIS	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG	347/DPM/I- PKS/DIR/VII/2021	/005/VI/2021
103	KLINIK RAWAT INAP MUSLIMAT SINGOSARI	INSTANSI KESEHATAN	15 April 2023	15 April 2026	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG	107.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	031.A/A.1/M/RSMS/02/IV/2023
104	KLINIK TIRTO HUSADA	INSTANSI KESEHATAN	18 September 2023	18 September 2026	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	176.3/DPM/E- PKS/DIR/IX/2023	015.004/KTH/IX/2023
105	KLINIK UTAMA JANTUNG HUSNA MEDIKA MALANG	INSTANSI KESEHATAN	01 Desember 2023	32/11/26	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	241.2/DPM/E- PKS/DIR/XII/2023	023/PKS/DIR-HMMMALANG/XII/2023
106	DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR NIA ANITA	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2029	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	347/DPM/E- PKS/DIR/2024	
107	DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR INDRAWAN DWANTORO	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2029	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	348/DPM/E- PKS/DIR/XII/2024	
108	RSJ DR RADJIMAN WEDIODONONGRAT LAWANG	INSTANSI KESEHATAN	30 Oktober 2023	30 Oktober 2026	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	220.1/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	HK.03.01/D.XXXVII/12226A/2023
109	RSUD DR SAIFUL ANWAR	INSTANSI KESEHATAN	01 November 2024	01 November 2026	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	234/DPM/E- PKS/VIII/2024	400.14.5/7499.1/102.7/2024
110	KLINIK PRATAMA RAWAT JALAN MAWAR WASKITHA HUSADA	INSTANSI KESEHATAN	23 Januari 2024	22 Januari 2027	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	001.34/DPM/E- PKS/DIR/I/2024	
111	PRAKTEK BIDAN MANDIRI RIZA KHUTMI, S.S.T	INSTANSI KESEHATAN	05 Agustus 2024	05 Februari 2027	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	221/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	
112	RSU UNIVERSITAS	INSTANSI	05	22 Agustus	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	248/DPM/E-	081/SK_PKS/RSU-UMM/VIII/2024

	MUHAMMADIYAH MALANG	KESEHATAN	Agustus 2024	2027		PKS/DIR/VIII/2024	
113	IBAZZ AESTHETIC MEDICAL CENTER BY DR UMMAH	INSTANSI KESEHATAN	14 Juni 2024	14 Juni 2027	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	180/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	
114	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MALANG	INSTANSI KESEHATAN	02 Januari 2025	02 Januari 2026	PELAYANAN KELUARGA BERENCANA IUD & IMPLANT	2053/E- PKS/DIR/XII/2024	100-3-7/103/35-07-313/2025